

Buku Ajar

KEPERAWATAN MATERNITAS

Nina Sunarti • Yuni Puji Widiastuti • Santi Wahyuni
Ety Nurhayati • Hemi Fitriani

Editor: Prof. Dr. M. Hasinuddin, S.Kep., Ns., M.Kep.



Buku Ajar :

Keperawatan Maternitas

Penulis:

Ns. Nina Sunarti, M.Kep

Yuni Puji Widiastuti, S.Kep., M.Kep., Ns.

Santi Wahyuni, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.

Ety Nurhayati, S.Kp., M.Kep., Ns.Sp.Kep.Mat.

Dr. Hemi Fitriani, M.Kep., Ns.Sp.Kep.Mat.

Editor: Prof. Dr. M. Hasinuddin, S.Kep., Ns., M.Kep.

Buku Ajar:

Keperawatan Maternitas

Penulis:

Ns. Nina Sunarti, M.Kep
Yuni Puji Widiastuti, S. Kep., M.Kep., Ns.
Santi Wahyuni, S.Kp., M.Kep., Sp.Mat.
Ety Nurhayati, S.Kp., M.Kep., Ns.Sp.Kep.Mat.
Dr. Hemi Fitriani, M.Kep., Ns.Sp.Kep.Mat.

Editor: Prof. Dr. M. Hasinuddin, S.Kep., Ns., M.Kep.

Desain Sampul: Ivan Zumarano

Penata Letak: Khoirul Anam

ISBN: 978-634-7927-29-3

Cetakan Pertama: September, 2026

Hak Cipta 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit PT Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta

Anggota IKAPI No. 635/DKI/2025

Kata Pengantar

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, *Buku Ajar Keperawatan Maternitas* ini dapat disusun dan diselesaikan. Buku ajar ini disusun sebagai salah satu referensi pembelajaran bagi mahasiswa keperawatan serta sebagai bahan pengayaan bagi dosen, praktisi, dan tenaga kesehatan yang berkecimpung dalam pelayanan keperawatan maternitas. Penyusunan buku ini dilandasi kebutuhan akan sumber belajar yang sistematis, aplikatif, dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta praktik berbasis bukti (*evidence-based practice*) dalam asuhan keperawatan maternitas.

Keperawatan maternitas merupakan bagian integral dari pelayanan kesehatan yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan bio-psiko-sosial-spiritual perempuan selama masa kehamilan, persalinan, nifas, dan adaptasi keluarga. Dalam konteks pelayanan modern, pendekatan *continuity of care* menjadi sangat penting untuk menjamin kesinambungan asuhan, meningkatkan keselamatan ibu dan bayi, serta memperkuat peran keluarga sebagai sistem pendukung utama. Oleh karena itu, buku ini dirancang untuk membantu pembaca memahami konsep dasar, keterampilan klinis, dan strategi intervensi keperawatan yang komprehensif, mulai dari kondisi fisiologis hingga kondisi patologis yang memerlukan penanganan tepat dan cepat.

Materi dalam buku ajar ini disusun secara bertahap dan terstruktur sesuai alur pembelajaran. Bab 1 membahas ruang lingkup keperawatan maternitas serta konsep *continuity of care* sebagai landasan pemberian asuhan yang holistik dan berkesinambungan. Bab 2 menguraikan asuhan keperawatan pada masalah umum kehamilan yang sering dijumpai, dengan penekanan pada pengkajian, diagnosa keperawatan, intervensi, serta edukasi kepada ibu dan keluarga. Bab 3 memfokuskan pembahasan pada komplikasi kehamilan seperti hipertensi, preeklamsia, dan eklamsia, mencakup deteksi dini, pencegahan komplikasi, monitoring ibu-janin, dan penanganan kegawatdaruratan. Bab 4 menyajikan materi tentang perdarahan antepartum dan risiko kehamilan tinggi, yang menuntut kepekaan klinis, kolaborasi interprofesional, serta keterampilan komunikasi terapeutik dalam situasi kritis. Selanjutnya, Bab 5 membahas persiapan persalinan, termasuk psikoprofilaksis, manajemen nyeri, serta dukungan keluarga, sebagai upaya meningkatkan kesiapan ibu dan keluarga menghadapi proses persalinan secara aman dan nyaman.

Kami berharap buku ajar ini tidak hanya membantu pembaca memahami teori, tetapi juga mendorong kemampuan berpikir kritis, pengambilan keputusan klinis, serta penerapan asuhan keperawatan yang aman, bermutu, dan berorientasi pada

keselamatan pasien (*patient safety*). Penyajian materi diupayakan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, namun tetap sesuai dengan kaidah ilmiah dan kebutuhan pembelajaran.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah mendukung penyusunan buku ajar ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kami menyadari bahwa buku ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan pada edisi berikutnya.

Akhir kata, semoga buku ajar *Keperawatan Maternitas* ini dapat memberikan manfaat yang luas bagi pengembangan kompetensi mahasiswa dan peningkatan kualitas pelayanan keperawatan maternitas di berbagai tatanan layanan kesehatan.

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	iii
---------------------	-----

Daftar Isi.....	v
-----------------	---

BAB 1 RUANG LINGKUP KEPERAWATAN MATERNITAS DAN CONTINUITY OF CARE (COC) 1

A. Teori Dasar	5
B. Tujuan Keperawatan Maternitas.....	7
C. Ruang Lingkup Keperawatan Maternitas	7
D. Perspektik Keperawatan Maternitas.....	8
E. Falsafah Keperawatan Maternitas	10
F. Implikasi Falsafah dalam Praktik Keperawatan	11
G. Etik Legal Keperawatan Maternitas	11
H. Prinsip Etika dalam Keperawatan Maternitas.....	11
I. Peran Perawat Maternitas	12
J. Tren dan Isu Keperawatan Maternitas.....	14
K. Tren Keperawatan Maternitas	14
L. Isu Keperawatan Maternitas.....	15
M. Aplikasi Keselamatan Pasien dalam Keperawatan Maternitas	15
N. Konsep Continuity Of Care dan Family Centered Maternity Care.....	16
O. RINGKASAN	23
P. MINI CASE.....	24

Referensi	29
-----------------	----

BAB 2 ASUHAN KEPERAWATAN PADA MASALAH UMUM KEHAMILAN 31

A. Pendahuluan	31
B. MASALAH UMUM PADA KEHAMILAN TRIMESTER I: EMESIS GRAVIDARUM.....	40
C. Masalah Umum pada Kehamilan Trimester II: Kram Kaki (Leg Cramps).....	56
D. Masalah Umum pada Kehamilan Trimester III: Nyeri Punggung Bawah (Lower Back Pain).....	64
E. Prosedur Keperawatan (Standar Operasional Prosedur)	78
F. Aktivitas Pembelajaran Klinik (Case-Based Learning dan Praktikum).....	90
G. Evaluasi Capaian Pembelajaran (OBE)	113
H. Rangkumam Materi.....	124

Glosarium	127
-----------------	-----

Referensi	131
------------------------	------------

BAB 3 KOMPLIKASI KEHAMILAN: HIPERTENSI, PREEKLAMPSIA, DAN EKLAMPSIA

.....	135
A. Konsep Dasar.....	142
B. Integrasi Asuhan Keperawatan & Keselamatan Ibu	160
C. Asuhan Keperawatan dengan Hipertensi Gestasional dan Preeklampsia	160
D. Asuhan Keperawatan Kegawatdaruratan pada Eklampsia.....	165
E. Edukasi Kesehatan pada Ibu dan Keluarga dengan Hipertensi gestasional.....	166
F. Edukasi Kesehatan pada Ibu dan Keluarga dengan Preeklampsia	167
G. Edukasi Kesehatan pada Ibu dan Keluarga dengan Preeklampsia	168
H. Ringkasan Bab.....	186
Referensi	191

BAB 4 PERDARAHAN ANTE PARTUM & RISIKO KEHAMILAN TINGGI

.....	193
A. Pendahuluan.....	197
B. TUJUAN INSTRUKSIONAL.....	198
C. URAIAN MATERI.....	199
D. ASUHAN KEPERAWATAN LENGKAP PERDARAHAN ANTE PARTUM (APH)(SDKI– SLKI–SIKI TERINTEGRAS I)	217
E. KESIMPULAN	220
F. RINGKASAN	236
Referensi	240

BAB 5 PERSIAPAN PERSALINAN: PSIKOPROFILAKSIS, NYERI DAN DUKUNGAN KELUARGA

.....	243
A. Psikoprofilaksis.....	248
B. Teknik Psikoprofilaksis dalam Persalinan	249
C. Nyeri Persalinan.....	252
D. Dukungan keluarga.....	256
E. Ringkasan.....	271
Referensi	276

Profil Penulis.....

BAB 1

RUANG LINGKUP KEPERAWATAN MATERNITAS DAN *CONTINUITY OF CARE (COC)*

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep, peran, dan prinsip praktik keperawatan maternitas berorientasi kesinambungan asuhan, etik, dan keselamatan pasien.	CPMK-1, CPMK-7
CPL-2	Menguasai dasar biomedik terkait reproduksi perempuan serta adaptasi maternal–neonatal sebagai landasan keputusan keperawatan.	CPMK-2
CPL-3	Mampu melakukan pengkajian komprehensif dan menetapkan tingkat risiko pada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir.	CPMK-2, CPMK-3
CPL-4	Mampu merumuskan prioritas masalah dan menyusun rencana asuhan keperawatan maternitas berbasis standar dan bukti.	CPMK-3, CPMK-4
CPL-5	Mampu melaksanakan intervensi, edukasi, dan komunikasi terapeutik pada ibu–bayi–keluarga selama kehamilan sampai nifas.	CPMK-4, CPMK-5
CPL-6	Mampu melakukan deteksi dini, penatalaksanaan awal kegawatdaruratan, kolaborasi/rujukan, serta evaluasi–dokumentasi dan perencanaan pulang.	CPMK-5, CPMK-6, CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan ruang lingkup, peran, dan prinsip Continuity of Care serta keselamatan pasien dalam keperawatan maternitas.
CPMK-2	Menganalisis anatomi–fisiologi reproduksi perempuan dan adaptasi maternal–neonatal untuk mendukung keputusan keperawatan.
CPMK-3	Melakukan pengkajian komprehensif dan stratifikasi risiko pada kehamilan, persalinan, nifas, dan neonatus.
CPMK-4	Menyusun rencana asuhan keperawatan maternitas untuk kondisi fisiologis dan masalah umum dengan luaran terukur.
CPMK-5	Melaksanakan intervensi, edukasi, manajemen nyeri, serta dukungan psikososial–keluarga pada periode maternitas.
CPMK-6	Melakukan deteksi dini dan penatalaksanaan awal komplikasi/kegawatdaruratan maternal, serta koordinasi kolaborasi/rujukan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Melakukan evaluasi, dokumentasi, perencanaan pulang, dan perencanaan layanan kesehatan reproduksi pascapersalinan.

C. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 1. Ruang Lingkup Keperawatan Maternitas dan Continuity of Care	1.1 Menjelaskan konsep keperawatan maternitas, rentang layanan, dan model kesinambungan asuhan.	1.2 Mengidentifikasi peran perawat, alur kolaborasi, dan prinsip keselamatan pasien dalam layanan maternitas.	CPMK-1	CPMK-7

D. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis (MCQ/essay terstruktur)	Persentase jawaban benar pada blueprint konsep (ruang lingkup, CoC, keselamatan pasien)	10	Lembar jawaban ujian
CPMK-7	Portofolio klinik/proyek perencanaan pulang	Kelengkapan dokumentasi evaluasi; kelengkapan rencana pulang; kesesuaian rencana layanan reproduksi pascapersalinan	10	Portofolio; format dokumentasi & discharge plan

Rubrik CPMK-1 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Penguasaan konsep ruang lingkup & CoC (akurasi elemen kunci)	Akurat $\leq 50\%$ elemen kunci; banyak miskonsepsi.	Akurat 51–69% elemen kunci; masih ada kekeliruan istilah/relasi konsep.	Akurat 70–84% elemen kunci; penjelasan runtut.	Akurat $\geq 85\%$ elemen kunci; sintesis jelas dan konsisten.
1.2 Aplikasi prinsip keselamatan pasien & etik pada skenario maternitas	Identifikasi risiko & tindakan aman $\leq 50\%$; keputusan tidak sesuai prinsip.	Identifikasi 51–69%; tindakan aman ada namun belum lengkap.	Identifikasi 70–84%; keputusan aman dan sesuai prinsip pada	Identifikasi $\geq 85\%$; keputusan aman, preventif, dan argumentatif.

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
			sebagian besar situasi.	

Rubrik CPMK-2 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Akurasi anatomi–fisiologi reproduksi (struktur–fungsi)	Ketepatan $\leq 50\%$; banyak salah konsep/relasi struktur–fungsi.	Ketepatan 51–69%; konsep dasar benar namun parsial.	Ketepatan 70–84%; relasi struktur–fungsi tepat dan logis.	Ketepatan $\geq 85\%$; integrasi konsep kuat dan konsisten.
2.2 Analisis adaptasi kehamilan & implikasi kebutuhan asuhan	Analisis tidak runtut; implikasi klinis tidak tepat ($\leq 50\%$ sesuai data).	Analisis cukup; implikasi masih umum (51–69% sesuai data).	Analisis baik; implikasi spesifik (70–84% sesuai data).	Analisis sangat baik; implikasi komprehensif & antisipatif ($\geq 85\%$ sesuai data).

Rubrik CPMK-3 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Kelengkapan data pengkajian (komponen inti)	Komponen terisi $\leq 50\%$; banyak data penting hilang/tidak valid.	Komponen terisi 51–69%; masih ada kekosongan data kunci.	Komponen terisi 70–84%; data kunci lengkap dan relevan.	Komponen terisi $\geq 85\%$; data sangat lengkap, terstruktur, dan konsisten.
3.2 Ketepatan stratifikasi risiko & prioritas masalah	Risiko & prioritas tepat $\leq 50\%$; tidak sesuai temuan.	Tepat 51–69%; prioritas masih kurang tajam.	Tepat 70–84%; prioritas jelas berbasis temuan.	Tepat $\geq 85\%$; prioritas sangat tepat disertai tindak lanjut yang terarah.

Rubrik CPMK-4 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Kesesuaian masalah–luaran–intervensi & keterukuran luaran	Kesesuaian $\leq 50\%$; luaran tidak terukur; intervensi tidak spesifik.	Kesesuaian 51–69%; luaran sebagian terukur; intervensi masih generik.	Kesesuaian 70–84%; luaran terukur; intervensi spesifik dan realistis.	Kesesuaian $\geq 85\%$; luaran sangat terukur; intervensi prioritatif dan tepat sasaran.

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.2 Rasional, prioritas, dan rencana evaluasi	Rasional lemah/absen; prioritas tidak jelas; evaluasi tidak terencana ($\leq 50\%$ memadai).	Rasional ada namun terbatas; prioritas cukup; evaluasi parsial (51–69%).	Rasional baik; prioritas jelas; evaluasi sesuai luaran (70–84%).	Rasional sangat kuat; prioritas tajam; evaluasi komprehensif & terjadwal ($\geq 85\%$).

Rubrik CPMK-5 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Ketepatan & keselamatan pelaksanaan intervensi keperawatan	Langkah benar/aman $\leq 50\%$; terdapat tindakan berisiko.	Langkah benar/aman 51–69%; ada kekurangan minor pada urutan/asepsis.	Langkah benar/aman 70–84%; pelaksanaan aman dan efektif.	Langkah benar/aman $\geq 85\%$; sangat terampil, efisien, dan konsisten aman.
5.2 Kualitas komunikasi terapeutik, edukasi, dan dukungan keluarga	Tujuan komunikasi tidak tercapai; pemahaman klien tidak terverifikasi ($\leq 50\%$).	Komunikasi cukup; edukasi disampaikan namun verifikasi terbatas (51–69%).	Komunikasi baik; edukasi relevan dengan verifikasi pemahaman (70–84%).	Komunikasi sangat baik; edukasi terstruktur dengan teach-back dan pelibatan keluarga optimal ($\geq 85\%$).

Rubrik CPMK-6 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Deteksi dini & keputusan prioritas stabilisasi awal kegawatdaruratan	Tanda bahaya terlewat; prioritas salah ($\leq 50\%$ keputusan tepat).	Tanda bahaya sebagian terdeteksi; prioritas cukup (51–69% tepat).	Deteksi cepat; prioritas stabilisasi tepat (70–84% tepat).	Deteksi sangat cepat; prioritas tepat & antisipatif ($\geq 85\%$ tepat).
6.2 Koordinasi kolaborasi/rujukan & komunikasi tim	Kolaborasi/rujukan terlambat/tidak tepat; komunikasi	Kolaborasi ada namun belum	Kolaborasi/rujukan tepat waktu; komunikasi jelas (70–84%).	Kolaborasi/rujukan sangat tepat; komunikasi terstruktur dan

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
	tidak efektif ($\leq 50\%$ sesuai).	sistematis; komunikasi cukup (51–69%).		memastikan kesinambungan ($\geq 85\%$).

Rubrik CPMK-7 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kualitas evaluasi luaran & dokumentasi asuhan	Dokumentasi tidak lengkap; evaluasi tidak berbasis data ($\leq 50\%$ komponen terpenuhi).	Dokumentasi cukup; evaluasi masih umum (51–69%).	Dokumentasi lengkap; evaluasi sesuai luaran (70–84%).	Dokumentasi sangat lengkap & rapi; evaluasi analitis berbasis data ($\geq 85\%$).
7.2 Komprehensif perencanaan pulang & rencana layanan reproduksi pascapersalinan	Rencana tidak jelas/tidak individual; tanda bahaya/kontrol terlewat ($\leq 50\%$ komponen).	Rencana ada namun parsial; komponen kunci belum lengkap (51–69%).	Rencana komprehensif; mencakup kontrol & tanda bahaya; cukup individual (70–84%).	Rencana sangat komprehensif & individual berbasis risiko; mencakup koordinasi layanan lanjutan dan konseling reproduksi terstruktur ($\geq 85\%$).

A. Teori Dasar

Keperawatan maternitas merupakan cabang ilmu keperawatan yang berfokus pada pemberian asuhan keperawatan kepada perempuan sepanjang siklus reproduksi, termasuk selama masa pra kehamilan, kehamilan, persalinan, nifas, serta perawatan bayi baru lahir yang melibatkan pemantauan kesehatan ibu dan bayi, memberikan pendidikan dan dukungan kepada ibu, serta membantu dalam proses

persalinan dan pemulihan setelah melahirkan. Dalam keperawatan maternitas mencakup upaya preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif dalam meningkatkan kesehatan ibu dan bayi. Sebagai bagian integral dari pelayanan kesehatan, keperawatan maternitas berperan dalam menurunkan angka morbiditas dan mortalitas ibu serta bayi. Oleh karena itu, tenaga keperawatan di bidang ini harus memiliki kompetensi dalam memberikan asuhan yang aman, efektif, serta berbasis bukti ilmiah.

Keperawatan Maternitas adalah cabang spesialisasi dalam keperawatan yang berfokus pada perawatan perempuan selama masa kehamilan, persalinan, dan masa nifas (postpartum), serta perawatan bayi baru lahir. Dimana perawat maternitas bekerja sama dengan ibu hamil, ibu yang baru melahirkan, dan bayi untuk memastikan kesehatan dan keselamatan mereka selama proses kehamilan, persalinan, dan pemulihan setelah melahirkan. Keperawatan maternitas merupakan subsistem dari pelayanan kesehatan khususnya pelayanan keperawatan, dimana perawat berkolaborasi dg tenaga kesehatan lain dalam membantu klien dan keluarga beradaptasi terhadap masalah yang timbul selama periode perinatal dan di luar periode perinatal. Pelayanan keperawatan maternitas yang profesional ditujukan kepada perempuan usia subur yang berkaitan dengan reproduksi pada masa diluar kehamilan, masa kehamilan, masa melahirkan, masa nifas sampai dengan 6 mg dan bayi yg dilahirkan sampai usia 40 hr beserta keluarganya. Fokus dari pelayanan pekerawatan maternitas adalah pemenuhan kebutuhan dasar dengan pendekatan proses keperawatan dengan mengikutsertakan keluarga dalam pemberian asuhan keperawatan (family centered meternity nursing).

Keperawatan maternitas yaitu suatu pelayanan keperawatan professional yang berkualitas, difokuskan pada pemenuhan kebutuhan ibu dalam beradaptasi, baik secara fisik maupun psikososial pada masa kehamilan, melahirkan, nifas, dan keluarga dalam memberikan pelayanan. Selain itu Keperawatan maternitas merupakan suatu sistem pelayanan kesehatan, dimana perawat melibatkan keluarga dalam rangka membantu ibu beradaptasi pada masa prenatal, intranatal, dan postnatal, serta bayi baru lahir. Keperawatan maternitas merupakan bentuk pelayanan yang luas, berawal pada masa konsepsi sampai enam minggu pascamelahirkan. Bidang ini memegang peranan vital dalam tatanan kesehatan masyarakat global sebagai garda terdepan dalam upaya menekan angka kesakitan (morbiditas) serta angka kematian (mortalitas) ibu dan bayi yang masih menjadi tantangan besar di Indonesia.

Kebijakan asuhan maternitas didasarkan pada komitmen terhadap pelayanan yang berfokus pada perempuan untuk memastikan perempuan mengetahui pelayanan apa saja terkait kehamilan dan menerima pelayanan tersebut. Kebijakan

tersebut di lakukan dengan responsibilitas dan mengalokasikan perawatan yang sesuai, aman dan efektif berdasarkan identifikasi kebutuhan dan keadaan individu masing-masing.

B. Tujuan Keperawatan Maternitas

Adapun tujuan utama dari keperawatan maternitas diantaranya adalah (Susilawati et al., 2024):

- a. Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ibu dan bayi secara holistic dan berkelanjutan.
- b. Menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu dan bayi melalui deteksi dini dan intervensi yang tepat guna.
- c. Pemberian pelayanan keperawatan maternitas yang berkelanjutan (continuity of maternity care).
- d. Meningkatkan pengalaman persalinan yang positif dengan memastikan proses kelahiran menjadi momen yang memberdayakan dan manusiawi bagi setiap ibu.
- e. Mempromosikan kesehatan reproduksi sepanjang siklus kehidupan Perempuan, sebagai pondasi bagi kualitas hidup generasi mendatang.

C. Ruang Lingkup Keperawatan Maternitas

Ruang lingkup keperawatan maternitas mencakup asuhan keperawatan yang komprehensif bagi Perempuan sepanjang siklus reproduksinya serta perawatan bayi baru lahir. Fokus utamanya adalah pada pemenuhan kebutuhan fisik dan psikososial melalui pendekatan holistik dan berkelanjutan serta berpusat pada keluarga.

Berikut adalah rincian ruang lingkup keperawatan maternitas diantaranya adalah:

1. Asuhan Keperawatan pada Kehamilan (Antenatal Care): Meliputi pemberian edukasi dan pemantauan kesehatan ibu hamil dan janin secara berkala, pemberian edukasi nutrisi, deteksi dini risiko atau komplikasi kehamilan, serta persiapan fisik dan psikologis menjelang persalinan.
2. Asuhan Keperawatan pada Persalinan (Intranatal Care): Fokus pada pemantauan kemajuan persalinan, manajemen nyeri persalinan (baik farmakologis maupun non-farmakologis), pendampingan teknik pernapasan, serta pemberian dukungan emosional untuk memastikan proses kelahiran yang aman dan nyaman bagi ibu dan bayi.
3. Asuhan Keperawatan pada Masa Nifas (Postnatal Care): Mencakup pemantauan pemulihan fisik ibu setelah melahirkan (involusi uterus, penyembuhan luka

perineum), manajemen laktasi atau pemberian ASI, serta dukungan psikologis untuk mencegah gangguan seperti *baby blues* atau depresi postpartum.

4. Perawatan Bayi Baru Lahir (Neonatus): Meliputi penilaian kondisi awal bayi (skor APGAR), pemantauan tanda-tanda vital, perawatan tali pusat, inisiasi menyusui dini (IMD), serta pemberian imunisasi awal.
5. Kesehatan Reproduksi: Memberikan asuhan keperawatan dan edukasi terkait kesehatan organ reproduksi perempuan di sepanjang siklus kehidupannya, termasuk masalah gangguan reproduksi, infertilitas, dan kesehatan seksual.
6. Keluarga Berencana (KB): Meliputi pemberian konseling mengenai berbagai metode kontrasepsi, pengaturan jarak kelahiran, serta edukasi mengenai kesehatan reproduksi untuk membantu keluarga mencapai kesejahteraan.
7. Penanganan Komplikasi: Mengidentifikasi dan memberikan intervensi pada kasus-kasus risiko tinggi atau komplikasi, seperti preeklamsia, perdarahan pasca-persalinan, infeksi masa nifas, hingga perawatan khusus bagi bayi dengan berat lahir rendah (BBLR).
8. Aspek Psikososial, Etika, dan Legal: Memberikan dukungan emosional, konseling, dan advokasi bagi hak-hak pasien, serta memastikan praktik keperawatan dilakukan sesuai dengan standar etika dan hukum yang berlaku.
9. Peran Komunitas: Melibatkan edukasi kesehatan masyarakat mengenai pentingnya asuhan pranatal, persalinan yang aman di fasilitas kesehatan, serta pelayanan perawatan di rumah (*home care/home nursing*) untuk mendukung kemandirian ibu dan keluarga.

Secara keseluruhan, ruang lingkup ini bertujuan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan ibu dan bayi, menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB), serta menciptakan pengalaman kehamilan, persalinan dan masa nifas yang positif.

D. Perspektik Keperawatan Maternitas

Perspektif keperawatan maternitas mencerminkan perkembangan ilmu dan praktik keperawatan yang bertujuan memberikan asuhan keperawatan yang komprehensif dan berkelanjutan bagi ibu dan bayi. Perspektif ini membentuk cara pandang perawat agar tetap dinamis, kritis, dan responsif terhadap perubahan kebutuhan kesehatan ibu dan anak di era modern dan menjadi landasan bagi perawat dalam memahami peran mereka serta cara memberikan pelayanan yang optimal. Berikut adalah perspektif utama dalam keperawatan maternitas antara lain:

1. Perspektif Holistik: Asuhan maternitas tidak hanya berfokus pada aspek fisik semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek psikologis, sosial, budaya, dan

spiritual ibu serta bayi,. Perawat memastikan kesejahteraan pasien secara keseluruhan dengan memperhatikan seluruh dimensi tersebut.

2. Perspektif Berpusat pada Keluarga (*Family-Centered Maternity Care*): Memandang kehamilan, persalinan, dan perawatan bayi sebagai pengalaman hidup keluarga yang signifikan. Perspektif ini menekankan keterlibatan aktif pasangan dan anggota keluarga lainnya dalam proses pengambilan keputusan serta pemberian dukungan emosional kepada ibu. Asosiasi Pendidikan Persalinan Internasional (ICEA) menyatakan bahwa perawatan persalinan yang berpusat pada keluarga adalah dasar dari perawatan persalinan fisiologis normal. Lebih lanjut, perawatan persalinan yang berpusat pada keluarga dapat dilakukan di lingkungan persalinan mana pun: rumah, pusat persalinan, rumah sakit, atau bahkan dalam situasi darurat. Singkatnya, perawatan persalinan yang berpusat pada keluarga menghormati unit keluarga dengan mendukung perkembangan fisik dan psikososialnya dengan perawatan individual yang berbasis bukti.
3. Perspektif Keperawatan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Practice*): Menekankan bahwa setiap keputusan klinis dan intervensi keperawatan harus didasarkan pada penelitian ilmiah terbaru dan praktik terbaik yang terus diperbarui untuk menjamin keamanan serta efektivitas asuhan,,.
4. Perspektif Kesehatan Masyarakat: Keperawatan maternitas tidak hanya terfokus pada individu di rumah sakit, tetapi juga pada upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Ini mencakup program edukasi, intervensi berbasis komunitas, serta identifikasi determinan sosial untuk menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB),.
5. Perspektif Pencegahan dan Promosi Kesehatan: Fokus pada pemberian edukasi mengenai nutrisi, olahraga, perawatan pranatal, dan praktik kesehatan yang aman untuk mencegah timbulnya komplikasi selama masa kehamilan dan setelah melahirkan,,.
6. Perspektif Historis: Mencakup pemahaman tentang bagaimana asuhan maternitas telah berkembang dari model tradisional berbasis kebidanan menuju pendekatan modern yang lebih terintegrasi dengan kemajuan teknologi dan sains.
7. Perspektif Kolaboratif: Mengutamakan kerja sama yang erat antara perawat, bidan, dokter kandungan, ahli gizi, dan profesional kesehatan lainnya untuk menyediakan perawatan yang terkoordinasi dan terpadu bagi ibu dan bayi,.
8. Humanistik, Empati dan Dukungan Emosional: mengutamakan empati dan penghormatan terhadap hak serta martabat ibu dan bayi serta Menitikberatkan pada pemberian dukungan psikologis kepada ibu dan keluarganya guna

membantu mereka mengatasi stres, kecemasan, atau tantangan mental lainnya selama transisi menjadi orang tua.

E. Falsafah Keperawatan Maternitas

Falsafah keperawatan maternitas merupakan kerangka kerja untuk praktik keperawatan yang etis, efektif, dan berpusat pada pasien. Falsafah ini berakar pada prinsip dasar keperawatan yang menempatkan ibu dan bayi sebagai pusat pelayanan guna memberikan asuhan keperawatan berkelanjutan (*continuity of nursing care*) yang berkualitas bagi kesejahteraan ibu, bayi, dan keluarga.

Adapun elemen-elemen kunci dalam falsafah keperawatan maternitas meliputi:

1. Penghargaan Terhadap Kehidupan: Menghormati dan menghargai kehidupan dalam segala bentuknya, termasuk memandang proses kehamilan dan persalinan sebagai pengalaman alami yang signifikan bagi seorang wanita.
2. Kemanusiaan dan Martabat: Ibu dan bayi memiliki hak atas pelayanan yang bermartabat, penuh empati, serta menghormati nilai-nilai budaya dan kepercayaan yang mereka anut.
3. Pendekatan Holistik: Asuhan keperawatan tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga sangat memperhatikan kesejahteraan psikologis, emosional, sosial, dan spiritual ibu serta bayi.
4. Pemberdayaan Ibu dan Keluarga: Keberhasilan asuhan sangat bergantung pada keterlibatan aktif ibu dan keluarga dalam proses perawatan serta pengambilan keputusan medis. Perawat bertujuan memberdayakan wanita agar merasa percaya diri dalam menjalani masa kehamilan hingga persalinan.
5. Asuhan Berbasis Bukti (*Evidence-Based Care*): Pelayanan keperawatan harus didasarkan pada penelitian ilmiah terkini dan praktik terbaik untuk meningkatkan kualitas serta keamanan asuhan bagi ibu dan bayi.
6. Pencegahan dan Promosi Kesehatan: Menekankan pada upaya preventif dan promotif melalui edukasi mengenai nutrisi, olahraga, dan praktik kesehatan yang aman guna meningkatkan kualitas hidup.
7. Keadilan dan Keadilan: Menegakkan prinsip keadilan dalam memberikan asuhan tanpa memandang perbedaan ras, agama, maupun status sosial-ekonomi.
8. Kehormatan dan Kerahasiaan: Menjaga privasi dan kerahasiaan informasi pasien merupakan prinsip dasar agar ibu dan keluarga merasa aman selama berinteraksi dengan tim kesehatan.

9. Kolaborasi Interdisipliner: Perawat bekerja sama secara terpadu dengan profesional kesehatan lainnya, seperti dokter, bidan, dan ahli gizi, untuk memastikan asuhan yang komprehensif.

F. Implikasi Falsafah dalam Praktik Keperawatan

Penerapan falsafah ini memengaruhi berbagai aspek praktik, di antaranya membimbing perawat dalam pengambilan keputusan klinis; membangun hubungan terapeutik perawat-klien yang didasarkan pada rasa hormat, kepercayaan dan empati; memberikan edukasi kesehatan yang relevan dan bermakna bagi Kesehatan ibu, bayi dan keluarga; serta melakukan advokasi untuk membela hak-hak ibu dan bayi serta memastikan akses ke layanan kesehatan yang berkualitas. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip falsafah keperawatan maternitas maka perawat maternitas dapat memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas dan berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan ibu, bayi, dan keluarga.

G. Etik Legal Keperawatan Maternitas

Etik Legal dalam keperawatan maternitas adalah prinsip-prinsip moral dan hukum yang mengatur perilaku perawat dalam memberikan asuhan keperawatan secara komprehensif dan berkelanjutan kepada ibu dan bayi. Pelayanan keperawatan maternitas dijalankan berdasarkan kerangka kerja yang etis, legal, dan profesional untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, kenyamanan dan kesejahteraan ibu, bayi, serta keluarganya. Aspek-aspek ini menjadi standar evaluasi dan perlindungan hukum bagi perawat dalam menjalankan praktiknya.

H. Prinsip Etika dalam Keperawatan Maternitas

Integritas seorang perawat maternitas bukan hanya dilihat dari kemampuannya melakukan tindakan teknis, melainkan dari kepatuhannya pada standar moral. Etika dalam bidang keperawatan maternitas berakar pada penghormatan terhadap kehidupan dan hak-hak pasien. Berikut beberapa aspek etik dalam keperawatan maternitas:

1. Otonomi: Perawat harus menghormati hak ibu untuk membuat keputusan tentang perawatan dirinya sendiri dan bayinya. Perawat menghormati pilihan ibu, seperti metode persalinan atau penggunaan pereda nyeri, dengan memberikan informasi yang akurat agar pasien dapat mengambil keputusan secara mandiri (*informed choice*).
2. Non-maleficence: Perawat harus tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan ibu dan bayi.

3. Beneficence: Perawat harus melakukan tindakan yang dapat memberikan manfaat bagi ibu dan bayi.
4. Justice: Menegakkan prinsip kesetaraan dalam memberikan asuhan tanpa diskriminasi berdasarkan ras, agama, atau status sosial-ekonomi. Perawat harus memberikan asuhan keperawatan yang adil dan tidak membeda-bedakan kepada semua ibu dan bayi.
5. Kerahasiaan: Menjaga privasi dan kerahasiaan informasi medis pasien merupakan kewajiban dasar untuk membangun kepercayaan. Perawat harus menjaga kerahasiaan data dan informasi tentang ibu dan bayi.
6. Informed consent: Perawat harus memperoleh persetujuan dari ibu sebelum melakukan tindakan keperawatan.
7. Kejujuran (veracity): menyampaikan kebenaran dengan jujur.
8. Menepati Janji (fidelity): perawat selayaknya untuk menepati janji yang telah diucapkan.
9. Dokumentasi: Perawat harus melakukan dokumentasi yang akurat dan lengkap tentang asuhan keperawatan yang diberikan.

I. Peran Perawat Maternitas

Perawat maternitas memiliki peran yang sangat vital dan luas, tidak hanya sebagai pelaksana tindakan keperawatan, tetapi juga sebagai pendukung holistik bagi ibu, bayi, dan keluarga di setiap tahapan siklus reproduksi. Berikut adalah peran utama perawat maternitas antara lain:

1. Pemberi Asuhan Keperawatan (Caregiver)

Perawat menyediakan asuhan keperawatan langsung yang komprehensif, mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial. Peran ini dilakukan sepanjang periode berikut:

- a. Prenatal (sebelum Kehamilan): Memberikan asuhan keperawatan sebelum kehamilan termasuk konseling perencanaan keluarga dan Pendidikan Kesehatan tentang nutrisi, gaya hidup sehat, kesehatan reproduksi.
- b. Antenatal (Kehamilan): Melakukan pemantauan kesehatan ibu dan janin (tekanan darah, berat badan, pertumbuhan janin) serta melakukan deteksi dini terhadap risiko komplikasi.
- c. Intranatal (Persalinan): Mendampingi ibu selama proses kelahiran, memberikan panduan teknik pernapasan dan relaksasi, serta memantau tanda-tanda vital untuk memastikan persalinan yang aman.
- d. Postnatal (Setelah Melahirkan): Memantau pemulihan fisik ibu, memberikan asuhan pada bayi baru lahir (imunisasi, pemantauan tanda vital), serta mendukung inisiasi menyusui dini (IMD).

2. Pendidik (Educator)

Perawat bertanggung jawab memberikan edukasi kesehatan kepada ibu dan keluarga mengenai pola makan sehat, tanda bahaya kehamilan, persiapan persalinan, perawatan bayi baru lahir, serta kesehatan reproduksi dan keluarga berencana. Tujuannya adalah agar klien yang semula tidak tahu menjadi tahu dan mampu melakukan perawatan mandiri.

3. Konselor (Counselor)

Perawat memberikan dukungan emosional dan psikologis guna membantu ibu dan keluarga mengatasi kecemasan, stres, atau depresi postpartum yang mungkin timbul selama transisi menjadi orang tua.

4. Advokat (Advocate)

Perawat bertindak untuk melindungi dan membela hak-hak ibu serta keluarganya dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Hal ini termasuk memastikan ibu mendapatkan informasi yang lengkap dan benar untuk mengambil keputusan medis yang tepat (*informed choice*).

5. Koordinator dan Kolaborator

Perawat mengoordinasikan berbagai layanan kesehatan yang dibutuhkan klien dengan tenaga kesehatan lain seperti dokter kandungan, bidan, dan ahli gizi. Mereka bekerja dalam tim interdisipliner untuk menyediakan perawatan yang terpadu dan melakukan rujukan jika ditemukan kasus risiko tinggi.

6. Peneliti (Researcher)

Perawat maternitas berpartisipasi dalam penelitian ilmiah untuk mengembangkan ilmu keperawatan, mengevaluasi praktik klinis, dan menggunakan temuan terbaru (*evidence-based practice*) guna meningkatkan kualitas asuhan bagi ibu dan bayi.

7. Peran dalam Komunitas

Di luar fasilitas rumah sakit, perawat maternitas berperan memberikan edukasi kesehatan masyarakat mengenai pentingnya asuhan pranatal dan melakukan kunjungan rumah (*home care/home nursing*) untuk memberikan dukungan lanjutan bagi ibu dan bayi di lingkungan keluarga.

8. Role Model dan Agen Perubahan

Perawat maternitas menjadi panutan baik bagi para ibu maupun teman sejawat dalam mempraktikkan asuhan yang berkualitas. Sebagai agen perubahan, perawat mendorong inovasi dan pengembangan dalam profesi keperawatan guna merespons tantangan kesehatan yang semakin kompleks.

Dalam menjalankan peran-peran tersebut, perawat maternitas juga memegang fungsi independen (mandiri dalam proses keperawatan), fungsi

dependen (pelaksanaan instruksi medis), dan fungsi interdependen (kerjasama tim)

J. Tren dan Isu Keperawatan Maternitas

Bidang keperawatan maternitas merupakan disiplin yang sangat dinamis dan terus berubah untuk merespons kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tuntutan sosial. Perawat maternitas dituntut untuk berpikir kritis, cepat dan cermat dalam mengidentifikasi berbagai tren (kecenderungan) serta isu terkini guna memberikan asuhan keperawatan yang berkualitas, aman, efektif, dan berbasis bukti.

K. Tren Keperawatan Maternitas

Tren merupakan gambaran atau informasi yang terjadi saat ini yang biasanya sedang populer dikalangan masyarakat. Tren mencerminkan arah perkembangan praktik keperawatan saat ini yang dipengaruhi oleh riset terbaru dan inovasi teknologi antara lain:

1. Praktik Berbasis Bukti (*Evidence-Based Practice*): Penggunaan data dan penelitian terbaru menjadi standar utama dalam memandu keputusan klinis untuk meningkatkan hasil kesehatan ibu dan bayi.
2. Kemajuan Teknologi dan Inovasi: Terjadi peningkatan penggunaan telehealth, telenursing dan telemedicine untuk konsultasi Kesehatan ibu dan bayi, serta penggunaan alat canggih seperti perangkat *wearable* dan aplikasi kesehatan untuk memantau kondisi janin serta ibu dari rumah.
3. Fokus pada Family-Centered Maternity Care (FCMC): Perawatan maternitas kini lebih menekankan pada pemberdayaan keluarga sebagai unit pendukung utama, yang terbukti meningkatkan *self-efficacy* ibu dan menurunkan risiko depresi postpartum.
4. Peningkatan Perhatian pada Kesehatan Mental: Fokus yang lebih besar diberikan pada deteksi dini dan penanganan gangguan psikologis seperti depresi pasca-persalinan dan kecemasan.
5. Pergeseran Metode dan Tempat Persalinan: Terjadi peningkatan signifikan pada persalinan melalui operasi Caesar dan induksi persalinan, persalinan waterbirt. Selain itu, persalinan telah bergeser dari rumah ke fasilitas kesehatan yang dibantu tenaga terampil.
6. Promosi Menyusui: Kesadaran akan pentingnya pemberian ASI eksklusif terus dipromosikan sebagai bagian integral dari asuhan nifas.

L. Isu Keperawatan Maternitas

Isu mencakup tantangan, hambatan, atau perdebatan yang masih dihadapi dalam pelayanan kesehatan maternitas diantaranya adalah:

1. Kesenjangan Akses Pelayanan Kesehatan: Masalah akses layanan yang tidak merata, terutama di daerah pedesaan atau komunitas yang kurang terlayani, serta ketidaksetaraan yang terkait dengan status sosial-ekonomi dan latar belakang etnis.
2. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) yang Masih Tinggi: Meskipun terjadi penurunan secara global, AKI dan AKB akibat komplikasi seperti preeklamsia, eklamsia, dan perdarahan masih menjadi tantangan besar, khususnya di negara berkembang.
3. Kekerasan terhadap Perempuan: Kekerasan fisik, psikologis, seksual, maupun ekonomi merupakan isu kesehatan serius yang berdampak pada kesehatan reproduksi dan kesejahteraan ibu hamil.
4. Pernikahan dini yang masih cukup tinggi: Hal ini terjadi sebagai akibat dari kurangnya akses Pendidikan dan layanan reproduksi, kemiskinan, budaya, dan ketimpangan gender.
5. Isu Legal dan Etik: Perawat maternitas menghadapi tanggung jawab hukum yang besar; ketidakmampuan memenuhi standar asuhan dapat berujung pada pertanggungjawaban hukum.
6. Masalah Gaya Hidup: Perilaku seperti merokok dan konsumsi alkohol selama kehamilan tetap menjadi isu penting karena risiko tinggi terhadap kelahiran prematur, bayi berat lahir rendah (BBLR), dan kematian janin.
7. Kesehatan Mental dan Stigma: Masih terdapat kekurangan dukungan psikologis yang memadai dan adanya stigma masyarakat yang menghambat ibu untuk mencari bantuan saat mengalami masalah mental postpartum.
8. Pengelolaan Sumber Daya: Beban kerja yang tinggi dan kurangnya tenaga keperawatan yang terlatih di bidang maternitas sering kali memengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan.

Perkembangan tren dan isu ini menuntut perawat maternitas untuk selalu meningkatkan dan memperbaharui pengetahuan dan keterampilannya guna menghadapi tantangan kesehatan ibu dan anak yang semakin kompleks.

M. Aplikasi Keselamatan Pasien dalam Keperawatan Maternitas

Keselamatan pasien dalam keperawatan maternitas berfokus pada pencegahan cedera, infeksi, dan kesalahan medis selama kehamilan, persalinan, dan nifas. Hal ini diwujudkan melalui identifikasi pasien dengan benar, komunikasi yang

efektif, manajemen obat, prosedur aman, serta pencegahan risiko jatuh. Penerapan *Respectful Maternity Care* (RMC) dan standar operasional yang berbasis bukti sangat penting untuk menjamin kualitas dan keamanan asuhan keperawatan maternitas yang diberikan.

Berikut adalah poin utama penerapan keselamatan pasien dalam keperawatan maternitas:

1. Enam Sasaran Keselamatan Pasien:
 - a. Identifikasi Pasien: Melakukan identifikasi terhadap identitas pasien (nama, tanggal lahir, alamat dan nomor rekam medis) sebelum melakukan tindakan (pemberian obat, darah, atau prosedur).
 - b. Komunikasi Efektif: Menggunakan teknik komunikasi yang efektif atau tehnik SBAR (Situation, Background, Assessment, Recommendation) saat operan pasien atau melapor ke dokter untuk mencegah miskomunikasi.
 - c. Keamanan Obat (High Alert): Kewaspadaan tinggi terhadap obat-obatan seperti oksitosin, magnesium sulfat, dan obat anestesi melalui Prosedur *double-check*.
 - d. Tepat Prosedur & Lokasi: Memastikan tindakan operasi Caesar atau tindakan kebidanan lain dilakukan pada pasien dan lokasi yang tepat.
 - e. Pencegahan Infeksi: Penerapan cuci tangan (hand hygiene) secara ketat, penggunaan APD, dan teknik aseptik saat persalinan.
 - f. Pengurangan Risiko Jatuh: Melakukan asesmen risiko jatuh pada ibu hamil dan bersalin, terutama pasca anestesi.
2. *Respectful Maternity Care* (RMC): Memberikan asuhan yang menghormati martabat, privasi, dan hak-hak ibu, serta non-diskriminatif.
3. Budaya Pelaporan Insiden: Melaporkan insiden seperti kejadian nyaris cedera (KNC) atau kejadian tidak diharapkan (KTD) untuk perbaikan layanan, bukan untuk menghukum.

N. Konsep Continuity Of Care dan Family Centered Maternity Care

Continuity of care (COC) adalah suatu proses di mana pasien dan tenaga kesehatan yang kooperatif terlibat dalam manajemen pelayanan kesehatan secara terus menerus menuju pelayanan yang berkualitas tinggi dengan biaya perawatan medis yang efektif. COC pada awalnya merupakan ciri dan tujuan utama pengobatan keluarga yang lebih menitikberatkan kepada kualitas pelayanan kepada pasien (keluarga). COC dapat membantu tenaga kesehatan untuk mendapatkan kepercayaan keluarga dan memungkinkan untuk menjadi advokat pasien. Kontinuitas perawatan berakar dari kemitraan pasien dan tenaga kesehatan dalam jangka panjang di mana tenaga kesehatan tahu riwayat pasien dari pengalamannya

dan dapat mengintegrasikan informasi baru serta dapat mengambil tindakan yang efisien tanpa penyelidikan mendalam atau review catatan. Hubungan pelayanan kontinuitas adalah hubungan terapeutik antara perempuan dan petugas kesehatan khususnya perawat dalam mengalokasikan pelayanan serta pengetahuan secara komprehensif. Hubungan tersebut salah satunya dengan dukungan emosional dalam bentuk dorongan, pujian, kepastian, mendengarkan keluhan perempuan dan menyertai perempuan telah diakui sebagai komponen kunci perawatan intrapartum. Dukungan tenaga kesehatan tersebut mengarah pada pelayanan yang berpusat pada Perempuan.

Continuity Of Care (COC) merupakan proses ketika pasien dan penyedia (provider) layanan kesehatan terlibat secara kooperatif dalam manajemen asuhan kesehatan yang berkelanjutan menuju tujuan asuhan medis yang berkualitas tinggi dan biaya yang efektif (American Academy of Family Physicians) atau dapat diartikan "Sejauh mana layanan diterima sebagai bagian dari koordinasi dan suksesi kejadian yang tak terputus dan konsisten dengan kebutuhan asuhan medis pasien". Dalam CoC, alur atau kemajuan layanan kesehatan yang diterima oleh pasien dari satu penyedia ke penyedia lainnya, atau dari satu shift ke shift lainnya, atau dari satu disiplin ilmu ke disiplin ilmu lainnya dilakukan secara terintegrasi dalam layanan yang diberikan oleh penyedia layanan yang terlibat dalam memberikan asuhan kepada pasien. COC merupakan pelayanan yang tercapai ketika terjalinnya hubungan secara berkelanjutan. Asuhan yang berkesinambungan dilakukan dengan tujuan memberikan pelayanan secara menyeluruh dan berkualitas tinggi yang dapat di mulai dari masa prakonsepsi, awal kehamilan, selama kehamilan di setiap trimester, proses persalinan, perawatan BBL, hingga pasca persalinan.

Filosofi model COC menekankan pada kondisi alamiah yaitu membantu perempuan agar mampu melahirkan dengan intervensi minimal dan pemantauan fisik, kesehatan psikologis, spiritual dan sosial perempuan dan keluarga. Continuity Of Care memiliki tiga jenis pelayanan yaitu manajemen, informasi dan hubungan. Kesenambungan manajemen melibatkan komunikasi antar perempuan dan tenaga kesehatan. Kesenambungan informasi menyangkut ketersediaan waktu yang relevan. Kedua hal tersebut penting untuk mengatur dan memberikan pelayanan kebidanan. Pemberian informasi kepada perempuan memungkinkan dan memberdayakan mereka dalam melakukan perawatan untuk mereka sendiri dan muncul sebagai dimensi secara terus menerus sebagai informasi dan kemitraan. Perawatan berencana tidak hanya menopang tenaga kesehatan dalam mengkoordinasikan layanan komprehensif mereka tetapi juga menimbulkan rasa aman serta membuat keputusan bersama. Tidak semua pasien dapat mengasumsikan keaktifan perannya namun mereka dapat membuat akumulasi

pengetahuan dari hubungan yang berkesinambungan untuk bisa mengerti terhadap pelayanan yang mereka terima.

Para penyedia (provider) layanan kesehatan harus mengetahui tiga komponen kontinuitas antara lain kontinuitas informasi; kontinuitas relasional (hubungan antara penyedia dan pasien); dan kontinuitas manajemen klinis supaya mampu memberikan CoC yang benar kepada pasien. Ketiga komponen ini merupakan atribut yang terkait erat satu sama lainnya. Jika salah satu dari ketiga atribut CoC tersebut tidak dihadirkan, asuhan yang diberikan kepada pasien akan menjadi kurang berkualitas. Sebagai contoh jika penyedia yang hanya fokus pada manajemen klinis saja tanpa mempedulikan hubungan dengan pasien atau tanpa mempedulikan catatan informasi pasien. Secara lebih rinci, berikut uraian tentang ketiga komponen kontinuitas sebagai berikut:

1. Kontinuitas informasi

Kontinuitas informasi merupakan kesinambungan penggunaan informasi tentang kejadian dan keadaan pasien sebelumnya untuk memastikan apakah layanan saat ini sesuai dengan kondisi pasien atau tidak. Informasi merupakan benang merah yang menghubungkan layanan dari satu penyedia ke penyedia lainnya atau dari satu tindakan klinis ke tindakan klinis lainnya. Kontinuitas informasi ini menekankan pada ketersediaan dan penggunaan informasi mengenai kejadian dan keadaan sebelumnya, baik dalam bentuk kunjungan, hasil laboratorium, rekomendasi rujukan, layanan informal, dsb. Salah satu metode untuk pendokumentasian layanan yang telah diberikan kepada pasien adalah dengan 'catatan SOAP'; oleh karena itu, semua penyedia (misal bidan) seharusnya menguasai keterampilan pendokumentasian layanan klinis ini dengan benar. Informasi dapat berbasis kertas, elektronik, atau terdapat dalam ingatan penyedia yang harus secepatnya didokumentasikan. Transfer informasi pasien yang terdokumentasi dari satu penyedia ke penyedia lainnya menjembatani unsur-unsur layanan yang terpisah dari waktu ke waktu dan merupakan prasyarat untuk koordinasi layanan kesehatan.

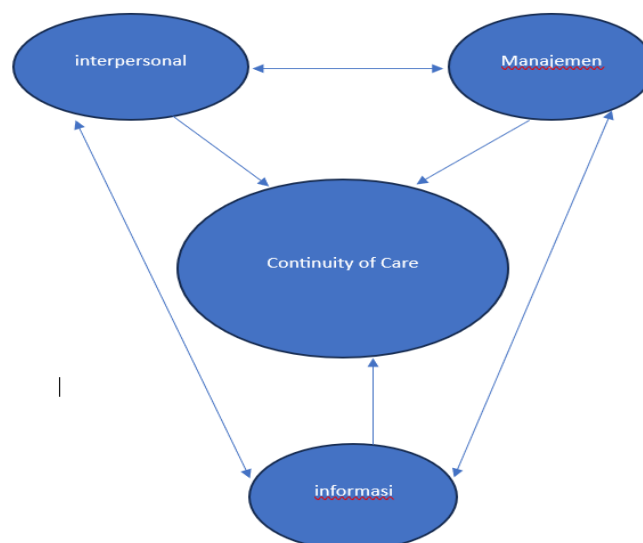
2. Kontinuitas relasional

Kontinuitas relasional mengacu pada hubungan yang berdasarkan komunikasi efektif (yang dapat berkembang menjadi hubungan sosial) yang berkelanjutan antara pasien dan satu penyedia layanan atau lebih. Kontinuitas relasional biasanya diukur dengan menggunakan afiliasi (hubungan) antara pasien dan penyedia, misal, pasien akan mengklaim 'bidan saya' dengan yakin karena memiliki keterikatan hubungan dengan bidan tersebut. Kontinuitas relasional menyatakan bahwa kontak yang berkelanjutan antara pasien dan penyedia adalah dasar yang menghubungkan layanan kesehatan dari waktu ke

waktu. Kontinuitas relasional sering dinyatakan sebagai loyalitas atau kesetiaan pasien karena sebagian besar kunjungan dilakukan atas inisiatif pasien, yang membuat pasien menjadi agen utama kontinuitas relasional. Namun demikian, penyedia juga seharusnya memandang diri mereka sebagai agen utama kontinuitas yang: 1) menjaga kontak dengan pasien; 2) memantau kemajuan mereka; dan 3) mengajak mereka kembali ke layanan tindakan klinis bila diperlukan. Oleh karena itu, kontinuitas relasional ini sangat berhubungan dengan keterampilan komunikasi dan kompetensi klinis penyedia kesehatan sehingga pasien akan selalu merasa nyaman dengan asuhan yang diterimanya. Dengan memiliki keterampilan komunikasi yang baik, penyedia akan mampu melakukan asuhannya dengan baik pula.

3. Kontinuitas manajemen klinis

Kurangnya integrasi layanan kesehatan dianggap sebagai salah satu penyebab utama buruknya kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Tindakan klinis yang terpecah (*fragmented care*), atau tindakan yang tidak terkoordinasi dengan baik antar penyedia, mungkin berbahaya bagi pasien karena hal-hal berikut dimungkinkan akan terjadi: a. duplikasi tes diagnostik; b. poliklinik yang tidak tepat; dan c. rencana tindakan yang saling bertentangan. Kontinuitas manajemen mengacu pada penyediaan layanan yang saling melengkapi dan tepat waktu dalam rencana manajemen bersama. Langkahlangkah kontinuitas manajemen berfokus pada penyampaian satu aspek tindakan klinis dalam rangkaian rencana manajemen, sehingga manajemen klinis akan dapat dilihat dari siapa yang memberikan layanan.



Gambar 1. 1 Konsep Model Continuity of Care

Sumber: Beadles, Voils, Crowley, Farley, Maciejewski, 2014

Continuity of Care (COC) dalam keperawatan maternitas adalah pendekatan yang memastikan konsistensi dan keterhubungan dalam pemberian pelayanan keperawatan kepada ibu hamil, ibu yang melahirkan, ibu nifas dan bayi beserta keluarganya. Pendekatan ini bertujuan untuk menyediakan perawatan yang berkelanjutan dan tidak terputus sejak awal kehamilan, selama persalinan, hingga masa postpartum. Continuity of Care (CoC) atau asuhan berkelanjutan dalam keperawatan maternitas adalah model pelayanan yang memberikan asuhan secara komprehensif dan berkesinambungan kepada ibu dan bayi sepanjang siklus kehidupan Perempuan. Hubungan dalam pelayanan berkelanjutan adalah hubungan terapeutik antara perempuan dengan perawat atau petugas kesehatan dalam mengalokasikan pelayanan serta pengetahuan secara komprehensif. Salah satunya bentuk hubungan tersebut adalah dengan pemberian dukungan emosional dalam bentuk dorongan, pujian, kepastian, mendengarkan keluhan perempuan dan menyertai perempuan telah diakui sebagai komponen kunci perawatan intrapartum. Dukungan tersebut mengarah pada pelayanan yang berpusat pada Perempuan.

Penelitian di Denmark menemukan bahwa dengan continuity of care mendapatkan pengalaman yang lebih baik, mengurangi morbiditas maternal, mengurangi penggunaan intervensi pada saat persalinan termasuk operasi Caesar, meningkatkan jumlah persalinan normal dibandingkan dengan perempuan yang merencanakan persalinan dengan Tindakan. Perempuan yang menerima pelayanan secara continuity of care dan pelayanan yang berfokus pada perempuan meliputi dukungan, partisipasi dalam pengambilan keputusan, perhatian terhadap psikologis, kebutuhan dan harapan pada saat akan melahirkan, informasi dan menghargai Perempuan. Continuity of care dalam pelayanan keperawatan maternitas dapat memberdayakan perempuan dan mempromosikan keikutsertaannya dalam pelayanan mereka juga meningkatkan pengawasan pada mereka sehingga perempuan merasa di hargai. Selain itu perawatan berkesinambungan dikaitkan dengan fakta bahwa perempuan merasa lebih siap untuk melahirkan dan lebih percaya diri untuk menjalani proses persalinan secara positif. Perempuan yang menjalani pelayanan kebidanan secara continuity of care secara langsung akan menerima informasi yang dibutuhkan, memiliki rasa percaya diri yang tinggi, dan merasa aman dan nyaman pada saat menjalani perawatan serta memiliki hubungan dengan tenaga kesehatan yang terpercaya secara berkesinambungan.

Beberapa elemen kunci dari Continuity of Care dalam keperawatan maternitas antara lain:

1. Konsistensi Perawatan: Perawatan diberikan oleh tim atau individu yang sama sepanjang periode maternitas, sehingga ibu dan keluarganya bisa mengembangkan hubungan yang kuat dengan penyedia layanan kesehatan. Ini

mencakup perawat, bidan, atau dokter yang terus terlibat selama seluruh proses kehamilan, persalinan, dan setelahnya.

2. Komunikasi Efektif: Dalam pendekatan ini, komunikasi yang baik antara ibu dan penyedia layanan kesehatan sangat ditekankan. Semua informasi penting mengenai kondisi kesehatan ibu dan bayi, preferensi ibu, serta rencana perawatan dibagikan secara efektif antara semua pihak yang terlibat.
3. Koordinasi Layanan: Layanan yang diberikan diintegrasikan dan dikoordinasikan dengan baik antara berbagai penyedia layanan kesehatan. Ini termasuk perawatan prenatal, layanan intranatal, postnatal dan bayi baru lahir beserta keluarganya.

Dalam pengaturan perawatan ibu dan bayi baru lahir, kontinuitas perawatan yang dipimpin oleh perawat maternitas mengacu pada model di mana perawatan diberikan oleh perawat yang sama, atau tim kecil, selama kehamilan, persalinan dan kelahiran, serta periode pasca persalinan dengan rujukan ke perawatan spesialis jika diperlukan. Model perawatan berkelanjutan di sejumlah kecil negara berpenghasilan tinggi telah dikaitkan dengan angka kelahiran prematur yang lebih rendah (penurunan 24%), dan angka kehilangan janin yang lebih rendah sebelum dan sesudah 24 minggu serta kematian neonatal (16%), serta kemungkinan kehilangan bayi secara keseluruhan lebih rendah (penurunan gabungan kehilangan janin dan kematian neonatal) untuk wanita dengan risiko komplikasi rendah dibandingkan dengan model perawatan lainnya. Selain itu, wanita cenderung lebih jarang mengalami intervensi dan lebih mungkin melaporkan pengalaman perawatan yang positif, mengurangi kelahiran prematur dan kematian perinatal. Ibu lebih menyukai pengalaman personal yang diberikan oleh model tersebut, yang mengarah pada kepercayaan antara perawat maternitas dan perempuan serta pemberdayaan Perempuan dan perawat maternitas.

Continuity of care dalam pelayanan kebidanan dapat memberdayakan perempuan dan mempromosikan keikutsertaan dalam pelayanan mereka juga meningkatkan pengawasan pada mereka sehingga perempuan merasa di hargai. Continuity of Care merupakan isu yang sangat penting bagi perempuan karena memberi kontribusi rasa aman dan nyaman bagi mereka selama kehamilan, persalinan dan nifas. Selain itu pelayanan kebidanan secara Continuity of Care berkontribusi pada peningkatan kualitas dan keselamatan pada saat partus. Perempuan yang mendapatkan pelayanan tersebut lebih cenderung menerima pelayanan yang efektif, pengalaman yang lebih efisien, hasil klinis yang lebih bermutu dan beberapa bukti dapat meningkatkan akses pelayanan yang sulit dicapai serta koordinasi yang lebih bermanfaat.

Selain Continuity of care dalam pelayanan keperawatan maternitas juga mengimplementasikan konsep tentang Family Centered Maternity Care (FCMC) yang merupakan sebuah model pendekatan dalam pelayanan keperawatan maternitas yang menempatkan keluarga sebagai pusat utama dari proses perawatan selama kehamilan, persalinan, dan postpartum. Tujuan utama dari FCMC adalah keterlibatan keluarga dalam memberikan dukungan dan motivasi kepada ibu selama kehamilan, persalinan dan masa nifas. Dalam FCMC melibatkan dan mendorong seluruh anggota keluarga berpartisipasi secara aktif dalam semua aspek perawatan ibu dan bayi. Pendekatan ini menekankan kerja sama antara tenaga kesehatan, ibu, dan keluarga dalam pengambilan keputusan serta pemberian perawatan. Keterlibatan keluarga terbukti dapat meningkatkan kenyamanan ibu, mempercepat pemulihan, mengurangi kecemasan, serta meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan bayi.

Integrasi Continuity of Care dengan Family Centered Maternity Care (FCMC) dalam praktik keperawatan maternitas modern yang saling melengkapi dapat menciptakan pengalaman kehamilan, persalinan dan masa nifas yang aman, nyaman, dan holistic. Secara rinci terkait focus utama, sasaran, tujuan serta implementasi dari COC dan FCMC dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 1. 1 Perbedaan Continuity of Care dengan Family Centered Maternity Care

Komponen	Continuity Of Care	Family Centered Maternity Care
Fokus Utama	Waktu, kesinambungan pelayanan, dan tenaga Kesehatan	Keterlibatan keluarga dan pengambilan keputusan Bersama
Sasaran	Ibu hamil hingga masa nifas (6 minggu pascapersalinan).	Ibu, bayi yang baru lahir, dan lingkungan keluarga terdekat (seperti suami atau orang tua).
Tujuan	Memastikan ibu mendapatkan perawatan yang terintegrasi, mengurangi risiko komplikasi, serta membangun ikatan saling percaya dengan satu tim perawat yang sama sejak awal hingga akhir masa kehamilan, persalinan dan masa nifas.	Menghargai dinamika budaya dan kekuatan keluarga, memberikan dukungan emosional bagi ibu, serta memberdayakan keluarga dalam proses persalinan dan perawatan bayi.

Penerapan	Pemantauan berkala mulai dari pemeriksaan kehamilan (antenatal), pertolongan persalinan (intranatal), hingga kunjungan rumah masa nifas (postnatal) oleh tenaga profesional yang sama.	Memfasilitasi suami untuk mendampingi saat proses persalinan, memberikan edukasi perawatan bayi baru lahir kepada keluarga, serta mengizinkan rawat gabung (<i>rooming-in</i>) di rumah sakit
------------------	--	---

O. RINGKASAN

Bab ini menekankan bahwa keperawatan maternitas yang berfokus pada asuhan keperawatan profesional bagi ibu dan bayi mulai dari masa pra kehamilan, kehamilan hingga pascapersalinan, bayi baru lahir beserta keluarga. Materi tersebut menyoroti pentingnya pendekatan Family-Centered Maternity Care (FCMC) yang melibatkan keluarga secara aktif untuk meningkatkan kesehatan mental serta fisik ibu. Selain membahas peran perawat sebagai pendidik, advokat, dan pelaksana klinis, teks ini juga mengidentifikasi berbagai tren global seperti peningkatan persalinan sesar dan upaya penurunan angka kematian ibudan bayi. Penjelasan tersebut turut mencakup aspek legal dan etika yang menjadi landasan praktik medis guna menjamin kualitas pelayanan yang aman. Secara keseluruhan, literatur ini menekankan strategi inovatif untuk mengatasi tantangan budaya dan keterbatasan fasilitas demi mengoptimalkan kesejahteraan keluarga.

Continuity of Care (CoC) atau asuhan berkelanjutan dalam keperawatan maternitas adalah model pelayanan yang memberikan asuhan secara komprehensif dan berkesinambungan kepada ibu dan bayi sepanjang siklus kehidupan Perempuan. Continuity of Care (COC) dalam keperawatan maternitas merupakan pendekatan yang memastikan konsistensi dan keterhubungan dalam pemberian pelayanan keperawatan kepada ibu hamil, ibu yang melahirkan, ibu nifas dan bayi beserta keluarganya. Pendekatan ini bertujuan untuk menyediakan perawatan yang berkelanjutan dan tidak terputus sejak awal kehamilan, selama persalinan, hingga masa postpartum. Hubungan dalam pelayanan berkelanjutan adalah hubungan terapeutik antara perempuan dengan perawat atau petugas kesehatan dalam mengalokasikan pelayanan serta pengetahuan secara komprehensif. Salah satunya bentuk hubungan tersebut adalah dengan pemberian dukungan emosional dalam bentuk dorongan, pujian, kepastian, mendengarkan keluhan perempuan dan menyertai perempuan telah diakui sebagai komponen kunci perawatan intrapartum. Dukungan tersebut mengarah pada pelayanan yang berpusat pada Perempuan.

Continuity of care dalam pelayanan keperawatan maternitas dapat memberdayakan perempuan dan mempromosikan keikutsertaan dalam pelayanan mereka juga meningkatkan pengawasan pada mereka sehingga perempuan merasa di hargai. Continuity of Care merupakan isu yang sangat penting bagi perempuan karena memberi kontribusi rasa aman dan nyaman bagi mereka selama kehamilan, persalinan dan nifas. Selain itu Continuity of Care berkontribusi pada peningkatan kualitas dan keselamatan pada saat partus. Perempuan yang mendapatkan pelayanan tersebut lebih cenderung menerima pelayanan yang efektif, pengalaman yang lebih efisien, hasil klinis yang lebih bermutu dan beberapa bukti dapat meningkatkan akses pelayanan yang sulit dicapai serta koordinasi yang lebih bermanfaat.

P. MINI CASE

Seorang perempuan, umur 37 tahun, P3A0 dirawat di ruang nifas dengan perdarahan post partum. Pasien mengatakan banyak keluar darah dari jalan lahir, badan lemas, dan mata berkunang. Hasil Pengkajian: pasien tampak lemah dan pucat, turgor kurang, mukosa kering, rahim teraba lembek, kandung kemih penuh, TD 90/60 mm Hg, frekwensi nafas 21x/menit dan nadi 110 x/menit. Perawat melakukan pengosongan urin dan masase uterus.

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi

1. Apa prinsip etik yang diterapkan oleh perawat pada kasus tersebut?
2. Apa peran perawat maternitas pada kasus tersebut?
3. Bagaimana penerapan Continuity of care (COC) pada kasus tersebut?
4. Bagaimana penerapan pasien

Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

Soal Multiple Choice:

1. Apa yang menjadi fokus utama dalam keperawatan maternitas?
 - a. Asuhan keperawatan pada Perempuan disepanjang siklus reproduksi, termasuk kehamilan, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir
 - b. Asuhan keperawatan pada Perempuan dengan penyakit kronis disepanjang siklus kehidupan Perempuan.
 - c. Perawatan paliatif pada Perempuan dengan keganasan pada system reproduksi
 - d. Manajemen perawatan pada ibu dengan masalah Kesehatan reproduksi
 - e. Asuhan keperawatan pada ibu dengan penyakit menular seksual

2. Salah satu perspektif dalam keperawatan maternitas yang menekankan bahwa setiap keputusan klinis dan intervensi keperawatan harus didasarkan pada penelitian ilmiah terbaru dan praktik terbaik Adalah....
 - a. Perspektif Holistik
 - b. Perspektif Historis
 - c. Perspektif Berbasis Keluarga
 - d. Perspektif Kesehatan Masyarakat
 - e. Perspektif Keperawatan Berbasis Bukti
3. Fokus keselamatan pasien dalam asuhan keperawatan maternitas Adalah....
 - a. Pencegahan terjadinya kejadian yang tidak diinginkan selama ibu hamil dan melahirkan serta nifas
 - b. Pencegahan cedera, infeksi, dan kesalahan medis selama kehamilan, persalinan, dan nifas
 - c. Pencegahan infeksi selama ibu dirawat karena kehamilan, persalinan dan nifas
 - d. Penatalaksanaan komplikasi dalam kehamilan, persalinan dan post partum
 - e. Pemberian asuhan keperawatan berbasis bukti
4. Seorang ibu hamil memiliki hak untuk menentukan sendiri keputusan terkait rencana asuhan keperawatan dan tindakan medis yang akan dilakukan terhadap dirinya sesuai dengan harkat dan martabatnya. Dalam etika keperawatan maternitas, prinsip ini disebut.....
 - a. *Beneficence*
 - b. *Autonomy*
 - c. *Justice*
 - d. *Veracity*
 - e. *Fidelity*
5. Perawat maternitas memiliki peran untuk mengatur pelayanan kesehatan yang komprehensif dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai profesi kesehatan lainnya, seperti dokter kandungan, bidan, farmasis dan ahli gizi guna memberikan perawatan terbaik. Dalam hal ini, perawat sedang menjalankan perannya sebagai...
 - a. Pemberi Asuhan (*Caregiver*)
 - b. Pendidik (*Educator*)
 - c. Konselor (*Counselor*)
 - d. Koordinator (*Coordinator*)
 - e. Advokat (*Advocate*)

6. Penerapan *Family Centered Maternity Care* (FCMC) dan *Continuity of Care* (COC) merupakan model asuhan yang mendukung kesinambungan asuhan maternitas karena...
- Memisahkan perawatan ibu dan bayi setelah lahir.
 - Berfokus hanya pada tindakan medis saat persalinan
 - Membatasi kunjungan keluarga agar ibu dapat beristirahat total.
 - Menyerahkan seluruh tanggung jawab pengambilan keputusan kepada tim medis.
 - Mengintegrasikan perawatan selama kehamilan, persalinan, nifas, dan perawatan bayi baru lahir ke dalam siklus hidup keluarga.
7. Seorang perawat maternitas memberikan edukasi pada ibu hamil mengenai tanda bahaya kehamilan selama kunjungan ANC dan melanjutkan pemantauan saat ibu tersebut masuk ke ruang persalinan serta masa nifas. Hal ini mencerminkan ruang lingkup keperawatan maternitas yang berfokus pada...
- Asuhan keperawatan kepada perempuan sepanjang siklus reproduksinya.
 - Asuhan sayang ibu selama kehamilan, persalinan dan nifas
 - Pemberian obat-obatan rutin sesuai instruksi dokter.
 - Perawatan ibu post partum dan bayi baru lahir.
 - Pelayanan kesehatan ibu berbasis komunitas.

Kunci Jawaban:

- A
- E
- B
- C
- D
- E
- A

Nama Mahasiswa : _____
 NIM : _____
 Tanggal : _____
 Tempat Praktik/Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian keperawatan maternitas	☐	☐	
2	Saya sudah bisa menjelaskan tentang tujuan keperawatan maternitas	☐	☐	
3	Saya sudah bisa menjelaskan tentang ruang lingkup keperawatan maternitas	☐	☐	
4	Saya sudah bisa menjelaskan tentang perspektif keperawatan maternitas	☐	☐	
5	Saya sudah bisa menjelaskan tentang falsafah keperawatan maternitas	☐	☐	
6	Saya sudah bisa menjelaskan tentang etik dan hukum dalam keperawatan maternitas	☐	☐	
7	Saya sudah bisa menjelaskan tentang peran perawat maternitas	☐	☐	
8	Saya sudah bisa menjelaskan tentang tren dan isu dalam keperawatan maternitas	☐	☐	
9	Saya sudah bisa menjelaskan tentang keselamatan pasien dalam keperawatan maternitas	☐	☐	
10	Saya sudah bisa menjelaskan tentang konsep continuity of care dalam keperawatan maternitas	☐	☐	
11	Saya sudah bisa menjelaskan tentang tujuan continuity of care dalam keperawatan maternitas	☐	☐	
12	Saya sudah bisa menjelaskan tentang manfaat continuity of care dalam keperawatan maternitas	☐	☐	
13	Saya sudah bisa menjelaskan tentang elemen kunci continuity of care dalam keperawatan maternitas	☐	☐	
14	Saya sudah bisa menjelaskan tentang model perawatan continuity of care dalam keperawatan maternitas	☐	☐	
15	Saya sudah bisa menjelaskan tentang jenis pelayanan continuity of care dalam keperawatan maternitas	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

Referensi

- Agustina S., Barokah L., Zolekhah D. 2022. Pengaruh continuity of care terhadap kehamilan. *Jurnal Midwifery Update (MU)* Volume 4 No. 2 <http://jurnalmu.poltekkes-mataram.ac.id/index.php/jurnalmu>
- Aisyaroh N. dkk. (2024). Keperawatan Maternitas. STIKES Banyuwangi. Banyuwangi.
- Ambarosi E, Mortari L. Women's experience of continuity of midwifery care in North-Eastern Italy: A qualitative study <https://www.europeanjournalofmidwifery.eu/pdf-159358-87698?filename=Women-s-experience-of-con.pdf>
- Australian College of Midwives (2017). Delivering midwifery continuity of care to Australian women: A handbook for hospitals and health services (3rd Edition). Australian College of Midwives: Canberra. <https://midwives.org.au/common/Uploaded%20files/Continuity%20of%20Care%20Handbook.pdf>
- Baart A. et all. 2024. Continuity of care as central theme in perinatal care: A systematic review <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0266613824003565#:~:text=Continuity%20of%20care%20is%20a,face%20of%20these%20growing%20challenges>
- Beadles, Voils, Crowley, Farley, Maciejewski. 2014. Continuity of medication management and continuity of care: Conceptual and operational considerations. SAGE Open Medicine. https://www.researchgate.net/figure/Conceptual-model-of-continuity-of-care-and-component-dimensions_fig1_285925118
- Bradford et all. 2022. Midwifery continuity of care: A scoping review of where, how, by whom and for whom?. PLOS Glob Public Health. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10021789/#sec001>
- Fitriyanti dkk. (2024). Buku Ajar Keperawatan Maternitas. Sonpedia Publishing Indonesia. Jambi.
- Herrien Y. 2024. *KEPERAWATAN MATERNITAS: INTEGRASI FAMILY-CENTERED MATERNITY CARE (FCMC) DAN CONTINUITY OF CARE (COC)*. EUREKA MEDIA <https://repository.penerbiteurka.com/media/publications/584403-keperawatan-maternitas-integrasi-family-3bb8b176.pdf>
- Lestari F.D. Hanum S.M.H. 2025. Continuity of Midwifery Care for Pregnancy, Childbirth, Postpartum, and Newborns : Kelanjutan Pelayanan Kebidanan untuk Kehamilan, Persalinan, Pasca Persalinan, dan Bayi Baru Lahir. *Indonesian Journal on Health Science and Medicine*. Vol 2 No 2 (2025):

October ISSN 3063-8186. Published by Universitas Muhammadiyah
Sidoarjo <https://ijhsm.umsida.ac.id/index.php/ijhsm/article/view/277>

Munthe J., Simbolon M., Adithya K.A., Damanik L.P. 2019. Buku Ajar Asuhan
Kebidanan Berkesinambungan. Trans Info Media. Jakarta

Natalia Putri Aricahyo, Dwi Izzati , Ivon Diah. 2025. The Importance of Continuity of
Care (COC) as a Support System During Pregnancy: a Case Report. *Jurnal
Eduhealth*. Volume 16, Number 03 2025
<https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/health/article/view/6949/5284>

Sandall J, Fernandez Turienzo C, Devane D, Soltani H, Gillespie P, Gates S, Jones LV,
Shennan AH, Rayment-Jones H. Cochrane Library Cochrane Database of
Systematic Reviews Midwife continuity of care models versus other
models of care for childbearing women (Review).
<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11005019/pdf/CD004667.pdf>

Sujianti1, Wilis Setyawati. 2025. Pemberian Asuhan Berkelanjutan (Continuity Of
Care/ COC) dari Masa Kehamilan sampai Keluarga Berencana. *Jurnal
Multidisiplin Ilmu*, 4(3), Tahun 2025e-ISSN: 2828-6863Page |
<https://koloni.or.id/index.php/koloni/article/view/739/652>

Susanti Ari dkk. 2018. Konsep Kesiambungan Asuhan Kebidanan. Nuha Medika.
Yogyakarta. <https://jurnal.htp.ac.id/index.php/jpkk/article/view/1324>

Wahyuni E.S. (2025). Buku Ajar Keperawatan Maternitas. Media Pustaka Indo.
Cilacap.

BAB 2

ASUHAN KEPERAWATAN PADA MASALAH UMUM KEHAMILAN

A. Pendahuluan

Kehamilan merupakan proses fisiologis yang dinamis dan membawa perubahan besar pada seluruh sistem tubuh wanita. Transformasi ini sering kali memicu berbagai ketidaknyamanan fisik dan psikologis yang spesifik di setiap tahapannya. Apabila tidak dikelola dengan baik, kondisi tersebut dapat memengaruhi kualitas hidup ibu dan kesejahteraan janin. Bab ini disusun untuk membekali calon perawat dengan kemampuan klinis dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengatasi masalah-masalah tersebut melalui pendekatan asuhan keperawatan yang komprehensif dan berbasis bukti (*Evidence-Based Practice*).

Capaian Pembelajaran (*Learning Outcomes*):

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep, peran, dan prinsip praktik keperawatan maternitas berorientasi kesinambungan asuhan, etik, dan keselamatan pasien.	CPMK-1, CPMK-7
CPL-2	Menguasai dasar biomedik terkait reproduksi perempuan serta adaptasi maternal–neonatal sebagai landasan keputusan keperawatan.	CPMK-2
CPL-3	Mampu melakukan pengkajian komprehensif dan menetapkan tingkat risiko pada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir.	CPMK-2, CPMK-3
CPL-4	Mampu merumuskan prioritas masalah dan menyusun rencana asuhan keperawatan maternitas berbasis standar dan bukti.	CPMK-3, CPMK-4
CPL-5	Mampu melaksanakan intervensi, edukasi, dan komunikasi terapeutik pada ibu–bayi–keluarga selama kehamilan sampai nifas.	CPMK-4, CPMK-5
CPL-6	Mampu melakukan deteksi dini, penatalaksanaan awal kegawatdaruratan, kolaborasi/rujukan, serta evaluasi–dokumentasi dan perencanaan pulang.	CPMK-5, CPMK-6, CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan ruang lingkup, peran, dan prinsip Continuity of Care serta keselamatan pasien dalam keperawatan maternitas.
CPMK-2	Menganalisis anatomi–fisiologi reproduksi perempuan dan adaptasi maternal–neonatal untuk mendukung keputusan keperawatan.
CPMK-3	Melakukan pengkajian komprehensif dan stratifikasi risiko pada kehamilan, persalinan, nifas, dan neonatus.
CPMK-4	Menyusun rencana asuhan keperawatan maternitas untuk kondisi fisiologis dan masalah umum dengan luaran terukur.
CPMK-5	Melaksanakan intervensi, edukasi, manajemen nyeri, serta dukungan psikososial–keluarga pada periode maternitas.
CPMK-6	Melakukan deteksi dini dan penatalaksanaan awal komplikasi/kegawatdaruratan maternal, serta koordinasi kolaborasi/rujukan.
CPMK-7	Melakukan evaluasi, dokumentasi, perencanaan pulang, dan perencanaan layanan kesehatan reproduksi pascapersalinan.

C. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 4. Asuhan Keperawatan pada Masalah Umum Kehamilan	4.1 Menyusun rencana asuhan untuk keluhan/masalah umum kehamilan dengan luaran dan intervensi spesifik.	4.2 Menetapkan kriteria evaluasi dan rencana edukasi self-care untuk pencegahan perburukan masalah.	CPMK-4	CPMK-3; CPMK-5

D. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis (MCQ/essay terstruktur)	Persentase jawaban benar pada blueprint konsep (ruang lingkup, CoC, keselamatan pasien)	10	Lembar jawaban ujian
CPMK-7	Portofolio klinik/proyek perencanaan pulang	Kelengkapan dokumentasi evaluasi; kelengkapan rencana pulang; kesesuaian rencana layanan reproduksi pascapersalinan	10	Portofolio; format dokumentasi & discharge plan

Rubrik CPMK-1 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Penguasaan konsep ruang lingkup & CoC (akurasi elemen kunci)	Akurat $\leq 50\%$ elemen kunci; banyak miskonsepsi.	Akurat 51–69% elemen kunci; masih ada kekeliruan istilah/relasi konsep.	Akurat 70–84% elemen kunci; penjelasan runtut.	Akurat $\geq 85\%$ elemen kunci; sintesis jelas dan konsisten.
1.2 Aplikasi prinsip keselamatan pasien & etik pada skenario maternitas	Identifikasi risiko & tindakan aman $\leq 50\%$; keputusan tidak sesuai prinsip.	Identifikasi 51–69%; tindakan aman ada namun belum lengkap.	Identifikasi 70–84%; keputusan aman dan sesuai prinsip pada sebagian besar situasi.	Identifikasi $\geq 85\%$; keputusan aman, preventif, dan argumentatif.

Rubrik CPMK-2 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Akurasi anatomi–fisiologi reproduksi (struktur–fungsi)	Ketepatan $\leq 50\%$; banyak salah konsep/relasi struktur–fungsi.	Ketepatan 51–69%; konsep dasar benar namun parsial.	Ketepatan 70–84%; relasi struktur–fungsi tepat dan logis.	Ketepatan $\geq 85\%$; integrasi konsep kuat dan konsisten.
2.2 Analisis adaptasi kehamilan & implikasi kebutuhan asuhan	Analisis tidak runtut; implikasi klinis tidak tepat ($\leq 50\%$ sesuai data).	Analisis cukup; implikasi masih umum (51–69% sesuai data).	Analisis baik; implikasi spesifik (70–84% sesuai data).	Analisis sangat baik; implikasi komprehensif & antisipatif ($\geq 85\%$ sesuai data).

Rubrik CPMK-3 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Kelengkapan data pengkajian (komponen inti)	Komponen terisi $\leq 50\%$; banyak data penting hilang/tidak valid.	Komponen terisi 51–69%; masih ada kekosongan data kunci.	Komponen terisi 70–84%; data kunci lengkap dan relevan.	Komponen terisi $\geq 85\%$; data sangat lengkap, terstruktur, dan konsisten.
3.2 Ketepatan stratifikasi risiko & prioritas masalah	Risiko & prioritas tepat $\leq 50\%$; tidak sesuai temuan.	Tepat 51–69%; prioritas masih kurang tajam.	Tepat 70–84%; prioritas jelas berbasis temuan.	Tepat $\geq 85\%$; prioritas sangat tepat disertai tindak lanjut yang terarah.

Rubrik CPMK-4 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Kesesuaian masalah–luaran–intervensi & keterukuran luaran	Kesesuaian $\leq 50\%$; luaran tidak terukur; intervensi tidak spesifik.	Kesesuaian 51–69%; luaran sebagian terukur; intervensi masih generik.	Kesesuaian 70–84%; luaran terukur; intervensi spesifik dan realistis.	Kesesuaian $\geq 85\%$; luaran sangat terukur; intervensi prioritatif dan tepat sasaran.
4.2 Rasional, prioritas, dan rencana evaluasi	Rasional lemah/absen; prioritas tidak jelas; evaluasi tidak terencana ($\leq 50\%$ memadai).	Rasional ada namun terbatas; prioritas cukup; evaluasi parsial (51–69%).	Rasional baik; prioritas jelas; evaluasi sesuai luaran (70–84%).	Rasional sangat kuat; prioritas tajam; evaluasi komprehensif & terjadwal ($\geq 85\%$).

Rubrik CPMK-5 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Ketepatan & keselamatan pelaksanaan intervensi keperawatan	Langkah benar/aman $\leq 50\%$; terdapat tindakan berisiko.	Langkah benar/aman 51–69%; ada kekurangan minor pada urutan/asepsis.	Langkah benar/aman 70–84%; pelaksanaan aman dan efektif.	Langkah benar/aman $\geq 85\%$; sangat terampil, efisien, dan konsisten aman.
5.2 Kualitas komunikasi terapeutik, edukasi, dan dukungan keluarga	Tujuan komunikasi tidak tercapai; pemahaman klien tidak terverifikasi ($\leq 50\%$).	Komunikasi cukup; edukasi disampaikan namun verifikasi terbatas (51–69%).	Komunikasi baik; edukasi relevan dengan verifikasi pemahaman (70–84%).	Komunikasi sangat baik; edukasi terstruktur dengan teach-back dan pelibatan keluarga optimal ($\geq 85\%$).

Rubrik CPMK-6 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Deteksi dini & keputusan prioritas stabilisasi awal kegawatdaruratan	Tanda bahaya terlewat; prioritas salah ($\leq 50\%$ keputusan tepat).	Tanda bahaya sebagian terdeteksi; prioritas	Deteksi cepat; prioritas stabilisasi tepat (70–84% tepat).	Deteksi sangat cepat; prioritas tepat & antisipatif ($\geq 85\%$ tepat).

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
		cukup (51–69% tepat).		
6.2 Koordinasi kolaborasi/rujukan & komunikasi tim	Kolaborasi/rujukan terlambat/tidak tepat; komunikasi tidak efektif ($\leq 50\%$ sesuai).	Kolaborasi ada namun belum sistematis; komunikasi cukup (51–69%).	Kolaborasi/rujukan tepat waktu; komunikasi jelas (70–84%).	Kolaborasi/rujukan sangat tepat; komunikasi terstruktur dan memastikan kesinambungan ($\geq 85\%$).

Rubrik CPMK-7 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kualitas evaluasi luaran & dokumentasi asuhan	Dokumentasi tidak lengkap; evaluasi tidak berbasis data ($\leq 50\%$ komponen terpenuhi).	Dokumentasi cukup; evaluasi masih umum (51–69%).	Dokumentasi lengkap; evaluasi sesuai luaran (70–84%).	Dokumentasi sangat lengkap & rapi; evaluasi analitis berbasis data ($\geq 85\%$).
7.2 Komprehensif perencanaan pulang & rencana layanan reproduksi pascapersalinan	Rencana tidak jelas/tidak individual; tanda bahaya/kontrol terlewat ($\leq 50\%$ komponen).	Rencana ada namun parsial; komponen kunci belum lengkap (51–69%).	Rencana komprehensif; mencakup kontrol & tanda bahaya; cukup individual (70–84%).	Rencana sangat komprehensif & individual berbasis risiko; mencakup koordinasi layanan lanjutan dan konseling reproduksi terstruktur ($\geq 85\%$).

Tujuan Buku:

Bab ini disusun dengan tujuan agar mahasiswa atau pembaca mampu memahami esensi Asuhan Keperawatan Maternitas secara komprehensif. Pembaca diharapkan tidak hanya menguasai konsep perubahan fisiologis, tetapi juga mampu mengaplikasikan Manajemen Asuhan Keperawatan yang terstandar (SDKI, SLKI, SIKI) dan berbasis bukti (*Evidence-Based Practice*) dalam mengelola berbagai respon klien di tatanan layanan kesehatan.

Sasaran Pembaca:

Buku ini ditujukan utama bagi mahasiswa keperawatan (D-III, Sarjana, dan Profesi Ners) yang sedang menempuh mata kuliah Keperawatan Maternitas. Selain itu, buku ini dirancang sebagai referensi aplikatif bagi rekan sejawat dosen dalam proses

pembelajaran, serta bagi praktisi keperawatan di tatanan layanan kesehatan yang ingin memperdalam implementasi asuhan keperawatan maternitas berbasis standar 3S (SDKI, SLKI, SIKI) dan bukti ilmiah terkini (*Evidence-Based Practice*).

Isi Buku:

Materi dalam bab ini disusun secara sistematis mengikuti perjalanan kehamilan ibu, yang disajikan melalui tiga model kasus utama dengan integrasi standar asuhan keperawatan nasional (3S) dan *Evidence-Based Practice* (EBP). Isi utama bab ini meliputi:

1. Masalah Umum Kehamilan Trimester I: Emesis Gravidarum

Berfokus pada adaptasi hormonal dan manajemen nutrisi awal. Pembahasan mencakup skenario kasus mual-muntah pagi hari, pengkajian tanda dehidrasi, penegakan diagnosis Nausea/Defisit Nutrisi, serta intervensi EBP berupa penggunaan terapi komplementer (ginger tea, Lemon, peppermint, aroma terapi) dan pengaturan pola makan. Dilengkapi dengan tabel *Red Flags* untuk mengenali Hyperemesis Gravidarum (HEG).

2. Masalah Umum Kehamilan Trimester II: Kram Kaki

Berfokus pada dinamika muskuloskeletal dan sirkulasi. Pembahasan mencakup pengkajian fokus untuk membedakan kram fisiologis dengan tanda-tanda *Deep Vein Thrombosis* (DVT). Intervensi ditekankan pada teknik dorsofleksi mandiri, latihan peregangan statis sebelum tidur, serta kecukupan asupan mineral (Magnesium/Kalsium).

3. Masalah Umum Kehamilan Trimester III: Nyeri Punggung Bawah

Berfokus pada perubahan pusat gravitasi akibat lordosis dan persiapan persalinan. Pembahasan meliputi pengkajian postur, penggunaan alat bantu (*maternity belt*), edukasi ergonomi, serta latihan *pelvic tilting*. Bagian ini juga memuat skrining tanda bahaya persalinan preterm atau preeklampsia.

4. Prosedur Keperawatan (SOP Terpilih)

Panduan praktis berupa Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mendukung kompetensi psikomotor mahasiswa, yang terdiri dari:

- a. SOP Manajemen Mual-Muntah Non-Farmakologis.
- b. SOP Teknik Dorsofleksi pada Kram Kaki.
- c. SOP Latihan *Pelvic Tilting* dan Postur Tubuh.

5. Evaluasi Capaian Pembelajaran (OBE)

Bagian akhir untuk mengukur ketercapaian kompetensi mahasiswa melalui:

- a. Evaluasi Kognitif: Kumpulan soal vignette MCQ untuk menguji analisis klinis.
- b. Evaluasi Psikomotor: Instrumen penilaian OSCE/DOPS.
- c. Evaluasi Afektif dan Refleksi: Checklist kemandirian mahasiswa dan refleksi mengenai *Patient Safety* pada setiap kasus.

Metode Pembelajaran:

Penyajian materi dalam bab ini menggunakan pendekatan *Student-Centered Learning* (SCL) dan *Case-Based Learning* (CBL) untuk memastikan ketercapaian kompetensi klinis yang terukur. Alur pembelajaran disusun sebagai berikut:

1. Tinjauan Fisiologis dan Etiologi (Kognitif Dasar): Mengupas tuntas mekanisme penyebab munculnya masalah pada setiap trimester agar mahasiswa memahami rasionalitas ilmiah di balik setiap keluhan fisik maupun psikologis.
2. Manajemen Asuhan Terintegrasi 3S dan EBP (Analisis Klinis): Penegakan diagnosis (SDKI), penentuan luaran (SLKI), dan aplikasi intervensi (SIKI) yang setiap tindakannya telah tervalidasi secara ilmiah melalui riset keperawatan terkini. Hal ini mencakup variasi intervensi komplementer seperti aromaterapi (lemon dan peppermint), terapi herbal (jahe), hingga teknik fisik (dorsofleksi dan pelvic tilting).
3. Analisis Kasus Model Representatif (Aplikasi Klinis): Pembelajaran difokuskan pada tiga kasus model utama (Emesis, Kram Kaki, dan Nyeri Punggung) untuk melatih kemampuan pengambilan keputusan klinis (*clinical decision making*) di setiap fase kehamilan.
4. Prosedur Psikomotor (*Skill Mastery*): Penyajian Standar Operasional Prosedur (SOP) terpilih untuk melatih keterampilan teknis mahasiswa dalam mengimplementasikan intervensi mandiri keperawatan secara aman dan benar.
5. Evaluasi Capaian Pembelajaran (*Outcome Evaluation*):
 - a. Evaluasi Kognitif: Uji analisis melalui soal vignet (*Vignette-Based MCQ*) untuk mengukur ketajaman logika berpikir sesuai standar Uji Kompetensi Nasional.
 - b. Evaluasi Psikomotor: Pengukuran keterampilan melalui instrumen OSCE/DOPS.
 - c. Refleksi Afektif: Penilaian diri (*self-assessment*) dan refleksi terhadap keselamatan pasien (*Patient Safety*) untuk membentuk karakter perawat yang empati dan bertanggung jawab.

Pendekatan Pembelajaran:

Bab ini menerapkan pendekatan pembelajaran aktif berbasis riset (*Research-Based Learning*) dan kasus (*Case-Based Learning*). Pembaca tidak hanya didorong untuk menghafal teori, tetapi aktif melakukan pemecahan masalah melalui:

1. Logika Berpikir Kritis (*Clinical Reasoning*): Mahasiswa ditantang untuk menganalisis data pengkajian pada tiga kasus model representatif guna membedakan respon fisiologis normal dari tanda bahaya (*Red Flags*).

2. Integrasi Standar Profesi (3S): Merumuskan rencana asuhan yang presisi dengan mensinergikan diagnosis (SDKI), luaran (SLKI), dan intervensi (SIKI) secara sistematis.
3. Aplikasi Bukti Ilmiah (*Evidence-Based Practice*): Mengintegrasikan hasil riset keperawatan terkini seperti efektivitas aromaterapi lemon, peppermint, dan teknik fisik lainnya ke dalam praktik klinis guna menjamin asuhan yang aman, efektif, dan berbasis data ilmiah.

Pedoman Penggunaan:

Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari bab ini, pembaca disarankan untuk mengikuti langkah-langkah belajar sebagai berikut:

1. Analisis Patofisiologi: Pahami kaitan erat antara perubahan fisiologis maternal dengan respon ketidaknyamanan yang muncul pada tiap trimester. Pemahaman "mengapa" masalah itu terjadi akan memudahkan pemilihan intervensi yang rasional.
2. Eksplorasi Kasus Model: Pelajari secara seksama tiga kasus model yang disajikan: Emesis Gravidarum (trimester I), Kram Kaki (trimester II), dan Nyeri Punggung Bawah (trimester III). Fokuslah pada bagaimana data pengkajian ditransformasikan secara sistematis menjadi diagnosis SDKI, luaran SLKI, dan intervensi SIKI.
3. Implementasi EBP: Perhatikan variasi tindakan mandiri perawat yang berbasis bukti (*Evidence-Based Practice*), mulai dari penggunaan aromaterapi, terapi herbal, hingga teknik mekanika tubuh yang tervalidasi secara ilmiah.
4. Praktik Mandiri (SOP): Gunakan bagian Prosedur Keperawatan (SOP) sebagai panduan langkah-demi-langkah saat melakukan tindakan mandiri keperawatan, baik di laboratorium maupun di lahan praktik.
5. Uji Analisis (*Vignette*): Kerjakan latihan soal berbasis vignette secara mandiri tanpa melihat kunci jawaban terlebih dahulu. Hal ini penting untuk mengukur ketajaman clinical reasoning dan kesiapan menghadapi Uji Kompetensi.
6. Glosarium: Merujuklah pada glosarium untuk memahami istilah teknis medis dan keperawatan guna menghindari ambiguitas dalam pendokumentasian asuhan.

Tujuan Instruksional:

Tujuan instruksional dari bab ini adalah agar pembelajar memperoleh pemahaman yang luas dan menyeluruh mengenai konsep dasar serta filosofi Asuhan Keperawatan Maternitas dalam mengelola berbagai respon fisik dan psikologis selama masa kehamilan. Secara khusus, bab ini bertujuan untuk:

1. Membangun Kerangka Berpikir Kritis (*Clinical Reasoning*)

Membekali pembelajar dengan kemampuan untuk mentransformasi fenomena perubahan fisiologis menjadi rencana asuhan yang komprehensif, mencakup pengkajian fokus dan stratifikasi risiko (Sesuai CPMK-3).

2. Integrasi Standar Profesi (3S)

Memastikan pembelajar mampu menyusun prioritas masalah dan mengaplikasikan standar nasional PPNI (SDKI, SLKI, SIKI) dengan luaran yang terukur (Sesuai CPMK-4).

3. Implementasi Praktik Berbasis Bukti (*Evidence-Based Practice*)

Mendorong pembelajar untuk mengintegrasikan bukti ilmiah terkini seperti aromaterapi lemon, peppermint, terapi jahe, hingga teknik fisik mekanika tubuh ke dalam intervensi mandiri (Sesuai CPMK-5).

4. Menjamin Keselamatan Pasien (*Patient Safety*)

Melatih pembelajar untuk melakukan skrining tanda bahaya (*Red Flags*) serta merencanakan edukasi self-care untuk pencegahan perburukan masalah (Sesuai Sub-CPMK 4.2).

Melalui pendekatan tiga kasus model representatif (Emesis Gravidarum, Kram Kaki, dan Nyeri Punggung Bawah), pembelajar diharapkan tidak hanya menguasai prosedur tindakan, tetapi juga memahami rasional ilmiah di balik setiap keputusan klinis yang diambil.

Uraian Materi

Bagian ini menyajikan Manajemen Asuhan Keperawatan secara komprehensif terhadap berbagai respon ketidaknyamanan yang lazim muncul selama masa kehamilan. Materi disusun secara sistematis untuk mencapai CPL-4 dan CPMK-4, dengan fokus pada transformasi data pengkajian menjadi keputusan klinis yang presisi.

Untuk memberikan gambaran klinis yang utuh dan mendalam, pembahasan difokuskan pada tiga kasus model representatif yang mewakili setiap fase kehamilan, yaitu Emesis Gravidarum (Trimester I), Kram Kaki (Trimester II), dan Nyeri Punggung Bawah (Trimester III). Pemilihan ketiga masalah ini didasarkan pada kompleksitas adaptasi fisiologis yang memerlukan intervensi keperawatan mandiri yang spesifik.

Setiap pembahasan masalah dikupas melalui alur proses keperawatan yang terintegrasi:

1. Analisis Pengkajian Fokus dan Stratifikasi Risiko (CMPK-3)

Mahasiswa diarahkan untuk mengidentifikasi data kunci dan melakukan stratifikasi risiko guna membedakan respon fisiologis normal dari tanda bahaya (*Red Flags*).

2. Penegakan Diagnosis Keperawatan mengacu pada Standar Diagnosa Keperawatan Indonesia (SDKI)

Menetapkan prioritas masalah berdasarkan label diagnosis keperawatan nasional.

3. Penetapan Luaran mengacu pada Standar Luaran Keperawatan Indonesia (SLKI) dan Penetapan Intervensi Keperawatan mengacu pada Standar Intervensi Keperawatan Indonesia (SIKI)

Menyusun rencana asuhan dengan target terukur dan intervensi yang aplikatif.

4. Integrasi *Evidence-Based Practice* (EBP)

Memperkuat asuhan keperawatan dengan rujukan ilmiah terkini, seperti penggunaan aromaterapi (lemon dan peppermint), terapi herbal (jahe), serta teknik ergonomi fisik.

Melalui pendekatan berbasis kasus ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai pola berpikir kritis dalam memberikan asuhan yang aman (*safe care*) dan responsif terhadap kebutuhan unik ibu hamil di setiap tahapannya.

B. MASALAH UMUM PADA KEHAMILAN TRIMESTER I: EMESIS GRAVIDARUM

Trimester pertama (minggu ke-1 hingga ke-12) ditandai dengan adaptasi endokrin yang melibatkan peningkatan hormonal secara drastis, khususnya *Human Chorionic Gonadotropin* (hCG) dan Estrogen. Perubahan ini menjadi fondasi fisiologis munculnya berbagai ketidaknyamanan, dengan *Emesis Gravidarum* sebagai masalah paling representatif.



Gambar 2. 1 Mual Muntah pada Kehamilan
Sumber: (Tim Klik Dokter, 2023)

1. Tinjauan Fisiologis dan Etiologi (Sintesis Multifaktorial)

Emesis Gravidarum atau *Nausea and Vomiting of Pregnancy* (NVP) merupakan fenomena kompleks yang melibatkan interaksi antara faktor endokrin, gastrointestinal, dan genetik. Etiologi masalah ini dapat dipahami melalui tiga pilar utama:

a. Pilar Endokrin: Teori Klasik hCG dan Estrogen

Peningkatan hormon kehamilan klasik tetap menjadi pemicu utama (*trigger*) yang menginisiasi sinyal mual pada trimester pertama melalui jalur berikut:

1) *Human Chorionic Gonadotropin* (hCG): Stimulasi Pusat Muntah dan Tiroid
Kadar hCG mencapai puncaknya pada minggu ke-10 hingga ke-12 kehamilan, yang berkorelasi linier dengan intensitas gejala emesis.

a) Mekanisme Molekuler dan Mimikri Tiroid

Hormon hCG dan TSH memiliki komponen penyusun (sub unit α) yang hampir identik. Hal ini membuat hCG mampu "menyamarkan" dan menempati reseptor TSH di kelenjar tiroid. Ketika kadar hCG melonjak drastis, kelenjar tiroid akan terstimulasi secara tidak sengaja, menciptakan kondisi mirip hipertiroidisme sementara yang menjadi akar penyebab mual hebat pada awal kehamilan (Korevaar et al., 2017)

b) *Gestational Transient Thyrotoxicosis* (GTT): Hipertiroidisme Sementara

Interaksi antara hormon hCG dan kelenjar tiroid menciptakan sebuah fenomena yang disebut GTT. Secara klinis, alur kejadiannya adalah sebagai berikut:

(1)Pemicu (*Trigger*)

Akibat penyamaran molekuler (hCG menyerupai TSH), kelenjar tiroid terstimulasi untuk memproduksi hormon tiroksin bebas (*fT4*) secara berlebihan.

(2)Respons Tubuh

Peningkatan *fT4* ini kemudian mengirim sinyal balik ke otak untuk menghentikan produksi TSH, sehingga kadar TSH dalam darah menurun drastis (tertekan).

(3)Dampak Klinis

Kondisi ini menciptakan keadaan "hipertiroidisme sementara" (transien) yang menjadi akar penyebab mual dan muntah yang hebat pada trimester pertama.

(4)Varian Individu

Variasi sensitivitas reseptor tiroid pada setiap ibu berbeda-beda. Hal inilah yang menjelaskan mengapa pada kadar hCG yang sama, seorang ibu mungkin hanya merasakan mual ringan, sementara ibu lainnya

mengalami emesis berat akibat respons kelenjar tiroid yang jauh lebih sensitif terhadap lonjakan hormon tersebut (Bustos et al., 2017; Korevaar et al., 2017).

c) Aktivasi Batang Otak: Pusat Koordinasi Muntah

Hormon hCG tidak hanya bekerja pada organ di perut atau leher (tiroid), tetapi juga memiliki akses langsung ke sistem saraf pusat melalui mekanisme berikut:

(1) Menembus Pertahanan Otak

Meskipun otak memiliki pelindung ketat berupa "Sawar Darah Otak", terdapat area khusus yang lebih terbuka yang disebut *Circumventricular Organs*. Di sinilah hCG dapat menyelinap masuk ke dalam sirkulasi saraf pusat.

(2) Merangsang Reseptor Spesifik

Begitu berhasil masuk, hCG secara langsung merangsang reseptor di Area *Postrema* atau yang dikenal sebagai *Chemoreceptor Trigger Zone* (CTZ). Area ini terletak di medula oblongata dan berfungsi sebagai "pos penjaga" yang mendeteksi zat-zat kimia dalam darah.

(3) Eksekusi Refleks Muntah

Stimulasi pada CTZ ini kemudian mengaktifkan pusat muntah, yang memerintahkan tubuh untuk melakukan gerakan otot secara sinkron (refleks muntah). Inilah yang menyebabkan ibu hamil merasakan dorongan kuat untuk mengeluarkan isi lambung secara involunte (Cunningham et al., 2022).

2) Estrogen: Hiperosmia dan Sensitivitas Sensorik

Peningkatan drastis kadar estradiol selama trimester pertama mengubah cara otak memproses input sensorik, khususnya penciuman.

a) Mekanisme *Hiperosmia* (Sensitivitas Penciuman yang Tajam)

Peningkatan kadar estrogen secara signifikan memengaruhi cara ibu hamil merespons rangsangan bau melalui mekanisme berikut:

1) Vaskularisasi Mukosa Hidung

Estrogen menyebabkan peningkatan aliran darah (vaskularisasi) pada selaput lendir hidung, yang membuat saraf-saraf penciuman menjadi jauh lebih sensitif dari biasanya.

2) Modulasi Reseptor Olfaktori

Selain di hidung, estrogen juga bekerja di otak dengan mempertajam respons reseptor penciuman. Kondisi ini memicu hiperosmia, yaitu kepekaan penciuman yang sangat ekstrem.

3) Respons Patologis (*Aversi*)

Hiperosmia menyebabkan terjadinya *aversi* atau rasa jijik yang mendadak terhadap aroma tertentu. Bau sehari-hari seperti nasi yang baru matang atau parfum kini dipersepsikan oleh sistem saraf sebagai bau yang sangat tidak enak dan sulit ditoleransi

4) Aktivasi Jalur Mual

Sinyal bau ini secara instan dikirim ke sistem limbik (pusat emosi dan memori di otak), yang langsung memicu refleks mual hebat meskipun ibu tidak sedang makan apa pun. (Lowdermilk et al., 2023; Maltepe & Koren, 2013).

b) Peran pada Otot Polos

Peningkatan kadar estrogen tidak hanya memengaruhi saraf pusat, tetapi juga bekerja sama dengan progesteron untuk memengaruhi saluran pencernaan secara langsung:

(1) Sinergi Relaksasi Otot

Kedua hormon ini menyebabkan otot polos di seluruh saluran pencernaan mengalami relaksasi atau "pelemasan". Akibatnya, gerak peristaltik lambung menjadi sangat lambat (*hipomotilitas*).

(2) Stagnasi Makanan

Kondisi ini menyebabkan waktu pengosongan lambung menjadi lebih lama (*delayed gastric emptying*). Makanan yang menetap terlalu lama di lambung akan memicu distensi (peregangan dinding lambung).

(3) Pemicu Mual Mekanis

Peregangan lambung yang terus-menerus ini mengirimkan sinyal rasa penuh dan tidak nyaman ke otak, yang secara klinis memperburuk sensasi mual. Inilah alasan mengapa ibu hamil sering merasa sangat mual setelah makan, meskipun porsi sedikit (Bustos et al., 2017; Ricci et al., 2021).

3) Indikator Klinis Thyroid Stimulating Hormone (TSH)

Pemantauan kadar TSH merupakan komponen penting dalam menilai risiko dan keparahan emesis pada awal kehamilan:

a) Efek Supresi Hormonal

Pada kondisi kehamilan dengan kadar hCG yang sangat ekstrem seperti pada kehamilan kembar (*gemelli*) atau mola hidatidosa terjadi penekanan (*supresi*) TSH yang sangat signifikan di dalam darah.

b) Korelasi Klinis

Rendahnya kadar TSH ini menjadi indikator biologis bagi risiko tinggi terjadinya emesis berat. Semakin rendah kadar TSH yang terdeteksi

(akibat besarnya pengaruh hCG terhadap tiroid), maka semakin berat pula gejala mual dan muntah yang dirasakan oleh ibu.

c) Aplikasi Pengkajian

Penemuan kadar TSH yang rendah pada hasil laboratorium trimester pertama sering kali menjadi pertanda awal bagi perawat untuk mewaspadaikan perkembangan kondisi ke arah *Hyperemesis Gravidarum* (HG) (Bustos et al., 2017).

b. Pilar Gastrointestinal (Dampak Progesteron)

Berdasarkan tinjauan klinis Ricci et al. (2021), perubahan sistem pencernaan selama Trimester I bukan sekadar efek samping, melainkan konsekuensi dari adaptasi mekanis dan kimiawi tubuh untuk mendukung pertumbuhan janin.

1) Hipomotilitas dan Disritmia Lambung

Peningkatan kadar progesteron menyebabkan relaksasi otot polos di seluruh tubuh, termasuk saluran pencernaan. Hal ini mengakibatkan perpanjangan waktu pengosongan lambung (*delayed gastric emptying*). Secara fisiologis, kondisi ini sebenarnya bertujuan agar penyerapan nutrisi oleh usus menjadi lebih maksimal, namun bagi ibu hamil, hal ini memicu rasa penuh, kembung, dan mual yang persisten.

2) Relaksasi Sfingter Kardial (Lower Esophageal Sphincter/LES)

Relaksasi pada katup antara esofagus dan lambung menyebabkan asam lambung lebih mudah naik kembali ke kerongkongan. Iritasi mukosa esofagus oleh asam lambung sering kali memperparah sensasi mual, terutama saat perut dalam keadaan kosong di pagi hari.

3) Perubahan Indra Perasa dan Air Liur (*Ptyalism*)

Terjadi perubahan sekresi kelenjar ludah di mana beberapa ibu mengalami *hipersalivasi* (*ptyalism*). Saliva tersebut sering kali memiliki rasa pahit atau asam (pH rendah) yang jika tertelan secara terus-menerus dapat merangsang refleks muntah di pangkal tenggorokan serta memperburuk iritasi lambung (Ricci et al., 2021; Yilmaz et al., 2024).

c. Pilar Genetik dan Molekuler (Peran Hormon GDF15)

Temuan terbaru dari Fejzo et al. (2024) mengungkapkan bahwa penyebab utama tingkat keparahan mual dan muntah berkaitan erat dengan protein GDF15 (*Growth Differentiation Factor 15*). Protein ini diproduksi oleh plasenta janin dan dilepaskan ke aliran darah ibu, yang kemudian berikatan dengan reseptor spesifik di batang otak (pusat mual).

1) Mekanisme Sensitivitas

Risiko mual hebat hingga *Hyperemesis Gravidarum* (HE) ditentukan oleh kadar GDF15 ibu sebelum hamil.

a) Kelompok Risiko Tinggi

Ibu dengan varian genetik tertentu cenderung memiliki kadar GDF15 basal yang sangat rendah sebelum pembuahan. Kondisi ini menyebabkan reseptor otak mereka menjadi sangat sensitif (tidak toleran). Saat hamil, lonjakan GDF15 dari janin dianggap sebagai "kejutan" biologis yang memicu respons muntah ekstrem (M. S. Fejzo et al., 2019).

b) Efek Protektif

Sebaliknya, ibu yang secara kronis terpapar kadar GDF15 tinggi sebelum hamil (misalnya pada penderita *Beta-Thalassemia*) terbukti jarang mengalami mual berat karena otak mereka telah beradaptasi (M. Fejzo et al., 2024).

2) Pemeriksaan Biomarker GDF15

Saat ini, pemeriksaan kadar GDF15 dapat dilakukan melalui sampel darah menggunakan teknik ELISA (*Enzyme-Linked Immunosorbent Assay*) atau *Immunoassay* kuantitatif melalui sampel darah vena (serum/plasma). Deteksi dini kadar GDF15 pada masa prakonsepsi memungkinkan perawat untuk melakukan stratifikasi risiko terhadap calon ibu yang rentan mengalami HEG.

3) Konsep Desensitisasi (Priming)

Temuan ini membuka paradigma baru dalam pencegahan mual muntah melalui teknik *desensitisasi*. Mekanismenya mirip dengan imunoterapi alergi, di mana calon ibu yang berisiko tinggi diberikan paparan GDF15 eksogen dosis rendah secara bertahap sebelum kehamilan terjadi. Tujuannya adalah untuk membiasakan (*priming*) reseptor di otak agar membangun toleransi imunologis, sehingga saat kehamilan berlangsung, tubuh tidak lagi memberikan respons mual yang mengancam nyawa (Fejzo et al., 2024).

CLINICAL PEARLS: MANAJEMEN EMESIS GRAVIDARUM

Tips Klinik: Anjurkan ibu untuk selalu menyediakan kraker kering di meja samping tempat tidur agar dapat dikonsumsi 15-20 menit sebelum beranjak dari kasur.

Warning Sign: Waspadai penurunan TSH serum $<0,1$ mIU/L dikombinasikan dengan ketonuria positif, karena ini menginduksi transisi dari emesis fisiologis ke hiperemesis patologis.

Common Mistake: Membiarkan lambung kosong terlalu lama atau menganjurkan minum air putih dalam jumlah banyak sekaligus saat lambung kosong di pagi hari, yang justru memicu distensi lambung akut dan emesis emetik.

Tabel 2. 1 Evidence Summary Intervensi Emesis Gravidarum

EVIDENCE SUMMARY: INTERVENSI NON-FARMAKOLOGIS EMESIS GRAVIDARUM		
Intervensi EBP Non-Farmakologis	Level Evidence (Kepastian Bukti)	Mekanisme Kerja Fisiologis dan Bio-Nutrisi
Modifikasi Diet dan Stabilisasi Glukosa (Small Frequent Feeding)	Level A (Systematic Review / Food Pyramid)	Mencegah distensi lambung akibat porsi besar, menekan fluktuasi asam lambung akibat hipomotilitas, serta menjaga stabilitas kadar glukosa darah maternal untuk menekan sinyal mual sentral.
Intervensi Bio-Nutrisi: Ginger (Jahe) dan Vitamin B6	Level A (Cochrane Systematic Review)	Senyawa aktif gingerol dan shogaol bekerja sebagai antagonis reseptor serotonin (5-HT ₃) perifer di saluran pencernaan untuk meningkatkan motilitas lambung. Vitamin B6 bertindak sebagai koenzim metabolisme asam amino yang menyeimbangkan neurotransmitter di SSP untuk meredakan mual.
Aromaterapi Inhalasi (Lemon dan Peppermint)	Level B (Randomized Controlled Trial)	Molekul volatil menstimulasi saraf olfaktorius menuju sistem limbik, memicu pelepasan endorfin dan neurotransmitter penenang yang menghambat jaras mual di batang otak.
Stimulasi Titik Akupresur Perikardium 6 (P6)	Level B (Clinical Trial / Gate Control)	Mengirimkan sinyal aferen melalui saraf perifer untuk menghambat impuls emetik di SSP berdasarkan gate control theory, serta merangsang opioid endogen untuk merelaksasi otot gastrointestinal.

Terapi Audio Psikofisiologis (ATHP-HC)	Level B (Riset Klinis Multimodal)	Mengintegrasikan instrumen Gamelan Cirebon dengan teknologi gelombang otak untuk memodulasi pola gelombang otak maternal, menginduksi respon relaksasi sistem otonom dan menurunkan intensitas mual.
---	-----------------------------------	--

Tabel 2. 2 Skrining Safety Emesis Gravidarum

RED FLAGS BOX: SKRINING SAFETY EMESIS GRAVIDARUM		
Ketidakseimbangan Cairan dan Metabolik	Gangguan Sistemik dan Neurologis	Diagnosis Banding (Eksklusi Patologis)
* **Ketosis Positif:** Hasil dipstick urine $\geq +1$ menandakan lipid burning akibat deplesi glukosa. * **Dehidrasi Klinis:** Penurunan turgor kulit, mukosa bibir pecah-pecah, mata cekung, dan oliguria pekat. * **Weight Loss:** Penurunan berat badan drastis $> 5\%$ dari berat badan pra-kehamilan.	* **Hemodinamik Instabil:** Hipotensi ortostatik dan takikardia persisten (> 100 x/menit). * **Ensefalopati Wernicke:** Trias klinis (konfusi, nistagmus, ataksia) akibat defisiensi Vitamin B1 (Thiamine). * **Hipokalemia Berat:** Kelemahan otot ekstrem dan disritmia jantung akibat deplesi kalium via emesis.	* **Infeksi Akut:** Demam tinggi dan nyeri ketok kostovertebra (indikasi ISK Atas / Pielonefritis). * **Abdomen Akut:** Nyeri tekan lokal kuadran kanan bawah (curiga apendisitis atau kolesistitis). * **Struma/Goiter:** Pembesaran kelenjar tiroid nyata yang mengindikasikan Graves' Disease, bukan GTT.

2. Asuhan Keperawatan Berbasis Standar PPNI

a. Pengkajian Keperawatan (Analisis Data)

Berdasarkan Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI), perawat harus mengumpulkan data tanda dan gejala untuk menegaskan diagnosis Nausea.

1) Gejala dan Tanda Mayor

Data ini merupakan indikator utama yang harus ditemukan (minimal satu) untuk menegaskan diagnosis:

Subjektif:

- a) Mengeluh Mual: Ibu melaporkan perasaan tidak nyaman di tenggorokan atau perut yang dapat menyebabkan muntah.
- b) Merasa Ingin Muntah: Adanya dorongan kuat untuk mengeluarkan isi lambung secara involunter (refleks batang otak).
- c) Tidak Berminat Makan: Anoreksia akibat peningkatan protein GDF15 yang menekan pusat lapar di otak (Fejzo et al., 2024).

Objektif:

(Pada diagnosis Nausea, gejala mayor umumnya bersifat subjektif).

2) Gejala dan Tanda Minor

Data tambahan yang mendukung derajat keparahan emesis:

Subjektif:

- a) Merasa asam di mulut: akibat paparan asam lambung atau perubahan pH saliva (*ptialisme*) (Yilmaz et al., 2024).
- b) Sering menelan: gerakan involunter untuk menetralkan rasa tidak enak di kerongkongan.
- c) Aversi terhadap makanan: rasa jijik mendadak terhadap makanan tertentu akibat *hiperosmia (estrogen-sentris)*.

Objektif:

- a) Salivasi meningkat (*ptialisme*): produksi air liur berlebih yang sering kali terasa pahit atau asam.
- b) Pucat: wajah tampak kurang segar akibat rasa tidak nyaman yang persisten.
- c) Takikardia: Peningkatan denyut nadi ringan, yang dapat dipicu oleh aktivitas tiroid yang meningkat (supresi TSH) atau kecemasan (Korevaar et al., 2017).
- d) Pupil Dilatasi: Respons sistem saraf otonom terhadap rasa mual yang hebat (Bustos et al., 2017).

3) Instrumen Pengukuran Tingkat Keparahan: Skor PUQE-24 Jam

Penegakan derajat atau tingkat keparahan mual muntah wajib menggunakan instrumen *Pregnancy Unique Quantification of Emesis* (PUQE-24 jam) secara objektif dalam kurun waktu 24 jam terakhir, untuk membedakan emesis dengan hyperemesis gravidarum.

Tabel 2. 3 Indeks PUQE-24 Scoring System

Dalam 24 jam terakhir, untuk berapa lama ibu merasa mual atau tidak nyaman pada perut ?	Tidak sama sekali	1 jam atau kurang	2-3 jam	4-6 jam	>6 jam
Score	1	2	3	4	5
Dalam 24 jam terakhir, apakah ibu mengalami muntah-muntah ?	Tidak muntah	1-2 kali	3-4 kali	5-6 kali	≥ 7 kali
Score	1	2	3	4	5
Dalam 24 jam terakhir, berapa kali ibu telah mengalami muntah kering ?	Tidak pernah	1-2 kali	3-4 kali	5-6 kali	≥ 7 kali
Score	1	2	3	4	5

Sumber : Modifikasi dari (Birkeland et al., 2015; Dochez et al., 2016; Ebrahimi et al., 2009; Koren et al., 2005)

Interpretasi Skor Total PUQE-24: Skor total diperoleh dengan menjumlahkan poin dari ketiga pertanyaan (mual, muntah, dan muntah kering). Hasil akhir tersebut menentukan derajat keparahan emesis gravidarum dan langkah klinis yang harus diambil oleh perawat.

- Emesis Gravidarum Tingkat Ringan (*Mild*) dengan rentang skor: PUQE-24 jam = 3–6 poin.
 - Emesis Gravidarum Tingkat Sedang (*Moderate*) dengan rentang skor: PUQE-24 jam = 7–12 poin.
 - Emesis Gravidarum Tingkat Berat (*Severe*) dengan rentang skor: PUQE-24 jam = 13–15 poin.
- 4) Data Pemeriksaan Penunjang (Klinis dan Laboratorium)
- Data tambahan untuk memvalidasi pilar etiologi yang telah dibahas:
- Laboratorium Tiroid: Ditemukan kadar TSH Rendah ($<0,1$ mIU/L) dan *fT4* yang berada di rentang atas normal sebagai indikator *Gestational Transient Thyrotoxicosis* (GTT).

- b) Urinalisis: Keton urine negatif (membedakan Emesis dengan Hiperemesis).
- c) USG: Memastikan jumlah janin (gemelli) atau kondisi mola yang berkorelasi dengan lonjakan hCG ekstrem.
- b. Diagnosis Keperawatan Berbasis Standar PPNI (3S)
- Asuhan keperawatan pada ibu dengan emesis gravidarum difokuskan pada manajemen gejala mual dan pencegahan perburukan kondisi menjadi hiperemesis, dengan merujuk pada standar nasional PPNI (SDKI, SLKI, SIKI).
- Diagnosis Keperawatan (SDKI): Nausea (D.0076)
- 1) Penyebab (Etiologi): Berhubungan dengan kehamilan (perubahan hormonal: peningkatan hCG, estrogen, dan protein GDF15).
 - 2) Gejala Mayor: Ibu mengeluh mual, merasa ingin muntah, dan tidak berminat makan.
 - 3) Gejala Minor: Peningkatan salivasi (*ptialisme*), aversi terhadap makanan, dan sensasi panas di dada (*heartburn*) akibat relaksasi sfingter esofagus (PPNI, 2017).
- c. Luaran Keperawatan (SLKI): Tingkat Nausea Menurun (L.08065)
- Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan tingkat nausea menurun dibuktikan dengan Skor PUQE-24 jam bergeser dari kategori Sedang (7-12 poin) menjadi kategori Ringan (3-6 poin) dengan kriteria hasil:
- 1) Keluhan mual menurun.
 - Frekuensi muntah berkurang.
 - Nafsu makan membaik.
 - Perasaan ingin muntah menurun.
 - Sekresi saliva (*ptialisme*) kembali normal (PPNI, 2018b)
- d. Intervensi Utama (SIKI): Manajemen Mual (I.03117) dan Terapi Komplementer.
- Intervensi dilakukan dengan mengombinasikan tindakan mandiri perawat dan edukasi berbasis perubahan fisiologis trimester pertama.

Tabel 2. 4 Matriks Intervensi dan Rasional Ilmiah Manajemen Mual

Kategori SIKI	Tindakan Keperawatan (SIKI)	Rasional Ilmiah Berbasis Bukti (EBP)
1) Observasi	Identifikasi faktor pencetus mual (misal: bau tajam/hiperosmia,	Membantu memetakan stimulan spesifik yang dapat mengaktivasi lambung atau saraf pusat. Kondisi lambung kosong memicu akumulasi

	makanan berlemak, atau perut kosong).	asam, sedangkan makanan berlemak memperlambat klirens pencernaan.
	Monitor frekuensi mual dan muntah untuk mendeteksi risiko dehidrasi dini.	Pemantauan kuantitas emesis sangat penting sebagai <i>threshold</i> evaluasi awal agar tidak terjadi transisi ke arah dehidrasi seluler dan gangguan keseimbangan elektrolit maternal.
	Cek riwayat sensitivitas bau (aversi) untuk memodifikasi lingkungan perawatan.	Hiperosmia dipicu oleh peningkatan estrogen yang mempertajam respons reseptor olfaktorius. Mengetahui riwayat aversi membantu perawat mengeliminasi agen pemicu secara spesifik dari lingkungan ibu.
2) Terapeutik	Intervensi <i>Dry Food</i>: Berikan makanan kering (kraker, biskuit, atau roti bakar) segera setelah bangun tidur sebelum ibu turun dari tempat tidur.	Bertujuan untuk langsung mengisi lambung yang kosong setelah periode tidur malam dan menyerap asam lambung yang menumpuk, sehingga mencegah stimulasi mual mekanis di pagi hari.
	Kontrol Lingkungan: Jauhkan ibu dari aroma yang menyengat (masakan, parfum, asap rokok) guna menekan aktivasi sistem limbik akibat hiperosmia.	Menghindari bau menyengat akan meminimalkan hantaran sinyal sensorik olfaktorius ke sistem limbik dan medula oblongata, sehingga jaras mual sentral tidak teraktivasi.
	Kebersihan Mulut: Berikan perawatan mulut setelah muntah untuk mengurangi rasa pahit/asam dan mencegah rangsangan muntah lebih lanjut.	Menghilangkan sisa keasaman emesis dan ptialisme di rongga mulut. Hal ini meminimalkan stimulasi balik pada saraf glossofaringeal yang dapat memicu refleks muntah sekunder.

3) Edukasi	Pola Makan <i>Small Frequent Feeding</i>: Anjurkan makan dalam porsi kecil namun sering (5–6 kali sehari).	Mengatasi lambung yang mengalami "malas" atau hipomotilitas akibat relaksasi progesteron, mencegah distensi berlebih dinding lambung, serta menjaga stabilitas kadar gula darah.
	Pilihan Cairan: Anjurkan minum air di antara waktu makan, bukan saat sedang makan.	Memisahkan konsumsi cairan dan makanan padat akan mencegah pencampuran volume besar dalam lambung, sehingga distensi lambung yang berlebihan dapat dihindari.
	Manajemen Posisi: Anjurkan ibu untuk tetap dalam posisi tegak atau duduk selama 30 menit setelah makan.	Memanfaatkan gaya gravitasi untuk mencegah terjadinya refluks asam lambung ke esofagus akibat kondisi relaksasi sfingter kardia selama trimester pertama kehamilan.
	Pemilihan Jenis Makanan: Anjurkan makanan tinggi karbohidrat kompleks dan rendah lemak.	Karbohidrat kompleks lebih mudah ditoleransi, diserap, dan dicerna oleh lambung yang mengalami perlambatan waktu pengosongan (<i>delayed gastric emptying</i>) dibandingkan makanan tinggi lemak.

3. Implementasi Evidence-Based Practice (EBP)

Penatalaksanaan NVP lebih berfokus pada terapi non-farmakologis sebagai pilihan utama untuk meminimalkan paparan zat kimia pada janin. Berdasarkan berbagai sumber riset terbaru, berikut adalah modalitas terapi komplementer yang divalidasi:

a. Strategi Piramida Makanan dan Modifikasi Diet

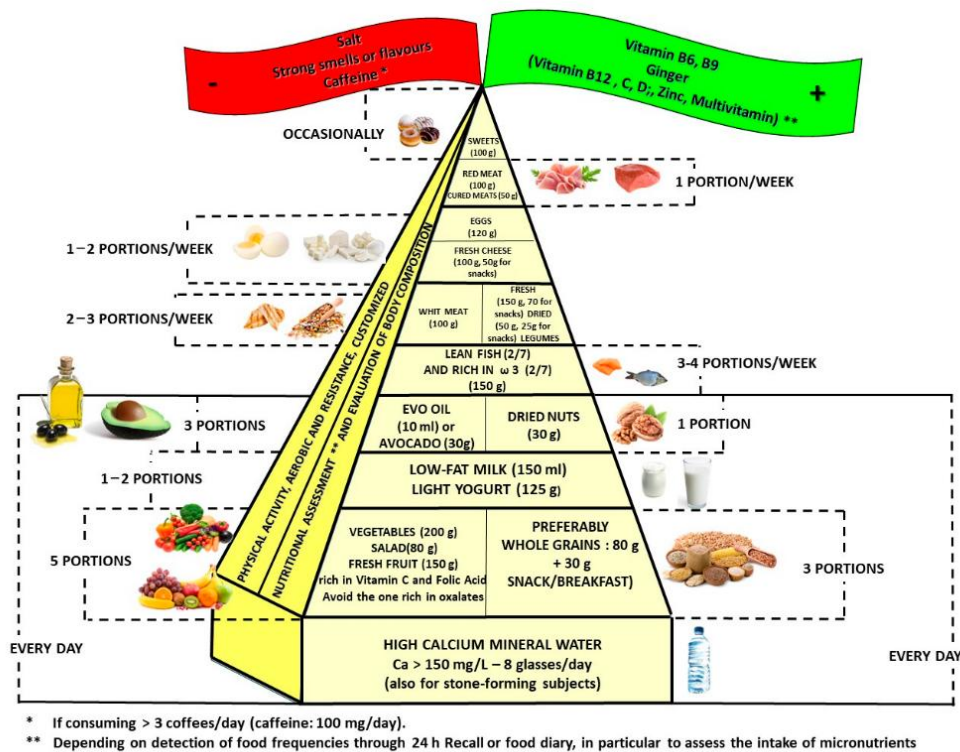
Menurut Rondanelli et al. (2025), manajemen NVP ditekankan pada pengaturan jenis dan waktu konsumsi makanan untuk menjaga stabilitas lambung dan kadar glukosa darah:

1) Stabilisasi Glukosa Darah

Mengonsumsi camilan tinggi protein dan pati kompleks (seperti biskuit kering atau roti gandum) segera setelah bangun tidur bahkan sebelum beranjak dari tempat tidur terbukti efektif menstabilkan kadar gula darah dan menurunkan intensitas morning sickness.

2) Hierarki Nutrisi (*Food Pyramid*)

Strategi diet diarahkan pada pemilihan makanan kering dan karbohidrat kompleks dalam porsi kecil namun sering (*small frequent meals*). Hal ini bertujuan untuk mencegah distensi lambung yang berlebihan dan meminimalkan pemicu mual akibat kekosongan lambung yang terlalu lama.



Gambar 2. 2 Food Pyramid
Sumber: (Rondanelli et al., 2025)

3) Pencegahan Pemicu

Menghindari makanan berlemak tinggi, pedas, atau beraroma tajam yang dapat memperlambat pengosongan lambung dan memperparah iritasi mukosa.

b. Intervensi Bio-Nutrisi (Jahe dan Vitamin B6)

Terdapat bukti ilmiah yang kuat bahwa penggunaan Jahe (Ginger) dan Vitamin B6 (Piridoksin) secara signifikan lebih efektif dibandingkan plasebo dalam meredakan mual ringan hingga sedang (Matthews et al., 2015). Meskipun demikian, dosis dan durasi pemberian harus dipantau secara klinis (O'Donnell et al., 2016). Secara fisiologis, jahe mengandung senyawa aktif gingerol dan shogaol yang bekerja sebagai antagonis reseptor serotonin di saluran pencernaan, sehingga meningkatkan motilitas lambung dan memberikan efek anti-mual. Sementara itu, Vitamin B6 berperan sebagai

koenzim dalam metabolisme asam amino yang membantu menyeimbangkan neurotransmitter di otak untuk menekan pusat mual.

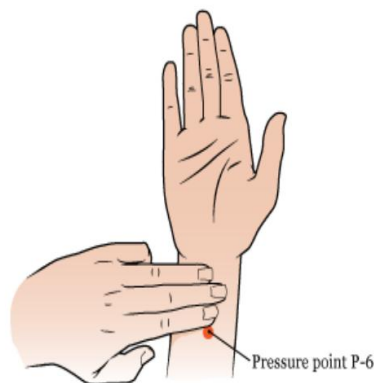
c. Aromaterapi

Inhalasi minyak esensial melalui sistem penciuman memberikan efek menyegarkan serta mengurangi sensitivitas terhadap aroma pemicu mual. Secara spesifik, aroma lemon terbukti menurunkan frekuensi mual (Harahap et al., 2022), yang didukung oleh efektivitas inhalasi peppermint (Astri, 2024), serta sinergi kombinasi keduanya (Rahmadhaniati et al., 2022). Aromaterapi jahe dan lavender juga divalidasi memberikan kenyamanan kompetitif (Retni & Damansyah, 2022; Rizki et al., 2022). Mekanisme kerja aromaterapi melibatkan stimulasi sistem limbik di otak melalui saraf olfaktorius, yang memicu pelepasan endorfin dan neurotransmitter penenang, sehingga memberikan efek relaksasi instan pada saluran cerna.

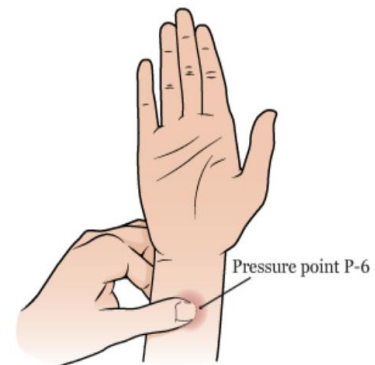
d. Teknik Stimulasi Titik P6 (Akupresur)

Intervensi menggunakan wristband atau penekanan manual pada titik P6 (Perikardium 6) merupakan metode populer yang aman dan minim risiko (Juwita, 2018; Mariza & Ayuningtias, 2019) Proses ini bekerja berdasarkan teori gate control, di mana penekanan pada titik P6 mengirimkan sinyal melalui saraf perifer ke sistem saraf pusat untuk menghambat impuls mual. Stimulasi ini juga merangsang pelepasan opioid endogen yang merelaksasi otot-otot saluran pencernaan.

Cara mengukur letak titik P6



Cara menekan titik P6



Sumber: (Gultom et al., 2024)

Gambar 2. 3 Akupresur pada Titik P6

e. Intervensi Psikofisiologis (Terapi Audio ATHP-HC)

Inovasi terbaru memperkenalkan *Audio Therapy Healthy Pregnancy* Harmoni Cinta (ATHP-HC), sebuah terapi yang mengintegrasikan instrumen Gamelan Cirebon dengan teknologi gelombang otak. Intervensi ini bekerja

dengan memicu respons relaksasi melalui modulasi pola gelombang otak ibu hamil. Hasil riset menunjukkan bahwa penggunaan ATHP-HC berkontribusi signifikan terhadap penurunan intensitas mual serta peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh (Wahyuni et al., 2024).

f. Mekanisme *Desensitisasi* GDF15

Desensitisasi adalah proses "membiasakan" tubuh ibu terhadap hormon GDF15 sebelum kehamilan terjadi, agar saat hamil nanti, otak tidak lagi memberikan respons mual yang ekstrem (M. Fejzo et al., 2024). Langkah-langkah detail *desensitisasi* (protokol untuk masa yang akan datang):

1) Pemaparan Bertahap (Priming)

Ibu yang teridentifikasi berisiko tinggi (kadar basal rendah) diberikan paparan GDF15 eksogen (buatan) dalam dosis sangat rendah dan terkontrol secara subkutan atau intravena sebelum pembuahan terjadi.

2) Mekanisme "Toleransi Immunologis"

Paparan dosis rendah ini merangsang reseptor di batang otak (*Area Postrema*) untuk melakukan regulasi ke bawah (*down-regulation*). Otak belajar untuk mengenali GDF15 sebagai zat yang "aman" dan tidak perlu direspons dengan sinyal muntah yang hebat.

3) Peningkatan Dosis Berkala

Dosis ditingkatkan secara perlahan hingga mencapai level yang menyerupai kondisi kehamilan normal. Dengan demikian, ketika plasenta janin mulai memproduksi GDF15 secara alami, tubuh ibu sudah memiliki "benteng" toleransi.

4. Skrining Tanda Bahaya (Red Flags)

Perawat harus melakukan deteksi dini untuk membedakan emesis gravidarum fisiologis dengan kondisi patologis yang memerlukan rujukan segera.

a. Ketidakseimbangan Cairan dan Metabolik

Kondisi ini menunjukkan bahwa tubuh ibu sudah tidak mampu lagi mengompensasi hilangnya asupan nutrisi dan cairan.

1) Gangguan Metabolisme Lemak

a) Ketosis Positif: Adanya keton dalam urine (hasil dipstick $\geq +1$) menandakan tubuh mulai membakar lemak secara tidak sempurna karena cadangan glukosa habis.

b) Asidosis Metabolik: Risiko gangguan pH darah akibat muntah yang berkepanjangan.

2) Dehidrasi Klinis

a) Penurunan Turgor Kulit: Kulit tidak segera kembali setelah dicubit, bibir pecah-pecah, dan mata tampak cekung.

- b) Oliguria: Jumlah urine berkurang drastis dengan warna yang sangat pekat/gelap.
 - c) Penurunan Berat Badan Drastis
 - Kriteria 5%: Kehilangan berat badan secara signifikan, yaitu lebih dari 5% dari berat badan sebelum hamil (RCOG, 2024).
- b. Gangguan Sistemik dan Neurologis
 - Muntah yang tidak terkendali dapat merusak sistem saraf otonom dan keseimbangan elektrolit tubuh.
 - 1) Ketidakstabilan Hemodinamik
 - a) Hipotensi Ortostatik: Penurunan tekanan darah secara mendadak saat ibu berubah posisi dari berbaring ke berdiri.
 - b) Takikardia Persisten: Denyut nadi istirahat >100 x/menit sebagai kompensasi kekurangan cairan atau stimulasi tiroid yang berlebihan (Korevaar et al., 2017).
 - 2) Defisiensi Nutrisi Spesifik
 - a) *Ensefalopati Wernicke*: Munculnya tanda kebingungan (*confusion*), gangguan *pandangan* (*nystagmus*), atau gangguan keseimbangan akibat kekurangan Vitamin B1 (*Thiamine*).
 - b) Hipokalemia: Kelemahan otot yang ekstrem atau gangguan irama jantung akibat hilangnya kalium melalui muntah.
- c. Diagnosis Banding (Eksklusi Penyebab Non-Kehamilan)
 - Perawat harus waspada jika mual disertai gejala yang tidak lazim pada emesis gravidarum.
 - 1) Tanda Infeksi dan Inflamasi.
 - a) Demam Tinggi: Menunjukkan adanya infeksi, paling sering adalah Infeksi Saluran Kemih (ISK).
 - b) Nyeri Abdomen Akut: Nyeri tekan yang tajam pada area perut (curigai apendisitis atau kolesistitis).
 - 2) Kelainan Organ Endokrin
 - Struma/Goiter*: Adanya pembengkakan pada kelenjar tiroid di leher yang menunjukkan penyakit tiroid patologis (*Graves*), bukan sekadar supresi TSH sementara (Bustos et al., 2017).

C. Masalah Umum pada Kehamilan Trimester II: Kram Kaki (*Leg Cramps*)

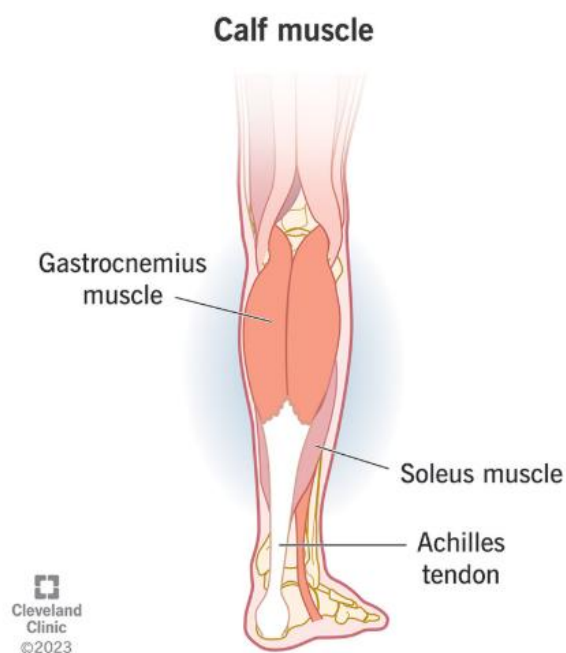
Trimester kedua (minggu ke-13 hingga ke-27) sering kali dianggap sebagai masa yang paling menyenangkan dalam kehamilan. Meskipun demikian, adaptasi endokrin yang terus berlanjut dan pembesaran uterus yang signifikan mulai menimbulkan tekanan pada sistem pencernaan dan vaskular.



Gambar 2. 4 Kram Kaki pada Ibu Hamil
Sumber: (Miller, 2023)

1. Tinjauan Fisiologis dan Etiologi

Kram otot, khususnya pada otot gastrocnemius (betis) yang sering terjadi di malam hari (*nocturnal cramps*), mulai dialami ibu pada Trimester II.



Gambar 2. 5 Otot Gastoknemius
Sumber: (Cleveland clinic, 2023)

Penyebab utama kram pada kaki meliputi:

a. Kompresi Mekanis dan Sirkulasi

Pembesaran uterus memberikan tekanan pada saraf-saraf panggul (khususnya *fleksus lumbosakra*) dan mengganggu aliran balik vena, yang memicu retensi produk sisa metabolisme di otot kaki.

b. Kelelahan Otot

Akibat kompensasi tubuh terhadap perubahan pusat gravitasi dan peningkatan beban berat badan yang ditopang oleh ekstremitas bawah

c. Ketidakseimbangan Elektrolit

Penurunan kadar magnesium serum serta gangguan rasio kalsium-fosfor yang meningkatkan eksitabilitas neuromuskular. (Lowdermilk et al., 2023).

CLINICAL PEARLS: MANAJEMEN KRAM KAKI

Tips Klinik: Ajarkan pasien melakukan peregangan otot betis statis selama 5 menit tepat sebelum tidur untuk memanjangkan serat otot dan meminimalkan eksitabilitas saraf motorik malam hari.

Warning Sign: Jika pasien mengeluh kram kaki unilateral yang menetap, periksa lingkaran betis. Selisih bengkak > 2 cm antar kaki adalah indikator kuat komplikasi vaskular patologis.

Common Mistake: Melakukan pemijatan kuat (*deep tissue massage*) atau manipulasi fisik paksa pada betis yang kram tanpa melakukan skrining tanda komplikasi vaskular terlebih dahulu.

Tabel 2. 5 Evidence Summary Manajemen Spasme Musculoskeletal Ekstremitas Bawah

EVIDENCE SUMMARY MANAJEMEN SPASME MUSKULOSKELETAL EXTREMITAS BAWAH		
Intervensi EBP Non-Farmakologis	Level Evidence (Kepastian Bukti)	Mekanisme Kerja Fisiologis dan Bukti Suplementasi
Peregangan Otot Betis Statis (Calf Stretching)	Level A (Systematic Review Cochrane)	Memanjangkan serat otot gastrocnemius yang memendek, memfasilitasi mikrosirkulasi lokal, dan menurunkan eksitabilitas refleks saraf motorik sebelum periode istirahat malam.
Latihan Pompa Pergelangan Kaki (Ankle Pumping)	Level B (Clinical Practice Guideline)	Mengaktivasi kontraksi intermiten otot betis yang berfungsi sebagai pompa vena (<i>peripheral heart mechanism</i>) untuk meningkatkan sirkulasi balik vena dan mencegah stasis.

Modifikasi Biomekanika dan Hidrasi Adekuat	Level B (Riset Muskuloskeletal)	Penggunaan alas kaki berhak rendah dengan penyangga arkus yang ergonomis meminimalkan beban kerja statis otot tungkai bawah. Hidrasi adekuat menjaga homeostasis cairan intraseluler otot.
Analisis Suplementasi Oral (Magnesium, Kalsium, Vitamin B)	Evidence Terbatas (Low Certainty Evidence)	Ulasan sistematis terkini menunjukkan bahwa pemberian suplemen magnesium oral tidak memperlihatkan efektivitas yang konsisten secara statistik dibanding plasebo. Oleh karena itu, terapi non-farmakologis fisik ditempatkan sebagai intervensi standar utama.

Tabel 2. 6 Skrining Utama Comprehensive Safety DVT vs Kram Fisiologis

RED FLAGS BOX: SKRINING UTAMA COMPREHENSIVE SAFETY (DVT VS KRAM FISIOLOGIS)		
Kriteria Kegawatdaruratan (Kecurigaan DVT)	Skrining Vaskular	Diferensial Diagnosis & Komplikasi Sistemik
* **Bengkak Asimetris (Unilateral Edema):** Pembengkakan terlokalisir nyata pada satu sisi betis/paha. * **Eritema & Hipertermia Lokal:** Kulit betis tampak kemerahan dan terasa panas dibanding area sekitar. * **Nyeri Patologis & Homan's Sign Positif:** Nyeri menetap yang konstan yang tidak mereda dengan regangan fisik, disertai nyeri tajam saat dorsofleksi paksa (indikasi trombus vena dalam).		* **Iskemia Arteri Perifer:** Ekstremitas dingin ekstrem, pucat menetap saat elevasi kaki, dan penurunan/hilangnya denyut nadi Arteri Dorsalis Pedis. * **Spasme Karpopedal Sistemik:** Kram meluas ke ekstremitas atas dan wajah, mengindikasikan krisis hipokalsemia akut. * **Edema Dependen Preeklampsia:** Pembengkakan bilateral masif disertai hipertensi ($\geq 140/90$ mmHg) dan sefalgi hebat.

2. Asuhan Keperawatan Berbasis Standar PPNI (3S)
 - a. Diagnosis Keperawatan (SDKI): Gangguan Rasa Nyaman (D.0074) berhubungan dengan gejala terkait kondisi kehamilan (PPNI, 2017).
 - b. Luaran Keperawatan (SLKI): Status Kenyamanan Meningkat (L.08064)
 Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan status kenyamanan meningkat dibuktikan dengan frekuensi serangan kram betis menurun dari 3-4 kali seminggu menjadi ≤ 1 kali seminggu dengan kriteria hasil:
 - 1) Keluhan tidak nyaman menurun.
 - Kontraksi otot (spasme) menurun,
 - Meringis menurun.
 - Pola tidur membaik (PPNI, 2018b).
 - c. Intervensi Utama (SIKI): Manajemen Nyeri (I.08238) dan Edukasi Biomekanika Tubuh dan Edukasi Aktivitas/Istirahat (I.12362).

Tabel 2. 7 Matriks Intervensi dan Rasional Ilmiah Manajemen Kram Kaki

Kategori SIKI	Tindakan Keperawatan (SIKI)	Rasional Ilmiah Berbasis Bukti (EBP)
1) Observasi	Identifikasi lokasi, durasi, frekuensi, dan faktor pencetus kram otot tungkai bawah (gastrocnemius).	Menilai tingkat keparahan spasme neuromuskular yang umumnya dipicu oleh kelelahan otot akibat beban statis, dehidrasi, atau fluktuasi rasio kalsium-fosfor serum bebas.
	Wajib melakukan Skrining Red Flags DVT (inspeksi edema unilateral dengan selisih lingkar betis >2 cm, eritema, hipertermia lokal, dan tanda Homan) sebelum melakukan manipulasi fisik.	Threshold Keselamatan (Non-maleficence): Jika tanda vaskular mengarah pada <i>Deep Vein Thrombosis</i> (DVT), manipulasi fisik/peregangan dilarang keras karena berisiko melepaskan trombus menjadi emboli paru yang fatal. Ingat: Manifestasi kram fisiologis memiliki kemiripan diagnosis dengan tanda vaskular patologis DVT, sehingga memerlukan penapisan fisik yang ketat.
2)Terapeutik	Fasilitasi reposisi tungkai bawah yang	Mengurangi tekanan mekanis eksternal pada pembuluh darah

	nyaman dan longgarkan pakaian atau selimut yang terlalu ketat di area kaki.	perifer dan saraf, serta memfasilitasi aliran balik vena (<i>venous return</i>) yang lebih lancar.
	Instruksikan pendamping (suami) untuk tidak melakukan pemijatan kuat (<i>deep tissue massage</i>) pada betis yang kram sebelum dipastikan bebas dari tanda DVT.	Pemijatan paksa pada otot yang sedang spasme akut tanpa skrining vaskular dapat merusak pembuluh darah perifer yang rentan akibat kompresi uterus pada vena cava inferior.
3) Edukasi	Ajarkan teknik Dorsofleksi Akut (meluruskan lutut secara perlahan, lalu menarik jari-jari kaki ke arah tubuh) segera saat kram terjadi selama 10–15 detik.	Memberikan regangan mekanis langsung pada serat otot gastrocnemius yang mengalami pemendekan involunter, sehingga merangsang organ tendon golgi untuk mengirim sinyal inhibisi yang merelaksasikan otot seketika.
	Ajarkan latihan Ankle Pumping (gerakan fleksi-ekstensi pergelangan kaki secara intermiten) dan peregangan betis ringan selama 5 menit sebelum tidur malam.	Mengaktivasi kontraksi intermiten otot tungkai bawah sebagai pompa vena sekunder (<i>peripheral heart mechanism</i>). Hal ini meningkatkan sirkulasi lokal dan mencegah penumpukan asam laktat di malam hari.
	Anjurkan penggunaan alas kaki hak rendah (2–3 cm) dengan penyangga lengkung kaki (<i>arch support</i>) yang ergonomis selama beraktivitas.	Meminimalkan beban kerja kompensasi biomekanika muskuloskeletal tungkai bawah saat menahan pergeseran titik berat tubuh (<i>Center of Gravity</i>) ibu hamil ke arah depan.

	Edukasi pentingnya hidrasi adekuat (minimal 2–2,5 liter air per hari) dan konsumsi makanan kaya kalsium serta magnesium.	Menjaga keseimbangan elektrolit dan hidrasi seluler pada tautan saraf-otot (<i>neuromuscular junction</i>), sehingga menurunkan ambang batas terjadinya iritabilitas otot involunter.
--	--	---

Dorsofleksi



Plantarfleksi



Rotasi Pergelangan Kaki



Sumber: (NHS Lanarkshire Maternity Department, 2022)

Gambar 2. 6 Teknik Latihan Pergelangan Kaki (Ankle Exercise) Mandiri

3. Implementasi Evidence-Based Practice (EBP)

Strategi pengelolaan kram kaki pada Trimester II menghadapi tantangan berupa keterbatasan data klinis berkualitas tinggi, sehingga pendekatan non-farmakologis menjadi prioritas utama:

a. Analisis Efektivitas Intervensi Farmakologis

Berdasarkan ulasan sistematis terbaru oleh Luo et al. (2020), intervensi farmakologis seperti pemberian suplemen magnesium, kalsium, maupun vitamin B belum menunjukkan efektivitas yang konsisten secara statistik dibandingkan dengan plasebo. Sejalan dengan temuan Garrison et al. (2020) yang secara spesifik meninjau penggunaan magnesium, terlihat bahwa potensi manfaat pada populasi ibu hamil hanya berskala kecil dengan kepastian bukti yang terbatas (*low certainty*). Akibatnya, tenaga kesehatan tidak dapat memberikan rekomendasi tunggal yang definitif mengenai penggunaan suplemen tersebut sebagai standar pengobatan utama.

b. Peregangan Otot Betis

Menyikapi keterbatasan bukti pada terapi oral, pendekatan klinis sebaiknya bergeser pada strategi non-farmakologis yang lebih aman. Peregangan otot betis (*calf stretching*) secara rutin selama 5 menit sebelum tidur terbukti lebih efektif dalam mencegah timbulnya kram pada malam hari

dibandingkan hanya mengandalkan terapi suplemen. Aktivitas peregangan membantu memanjangkan serat otot yang menegang, melancarkan mikrosirkulasi, dan mengurangi eksitabilitas saraf motorik sebelum periode istirahat panjang di malam hari (Luo et al., 2020).

c. Modifikasi Aktivitas dan Mekanika Tubuh

Edukasi klinis menurut Lowdermilk et al. (2023) mencakup penggunaan mekanika tubuh yang tepat untuk mencegah pemicu kram mendadak:

1) Hindari Plantarfleksi Ekstrem

Anjurkan ibu untuk menghindari gerakan menyentak jari kaki ke bawah (*plantar flexion*) secara mendadak (misalnya saat meregangkan kaki di tempat tidur) yang dapat memicu kontraksi otot betis seketika.

2) Alas Kaki yang Tepat

Penggunaan sepatu berhak rendah dan penyangga arkus kaki yang baik membantu mengurangi kelelahan otot tungkai bawah akibat pergeseran pusat gravitasi pada Trimester II.

3) Hidrasi Adekuat

Meskipun bukti mengenai elektrolit masih terbatas, menjaga hidrasi tetap dianggap penting untuk menjaga keseimbangan cairan intraseluler otot.

4. Skrining Tanda Bahaya (*Red Flags*)

Meskipun kram kaki pada trimester II umumnya bersifat fisiologis akibat perubahan sirkulasi dan tekanan uterus, perawat harus waspada terhadap tanda-tanda komplikasi vaskular yang serius.

a. Kecurigaan *Deep Vein Thrombosis* (DVT)

DVT adalah penggumpalan darah pada vena dalam yang merupakan kegawatdaruratan medis karena berisiko menyebabkan emboli paru.

1) Tanda Fisik Unilateral

- a) Bengkak Asimetris: Pembengkakan yang signifikan hanya pada satu sisi kaki (unilateral), biasanya pada betis atau paha.
- b) Perubahan Warna Kulit: Area yang kram tampak kemerahan (*erythema*) atau kebiruan (*sianosis*) dibandingkan kaki yang sehat.

2) Gejala Nyeri Patologis

- a) Nyeri Menetap: Rasa sakit yang tidak hilang meski otot sudah diregangkan atau dipijat.
- b) Tanda Homan Positif: Munculnya nyeri tajam di betis saat telapak kaki ditekuk ke arah tulang kering (*dorso-fleksi*).

3) Perubahan Suhu Lokal

Hipertermia Lokal: Area yang kram terasa panas saat diraba dibandingkan area kulit di sekitarnya.

b. Gangguan Sirkulasi Arteri Perifer

Gangguan aliran darah dari jantung ke ekstremitas bawah yang dapat mengancam jaringan.

1) Gejala Iskemik

- a) Kaki Terasa Dingin: Penurunan suhu kulit yang ekstrem pada bagian kaki yang sering mengalami kram.
- b) Pucat yang Menetap: Kulit tampak pucat atau keabu-abuan saat kaki diangkat.

2) Pemeriksaan Pulsa Arteri

Denyut Lemah: Penurunan atau hilangnya denyut nadi pada arteri dorsalis pedis (punggung kaki) atau arteri tibialis posterior.

c. Gangguan Elektrolit dan Neurologis Berat

Kondisi sistemik yang memerlukan koreksi medis segera.

1) Defisiensi Mineral Akut

- a) Spasme Karpopedal: Kram yang tidak hanya di kaki, tetapi juga mulai menyerang otot tangan atau wajah (menandakan hipokalsemia berat).
- b) Kelemahan Otot Ekstrem: Ibu merasa kaki sangat lemas hingga sulit untuk berjalan atau menumpu beban tubuh.

2) Tanda Pre-eklampsia Terkait

Edema Dependen: Pembengkakan kaki yang disertai dengan peningkatan tekanan darah dan nyeri kepala hebat (Ricci et al., 2021).

D. Masalah Umum pada Kehamilan Trimester III: Nyeri Punggung Bawah (*Lower Back Pain*)

Memasuki trimester III (minggu ke-28 hingga ke-40), tubuh ibu hamil berada pada puncak adaptasi anatomi dan fisiologis. Jika trimester sebelumnya sering dianggap sebagai masa yang paling nyaman, fase akhir ini justru menjadi "tantangan fisik maksimal". Pertumbuhan janin yang sangat pesat menuntut uterus untuk membesar secara vertikal dan menonjol ke depan. Dinamika ini tidak hanya mengubah bentuk tubuh, tetapi secara drastis menggeser pusat gravitasi ibu, yang pada akhirnya memberikan beban mekanis luar biasa pada sistem penyangga tulang belakang dan otot punggung.



Gambar 2. 7 Nyeri Punggung Bawah pada Ibu Hamil *Sumber: (Rasnaya, 2023)*

1. Tinjauan Fisiologis dan Etiologi

Nyeri punggung bawah pada trimester ketiga bukan lagi sekadar dampak dari pelunakan ligamen secara umum, melainkan manifestasi dari beban mekanis ekstrem (*overload*) dan kompensasi tubuh terhadap perubahan pusat gravitasi.

a. Pergeseran Gravitasi Maksimal

1) Mekanisme Center of Gravity

Seiring pesatnya pertumbuhan janin, uterus menonjol ke arah anterior (depan), yang secara otomatis menarik pusat gravitasi tubuh menjauhi sumbu penyangga kaki.

2) Kompensasi Lordosis Progresif

Untuk mencegah tubuh terjatuh ke depan, ibu hamil melakukan kompensasi dengan menarik bahu ke belakang dan melengkungkan tulang belakang bagian lumbar ke arah dalam secara berlebihan. Keluhan mekanis lordosis lumbar ini berjalan simultan dengan pelebaran diastasis rekti, sehingga intervensi harus berfokus pada stabilitas biomekanika dan postur tubuh.

3) Dampak Biomekanika

Kondisi ini memberikan tekanan statis yang besar pada diskus intervertebralis dan meregangkan ligamen longitudinal anterior, yang menjadi sumber utama nyeri tumpul (*dull ache*) di area pinggang (Cunningham et al., 2022).

b. Kelelahan otot dan Ketidakseimbangan Statis

1) Hiperaktivitas Otot Paraspinal

Postur lordosis yang menetap memaksa otot-otot penyangga punggung (paraspinal) untuk berkontraksi terus-menerus demi mempertahankan posisi tegak.

2) Iskemia Otot Lokal

Kontraksi tanpa relaksasi ini menghambat aliran darah ke jaringan otot, memicu penumpukan asam laktat, dan menyebabkan kelelahan otot kronis.

3) Faktor Pendukung (Diastasis Rekti)

Peregangan otot abdominal (perut) yang ekstrem melemahkan kemampuannya dalam menyangga berat uterus dari depan. Hal ini memaksa otot punggung bekerja sendirian tanpa bantuan otot perut (*core muscle*), sehingga memperberat nyeri (Lowdermilk et al., 2023).

c. Instabilitas Sendi Panggul dan Efek Relaxin

1) Laksitas Ligamen Panggul: Kadar hormon Relaxin mencapai puncaknya di akhir kehamilan, yang secara fisiologis melunakkan simfisis pubis dan sendi sakroiliaka untuk mempersiapkan jalan lahir.

2) Tekanan Kepala Janin: Masuknya kepala janin ke Pintu Atas Panggul (PAP) memberikan beban mekanis langsung pada sendi sakroiliaka yang sudah tidak stabil.

3) Radiasi Nyeri: Kondisi ini sering memicu nyeri tajam yang menjalar ke bokong atau paha bagian belakang (posterior pelvic pain), yang sering kali disalahartikan sebagai cedera saraf iskias (Bustos et al., 2023).

CLINICAL PEARLS: MANAJEMEN NYERI PUNGGUNG BAWAH

Tips Klinik: Ajarkan ibu teknik bangun dari tempat tidur yang benar, yaitu miringkan seluruh tubuh ke samping terlebih dahulu, lalu gunakan kekuatan lengan untuk mendorong tubuh ke posisi duduk. Hindari gerakan meniru sit-up.

Warning Sign: Waspadai keluhan nyeri punggung bawah yang datang berirama dengan intensitas yang meningkat secara periodik, karena ini sering kali merupakan manifestasi dari back labor pada persalinan preterm.

Common Mistake: Menggunakan kasur yang terlalu empuk karena dianggap nyaman, padahal kasur empuk memperparah distorsi kurvatura lumbal dan eksaserbasi nyeri punggung.

Tabel 2. 8 evidence Summary Stabilisasi Postural dan Biomekanika Lumbal

EVIDENCE SUMMARY BOX 4.3: STABILISASI POSTURAL DAN BIOMEKANIKA LUMBAL					
Intervensi EBP Non-Farmakologis	Level Evidence (Kepastian Bukti)	Mekanisme Kerja	Fisiologis	dan	Stabilisasi Eksternal

Penggunaan Maternity Support Belt	Level B (Quasi-Experimental Study)	Mendistribusikan beban mekanis abdomen secara merata ke area punggung dan panggul, menstabilkan cincin panggul, dan terbukti secara klinis menurunkan skor nyeri VAS secara signifikan (rata-rata 3,1 poin).
Aplikasi Kinesio Taping Lumbal	Level B (Randomized Controlled Trial)	Memberikan dukungan somatosensorik, propioseptif, dan mekanis eksternal tanpa membatasi ruang gerak anatomis, membantu ibu mempertahankan postur lumbal netral.
Prenatal Yoga dan Pelvic Tilting (Cat and Cow Pose)	Level B (Riset Klinis Komplementer)	Mobilisasi panggul (<i>pelvic rocking</i>) memobilisasi sendi lumbal, meregangkan otot paraspinal yang tegang, memanjangkan otot abdomen yang mengalami diastasis, serta mengoptimalkan sirkulasi uteroplasenta.
Optimasi Ergonomi & Body Mechanics	Level B (Pedoman Praktik Keperawatan)	Modifikasi postur mengangkat benda (jongkok dengan tumpuan otot paha, bukan membungkuk dari pinggang) meminimalkan gaya geser (<i>shear force</i>) pada diskus intervertebralis. Penggunaan bantal penyangga saat tidur miring mempertahankan alignment pelvis.

Tabel 2. 9 Skrining Safety Transisi Masalah Mekanis Vs Patologis

RED FLAGS BOX: SKRINING SAFETY TRANSISI MASALAH MEKANIS VS PATOLOGIS		
Kewaspadaan Persalinan Preterm (Back Labor)	Kecurigaan Infeksi Ginjal (Pielonefritis)	Kompresi Neurologis dan Vaskular Ekstrem
* **Nyeri Berirama (Periodik):** Nyeri punggung bawah yang datang-pergi	* **Nyeri Ketok Kostovertebra Positif:** Nyeri tajam terlokalisir saat perkusi ringan pada	* **Sciatica Berat (Kompresi Saraf Radiks):** Defisit sensorik berupa parastesia/sensasi terbakar

teratur meniru kram menstruasi. * **Penjaran Anterior:** Nyeri menjalar dari lumbal menuju area perut bagian depan (simfisis). * **Gejala Uterovaginal:** Disertai pengeluaran lendir darah (<i>bloody show</i>), rembesan cairan ketuban, atau tekanan panggul masif sebelum minggu ke-37.	sudut iga-belakang (area ginjal). * **Nyeri Unilateral Menetap:** Nyeri dominan pada satu sisi lumbal yang tidak responsif terhadap reposisi fisik. * **Respon Inflamasi Sistemik:** Disertai disuria, urine keruh berbau menyengat, demam tinggi, dan menggigil.	yang menjalar ke ujung ekstremitas, disertai defisit motorik nyata seperti kelemahan ekstrem (<i>foot drop</i>). * **Supine Hypotension Syndrome:** Nyeri punggung disertai pusing, dispnea, dan diaforesis saat posisi terlentang akibat oklusi Vena Cava Inferior.
--	--	--

Tabel 2. 10 Differential Diagnosis dan Parameter Pembeda Utama

Ketidaknyamanan Fisiologis	Diagnosis Banding Patologis (Red Flags)	Parameter Pembeda Utama (Kunci Pengkajian Klinis)
Emesis Gravidarum (Trimester I)	Hyperemesis Gravidarum (HEG) / Pielonefritis / Penyakit Tiroid Patologis (Graves)	* **HEG:** Keton urine positif ($\geq +1$), penurunan BB $>5\%$, tanda dehidrasi nyata (mukosa kering, oliguria). * **Pielonefritis:** Demam tinggi, menggigil, disuria, nyeri ketok sudut kostovertebra. * **Graves:** Ditemukan struma/goiter nyata pada leher, bukan sekadar Gestational Transient Thyrotoxicosis biasa.
Kram Kaki Fisiologis (Trimester II)	Deep Vein Thrombosis (DVT) / Hipokalsemia Berat	* **DVT:** Bengkak asimetris/unilateral hanya pada satu sisi kaki (selisih lingkar >2 cm), area kram tampak

		kemerahan (eritema), teraba panas (hipertermia lokal), dan Homan's Sign positif. * **Hipokalsemia:** Spasme karpopedal yang meluas ke area tangan dan wajah, disertai kelemahan otot ekstrem.
Nyeri Punggung Mekanis (Trimester III)	Persalinan Prematur (Back Labor) / Sciatica Berat	* **Persalinan Prematur:** Nyeri punggung bawah datang-pergi secara periodik/berirama teratur, menjalar ke perut depan, disertai pengeluaran bloody show atau rembesan ketuban sebelum minggu ke-37. * **Sciatica:** Defisit neurologis sensorik (kesemutan/kebas menjalar sampai ujung kaki) dan defisit motorik (foot drop).

2. Asuhan Keperawatan Berbasis Standar PPNI (3S)

a. Pengkajian Keperawatan (Analisis Data)

Pengkajian difokuskan pada evaluasi postur dan karakteristik nyeri guna membedakan nyeri punggung mekanis dengan nyeri akibat kontraksi atau gangguan ginjal.

1) Gejala dan Tanda Mayor (SDKI: Nyeri Akut)

Subjektif:

Mengeluh Nyeri: Ibu melaporkan nyeri tumpul atau pegal pada area pinggang (lumbar) yang meningkat di sore atau malam hari setelah beraktivitas.

Objektif:

- Tampak Meringis: Terutama saat berubah posisi (dari duduk ke berdiri).
- Bersikap Protektif: Ibu tampak menyangga punggung dengan tangan saat berjalan atau duduk.
- Gelisah: Kesulitan menemukan posisi nyaman untuk beristirahat.

2) Gejala dan Tanda Minor (SDKI: Gangguan Rasa Nyaman)

Subjektif:

- Keluhan Tidak Nyaman: Merasa berat pada perut bagian bawah dan pegal pada area sakroiliaka.

- b) Lelah: Kelelahan otot punggung akibat kompensasi lordosis yang lama.
Objektif:
- Postur Tubuh Berubah: Tampak kurvatura lordosis yang nyata pada tulang belakang lumbar.
 - Diastasis Rekti: Adanya celah pada otot perut (linea alba) saat dilakukan palpasi ringan (Lowdermilk et al., 2023).
- b. Diagnosis Keperawatan (SDKI)
Berdasarkan data pengkajian, diagnosis yang ditegakkan adalah:
- Nyeri Akut (D.0077) berhubungan dengan agen pencedera fisiologis (perubahan postur tubuh dan peregangan ligamen).
 - Gangguan Rasa Nyaman (D.0074) berhubungan dengan gangguan adaptasi kehamilan (pergeseran pusat gravitasi dan ketidakseimbangan otot). (PPNI, 2017).
- c. Luaran Keperawatan (SLKI): Tingkat nyeri menurun (L.08066).
Setelah dilakukan intervensi keperawatan selama 3x24 jam, diharapkan tingkat nyeri menurun dengan kriteria hasil: keluhan nyeri menurun, meringis menurun dibuktikan dengan skor skala nyeri VAS/NRS menurun dari skala 5 (sedang) menjadi ≤ 2 (ringan) dengan kriteria hasil:
- Keluhan nyeri menurun.
 - Meringis menurun.
 - Sikap protektif menurun.
 - Kemampuan menuntaskan aktivitas meningkat (PPNI, 2018b).
- d. Intervensi Keperawatan (SIKI)
Intervensi keperawatan mengkombinasikan manajemen nyeri (I.08238) dan edukasi aktivitas/istirahat (I.12362).

Tabel 2. 11 Matriks Intervensi dan Rasional Ilmiah Manajemen Nyeri Punggung Bawah

Kategori SIKI	Tindakan Keperawatan (SIKI)	Rasional Ilmiah Berbasis Bukti (EBP)
1) Observasi	(a) Kaji karakteristik nyeri punggung secara komprehensif (lokasi, durasi, frekuensi, kualitas, dan skala VAS/NRS).	Menilai derajat keparahan ketegangan otot paraspinal lumbar akibat kompensasi lordosis, serta membantu menetapkan rencana evaluasi yang terukur.
	(b) Periksa adanya kurvatura lordosis	Pemisahan otot perut (<i>diastasis rekti</i>) menghilangkan fungsi dinding perut

	lumbal yang menonjol dan ukur lebar celah <i>rectus abdominis</i> (diastasis rekti).	depan sebagai penyangga (<i>core support</i>), sehingga seluruh gaya statis uterus dibebankan pada otot punggung.
	(c) Wajib melakukan Skrining Red Flags Tanda Persalinan Prematur (pastikan nyeri punggung bawah tidak datang berirama, menetap, periodik, atau disertai rembesan cairan jalan lahir).	Threshold Keselamatan (Patient Safety): Memastikan nyeri lumbal murni gangguan mekanis muskuloskeletal, bukan manifestasi <i>back labor</i> (kontraksi rahim rahasia pada persalinan prematur) sebelum minggu ke-37.
2)Terapeutik	(a) Fasilitasi permukaan kasur atau matras latihan yang rata, padat, stabil, dan tidak empuk.	Matras yang padat menjaga kelurusan tulang belakang (<i>pelvic alignment</i>), sedangkan kasur yang terlalu empuk justru akan memperparah lengkungan lordosis lumbar.
	(b) Rekomendasikan penggunaan alat bantu eksternal berupa sabuk penyangga kehamilan (<i>Maternity Support Belt</i>).	Membantu mendistribusikan beban mekanis uterus ke panggul dan punggung secara merata, serta menstabilkan sendi sakroiliaka yang melunak akibat hormon <i>relaxin</i> .
3) Edukasi	(a) Demonstrasikan teknik latihan fisik spesifik <i>Pelvic Tilting / Pelvic Rocking</i> dengan posisi merangkak (<i>Cat and Cow Pose</i>) secara bertahap dan sinkron dengan pola napas.	Memobilisasi sendi lumbal, meregangkan serat otot <i>erector spinae</i> posterior yang tegang, serta memperkuat otot abdomen tanpa meningkatkan tekanan intra-abdomen berlebih.

	(b) Ajarkan mekanika tubuh (<i>Body Mechanics</i>) yang benar saat bangun dari tempat tidur (posisi miring ke samping dahulu, lalu gunakan lengan untuk mendorong tubuh ke posisi duduk).	Mencegah Komplikasi: Gerakan fleksi trunkus langsung (posisi terlentang langsung sit-up) memicu peningkatan tekanan intra-abdomen ekstrem yang dapat memperparah pemisahan <i>diastasis rekti</i> .
	(c) Ajarkan prinsip ergonomi saat mengambil benda di lantai (posisi menekuk kedua lutut/jongkok tegak, bukan membungkuk langsung dari pinggang).	Mengalihkan tumpuan beban mekanis pada kelompok otot paha (<i>quadriceps</i>) yang besar dan kuat, sehingga meminimalkan gaya geser (<i>shear force</i>) merusak pada diskus intervertebralis lumbal.
	(d) Anjurkan posisi tidur miring kiri dengan menggunakan bantal penyangga di bawah perut dan di antara kedua kaki.	Mempertahankan panggul tetap sejajar (<i>pelvic alignment</i>), mengurangi tarikan mekanis pada lumbal, serta mencegah penekanan uterus pada vena cava inferior (<i>Supine Hypotension Syndrome</i>).

1) Terapeutik: Modifikasi Biomekanika dan Latihan

a) Optimasi Posisi Tidur

Gunakan kasur atau matras yang datar dan padat untuk menjaga kelurusan tulang belakang. Hindari kasur yang terlalu empuk karena dapat memperparah lengkungan lumbal.

b) Latihan Spesifik (*Pelvic Tilt*)

Ajarkan teknik *Pelvic Tilt* (ayunan panggul) untuk meregangkan otot lumbal yang tegang dan memperkuat otot perut (Fiona, 2018).



Gambar 2. 8 Pelvic Tilt Exercise
Sumber: (Fiona, 2018)

2) Edukasi: *Body Mechanics* dan Perlindungan Punggung

a) Teknik Mengangkat Benda

Ajarkan ibu untuk menekuk lutut (posisi jongkok) saat mengambil benda di lantai, bukan membungkuk, agar beban ditopang oleh otot paha, bukan otot punggung.



Gambar 2. 9 Posisi saat mengangkat benda
Sumber: (NHS Lanarkshire Maternity Departement, 2022)

- b) Postur Berdiri dan Duduk: Anjurkan ibu untuk selalu menjaga tulang belakang tetap tegak saat berdiri (menarik bahu ke belakang, mengencangkan perut) dan duduk (menggunakan sandaran punggung dan kaki menapak lantai).



Gambar 2. 10 Postur Berdiri dan Duduk yang Benar

Sumber: (NHS Lanarkshire Maternity Departement, 2022)

- c) Posisi Tidur dan Penggunaan Penyangga: Gunakan bantal penyangga di bawah perut atau di antara kedua kaki saat tidur menyamping guna menjaga panggul tetap sejajar (*pelvic alignment*) dan mengurangi beban lumbar.



Gambar 2. 11 Posisi Berbaring/Tidur Miring dengan Bantal Penyangga

Sumber: (NHS Lanarkshire Maternity Departement, 2022)

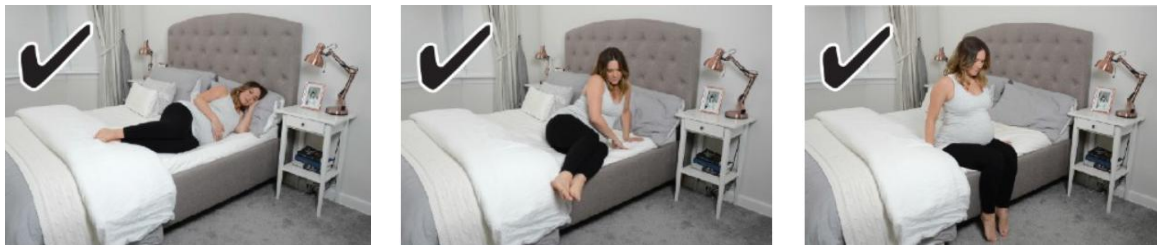
- d) Aktivitas Rumah Tangga

Modifikasi cara melakukan pekerjaan, misalnya saat merapikan tempat tidur: Ajarkan ibu untuk berlutut di samping tempat tidur saat memasang sprei atau merapikan selimut, daripada membungkuk dari pinggang. Contoh lainnya, ketika ibu mengambil cucian dari mesin cuci: Ajarkan ibu untuk jongkok di depan mesin cuci bukaan depan (*front-load*), atau menggunakan kursi kecil saat mengambil pakaian, untuk menghindari posisi membungkuk yang ekstrem



Gambar 2. 12 Body Mechanics dalam Pekerjaan Rumah Tangga
Sumber: (NHS Lanarkshire Maternity Departement, 2022)

- e) Teknik Bangun dan Turun dari Tempat Tidur: Ajarkan ibu untuk selalu bangun tidur dari posisi miring. Hindari langsung bangun dari posisi terlentang (*sit-up*).



Gambar 2. 13 Teknik Bangun dan Turun dari Tempat Tidur
Sumber: (NHS Lanarkshire Maternity Departement, 2022)

- f) Penggunaan Penyangga (*Supportive Aids*)
Anjurkan penggunaan bantal penyangga di bawah perut atau di antara kedua kaki saat tidur menyamping guna menjaga panggul tetap sejajar.
- g) Modifikasi Aktivitas
Hindari penggunaan sepatu hak tinggi (*high heels*) yang dapat memperparah pergeseran pusat gravitasi, serta batasi durasi berdiri atau duduk terlalu lama tanpa jeda istirahat. (Cunningham et al., 2022; PPNI, 2018a)

3. Implementasi Evidence-Based Practice (EBP)

Integrasi EBP pada trimester III berfokus pada stabilisasi eksternal dan manajemen beban:

a. Penggunaan Maternity Support Belt

Penggunaan sabuk penyangga modifikasi secara signifikan menurunkan skor nyeri (VAS) sebesar 3,1 poin. Intervensi ini bekerja dengan mendistribusikan beban abdomen secara merata ke area punggung dan panggul, sehingga menstabilkan cincin panggul dan mengurangi ketegangan pada ligamen sakroiliaka (Paisal et al., 2025).



Gambar 2. 14 Maternity Support Belt

Sumber: (Ebay shop, n.d.)

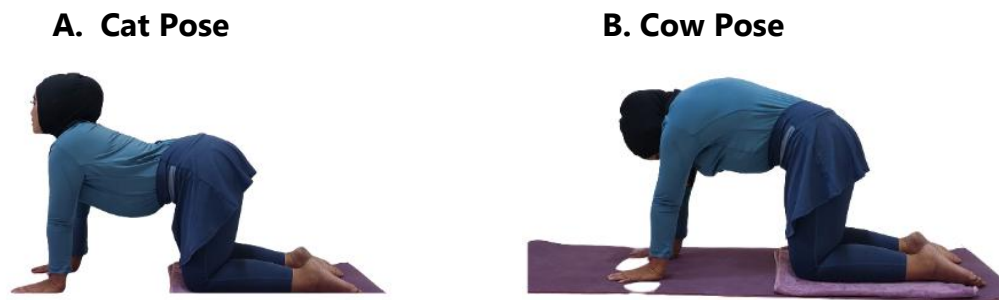
b. Aplikasi *Kinesio Taping* pada area lumbal

Kinesio Taping terbukti secara klinis mampu menurunkan intensitas nyeri dan tingkat disabilitas fisik pada ibu hamil secara signifikan. *Kinestio Taping* bekerja dengan memberikan dukungan mekanis dan proprioseptif tanpa membatasi ruang gerak, sehingga membantu ibu mempertahankan postur tubuh yang lebih netral selama trimester ketiga (Kaplan et al., 2016).

c. Prenatal Yoga

Praktik prenatal yoga secara sistematis memperbaiki postur dan memperkuat otot-otot panggul serta punggung bawah. Hal ini mengurangi ketegangan muskuloskeletal sekaligus meningkatkan sirkulasi utero-plasenta yang bermanfaat bagi pertumbuhan janin (Patni dan Sinha, 2023).

Salah satu variasi dinamis dari latihan pelvic tilt adalah gerakan *Cat and Cow Pose*. Latihan ini berfokus pada mobilisasi panggul (*pelvic rocking*) dan peregangan tulang belakang. *Cat pose* dilakukan dengan menunduk atau melengkungkan punggung ke atas. Gerakan ini secara aktif menarik tulang ekor ke bawah (*anterior pelvic tilt*) dan menguatkan otot perut, memberikan peregangan yang sangat dibutuhkan pada otot lumbal yang tegang. *Cow Pose* dilakukan dengan menengadahkan atau menurunkan perut. Gerakan ini membantu memanjangkan otot abdomen (perut) dan melancarkan mikrosirkulasi di area panggul (Nurasih et al., 2025).



Gambar 2. 15 Cat and Cow Pose
Sumber: (Dokumentasi Pribadi, 2023)

d. Optimasi Mekanika Tubuh dan Alas Kaki

Edukasi penggunaan sepatu dengan tumit rendah (2–3 cm) sangat penting pada Trimester III untuk mencegah pergeseran pusat gravitasi lebih jauh ke depan, yang merupakan pemicu utama kelelahan otot paraspinal dan instabilitas postur. Selain itu, penggunaan bantal penyangga di bawah abdomen saat tidur menyamping secara klinis terbukti mengurangi tarikan mekanis pada tulang belakang lumbar, sehingga menurunkan intensitas nyeri saat bangun tidur (Lowdermilk et al., 2023).

4. Skrining Tanda Bahaya (Red Flags)

Perawat harus mampu membedakan nyeri punggung mekanis akibat perubahan postur dengan nyeri patologis yang memerlukan intervensi medis segera.

a. Kewaspadaan Persalinan Prematur

Nyeri punggung sering kali merupakan tanda awal kontraksi uterus yang tidak disadari oleh ibu hamil.

1) Karakteristik Nyeri Periodik

- Nyeri Berirama: Nyeri punggung yang datang dan pergi secara teratur (seperti kram menstruasi) dan intensitasnya semakin meningkat.
- Penyebaran Nyeri: Nyeri yang berawal dari punggung bawah dan menjalar ke arah perut bagian depan (simfisis).

2) Gejala Penyerta Uterovaginal

- Perubahan Cairan Pervaginam: Keluar lendir bercampur darah (*bloody show*) atau rembesan cairan ketuban.
- Tekanan Panggul: Perasaan seperti bayi mendorong ke bawah secara terus-menerus sebelum waktunya (sebelum minggu ke-37).

b. Infeksi Saluran Kemih Atas (Pielonefritis)

Letak ginjal yang berdekatan dengan area lumbar sering kali menyebabkan nyeri ginjal dikelirukan dengan nyeri punggung biasa.

1) Lokasi dan Karakteristik Spesifik

- Nyeri Ketok Kostovertebra: Nyeri tajam yang dirasakan saat perawat melakukan perkusi ringan pada sudut iga-belakang (area ginjal).
- Nyeri Unilateral: Nyeri yang lebih dominan pada satu sisi punggung (kanan atau kiri) dan tidak berkurang dengan perubahan posisi.

2) Gejala Sistemik

- Gangguan Eliminasi Urin: Keluhan nyeri saat berkemih (disuria) atau urin yang tampak keruh dan berbau menyengat.
- Respon Inflamasi: Disertai dengan demam, menggigil, atau mual-muntah yang baru muncul di Trimester III.

c. Komplikasi Neurologis dan Vaskular

Tekanan uterus yang ekstrem dapat menekan saraf atau pembuluh darah besar.

1) Kompresi Saraf Berat (Sciatica)

- Defisit Sensorik: Rasa kesemutan, mati rasa (kebas), atau sensasi terbakar yang menjalar hingga ke ujung kaki.
- Defisit Motorik: Kelemahan pada kaki hingga ibu sulit untuk mengangkat kaki saat berjalan (*foot drop*).

2) Sindrom Hipotensi Supine

- Gejala Saat Berbaring: Nyeri punggung yang disertai pusing, sesak napas, dan keringat dingin saat ibu tidur terlentang (akibat penekanan vena cava inferior oleh uterus).
- Tindakan: Segera miringkan ibu ke sisi kiri untuk memulihkan curah jantung (Cunningham et al., 2022).

E. Prosedur Keperawatan (Standar Operasional Prosedur)

1. Standar Operasional Prosedur Edukasi dan Demonstrasi Manajemen Muntah Non-Farmakologis

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra Interaksi				
1	Mengecek catatan medis terkait riwayat				

	emesis gravidarum dan asupan nutrisi.				
2	Menyiapkan alat: Kuesioner PUQE-24, media edukasi (Leaflet diet dan aromaterapi), sampel jahe/aromaterapi lemon.				
3	Mencuci tangan				
B	Tahap Orientasi				
4	Menyampaikan salam terapeutik				
5	Menyampaikan nama dan peran perawat				
6	Mengecek identitas pasien, minimal nama ibu dan umur				
7	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
8	Memberikan kesempatan bertanya				
9	Memulai tindakan dengan baik				
10	Menjaga privasi dan kenyamanan ibu				
C	Tahap Kerja				
11	Pengkajian Fokus: Mengkaji keluhan mual muntah menggunakan instrumen PUQE-24 (24 jam terakhir).				

12	Skrining Red Flags: Observasi tanda bahaya apabila terdapat dehidrasi berat (mata cekung, turgor buruk), penurunan BB >5%, atau muntah bercampur darah.				
13	Keputusan Klinis: Jika skor PUQE-24 ≥ 13 (kategori berat), terdapat tanda dehidrasi klinis, ketonuria positif, atau penurunan BB >5%, segera kolaborasi medis/rujuk. Jika <13, lanjutkan edukasi.				
14	Edukasi Diet: Menganjurkan makan kraker/biskuit kering 15-20 menit sebelum bangun dari tempat tidur dan pola <i>small frequent feeding</i> (porci kecil tapi sering, 5-6 kali sehari).				
15	Edukasi Pemisahan Cairan: Menganjurkan minum di antara waktu makan (bukan saat makan) untuk				

	mencegah distensi lambung.				
16	Demonstrasi Aromaterapi: Mengajarkan cara menghirup uap jahe atau minyak esensial lemon selama 5-10 menit saat mual muncul.				
17	Lokalisasi Titik P6 (Neiguan): Mengajarkan cara mencari titik P6 (terletak 3 jari di bawah pergelangan tangan, di antara dua tendon otot palmaris longus).				
18	Demonstrasi Akupresur P6: Melakukan penekanan lembut namun mantap pada titik P6 selama 2-5 menit secara sirkular (bisa menggunakan ibu jari atau <i>sea-band</i>).				
19	Edukasi Mandiri: Menganjurkan ibu melakukan akupresur P6 secara mandiri 3 kali sehari atau saat sensasi mual mulai terasa kuat.				

20	Modifikasi Lingkungan: Edukasi cara menghindari pemicu bau (<i>hiperosmia</i>) dan memastikan sirkulasi udara yang baik di rumah.				
D	Tahap Terminasi				
21	Menyimpulkan kegiatan				
22	Mengevaluasi respon ibu (subjektif: skala mual, objektif: kemampuan menyusun jadwal makan kecil).				
23	Memberikan <i>reinforcement</i> positif				
24	Membuat kontrak selanjutnya				
25	Mengakhiri tindakan dengan baik				
E	Tahap Dokumentasi				
26	Mencatat hari, tanggal, jam, skor PUQE-24, hasil edukasi, dan rencana tindak lanjut.				
27	Sikap: Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif.				

MEDIA PEMBELAJARAN DIGITAL

Pindai QR Code / Barcode berikut untuk langkah-langkah prosedur edukasi dan demonstrasi manajemen mual muntah non-farmakologis dan menyaksikan video tindakan akupresur pada titik perikardium (P6):



SOP 1

myqrcode.mobi/d2dac996



**Video Akupresure Titik P6
(Neiguan)**

2. Standar Operasional Prosedur Edukasi dan Demonstrasi Teknik Dorsifleksi dan Ankle Pumping

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra Interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: media edukasi				
3	Mencuci tangan				
B	Tahap Orientasi				
4	Menyampaikan salam terapeutik				
5	Menyampaikan nama dan peran perawat				
6	Mengecek identitas pasien, minimal nama ibu dan umur				

7	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
8	Memberikan kesempatan bertanya				
9	Memulai tindakan dengan baik				
10	Menjaga privasi dan kenyamanan ibu				
C	Tahap Kerja				
11	Pengkajian Fokus: Identifikasi frekuensi kram dan durasi terjadinya.				
12	Skrining Red Flags (DVT): Observasi tanda bahaya apabila ditemukan edema asimetris unilateral (selisih lingkar betis >2 cm), hipertermia lokal, eritema, dan tanda Homan positif.				
13	Keputusan Klinis: Lanjutkan teknik dorsofleksi hanya jika tanda DVT negatif. Jika positif, segera lakukan eskalasi/lapor dokter.				
14	Menjelaskan tujuan Dorsifleksi untuk meregangkan otot Gastrocnemius.				
15	Mendemonstrasikan posisi kaki lurus dan				

	menarik jari-jari ke arah lutut sambil menjaga keseimbangan tubuh ibu (pegangan pada kursi/bed).				
16	Menganjurkan latihan Ankle Pumping rutin untuk melancarkan sirkulasi vena (mencegah edema).				
17	Edukasi penggunaan alas kaki hak rendah.				
D	Tahap Terminasi				
18	Menyimpulkan kegiatan				
19	Mengevaluasi respon ibu secara subjektif dan objektif				
20	Memberikan <i>reinforcement</i> positif				
21	Membuat kontrak selanjutnya				
22	Mengakhiri tindakan dengan baik				
E	Tahap Dokumentasi				
23	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pengkajian singkat, kegiatan edukasi dan demonstrasi teknik dorsofleksi dan latihan ankle pumping, respon ibu serta tindak lanjut				

24	Sikap: Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif.				
----	---	--	--	--	--

MEDIA PEMBELAJARAN DIGITAL

Pindai QR Code / Barcode berikut untuk langkah-langkah prosedur Edukasi dan demonstrasi teknik dorsifleksi dan ankle pumping dan menyaksikan video latihan dorsofleksi dan ankle pumping:



myqrcode.mobi/d81e9ee1



Video Latihan dorsofleksi betis dan Ankle Pumping

3. Standar Operasional Prosedur Edukasi dan Demonstrasi Latihan Pelvic Tilting serta Postur Tubuh

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra Interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan terkait keluhan nyeri punggung bawah.				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: Matras/alas datar, media edukasi				

	(leaflet/poster body mechanics).				
3	Mencuci tangan				
B	Tahap Orientasi				
4	Menyampaikan salam terapeutik				
5	Menyampaikan nama dan peran perawat				
6	Mengecek identitas pasien, minimal nama ibu dan umur				
7	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
8	Memberikan kesempatan bertanya				
9	Memulai tindakan dengan baik				
10	Menjaga privasi dan kenyamanan ibu				
C	Tahap Kerja				
11	Pengkajian Fokus: Identifikasi lokasi nyeri, skala nyeri (0-10), dan faktor yang memperberat nyeri punggung.				
12	Skrining Red Flags: Observasi tanda bahaya apabila terdapat nyeri bersifat periodik/berirama (menandakan back labor persalinan				

	preterm) atau disertai nyeri ketok sudut kostovertebra (tanda infeksi ginjal).				
13	Keputusan Klinis: Lanjutkan latihan jika nyeri bersifat mekanis (akibat postur). Tunda jika ada tanda kontraksi prematur.				
14	Menjelaskan tujuan Pelvic Tilting untuk meregangkan otot lumbal dan memperkuat otot perut.				
15	Demonstrasi Pelvic Tilting: Mengajarkan posisi merangkak, melengkungkan punggung ke atas (napas masuk) dan mendatarkan punggung (napas keluar).				
16	Demonstrasi Bangun Tidur: Mengajarkan teknik bangun dari posisi miring (bukan sit-up)				
17	Demonstrasi Body Mechanics: Mencontohkan posisi jongkok saat mengambil benda dan posisi				

	duduk/berdiri yang tegak.				
18	Aktivitas Rumah Tangga: Demonstrasi cara merapikan tempat tidur (berlutut) dan mengambil cucian (duduk/jongkok).				
D	Tahap Terminasi				
19	Menyimpulkan kegiatan				
20	Mengevaluasi respon ibu (subjektif: kenyamanan, objektif: kemampuan demonstrasi ulang)				
21	Memberikan <i>reinforcement</i> positif				
22	Membuat kontrak selanjutnya				
23	Mengakhiri tindakan dengan baik				
E	Tahap Dokumentasi				
24	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pengkajian, materi edukasi, serta respon ibu.				
25	Sikap: Aman, nyaman, cermat, teliti, tepat, responsif.				

MEDIA PEMBELAJARAN DIGITAL

Pindai QR Code / Barcode berikut untuk langkah-langkah prosedur edukasi dan demonstrasi latihan pelvic tilting serta postur tubuh dan menyaksikan video demonstrasi latihan pelvic tilting (gerakan cat and cow):



F. Aktivitas Pembelajaran Klinik (Case-Based Learning dan Praktikum)

1. Aktivitas 1. Knows How

Skenario Kasus 1: Emesis Gravidarum (Trimester I)

Kasus:

Ny. A (22 tahun), G1P0A0 hamil 8 minggu, datang ke puskesmas dengan keluhan mual dan muntah yang memburuk dalam 3 hari terakhir. Ibu melaporkan muntah 3-4 kali sehari, terutama saat mencium aroma masakan dan saat bangun tidur di pagi hari.

Hasil Pengkajian Fokus:

a. Skor PUQE-24 jam

Total 11 poin. Rincian data: durasi mual berkisar 2–3 jam/hari (skor 3), frekuensi muntah 3–4 kali/hari (skor 3), dan mengalami muntah kering (retching) selama 3–6 jam/hari (skor 5)

b. Pemeriksaan Fisik

Tekanan Darah 110/70 mmHg, Nadi 88 x/menit, turgor kulit baik (elastis), mukosa bibir lembap. Berat badan turun 0,5 kg sejak awal kehamilan.

c. Riwayat Kebiasaan

Ny. A langsung minum air putih hangat dalam jumlah banyak sekaligus saat bangun tidur untuk menghilangkan rasa pahit di mulut, namun aktivitas ini justru langsung memicu refleks muntah.

Pertanyaan Diskusi Klinis (Clinical Reasoning Challenge):

a. Analisis Derajat Keparahan (C4)

Berdasarkan total skor PUQE-24 jam yang didapatkan (11 poin), interpretasikan kategori derajat keparahan emesis yang dialami oleh Ny. A! Analisis pula seluruh data pemeriksaan fisik pasien (safety screening) untuk menetapkan apakah Ny. A cukup diberikan asuhan rawat jalan atau harus segera dirujuk untuk rawat inap!

b. Evaluasi Modifikasi Perilaku dan Diet (C5)

Identifikasi kesalahan pada riwayat kebiasaan perilaku Ny. A saat bangun tidur di pagi hari yang memperberat keluhan mual muntahnya! Sebagai perawat, berikan rekomendasi strategi nutrisi non-farmakologis (Dry Food Intervention) yang tepat dan jelaskan alasan rasional ilmiahnya!

c. Sintesis Diagnosis & Mekanisme EBP (C6)

Tegakkan diagnosis keperawatan utama berdasarkan Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) untuk Ny. A! Jelaskan pula secara komprehensif bagaimana mekanisme fisiologis penekanan titik akupresur Perikardium 6 (P6) dapat memodulasi dan menghambat sinyal emetik pada sistem saraf pusat!

Skenario Kasus 2: Kram kaki (Trimester II)

Kasus:

Ny. M (26 tahun), G2P1A0 hamil 24 minggu (Trimester II), datang ke poli KIA dengan keluhan sering mengalami kram mendadak pada betis kanannya, terutama pada malam hari menjelang tidur atau saat ia tidak sengaja meluruskan ujung kakinya (plantar flexion). Ny. M merasa khawatir karena ia merasa frekuensi kram kali ini jauh lebih sering muncul dibanding kehamilan pertamanya. Ia juga mengeluh kedua tungkai bawahnya terasa sangat pegal setelah bekerja seharian sebagai guru.

Hasil pengkajian Fokus:

a. Karakteristik Spasme

Kram terjadi 3–4 kali dalam seminggu dengan durasi kaku sekitar 1–2 menit per serangan. Ny. M tampak meringis menahan sakit saat mencoba meregangkan kakinya.

b. Skrining Safety Vaskular

Inspeksi dan palpasi pada betis kanan tidak memperlihatkan adanya edema unilateral yang ekstrem, area kulit tidak tampak kemerahan (eritema), suhu kulit teraba hangat merata (Skrining DVT Negatif).

c. Riwayat Tatalaksana

Ny. M belum mengetahui cara penanganan kram yang aman secara mandiri selain meminta suaminya memijat betis kanannya dengan tekanan yang sangat kuat saat serangan kram muncul.

Pertanyaan Diskusi (Clinical Reasoning Challenge):

a. Analisis Patofisiologi dan Elektrolit (C4)

Analisis perubahan adaptasi vaskular-mekanis akibat pembesaran uterus dan gangguan rasio elektrolit (Kalsium, Magnesium, Fosfor) yang menjadi fondasi pemicu terjadinya hipereksitabilitas neuromuskular (*nocturnal cramps*) pada Ny. M di Trimester II!

b. Evaluasi Threshold Safety Keperawatan (C5)

Mengapa perawat diwajibkan melakukan skrining inspeksi asimetris dan penapisan komplikasi vaskular patologis (DVT) secara ketat sebelum mengajarkan atau mengeksekusi latihan fisik regangan pada kaki ibu hamil? Analisis risiko klinis yang mengancam nyawa jika skrining ini diabaikan!

c. Sintesis Manajemen Intervensi Berbasis Bukti (C6)

Tegakkan diagnosis keperawatan prioritas utama berdasarkan Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) untuk Ny. M! Jelaskan secara anatomis-biomekanika mengapa teknik Dorsofleksi Akut terbukti jauh lebih efektif, rasional, dan aman untuk menghentikan spasme otot betis secara instan dibandingkan dengan metode pemijatan jaringan kuat (*deep tissue massage*)!

Skenario Kasus 3: Nyeri Punggung Bawah (Trimester III)

Kasus:

Ny. Q (30 tahun), G3P2A0 hamil 34 minggu, datang mengevaluasi diri ke poli KIA dengan keluhan utama nyeri tumpul yang berat pada area pinggang menjalar hingga ke bokong. Ibu melaporkan rasa nyeri semakin memberat saat ia harus berdiri dalam waktu lama atau saat hendak beranjak bangun dari posisi duduk. Ny. Q merasa sangat khawatir and cemas karena gangguan ketidaknyamanan fisik ini membuatnya sangat kesulitan untuk beristirahat tidur dengan nyenyak di malam hari.

Hasil Pengkajian Fokus:

a. Postur dan Biomekanika

Saat diobservasi, tampak kurvatura lordosis lumbar yang sangat menonjol pada kolumna vertebralis Ny. Q. Saat perawat melakukan palpasi ringan pada dinding perut anterior, ditemukan adanya celah pemisahan selebar 2 jari pada otot rectus abdominis sepanjang linea alba (Diastasis Rekti).

b. Pengkajian Nyeri dan Mekanika Tubuh

Skala nyeri dilaporkan berada pada skor 5 dari rentang rentang (0–10). Saat diminta mengambil tas kosmetiknya yang jatuh di lantai, Ny. Q tampak langsung melakukan gerakan membungkuk dari pinggang secara mendadak dengan posisi kaki lurus tanpa menekuk lutut sama sekali. Aktivitas ini seketika memicu pasien meringis kesakitan.

c. Skrining Safety Uterovaginal

Hasil palpasi abdomen menunjukkan uterus teraba lunak (tidak ada kontraksi prematur), nyeri dilaporkan mereda / hilang saat pasien beristirahat dalam posisi berbaring miring, serta tidak ditemukan pengeluaran lendir darah ataupun cairan pervaginam.

Pertanyaan Diskusi Klinis (Clinical Reasoning Challenge):

a. Analisis Biomekanika Postural (C4)

Analisis kaitan patofisiologi antara keberadaan pemisahan otot perut (Diastasis Rekti) selebar 2 jari dengan hilangnya fungsi stabilitas dinding penyangga abdominal terhadap beban mekanis tulang belakang Ny. Q dalam mempertahankan postur tegak! Jelaskan pula jaras oklusi sirkulasi paraspinal yang melandasi timbulnya rasa nyeri tumpul kronis tersebut!

b. Evaluasi Diferensial Diagnosis dan Safety (C5)

Susunlah analisis pembeda klinis untuk membuktikan bahwa keluhan nyeri lumbal Ny. Q murni gangguan mekanis muskuloskeletal kehamilan biasa, and bukan merupakan manifestasi dari tanda bahaya (Red Flags) kegawatdaruratan kontraksi persalinan prematur (back labor) atau pielonefritis!

c. Sintesis Modifikasi Perilaku dan Care Plan 3S (C6)

Tegakkan diagnosis keperawatan prioritas utama berdasarkan Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI) untuk Ny. Q! Susunlah rencana edukasi Body Mechanics harian (termasuk cara merapikan tempat tidur, mengambil cucian, and teknik bangun dari kasur) serta demonstrasikan langkah latihan spesifik Pelvic Tilting (*Cat and Cow Pose*) yang aman guna meminimalkan tekanan kompresi pada diskus intervertebralis pasien!

2. Aktivitas 2. Shows How (Simulasi/Skill Lab dan OSCE)

Fokus pada demonstrasi klinis dan edukasi pasien berdasarkan skenario kasus pada Aktivitas 1. Mahasiswa dibagi menjadi kelompok kecil untuk mensimulasikan peran perawat dan pasien.

Asesment (Piramida Miller):

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check + analisis mini-case (aktivitas 1)
Shows How	OSCE Edukasi dan Demonstrasi Intervensi Mandiri (SOP 1,2,3)

Panduan Simulasi Berdasarkan Kasus:

- a. Simulasi Kasus 1: Manajemen Mual Muntah (Trimester I)
 - 1) Instruksi Mahasiswa: Demonstrasikan cara pengkajian PUQE-24 dan edukasi teknik akupresur P6.
 - 2) Critical Items (Wajib Lulus):
 - a) Melakukan pengkajian PUQE-24 dengan benar.
 - b) Menentukan lokasi titik P6 secara akurat (3 jari di bawah pergelangan tangan).
 - c) Edukasi diet *small frequent feeding* dan penggunaan aromaterapi.
- b. Simulasi Kasus 2: Manajemen Kram Kaki (Trimester II)
 - 1) Instruksi Mahasiswa: Demonstrasikan teknik dorsofleksi saat kram terjadi dan skrining tanda DVT.
 - 2) Critical Items (Wajib Lulus):
 - a) Melakukan inspeksi unilateral pada betis (skrining tanda DVT: bengkak, merah, panas).
 - b) Mendemonstrasikan teknik Dorsofleksi yang benar (menarik jari kaki ke arah lutut).
 - c) Edukasi pencegahan kram (hindari plantar fleksi berlebihan dan asupan kalsium).
- c. Simulasi Kasus 3: Manajemen Nyeri Punggung (Trimester III)
 - 1) Instruksi Mahasiswa: Demonstrasikan latihan *Pelvic Tilting* dan edukasi *Body Mechanics* harian.
 - 2) Critical Items (Wajib Lulus):
 - a) Mendemonstrasikan teknik *Pelvic Tilt* posisi merangkak dengan benar.
 - b) Edukasi *Body Mechanics* saat bangun tidur (posisi miring) dan mengangkat benda (jongkok).
 - c) *Skrining Red Flags* (membedakan nyeri punggung dengan kontraksi persalinan).
3. Aktivitas 3: Does (Aplikasi Klinis dan Dokumentasi)

Bagian ini menggabungkan tindakan langsung dan bukti pengerjaan asuhan:

 - a. Penerapan *Direct Observation of Procedural Skills* (DOPS): Observasi langsung oleh dosen saat mahasiswa melakukan tindakan (misal: teknik P6 atau Pelvic Tilting) menggunakan lembar penilaian yang tersedia.

1) DOPS Asuhan Keperawatan pada Ibu Hamil dengan masalah Mual dan Muntah

Komponen	Deskripsi	Contoh pada kasus Ibu Hamil dengan Mual dan Muntah
Metode Penilaian	Observasi langsung secara sistematis terhadap keterampilan klinis mahasiswa saat berinteraksi dengan pasien nyata di lahan praktik.	Pembimbing/CI mengamati mahasiswa saat melakukan pengkajian mual muntah (menggunakan skor PUQE-24 jam) dan memberikan intervensi non-farmakologis (seperti akupresur P6 atau edukasi diet) di Poli KIA.
Tujuan Penilaian	Menilai kompetensi psikomotor, komunikasi, dan kemampuan penalaran klinis mahasiswa dalam menangani keluhan spesifik secara aman dan efektif.	Menilai apakah mahasiswa mampu menentukan tingkat keparahan mual muntah (skor PUQE-24 jam) dan mendemonstrasikan teknik akupresur P6 secara akurat kepada ibu.
Kasus klinik	Kasus nyata yang ditemukan di lahan praktik sesuai dengan tingkat capaian pembelajaran.	Ny. A, G1P0A0, hamil 8 minggu, mengeluh mual muntah setiap pagi (skor PUQE-24 jam = 11), tampak lemas namun tanda dehidrasi negatif.
Aktivitas Mahasiswa yang diamati	Seluruh rangkaian interaksi klinis, mulai dari pengkajian hingga pemberian edukasi/tindakan.	Mahasiswa menghitung skor PUQE-24 jam, melakukan inspeksi tanda dehidrasi, lalu mengajarkan teknik akupresur P6 dan modifikasi pola makan small frequent feeding.
Aspek yang dinilai	Meliputi keterampilan prosedur, komunikasi	Ketepatan menentukan lokasi titik P6 (3 jari di

	terapeutik, organisasi alat/tindakan, dan profesionalisme.	bawah pergelangan tangan), kejelasan instruksi diet kering (biskuit) sebelum bangun tidur, dan empati terhadap kondisi ibu.
Fokus observasi pembimbing	Penekanan pada aspek kritis (critical items) dan keselamatan pasien (patient safety).	Pembimbing memastikan mahasiswa mampu mengenali Red Flags (kapan mual biasa berubah menjadi Hiperemesis yang butuh rujukan) dan memastikan penekanan akupresur tidak menyakitkan.
Umpan balik	Diskusi konstruktif antara pembimbing dan mahasiswa segera setelah tindakan selesai.	"Penentuan titik P6 sudah sangat akurat, namun tadi kamu perlu lebih menekankan pentingnya memisahkan asupan cairan dan makanan padat agar lambung tidak terlalu penuh."
Keputusan penilaian	Penentuan tingkat kompetensi berdasarkan skala performa yang ditetapkan.	Kompeten: Jika mahasiswa mampu melakukan skrining PUQE-24 dan demonstrasi akupresur secara mandiri, sistematis, serta komunikatif.
Makna dalam OBE	Bukti autentik bahwa mahasiswa telah mencapai hasil belajar (outcome) yang diharapkan pada situasi klinis nyata.	Menjamin bahwa lulusan benar-benar mampu memberikan asuhan mandiri untuk mengatasi emesis gravidarum secara efektif tanpa hanya mengandalkan obat-obatan.

2) DOPS Asuhan Keperawatan pada Ibu Hamil dengan masalah Kram Kaki

Komponen	Deskripsi	Contoh pada kasus Ibu Hamil dengan Kram Kaki
Metode Penilaian	Observasi langsung secara sistematis terhadap keterampilan klinis mahasiswa saat berinteraksi dengan pasien nyata di lahan praktik.	Pembimbing/CI mengamati mahasiswa saat memberikan intervensi mandiri (seperti teknik peregangan atau pemijatan ringan) pada ibu hamil yang mengeluh kram kaki di Poli KIA.
Tujuan Penilaian	Menilai kompetensi psikomotor, komunikasi, dan kemampuan penalaran klinis mahasiswa dalam menangani keluhan spesifik secara aman dan efektif.	Menilai apakah mahasiswa mampu mengidentifikasi penyebab kram (seperti sirkulasi atau defisiensi kalsium) dan mendemonstrasikan cara mengatasi kram dengan benar kepada ibu.
Kasus klinik	Kasus nyata yang ditemukan di lahan praktik sesuai dengan tingkat capaian pembelajaran.	Ny. M, G2P1A0, hamil 24 minggu, mengeluh sering mengalami kram pada betis terutama saat malam hari atau saat meluruskan ujung jari kaki (plantar fleksi).
Aktivitas Mahasiswa yang diamati	Seluruh rangkaian interaksi klinis, mulai dari pengkajian hingga pemberian edukasi/tindakan.	Mahasiswa melakukan pengkajian durasi kram, memeriksa adanya tanda Homan's Sign (untuk menyingkirkan risiko trombosis), lalu mengajarkan teknik dorso-fleksi kaki untuk meredakan kram.
Aspek yang dinilai	Meliputi keterampilan prosedur, komunikasi terapeutik, organisasi	Ketepatan teknik peregangan otot betis, kejelasan instruksi saat

	alat/tindakan, dan profesionalisme.	edukasi nutrisi (tinggi kalsium dan magnesium), dan empati terhadap rasa nyeri yang dirasakan ibu.
Fokus observasi pembimbing	Penekanan pada aspek kritis (critical items) dan keselamatan pasien (patient safety).	Pembimbing memastikan mahasiswa memberikan saran yang aman (misal: tidak memijat terlalu keras pada area betis jika ada risiko varises) dan memastikan posisi ibu stabil saat latihan.
Umpan balik	Diskusi konstruktif antara pembimbing dan mahasiswa segera setelah tindakan selesai.	"Teknik peregangan yang kamu ajarkan sudah tepat, namun tadi kamu lupa menanyakan asupan susu/kalsium ibu. Pastikan lain kali hal itu dikaji juga ya."
Keputusan penilaian	Penentuan tingkat kompetensi berdasarkan skala performa yang ditetapkan.	Kompeten: Jika mahasiswa mampu melakukan edukasi dan demonstrasi penanganan kram secara mandiri, runtut, dan komunikatif tanpa arahan berlebih.
Makna dalam OBE	Bukti autentik bahwa mahasiswa telah mencapai hasil belajar (outcome) yang diharapkan pada situasi klinis nyata.	Menjamin bahwa lulusan benar-benar bisa memberikan asuhan mandiri pada ibu hamil, bukan sekadar menghafal teori tentang penyebab kram kaki.

3) DOPS Asuhan Keperawatan pada Ibu Hamil dengan masalah Nyeri Punggung Bawah

Komponen	Deskripsi	Contoh pada kasus Ibu Hamil dengan Nyeri Punggung Bawah
Metode Penilaian	Observasi langsung secara sistematis terhadap keterampilan klinis mahasiswa saat berinteraksi dengan pasien nyata di lahan praktik.	Pembimbing/CI mengamati mahasiswa saat melakukan pengkajian postur dan memberikan intervensi <i>body mechanics</i> serta latihan fisik pada ibu hamil di unit rawat jalan atau poli KIA.
Tujuan Penilaian	Menilai kompetensi psikomotor, komunikasi, dan kemampuan penalaran klinis mahasiswa dalam menangani keluhan spesifik secara aman dan efektif.	Menilai apakah mahasiswa mampu mengidentifikasi penyebab nyeri (pergeseran <i>center of gravity</i>) dan mendemonstrasikan teknik Pelvic Tilting serta <i>body mechanics</i> yang benar.
Kasus klinik	Kasus nyata yang ditemukan di lahan praktik sesuai dengan tingkat capaian pembelajaran.	Ny. Q, G3P2A0, hamil 34 minggu, mengeluh nyeri punggung bawah yang menjalar ke bokong, tampak postur lordosis yang nyata dan sulit bangun dari posisi duduk.
Aktivitas Mahasiswa yang diamati	Seluruh rangkaian interaksi klinis, mulai dari pengkajian hingga pemberian edukasi/tindakan.	Mahasiswa mengkaji skala nyeri, memeriksa adanya <i>diastasis rekti</i> , mengajarkan posisi tidur miring yang benar, serta mendemonstrasikan latihan Pelvic Tilt posisi merangkak.

Aspek yang dinilai	Meliputi keterampilan prosedur, komunikasi terapeutik, organisasi alat/tindakan, dan profesionalisme.	Ketepatan instruksi saat latihan Pelvic Tilt, kejelasan edukasi cara mengangkat benda (jongkok bukan membungkuk), dan empati terhadap keterbatasan gerak ibu.
Fokus observasi pembimbing	Penekanan pada aspek kritis (critical items) dan keselamatan pasien (patient safety).	Pembimbing memastikan mahasiswa melakukan skrining Red Flags (membedakan nyeri punggung vs kontraksi) dan memastikan ibu tidak kehilangan keseimbangan saat melakukan latihan fisik.
Umpan balik	Diskusi konstruktif antara pembimbing dan mahasiswa segera setelah tindakan selesai.	"Demonstrasi Pelvic Tilt yang kamu berikan sangat bagus, namun jangan lupa ingatkan ibu untuk selalu membuang napas saat melengkungkan punggung agar tidak terjadi tekanan intra-abdomen berlebih."
Keputusan penilaian	Penentuan tingkat kompetensi berdasarkan skala performa yang ditetapkan.	Kompeten: Jika mahasiswa mampu melakukan pengkajian postur, edukasi body mechanics, dan demonstrasi latihan fisik secara mandiri, aman, dan sistematis.
Makna dalam OBE	Bukti autentik bahwa mahasiswa telah mencapai hasil belajar (outcome) yang diharapkan pada situasi klinis nyata.	Menjamin bahwa lulusan kompeten dalam memberikan asuhan komplementer untuk meningkatkan kenyamanan ibu hamil dan mencegah

		komplikasi muskuloskeletal jangka panjang.
--	--	--

b. Case Report Asuhan Keperawatan

Tabel laporan kasus (Data Subjektif, Objektif, Analisis, dan Rencana) yang harus diisi mahasiswa berdasarkan skenario di Aktivitas 1.

1) Case Report pada Asuhan Keperawatan Ibu Hamil dengan masalah Mual dan Muntah

Komponen	Deskripsi	Contoh pada kasus Ibu Hamil dengan Mual dan Muntah
Hakikat Case Report	Laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Berfungsi sebagai bukti kemampuan memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang Ny. A (hamil 8 minggu) yang mengeluh mual muntah setiap pagi, skor PUQE-24 kategori sedang, lemas, namun tanda dehidrasi negatif.
Tujuan	Menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan keluhan mual, tetapi menjelaskan hasil skor PUQE-24 jam (11 poin), skrining tanda dehidrasi (negatif), tindakan akupresur P6 yang dilakukan, dan edukasi diet yang diberikan.
Isi Laporan	Mencakup identitas singkat, keluhan utama, data subjektif dan objektif (termasuk skrining safety), diagnosis, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran kasus.	Mahasiswa menuliskan: frekuensi muntah, hasil skor PUQE-24 jam, turgor kulit/mukosa bibir, diagnosis Nausea, intervensi teknik akupresur P6, edukasi makan biskuit kering sebelum bangun tidur, dan evaluasi penurunan rasa mual.

Fokus Penilaian	Difokuskan pada ketepatan pengkajian (skor PUQE-24), relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan teknik intervensi, dan evaluasi respons pasien.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan keluhan mual dengan pola makan ibu, memilih titik P6 yang akurat, dan memastikan keamanan (safety) dengan memantau tanda dehidrasi.
Nilai Edukatif	Membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus ini, mahasiswa belajar bahwa penggunaan instrumen pengkajian yang objektif (PUQE-24 jam) sangat penting untuk menentukan apakah ibu cukup dirawat jalan atau harus dirujuk (HG).
Makna dalam OBE	Bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori (fisiologi kehamilan dan sistem pencernaan) ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya hafal teori emesis, tetapi mampu menyusun laporan yang menggambarkan asuhan keperawatan maternitas yang aman, terukur, dan komprehensif.

2) Case Report pada Asuhan Keperawatan Ibu Hamil dengan masalah Kram Kaki

Komponen	Deskripsi	Contoh pada kasus Ibu Hamil dengan Kram Kaki
Hakikat Case Report	Laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Berfungsi sebagai bukti kemampuan memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang Ny. M (hamil 24 minggu) yang mengeluh kram hebat pada betis kanan saat bangun tidur, betis terasa tegang, namun tidak ada kemerahan atau panas.

Tujuan	Menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan keluhan kram, tetapi menjelaskan hasil skrining DVT (negatif), tindakan dorsofleksi yang dilakukan, dan edukasi pencegahan yang diberikan.
Isi Laporan	Mencakup identitas singkat, keluhan utama, data subjektif dan objektif (termasuk skrining safety), diagnosis, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran kasus.	Mahasiswa menuliskan: frekuensi kram, hasil inspeksi betis (tidak bengkak unilateral), diagnosis Gangguan Rasa Nyaman, intervensi teknik dorsofleksi, edukasi ankle pumping, dan evaluasi berkurangnya ketegangan otot.
Fokus Penilaian	Difokuskan pada ketepatan pengkajian (skrining DVT), relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan teknik intervensi, dan evaluasi respons pasien.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan keluhan kram dengan aktivitas/posisi tidur ibu, memilih teknik dorsofleksi yang benar, dan memastikan keamanan (safety) saat tindakan.
Nilai Edukatif	Membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus ini, mahasiswa belajar bahwa pengkajian fisik untuk menyingkirkan tanda bahaya (DVT) sebelum melakukan intervensi fisik pada kaki adalah bagian paling kritis dalam asuhan
Makna dalam OBE	Bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori (fisiologi kehamilan dan muskuloskeletal) ke dalam analisis kasus nyata secara	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya hafal teori kram kaki, tetapi mampu menyusun laporan yang menggambarkan asuhan keperawatan

	sistematis dan bertanggung jawab.	maternitas yang aman dan komprehensif.
--	-----------------------------------	--

3) Case Report pada Asuhan Keperawatan Ibu Hamil dengan masalah Nyeri Punggung Bawah

Komponen	Deskripsi	Contoh pada kasus Ibu Hamil dengan Nyeri Punggung Bawah
Hakikat Case Report	Laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Berfungsi sebagai bukti kemampuan memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang Ny. Q (hamil 34 minggu) yang mengeluh nyeri punggung bawah tumpul, postur lordosis lumbar menonjol, dan adanya diastasis rekti selebar 2 jari.
Tujuan	Menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan keluhan nyeri, tetapi menjelaskan hasil pengkajian postur tubuh, skrining Red Flags (membedakan nyeri mekanis vs kontraksi), tindakan Pelvic Tilt, dan edukasi <i>body mechanics</i> .
Isi Laporan	Mencakup identitas singkat, keluhan utama, data subjektif dan objektif (termasuk skrining safety), diagnosis, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran kasus.	Mahasiswa menuliskan: skala nyeri (0-10), hasil inspeksi postur (lordosis), lebar diastasis rekti, diagnosis Gangguan Rasa Nyaman/Nyeri Akut, intervensi latihan Pelvic Tilt, edukasi cara bangun tidur (miring), dan evaluasi kenyamanan punggung.
Fokus Penilaian	Difokuskan pada ketepatan pengkajian (skala nyeri dan	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu

	postur), relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan teknik intervensi, dan evaluasi respons pasien.	menghubungkan keluhan nyeri dengan kelemahan otot perut (diastasis), memilih latihan fisik yang aman bagi ibu hamil tua, dan memastikan keamanan (safety) saat latihan.
Nilai Edukatif	Membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus ini, mahasiswa belajar bahwa nyeri punggung di Trimester III bersifat multifaktorial (hormonal dan mekanis), sehingga penanganannya harus mencakup modifikasi perilaku harian dan penguatan otot.
Makna dalam OBE	Bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori (fisiologi muskuloskeletal kehamilan) ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia mampu menyusun laporan yang menggambarkan asuhan mandiri perawat dalam mengurangi ketidaknyamanan tanpa intervensi farmakologis yang berisiko bagi janin.

c. Implementasi (Catatan Tindakan)

Lembar catatan tindakan nyata berikan uraian tindakan yang dilakukan, jam berapa dan respon pasien, dilengkapi dengan paraf mahasiswa.

1) Implementasi Kasus Ibu Hamil dengan Masalah Mual dan Muntah

Nama Pasien: Ny. A (22 tahun)

Diagnosa Keperawatan: Nausea berhubungan dengan kehamilan (Trimester I) dibuktikan dengan mengeluh mual, merasa ingin muntah, frekuensi muntah meningkat, dan Skor PUQE-24 jam kategori Sedang (11 poin).

Jam	Tindakan Keperawatan (Implementasi)	Respon Pasien (Evaluasi Formatif)	Paraf Mhsw
08.00	Melakukan pengkajian mual muntah menggunakan kuesioner PUQE-24 jam.	S: Ibu mengeluh mual terutama saat mencium bau nasi. O: Skor total PUQE = 11 (Kategori Sedang).	[Nama]
08.15	Melakukan skrining dehidrasi (cek turgor kulit, mukosa mulut, dan tanda vital).	S: Ibu merasa lemas. O: Turgor elastis, mukosa lembap, TD 110/70 mmHg, Nadi 84x/m.	[Nama]
08.30	Mengajarkan dan mendemonstrasikan teknik akupresur pada titik P6 (<i>Neiguan</i>) selama 3-5 menit.	S: Ibu mengatakan area pergelangan tangan terasa hangat dan lebih rileks. O: Ibu mampu menentukan titik P6 secara mandiri.	[Nama]
08.45	Memberikan edukasi diet: Makan biskuit kering sebelum bangun tidur dan memisahkan asupan cairan dengan makanan padat.	S: Ibu bersedia mencoba makan biskuit yang disiapkan di meja samping tempat tidur. O: Ibu mampu menyebutkan 3 jenis makanan kering yang disarankan.	[Nama]

2) Implementasi Kasus Ibu Hamil dengan Masalah Kram Kaki

Nama Pasien: Ny. M (26 tahun).

Diagnosa Keperawatan: Gangguan Rasa Nyaman berhubungan dengan gangguan adaptasi kehamilan (Trimester II) dibuktikan dengan mengeluh tidak nyaman, postur tubuh tidak rileks (meringis), dan mengalami kontraksi otot (spasme) involunter pada betis.

Jam	Tindakan Keperawatan (Implementasi)	Respon Pasien (Evaluasi Formatif)	Paraf Mhsw
10.00	Mengkaji frekuensi kram dan melakukan inspeksi pada kedua betis (Skrining DVT).	S: Ibu kram 3x seminggu. O: Tidak ada edema unilateral, tidak merah, suhu kulit betis hangat merata (DVT negatif).	[Nama]
10.15	Mendemonstrasikan teknik Dorsofleksi	S: Ibu merasa otot betis yang tegang menjadi lebih lurus/rileks saat ditarik.	[Nama]

	(menarik jari kaki ke arah lutut) saat kram terjadi.	O: Ibu mampu mempraktikkan gerakan dorsofleksi tanpa bantuan.	
10.30	Mengajarkan latihan Ankle Pumping (gerakan memutar pergelangan kaki) untuk dilakukan sebelum tidur.	S: Ibu merasa aliran darah di kaki lebih lancar. O: Ibu melakukan gerakan memutar pergelangan kaki 10x per sesi.	[Nama]
10.45	Edukasi nutrisi: Meningkatkan asupan makanan tinggi kalsium dan magnesium (susu, sayuran hijau, kacang-kacangan).	S: Ibu mengaku jarang minum susu karena perut kembung. O: Disepakati pengganti kalsium dari brokoli dan kacang hijau.	[Nama]

3) Implementasi Kasus 3: Ibu Hamil dengan Masalah Nyeri Punggung Bawah
Nama Pasien: Ny. Q (34 tahun)

Diagnosa Keperawatan: Gangguan Rasa Nyaman berhubungan dengan perubahan postur tubuh (Trimester III) dibuktikan dengan mengeluh diperberat saat beraktivitas, kurvatura lordosis lumbar menonjol, dan terdapat diastasis rekti.

Jam	Tindakan Keperawatan (Implementasi)	Respon Pasien (Evaluasi Formatif)	Paraf Mhsw
13.00	Mengkaji skala nyeri punggung dan memeriksa adanya diastasis rekti.	S: Skala nyeri 5 (nyeri tumpul). O: Tampak lordosis lumbar, jarak otot perut (diastasis) = 2 jari.	[Nama]
13.15	Melakukan skrining tanda persalinan (memastikan nyeri bukan kontraksi).	S: Nyeri hilang saat posisi miring, tidak ada mulas beraturan. O: Perut teraba lunak (tidak ada kontraksi prematur).	[Nama]
13.30	Mendemonstrasikan teknik Pelvic Tilting (posisi merangkak) untuk penguatan otot lumbar.	S: Ibu merasa beban di pinggang sedikit berkurang saat punggung dilengkungkan. O: Ibu melakukan 5x repetisi latihan Pelvic Tilt.	[Nama]

13.45	Mengajarkan <i>Body Mechanics</i> . Cara bangun dari tempat tidur (miring dulu baru duduk) dan cara mengambil benda (jongkok).	S: Ibu merasa lebih nyaman bangun dengan cara miring. O: Ibu mampu mendemonstrasikan cara jongkok yang benar tanpa membungkuk.	[Nama]
-------	--	---	--------

d. Portofolio Asuhan Keperawatan

Kumpulan dari laporan kasus, catatan implementasi, dan hasil DOPS yang dibukukan sebagai syarat kelulusan bab ini.

1) Portofolio Asuhan Keperawatan pada Ibu Hamil dengan Masalah Mual dan Muntah

Komponen	Deskripsi	Contoh pada kasus Ibu Hamil dengan Mual dan Muntah
Hakikat Portofolio	Kumpulan bukti hasil belajar yang sistematis dan berkelanjutan untuk menunjukkan perkembangan kompetensi mahasiswa dalam jangka waktu tertentu.	Dokumen yang membuktikan mahasiswa mampu melakukan pengkajian PUQE-24, memberikan intervensi akupresur P6, hingga edukasi diet emesis.
Tujuan Portofolio	Mendokumentasikan perjalanan klinis mahasiswa, memfasilitasi refleksi diri, dan menyediakan data autentik untuk penilaian akhir (sumatif).	Menunjukkan bahwa mahasiswa secara bertahap semakin mahir dalam melakukan skrining dehidrasi dan manajemen mual tanpa obat pada ibu hamil.
OSCE dan DOPS	Komponen keterampilan klinis yang terstruktur (OSCE di lab) dan observasi langsung di lapangan (DOPS).	Lembar penilaian OSCE "Edukasi Akupresur P6" dan lembar penilaian DOPS saat melakukan "Edukasi Diet Kering dan Aromaterapi" pada pasien emesis di Puskesmas.

Catatan Kasus Singkat	Ringkasan pengalaman menangani pasien nyata yang mencakup data fokus, diagnosa, dan intervensi. Lengkapi evaluasi keberhasilan.	Laporan singkat Ny. A (8 minggu) dengan muntah 3-4 kali sehari. Intervensi: Akupresur P6 dan biskuit sebelum bangun tidur. Hasil: Mual berkurang di pagi hari.
Refleksi Patient Safety	Analisis kritis mahasiswa terhadap risiko tindakan dan cara mencegah cedera pada pasien selama pemberian asuhan.	Mahasiswa menuliskan pentingnya memantau tanda dehidrasi (turgor/nadi) agar tidak terlambat merujuk kasus Hiperemesis Gravidarum (HG).
Feedback CI / Dosen	Umpan balik tertulis dari pembimbing klinis mengenai aspek yang sudah baik dan area yang perlu diperbaiki.	Catatan CI: "Mahasiswa sudah tepat menentukan titik P6, namun perlu lebih mendalam menanyakan riwayat alergi bau (hiperosmia) pada ibu."
Karakteristik Penilaian	Penilaian yang bersifat formatif, berkelanjutan, dan multidimensi (pengetahuan, keterampilan, sikap).	Penilaian didasarkan pada akumulasi hasil pengkajian PUQE-24 pada minimal 3 pasien berbeda selama stase Trimester I.
Bukti Konsistensi Kompetensi	Rekam jejak yang menunjukkan bahwa mahasiswa mampu mempertahankan standar kualitas asuhan.	Mahasiswa terbukti mampu melakukan edukasi manajemen mual secara stabil dan komunikatif pada berbagai karakteristik pasien (primipara/multipara).
Makna Dalam OBE	Penjaminan bahwa mahasiswa benar-benar menguasai outcome berupa kemampuan memberikan asuhan kehamilan secara komprehensif.	Memberikan bukti nyata bahwa lulusan kompeten menangani keluhan awal kehamilan secara non-farmakologis yang aman bagi janin.

2) Portofolio Asuhan Keperawatan pada Ibu Hamil dengan Masalah Kram Kaki

Komponen	Deskripsi	Contoh pada kasus Ibu Hamil dengan Kram Kaki
Hakikat Portofolio	Kumpulan bukti hasil belajar yang sistematis dan berkelanjutan untuk menunjukkan perkembangan kompetensi mahasiswa dalam jangka waktu tertentu.	Dokumen yang membuktikan mahasiswa mampu melakukan pengkajian, memberikan intervensi (seperti edukasi posisi tidur dan suplemen), hingga evaluasi pada keluhan kram kaki.
Tujuan Portofolio	Mendokumentasikan perjalanan klinis mahasiswa, memfasilitasi refleksi diri, dan menyediakan data autentik untuk penilaian akhir (sumatif).	Menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya sekali melakukan tindakan, tetapi secara bertahap semakin mahir dalam menangani ketidaknyamanan muskuloskeletal pada ibu hamil.
OSCE dan DOPS	Komponen keterampilan klinis yang terstruktur (OSCE di lab) dan observasi langsung di lapangan (DOPS).	Lembar penilaian OSCE "Edukasi Peregangan Otot" dan lembar penilaian DOPS saat melakukan "Massage Ringan dan Kompres Hangat" pada pasien kram di Puskesmas.
Catatan Kasus Singkat	Ringkasan pengalaman menangani pasien nyata yang mencakup data fokus, diagnosa, dan intervensi yang diberikan. Lengkapi evaluasi keberhasilan (apakah kram berkurang setelah diedukasi ?)	Laporan singkat Ny. R (hamil 24 minggu) dengan kram betis setiap malam. Intervensi: Edukasi dorso-fleksi kaki sebelum tidur dan meningkatkan asupan makanan kaya kalsium.
Refleksi Patient Safety	Analisis kritis mahasiswa terhadap risiko tindakan dan cara mencegah cedera pada	Mahasiswa menuliskan pentingnya memastikan ibu berpegangan saat melakukan peregangan berdiri agar

	pasien selama pemberian asuhan.	tidak jatuh, serta memastikan tidak ada tanda Deep Vein Thrombosis (DVT) sebelum memijat.
Feedback CI / Dosen	Umpan balik tertulis dari pembimbing klinis mengenai aspek yang sudah baik dan area yang perlu diperbaiki.	Catatan CI: "Mahasiswa sangat baik dalam mendemonstrasikan gerakan kaki, namun perlu lebih teliti menanyakan kebiasaan ibu memakai sepatu hak tinggi yang memicu kram."
Karakteristik Penilaian	Penilaian yang bersifat formatif, berkelanjutan, dan multidimensi (pengetahuan, keterampilan, sikap).	Penilaian didasarkan pada akumulasi nilai dari berbagai pertemuan klinis, bukan hanya bergantung pada satu nilai ujian akhir semester.
Bukti Konsistensi Kompetensi	Rekam jejak yang menunjukkan bahwa mahasiswa mampu mempertahankan standar kualitas asuhan pada berbagai pasien dan situasi.	Mahasiswa terbukti mampu menangani keluhan kram kaki pada minimal 3 pasien berbeda dengan hasil evaluasi yang selalu stabil dan memuaskan.
Makna Dalam OBE	Penjaminan bahwa mahasiswa benar-benar menguasai outcome (capaian pembelajaran) berupa kemampuan memberikan asuhan kehamilan secara komprehensif.	Memberikan bukti nyata kepada institusi bahwa lulusan "siap pakai" dan memiliki portofolio bukti kinerja yang valid sebagai perawat maternitas.

3) Portofolio Asuhan Keperawatan pada Ibu Hamil dengan Masalah Nyeri Punggung Bawah

Komponen	Deskripsi	Contoh pada kasus Ibu Hamil dengan nyeri punggung bawah
Hakikat Portofolio	Kumpulan bukti hasil belajar yang sistematis dan	Dokumen yang membuktikan mahasiswa

	berkelanjutan untuk menunjukkan perkembangan kompetensi mahasiswa dalam jangka waktu tertentu.	mampu melakukan pengkajian postur (lordosis), skrining diastasis rekti, hingga memberikan latihan fisik (Pelvic Tilting).
Tujuan Portofolio	Mendokumentasikan perjalanan klinis mahasiswa, memfasilitasi refleksi diri, dan menyediakan data autentik untuk penilaian akhir (sumatif).	Menunjukkan perkembangan mahasiswa dalam memberikan edukasi mekanika tubuh (<i>body mechanics</i>) yang kompleks untuk meningkatkan kualitas hidup ibu hamil tua.
OSCE dan DOPS	Komponen keterampilan klinis yang terstruktur (OSCE di lab) dan observasi langsung di lapangan (DOPS).	Lembar penilaian OSCE "Demonstrasi Latihan Pelvic Tilt" dan lembar penilaian DOPS saat mengajarkan "Posisi Tidur Miring dan Cara Bangun dari Bed" di Poli KIA.
Catatan Kasus Singkat	Ringkasan pengalaman menangani pasien nyata yang mencakup data fokus, diagnosa, dan intervensi. Lengkapi evaluasi keberhasilan.	Laporan singkat Ny. S (34 minggu) dengan nyeri punggung hebat. Intervensi: Latihan Pelvic Tilt 2x sehari dan edukasi posisi jongkok saat mengambil benda. Hasil: Skala nyeri turun dari 5 ke 2.
Refleksi Patient Safety	Analisis kritis mahasiswa terhadap risiko tindakan dan cara mencegah cedera pada pasien selama pemberian asuhan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya membedakan nyeri punggung mekanis biasa dengan nyeri pinggang tanda persalinan prematur atau back labor.
Feedback CI / Dosen	Umpan balik tertulis dari pembimbing klinis mengenai aspek yang sudah baik dan area yang perlu diperbaiki.	Catatan CI: "Instruksi latihan sudah sangat jelas, namun pastikan ibu memiliki tumpuan tangan yang stabil saat berlatih agar tidak kehilangan keseimbangan."

Karakteristik Penilaian	Penilaian yang bersifat formatif, berkelanjutan, dan multidimensi (pengetahuan, keterampilan, sikap).	Penilaian mencakup ketepatan diagnosa keperawatan terkait gangguan rasa nyaman dan kualitas demonstrasi teknik mekanika tubuh harian.
Bukti Konsistensi Kompetensi	Rekam jejak yang menunjukkan bahwa mahasiswa mampu mempertahankan standar kualitas asuhan pada berbagai pasien.	Mahasiswa terbukti mampu menangani minimal 3 kasus nyeri punggung dengan berbagai tingkat keparahan postur secara efektif dan aman.
Makna Dalam OBE	Penjaminan bahwa mahasiswa benar-benar menguasai outcome berupa kemampuan memberikan asuhan kehamilan secara komprehensif.	Menjamin lulusan memiliki bukti kinerja yang valid dalam manajemen nyeri non-farmakologis, sehingga siap memberikan asuhan maternitas yang berkualitas.

G. Evaluasi Capaian Pembelajaran (OBE)

1. Evaluasi Kognitif

a. Latihan Soal Vignette: Asuhan Keperawatan dengan Masalah Mual Muntah

Instruksi: Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

Soal 1

Seorang perempuan, G1P0A0 hamil 8 minggu, datang ke poli KIA mengeluh mual dan muntah setiap pagi sejak 1 minggu terakhir. Hasil pengkajian: TD 110/80 mmHg, nadi 82 x/menit, skor PUQE-24 jam menunjukkan total 11 poin. Ibu mengatakan masih bisa masuk makanan sedikit demi sedikit (biskuit).

Apakah kategori keparahan mual muntah yang tepat pada pasien tersebut?

- A. Emesis Ringan (Mild)
- B. Emesis Sedang (Moderate)
- C. Emesis Berat (Severe)
- D. Hiperemesis Gravidarum Grade I
- E. Hiperemesis Gravidarum Grade II

Soal 2

Seorang perempuan, G1P0A0 hamil 9 minggu, mengeluh mual muntah yang mengganggu aktivitas. Perawat hendak mengajarkan teknik akupresur pada titik Perikardium 6 (P6) untuk mengurangi keluhan mual secara non-farmakologis.

Di manakah lokasi penekanan yang tepat untuk titik tersebut?

- A. Di antara ibu jari dan jari telunjuk kaki
- B. Tiga jari di bawah pergelangan tangan di antara dua tendon
- C. Di atas tempurung lutut bagian lateral
- D. Di belakang telinga tepat pada prosesus mastoideus
- E. Di area ulu hati (epigastrium)

Soal 3

Seorang perempuan, G2P1A0 hamil 10 minggu, mengeluh mual hebat terutama saat bangun tidur. Ibu melaporkan langsung minum air putih hangat dalam jumlah banyak untuk meredakan mual, namun justru berakhir dengan muntah.

Apakah saran pola makan yang paling tepat disampaikan perawat?

- A. Minum air sebanyak mungkin saat perut kosong
- B. Makan makanan berlemak tinggi agar perut terasa penuh
- C. Mengonsumsi biskuit kering 15-20 menit sebelum bangun tidur
- D. Menghindari sarapan pagi agar tidak memicu mual
- E. Makan porsi besar 2 kali sehari secara teratur

Soal 4

Seorang perempuan, G1P0A0 hamil 8 minggu, datang dengan keluhan muntah terus menerus. Hasil pengkajian: skor PUQE-24 menunjukkan 14 poin, mata tampak cekung, turgor kulit lambat kembali (> 2 detik), dan ibu tidak mampu menelan cairan sama sekali selama 12 jam terakhir.

Apakah tindakan prioritas yang harus dilakukan perawat?

- A. Mengajarkan teknik relaksasi napas dalam
- B. Memberikan edukasi aromaterapi lemon
- C. Mendemonstrasikan teknik akupresur P6
- D. Melakukan kolaborasi untuk rehidrasi cairan intravena (rujuk)
- E. Menyarankan ibu untuk tetap mencoba makan nasi hangat

Soal 5

Seorang perempuan hamil 9 minggu didiagnosis dengan Nausea berhubungan dengan kehamilan. Perawat telah mengajarkan teknik akupresur P6 dan modifikasi diet. Saat dilakukan evaluasi, ibu mengatakan mual berkurang dan ia sudah tidak muntah lagi di pagi hari.

Manakah kriteria hasil yang paling tepat menunjukkan keberhasilan asuhan?

- A. Ibu hafal lokasi semua titik akupresur di tubuh
- B. Skor PUQE-24 menurun dan rasa nyaman meningkat
- C. Berat badan ibu naik 5 kg dalam satu minggu
- D. Ibu bersedia membeli obat mual di apotek mandiri
- E. Tekanan darah ibu meningkat menjadi 130/90 mmHg

b. Latihan Soal Vignette: Asuhan Keperawatan dengan Masalah Kram Kaki

Instruksi: Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

Soal 1

Seorang perempuan, G1P0A0 hamil 24 minggu, datang ke poli KIA mengeluh sering terbangun di malam hari karena nyeri hebat dan tegang pada betis kanannya. Hasil pengkajian: TD 110/70 mmHg, nadi 84 x/menit, pada betis kanan tidak ditemukan edema unilateral, tidak ada kemerahan, dan suhu kulit teraba normal.

Apakah tindakan keperawatan segera yang paling tepat dilakukan pada pasien tersebut?

- A. Menganjurkan ibu untuk memijat kuat betisnya
- B. Memberikan kompres hangat pada area betis
- C. Membantu ibu melakukan teknik dorsofleksi
- D. Menyarankan ibu untuk posisi tidur terlentang
- E. Menganjurkan ibu membatasi minum di malam hari

Soal 2

Seorang perempuan, G2P1A0 hamil 26 minggu, mengeluh kram kaki yang menetap sejak pagi tadi. Hasil pengkajian perawat menemukan betis kiri tampak lebih besar dari betis kanan (edema unilateral), teraba panas, dan berwarna kemerahan. Pasien meminta perawat untuk melakukan peregangan pada kakinya.

Apakah tindakan prioritas yang harus dilakukan perawat?

- A. Melakukan teknik dorsofleksi sesuai permintaan pasien
- B. Mengajarkan latihan ankle pumping untuk sirkulasi
- C. Melakukan masase ringan untuk mengurangi ketegangan

- D. Melaporkan temuan (eskalasi) kepada dokter/preseptor
- E. Menganjurkan ibu untuk berjalan pelan di sekitar ruangan

Soal 3

Seorang perawat sedang memberikan edukasi kepada kelompok ibu hamil trimester II tentang cara mencegah kram kaki di malam hari berdasarkan Evidence-Based Practice (EBP).

Manakah materi edukasi pencegahan yang paling tepat disampaikan?

- A. Melakukan peregangan otot betis secara rutin sebelum tidur
- B. Mengurangi asupan kalsium dan magnesium dalam diet
- C. Menggunakan sepatu hak tinggi saat beraktivitas
- D. Menghindari posisi tidur miring ke arah kiri
- E. Melakukan aktivitas berdiri dalam waktu lama

Soal 4

Seorang perempuan hamil 24 minggu mengeluh nyeri pada betis saat bangun tidur. Perawat hendak mengajarkan teknik dorsofleksi dalam posisi berdiri. Perawat meminta ibu untuk berpegangan pada sandaran kursi yang stabil sebelum memulai gerakan.

Apakah prinsip etik/legal utama yang diterapkan perawat pada kasus tersebut?

- A. Autonomy (Menghargai keputusan pasien)
- B. Beneficence (Melakukan hal yang bermanfaat)
- C. Non-maleficence (Menjaga keamanan/tidak membahayakan)
- D. Justice (Berlaku adil pada pasien)
- E. Veracity (Mengatakan kebenaran)

Soal 5

Seorang perempuan hamil 25 minggu didiagnosis mengalami Gangguan Rasa Nyaman berhubungan dengan kram otot fisiologis kehamilan. Perawat telah memberikan demonstrasi teknik dorsofleksi dan edukasi pencegahan.

Manakah indikator keberhasilan (kriteria hasil) yang paling tepat untuk evaluasi?

- A. Ibu mampu menyebutkan definisi kram kaki secara medis
- B. Keluhan kram berkurang dan ibu mampu mendemonstrasikan teknik secara mandiri
- C. Tekanan darah ibu tetap dalam batas normal (120/80 mmHg)
- D. Ibu bersedia membeli suplemen kalsium di apotek
- E. Ibu tidak lagi melakukan aktivitas di luar rumah

- c. Latihan Soal Vignette: Asuhan Keperawatan dengan Masalah Nyeri Punggung
Instruksi: Pilihlah satu jawaban yang paling tepat!

Soal 1

Seorang perempuan, G2P1A0 hamil 34 minggu, datang ke poli KIA mengeluh nyeri tumpul pada punggung bawah yang memberat saat berdiri lama. Hasil pengkajian: tampak kurvatura lordosis yang menonjol dan skala nyeri 4 (0-10). Apakah penyebab fisiologis utama dari keluhan nyeri punggung pada kasus tersebut?

- A. Penurunan volume darah secara drastis
- B. Pergeseran pusat gravitasi tubuh (center of gravity) ke depan
- C. Adanya infeksi pada saluran kemih
- D. Kurangnya aktivitas fisik selama kehamilan
- E. Penurunan hormon relaksin pada sendi panggul

Soal 2

Seorang perempuan, G3P2A0 hamil 36 minggu, mengeluh nyeri punggung yang menjalar ke bokong. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan adanya celah selebar 2 jari pada otot rektus abdominis (diastasis rekti). Perawat hendak mengajarkan latihan untuk memperkuat otot abdomen.

Apakah teknik latihan yang paling tepat didemonstrasikan perawat?

- A. Sit-up sebanyak 10 kali repetisi
- B. Chest Physiotherapy
- C. Pelvic Tilting (panggul bergoyang) posisi merangkak
- D. Jogging di tempat selama 30 menit
- E. Lompat tali ringan di pagi hari

Soal 3

Seorang perempuan, G1P0A0 hamil 32 minggu, bertanya kepada perawat mengenai cara mengambil benda di lantai yang aman agar punggungnya tidak bertambah nyeri.

Apakah prinsip mekanika tubuh (body mechanics) yang harus diajarkan perawat?

- A. Membungkuk langsung dengan tumpuan pada pinggang
- B. Menekuk lutut (posisi jongkok) dengan punggung tetap tegak
- C. Mengambil benda dengan posisi kaki lurus dan rapat
- D. Meminta orang lain mengambilkan benda tersebut
- E. Menahan napas saat mengangkat benda dari lantai

Soal 4

Seorang perempuan, G2P1A0 hamil 35 minggu, mengeluh nyeri punggung hebat. Perawat sedang melakukan pengkajian untuk menyingkirkan tanda bahaya (Red Flags) persalinan prematur.

Manakah temuan yang menunjukkan bahwa nyeri tersebut adalah tanda bahaya (bukan nyeri mekanis biasa)?

- A. Nyeri berkurang saat ibu berbaring miring
- B. Nyeri terasa tumpul dan menetap di area pinggang
- C. Nyeri punggung disertai perut kencang yang berirama dan semakin kuat
- D. Nyeri hilang setelah ibu melakukan jalan santai
- E. Nyeri punggung terjadi setelah ibu berdiri selama 2 jam

Soal 5

Seorang perawat mengajarkan cara bangun dari tempat tidur yang benar kepada ibu hamil Trimester III untuk mengurangi tekanan pada tulang belakang.

Manakah instruksi yang paling tepat diberikan?

- A. Langsung bangun dari posisi terlentang ke posisi duduk (sit-up)
- B. Miringkan tubuh ke samping, lalu gunakan tangan untuk mendorong tubuh ke posisi duduk
- C. Mengayunkan kaki dengan cepat untuk mendapatkan momentum bangun
- D. Meminta suami menarik kedua tangan ibu agar bisa duduk
- E. Bangun secara perlahan dari posisi tengkurap

Kunci Jawaban dan Rasional Singkat Kasus 1 (Mual Muntah):

No Soal	Kunci Jawaban	Rasional
1	B (Emesis Sedang)	Skor 7-12 pada PUQE-24 masuk kategori sedang (moderate).
2	B (Tiga jari di bawah pergelangan)	Lokasi anatomis titik P6 (Neiguan).
3	C (Biskuit kering)	Mencegah mual akibat perut kosong dan asam lambung di pagi hari.
4	D (Kolaborasi rehidrasi)	Adanya tanda dehidrasi (mata cekung, turgor buruk) adalah indikasi rujukan/HG.

5	B (Skor PUQE menurun)	Luaran utama (SLKI) untuk Nausea adalah penurunan keluhan subjektif dan objektif.
---	-----------------------	---

Kunci Jawaban dan Rasional Kasus 2 (Kram Kaki)

No Soal	Kunci Jawaban	Rasional
1	C (Teknik Dorsofleksi)	Tindakan ini adalah standar emas untuk meregangkan otot yang kram secara fisiologis.
2	D (Melaporkan temuan / Eskalasi)	Adanya edema unilateral, panas, dan merah adalah tanda Red Flag (DVT). Manipulasi fisik dilarang karena berisiko emboli.
3	A (Peregangan rutin sebelum tidur)	EBP menunjukkan peregangan otot gastrocnemius sebelum tidur efektif menurunkan frekuensi kram.
4	C (Non-maleficence)	Meminta ibu berpegangan adalah tindakan untuk mencegah risiko jatuh (menjaga keselamatan pasien).
5	B (Keluhan berkurang dan demonstrasi mandiri)	Sesuai standar SLKI untuk luaran Gangguan Rasa Nyaman.

Kunci Jawaban dan Rasional Kasus 3. Nyeri Punggung Bawah

No Soal	Kunci Jawaban	Rasional
1	B (Pergeseran gravitasi)	Pembesaran uterus mengubah postur menjadi lordosis untuk menjaga keseimbangan.
2	C (Pelvic Tilting)	Latihan paling aman dan efektif untuk meregangkan otot lumbar dan menguatkan abdomen.
3	B (Posisi jongkok)	Menggunakan otot paha sebagai tumpuan, bukan otot punggung.
4	C (Perut kencang berirama)	Tanda kontraksi persalinan, bukan nyeri punggung mekanis biasa.

5	B (Miring lalu dorong)	Teknik bangun tidur yang aman untuk mencegah ketegangan otot abdomen dan punggung.
---	------------------------	--

Evaluasi Afektif dan Refleksi

- a. Refleksi Patient Safety pada Asuhan Keperawatan Ibu Hamil dengan masalah Mual dan Muntah

Komponen	Deskripsi	Contoh pada kasus Ibu Hamil dengan Mual dan Muntah
Hakikat Refleksi Patient Safety	Tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Mahasiswa merefleksikan bahwa mual muntah tidak selalu fisiologis; kegagalan mengenali tanda dehidrasi berat dapat menyebabkan gangguan elektrolit dan kegawatan janin.
Tujuan	Menumbuhkan kesadaran bahwa keselamatan pasien merupakan bagian integral dari setiap tindakan keperawatan maternitas.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti mengabaikan skor PUQE-24 jam yang tinggi atau tidak memantau asupan cairan, dapat menyebabkan kondisi Hiperemesis Gravidarum (HG).
Fokus Refleksi	Meliputi identifikasi risiko (Dehidrasi/Ketosis), analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama adalah salah mengartikan dehidrasi sebagai lemas biasa, serta risiko ketidakseimbangan elektrolit akibat muntah yang tidak terkendali.
Risiko yang Diidentifikasi	Kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan ibu selama proses asuhan ketidaknyamanan sistem pencernaan.	Risiko yang diidentifikasi: Dehidrasi berat, syok hipovolemik, ketidakseimbangan elektrolit, hingga risiko aspirasi jika muntah terjadi saat posisi berbaring terlentang.

Tindakan Pencegahan	Langkah konkret yang dilakukan mahasiswa untuk mengurangi risiko keselamatan selama intervensi mual muntah.	Mahasiswa melakukan skrining Red Flags (mukosa kering/turgor buruk), memantau toleransi asupan cairan, dan memastikan teknik akupresur P6 dilakukan dengan tekanan yang tepat.
Pembelajaran Mahasiswa	Menunjukkan apa yang dipelajari dan bagaimana hal itu memengaruhi praktik keperawatan maternitas berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa penggunaan instrumen objektif (PUQE-24 jam) dan pemantauan tanda vital adalah prioritas utama untuk menentukan kapan pasien harus segera dirujuk.
Makna dalam OBE	Menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan berpikir kritis terhadap keselamatan pasien secara berkelanjutan.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya "mengajarkan diet", tetapi mampu mengevaluasi ambang batas keamanan ibu hamil dan menjaga kualitas asuhan yang responsif terhadap kegawatan.

b. Refleksi Patient Safety pada Asuhan Keperawatan Ibu Hamil dengan masalah Kram Kaki

Komponen	Deskripsi	Contoh pada kasus Ibu Hamil dengan Kram Kaki
Hakikat Refleksi Patient Safety	Tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Mahasiswa merefleksikan bahwa keluhan kram kaki tidak selalu fisiologis; kegagalan mengenali tanda DVT dapat menyebabkan emboli paru yang fatal bagi ibu hamil.
Tujuan	Menumbuhkan kesadaran bahwa keselamatan pasien merupakan bagian integral dari	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti langsung memijat betis tanpa skrining atau tidak menjaga keseimbangan ibu

	setiap tindakan keperawatan maternitas.	saat latihan, dapat berdampak pada cedera fisik.
Fokus Refleksi	Meliputi identifikasi risiko (DVT/jatuh), analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama adalah salah mengartikan trombosis sebagai kram biasa, serta risiko ibu kehilangan keseimbangan saat melakukan peregangan mandiri.
Risiko yang Diidentifikasi	Kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan ibu selama proses asuhan ketidaknyamanan muskuloskeletal.	Risiko yang diidentifikasi: lepasnya bekuan darah (trombus) akibat dorsofleksi paksa pada DVT, kram yang semakin hebat akibat teknik yang salah, atau ibu terjatuh saat latihan posisi berdiri.
Tindakan Pencegahan	Langkah konkret yang dilakukan mahasiswa untuk mengurangi risiko keselamatan selama intervensi kram kaki.	Mahasiswa memastikan skrining Red Flags (bengkak/merah/panas) dilakukan di awal, melakukan dorsofleksi secara perlahan, dan memastikan ibu dalam posisi duduk/berpegangan yang stabil.
Pembelajaran Mahasiswa	Menunjukkan apa yang dipelajari dan bagaimana hal itu memengaruhi praktik keperawatan maternitas berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pengkajian fisik yang teliti dan memastikan keamanan posisi ibu adalah prioritas utama sebelum memberikan edukasi mandiri (self-care).
Makna dalam OBE	Menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan berpikir kritis terhadap keselamatan pasien secara berkelanjutan.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya "bisa melakukan gerakan", tetapi mampu mengevaluasi risiko klinis dan menjaga kualitas asuhan antenatal yang aman

C.

d. Refleksi Patient Safety pada Asuhan Keperawatan Ibu Hamil dengan masalah Nyeri Punggung Bawah

Komponen	Deskripsi	Contoh pada kasus Ibu Hamil dengan Nyeri Punggung Bawah
Hakikat Refleksi Patient Safety	Tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Mahasiswa merefleksikan bahwa nyeri punggung di trimester akhir tidak selalu masalah otot; kegagalan mengenali pola nyeri yang teratur dapat menutupi tanda persalinan prematur (back labor).
Tujuan	Menumbuhkan kesadaran bahwa keselamatan pasien merupakan bagian integral dari setiap tindakan keperawatan maternitas.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti tidak memastikan stabilitas ibu saat latihan Pelvic Tilt atau membiarkan ibu bangun mendadak, dapat menyebabkan jatuh atau hipotensi ortostatik.
Fokus Refleksi	Meliputi identifikasi risiko (Jatuh/Kontraksi), analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama adalah salah mengartikan kontraksi persalinan sebagai nyeri punggung biasa, serta risiko kehilangan keseimbangan akibat perubahan postur lordosis yang ekstrem.
Risiko yang Diidentifikasi	Kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan ibu selama proses asuhan ketidaknyamanan muskuloskeletal.	Risiko yang diidentifikasi: Jatuh akibat ketidakseimbangan tubuh, cedera tulang belakang akibat teknik mengangkat yang salah, serta risiko keterlambatan penanganan persalinan prematur.
Tindakan Pencegahan	Langkah konkret yang dilakukan mahasiswa untuk mengurangi risiko keselamatan	Mahasiswa melakukan skrining Red Flags (cek irama kontraksi), memastikan ibu berlatih di permukaan yang stabil dan tidak

	selama intervensi nyeri punggung.	licin, serta mengajarkan cara bangun tidur posisi miring untuk mencegah ketegangan otot abdomen.
Pembelajaran Mahasiswa	Menunjukkan apa yang dipelajari dan bagaimana hal itu memengaruhi praktik keperawatan maternitas berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pengkajian karakteristik nyeri secara mendalam dan memastikan lingkungan yang aman bagi ibu hamil tua adalah prioritas utama sebelum memberikan latihan fisik.
Makna dalam OBE	Menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan berpikir kritis terhadap keselamatan pasien secara berkelanjutan.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya "bisa mengajarkan senam", tetapi mampu mengevaluasi risiko muskuloskeletal dan menjaga kualitas asuhan antenatal yang aman dan protekti

H. Rangkumam Materi

1. Asuhan Keperawatan Maternitas: Penatalaksanaan Mual dan Muntah

Asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan mual muntah dimulai dengan pengkajian mendalam mengenai pola ketidaknyamanan sistem pencernaan. Perawat harus menggali frekuensi muntah, durasi mual, serta pemicu aroma atau makanan tertentu. Hal yang paling penting dalam tahap ini adalah melakukan skrining keselamatan (*Safety Screening*) untuk menyingkirkan kemungkinan dehidrasi berat atau Hiperemesis Gravidarum. Perawat wajib mengamati tanda-tanda objektif seperti mukosa bibir yang kering, penurunan turgor kulit, mata cekung, serta menggunakan instrumen PUQE-24 untuk menentukan derajat keparahan secara klinis. Jika ditemukan tanda dehidrasi atau penurunan berat badan yang drastis, kolaborasi medis untuk terapi cairan harus segera dilakukan.

Setelah data terkumpul, diagnosis keperawatan yang ditegakkan umumnya adalah Nausea yang berhubungan dengan perubahan hormonal (hCG) selama kehamilan. Rencana keperawatan disusun dengan fokus pada stabilisasi asupan nutrisi dan kenyamanan lambung ibu. Pada tahap implementasi, perawat mendemonstrasikan teknik Akupresur P6, yaitu penekanan pada titik tiga jari di bawah pergelangan tangan untuk menstimulasi saraf yang meredakan mual.

Selain itu, perawat memberikan edukasi diet kering (seperti biskuit atau roti) yang dikonsumsi sebelum bangun tidur di pagi hari, serta anjuran makan porsi kecil tapi sering.

Tahap akhir adalah evaluasi, di mana perawat memastikan ibu tidak hanya merasakan mual yang berkurang, tetapi juga mampu mendemonstrasikan teknik akupresur secara mandiri. Ibu diharapkan memahami bahwa penanganan mual yang aman bukan dengan mengosongkan lambung, melainkan melalui pengaturan pola makan yang tepat dan stimulasi titik saraf yang aman bagi janin.

2. Asuhan Keperawatan Maternitas: Penatalaksanaan Kram Kaki

Asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan kram kaki dimulai dengan pengkajian mendalam mengenai pola ketidaknyamanan sistem muskuloskeletal. Perawat harus menggali kapan kram sering muncul, durasinya, serta posisi tubuh yang memicu kontraksi otot mendadak tersebut. Hal yang paling krusial dalam tahap ini adalah melakukan skrining keselamatan (*Safety Screening*) untuk menyingkirkan kemungkinan *Deep Vein Thrombosis* (DVT). Perawat wajib mengobservasi tanda-tanda objektif seperti bengkak unilateral (hanya pada satu sisi kaki), adanya kemerahan, atau suhu kulit betis yang terasa panas. Jika tanda-tanda bahaya ini ditemukan, intervensi fisik berupa dorsofleksi harus dihentikan dan segera dikolaborasikan dengan tenaga medis untuk mencegah risiko emboli paru.

Setelah data terkumpul, diagnosis keperawatan yang ditegakkan umumnya adalah Gangguan Rasa Nyaman atau Nyeri Akut yang berhubungan dengan perubahan sirkulasi perifer dan ketidakseimbangan elektrolit (kalsium/magnesium) selama kehamilan. Rencana keperawatan disusun dengan fokus pada dua aspek: penanganan segera saat serangan kram terjadi dan tindakan pencegahan jangka panjang melalui latihan sirkulasi. Pada tahap implementasi, perawat mendemonstrasikan teknik Dorsofleksi, yaitu meluruskan lutut dan menarik jari-jari kaki ke arah lutut secara perlahan untuk meregangkan otot gastrocnemius yang memendek. Selain itu, perawat mengajarkan latihan *Ankle Pumping* (menggerakkan pergelangan kaki naik-turun) yang dilakukan secara rutin untuk meningkatkan aliran balik vena.

Tahap akhir adalah evaluasi, di mana perawat memastikan bahwa ibu hamil tidak hanya merasakan nyeri yang berkurang, tetapi juga mampu mendemonstrasikan teknik dorsofleksi secara mandiri dan benar. Ibu diharapkan memahami bahwa penanganan kram kaki yang aman bukan melalui pemijatan kuat pada betis yang berisiko, melainkan melalui teknik peregangan yang tepat, menjaga hidrasi, serta menjaga sirkulasi kaki tetap optimal melalui penggunaan alas kaki yang ergonomis.

3. Asuhan Keperawatan Maternitas: Penatalaksanaan Nyeri Punggung Bawah

Asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan nyeri punggung bawah dimulai dengan pengkajian mendalam mengenai perubahan postur dan skala nyeri yang dirasakan. Perawat harus menggali kapan nyeri memberat, durasinya, serta pengaruh posisi tubuh terhadap intensitas nyeri. Hal yang paling penting dalam tahap ini adalah melakukan skrining keselamatan (*Safety Screening*) untuk membedakan nyeri punggung mekanis dengan nyeri *persalinan* (*back labor*). Perawat wajib memastikan bahwa nyeri tidak disertai kontraksi rahim yang teratur atau keluarnya lendir darah. Jika ditemukan tanda-tanda persalinan prematur, intervensi fisik untuk nyeri punggung harus dihentikan dan segera dikolaborasikan untuk penanganan persalinan.

Setelah data terkumpul, diagnosis keperawatan yang ditegakkan umumnya adalah Gangguan Rasa Nyaman atau Nyeri Akut yang berhubungan dengan perubahan pusat gravitasi tubuh (*lordosis*) dan peregangan otot abdominal (*diastasis rekti*). Rencana keperawatan disusun dengan fokus pada perbaikan postur dan penguatan otot penyangga punggung. Pada tahap implementasi, perawat mendemonstrasikan teknik Latihan *Pelvic Tilt* (goyang panggul) dalam posisi merangkak dengan sinkronisasi napas yang benar. Selain itu, perawat mengedukasi Mekanika Tubuh (*Body Mechanics*), mencakup cara bangun tidur dari posisi miring, cara mengambil benda dengan menekuk lutut, serta penggunaan alas tidur yang menopang tulang belakang.

Tahap akhir adalah evaluasi, di mana perawat memastikan ibu hamil tidak hanya merasakan nyeri yang berkurang, tetapi juga mampu mempraktikkan mekanika tubuh yang benar dalam aktivitas sehari-hari. Ibu diharapkan memahami bahwa nyeri punggung dapat diminimalisir bukan dengan membatasi gerak secara total, melainkan dengan menjaga postur tubuh yang ergonomis dan rutin melakukan latihan penguatan otot panggul.

Glosarium

Akupresur P6	: Teknik penekanan pada titik saraf Perikardium 6 (3 jari di bawah pergelangan tangan) untuk meredakan mual dan muntah.
Ankle Pumping	: Latihan dorsofleksi dan plantarfleksi pergelangan kaki untuk meningkatkan aliran balik vena (venous return).
ATHP-HC	: Audio Therapy Healthy Pregnancy Harmoni Cinta, sebuah inovasi terapi psikofisiologis interaktif yang mengintegrasikan musik instrumen Gamelan Cirebon dengan teknologi modulasi gelombang otak untuk merangsang respon relaksasi otonom dan menurunkan intensitas mual-muntah pada ibu hamil.
Back Labor	: Sensasi nyeri punggung hebat yang berirama, seringkali merupakan pertanda posisi janin posterior atau tanda awal persalinan.
Body Mechanics	: Mekanika Tubuh; penggunaan tubuh yang efisien dan aman untuk bergerak atau mengangkat benda guna mencegah cedera tulang belakang.
Desensitisasi GDF15	: (GDF15 Priming Protocol), paradigma preventif masa depan melalui teknik paparan protein GDF15 eksogen dosis rendah terkontrol secara bertahap kepada calon ibu sebelum masa konsepsi (prakonsepsi) untuk membiasakan reseptor otak (down-regulation), sehingga mencegah respons mual ekstrem/hiperemesis saat hamil.
Diastasis Rekti	: Pemisahan otot perut (musculus rectus abdominis) akibat peregangan rahim yang berlebihan, sering memicu nyeri punggung.
Disritmia Lambung	: (Gastric Dysrhythmia), gangguan atau kekacauan pada ritme aktivitas bioelektrik intrinsik lambung (berupa tachygastria atau bradygastria) akibat lonjakan hormon kehamilan maternal, yang memicu timbulnya sensasi mual, kembung, dan rasa penuh yang persisten.

Dorsofleksi	: Gerakan menarik jari-jari kaki ke arah lutut untuk meregangkan otot betis, digunakan sebagai penanganan utama kram kaki.
DVT (Deep Vein Thrombosis)	: Penggumpalan darah pada vena dalam (biasanya di betis); merupakan kondisi berbahaya yang menjadi Red Flag kram kaki.
EBP	: Evidence-Based Practice (Praktik Keperawatan Berbasis Bukti Ilmiah).
Emesis Gravidarum	: Gejala mual dan muntah yang lazim terjadi pada ibu hamil, biasanya pada trimester pertama.
GDF15	: Growth Differentiation Factor 15, sebuah protein biomarker yang disekresikan secara masif oleh plasenta janin ke dalam sirkulasi darah ibu, yang berikatan dengan reseptor spesifik di batang otak (Area Postrema) dan bertindak sebagai mediator utama penentu tingkat keparahan mual-muntah kehamilan.
GTT	: Gestational Transient Thyrotoxicosis; kondisi hipertiroidisme transien (sementara) fisiologis pada trimester pertama yang dipicu oleh stimulasi kelenjar tiroid secara tidak sengaja oleh hormon hCG akibat kemiripan struktural molekuler (mimikri) sub-unit α dengan TSH.
hCG	: Human Chorionic Gonadotropin, hormon yang diproduksi oleh plasenta dan menjadi indikator kehamilan.
Hipomotilitas Lambung	: Penurunan frekuensi dan kekuatan gerak peristaltik saluran pencernaan akibat efek relaksasi otot polos oleh hormon progesteron, yang berdampak pada perpanjangan waktu pengosongan lambung (delayed gastric emptying).
Homan's Sign	: Prosedur pengkajian fisik vaskular yang dilakukan dengan cara menekuk telapak kaki secara mendadak ke arah tulang kering (dorsofleksi) saat lutut lurus; munculnya nyeri tajam di betis menandakan hasil positif yang mengindikasikan adanya thrombosis vena dalam (DVT).

Lordosis	:	Kelengkungan tulang belakang ke arah depan yang berlebihan pada area lumbal, sering terjadi sebagai kompensasi beban uterus.
Maternity Support Belt	:	Sabuk penyangga kehamilan mekanis eksternal yang dimodifikasi khusus untuk membantu mendistribusikan beban massa abdomen Trimester III secara proporsional ke area punggung dan panggul, guna menstabilkan cincin panggul dan mengurangi nyeri lumbal.
NVP	:	Nausea and Vomiting of Pregnancy (Istilah klinis untuk mual dan muntah dalam kehamilan).
OBE	:	Outcome-Based Education (Pendidikan Berbasis Capaian Pembelajaran).
Pelvic Tilt	:	Latihan goyang panggul (posisi merangkak atau berdiri) untuk meregangkan otot punggung bawah dan mengurangi nyeri.
Peripheral Heart Mechanism	:	Mekanisme pompa vena perifer yang digerakkan oleh kontraksi aktif otot-otot betis tungkai bawah (misalnya melalui latihan ankle pumping) untuk mendorong darah balik dari ekstremitas bawah menuju ke jantung guna mencegah stasis sirkulasi.
Ptialisme	:	(Hipersalivasi), produksi air liur yang berlebihan pada ibu hamil trimester pertama (sering kali memiliki pH rendah/rasa asam-pahit) akibat perubahan sekresi otonom, yang jika tertelan berulang dapat mengaktifasi refleks muntah.
PUQE-24 jam	:	Pregnancy-Unique Quantification of Emesis; instrumen objektif untuk mengukur derajat keparahan mual dan muntah.
Red Flags	:	Tanda-tanda bahaya klinis yang memerlukan penanganan segera atau rujukan (misal: dehidrasi berat, tanda DVT, atau kontraksi).
SDKI	:	Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia.
SIKI	:	Standar Intervensi Keperawatan Indonesia.
SLKI	:	Standar Luaran Keperawatan Indonesia.
Striae Gravidarum	:	Garis-garis peregangan (stretch marks) pada kulit perut, payudara, atau paha.

Waddling Gait : Gaya berjalan yang melebar/bergoyang (seperti bebek) akibat instabilitas sendi panggul di akhir kehamilan.

Referensi

- Astri, B. Y. (2024). Kajian Pengaruh Pemberian Essential Oil Peppermint (*Mentha Piperita*) untuk Mengatasi Mual Muntah pada Ibu Hamil Trimester I Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Mujur, Praya Timur. *Jurnal Kesehatan (Nakes)*, 1(2), 1–8.
- Birkeland, E., Stokke, G., Tangvik, R. J., Torkildsen, E. A., Boateng, J., Wollen, A. L., Albrechtsen, S., Flaatten, H., & Trovik, J. (2015). Norwegian PUQE (pregnancy-unique quantification of emesis and nausea) identifies patients with hyperemesis gravidarum and poor nutritional intake: A prospective cohort validation study. *PLoS ONE*, 10(4), 1–15. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0119962>
- Bustos, M., Venkataramanan, R., & Caritis, S. (2017). Nausea and vomiting of pregnancy-What's new? *Autonomic Neuroscience*, 202, 62–72. <https://doi.org/10.1016/j.autneu.2016.05.002>
- Cleveland clinic. (2023). *Calf Muscle*. Medically Reviewed. <https://my.clevelandclinic.org/health/body/21662-calf-muscle>
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Spong, C. Y. (2022). *Williams Obstetrics (26th Edition)*. McGraw-Hill Education.
- Dochez, V., Dimet, J., David-Gruselle, A., Le Thuaut, A., & Ducarme, G. (2016). Validation of specific questionnaires to assess nausea and vomiting of pregnancy in a French population. *International Journal of Gynecology and Obstetrics*, 134(3), 294–298. <https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2016.01.023>
- Ebrahimi, N., Maltepe, C., Bournissen, F. G., & Koren, G. (2009). Nausea and vomiting of pregnancy: Using the 24-hour Pregnancy-Unique Quantification of Emesis (PUQE-24) scale. *Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada*, 31(9), 803–807. [https://doi.org/10.1016/S1701-2163\(16\)34298-0](https://doi.org/10.1016/S1701-2163(16)34298-0)
- Fejzo, M., Rocha, N., Cimino, I., Lockhart, S. M., Petry, C. J., Kay, R. G., Burling, K., Barker, P., George, A. L., Yasara, N., Premawardhena, A., Gong, S., Cook, E., Rimmington, D., Rainbow, K., Withers, D. J., Cortessis, V., Mullin, P. M., Macgibbon, K. W., ... Rahilly, S. O. (2024). *GDF15 linked to maternal risk of nausea and vomiting during pregnancy*. 625(January). <https://doi.org/10.1038/s41586-023-06921-9>
- Fejzo, M. S., Trovik, J., Grooten, I. J., Sridharan, K., Roseboom, T. J., Vikanes, Å., Painter, R. C., & Mullin, P. M. (2019). Nausea and vomiting of pregnancy and hyperemesis gravidarum. *Nature Reviews Disease Primers*, 5(62), 1–17. <https://doi.org/10.1038/s41572-019-0110-3>
- Fiona. (2018). *Pelvic Tilt Exercises for Pregnancy*. Health & Parenting. <https://philips-digital.com/pelvic-tilt-exercises-pregnancy/>

- Garrison, S., Korownyk, C., Allan, G., Musini, V., Sekhon, R., & Dugre, N. (2020). Magnesium for skeletal muscle cramps (Review). *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 9. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD009402.pub3>. www.cochranelibrary.com
- Gultom, S. H., Damanik, C. M., Ritonga, Y. S., Nainggolan, S. H., & Harahap, A. A. (2024). Pengaruh Terapi Komplementer Akupressur Terhadap Kejadian Mual Muntah Pasca Pembiusan Regional Blok (Spinal Anestesi) di Ruang Pulih Rumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia Medan. *OBAT: Jurnal Riset Ilmu Farmasi Dan Kesehatan*, 2(6), 183–213. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/obat.v2i6.824>
- Harahap, N. R., Nasution, P., Syari, M., & Pitriana, D. (2022). Pengaruh aroma terapi lemon terhadap emesis gravidarum. *Indonesian Trust Health Journal*, 5(2), 57–63. https://www.researchgate.net/publication/366431862_PENGARUH_AROMA_TERAPI_LEMON_TERHADAP_EMESIS_GRAVIDARUM/citations
- Juwita, L. (2018). Literature Review: Complementary Therapy of Acupressure on Point of Pericardium 6 for Overcoming Nausea and Vomiting in Early Pregnancy. *Jurnal Ners Lentara*, 3(1), 40–50. <http://journal.wima.ac.id/index.php/NERS/article/view/712>
- Kaplan, Ş., Alpayci, M., Karaman, E., Çetin, O., Özkan, Y., Şah, S., & Şahin, H. G. (2016). Short-Term Effects of Kinesio Taping in Women with Pregnancy-Related Low Back Pain: A Randomized Controlled Clinical Trial. *Medical Science Monitor*, 22, 1297–1301. <https://doi.org/10.12659/MSM.898353>
- Koren, G., Piwko, C., Ahn, E., Boskovic, R., Maltepe, C., Einarson, A., Navioz, Y., & Ungar, W. (2005). Validation studies of the Pregnancy Unique-Quantification of Emesis (PUQE) scores. *Journal of Obstetrics and Gynaecology*, 25(3), 241–244. <https://doi.org/10.1080/01443610500060651>
- Korevaar, T. I. M., Rijke, Y. B. de, Chaker, L., Medici, M., Jaddoe, V. W. V., Steegers, E. A. P., Visser, T. J., & Peeters, R. P. (2017). Stimulation of Thyroid Function by Human Chorionic Gonadotropin During Pregnancy: A Risk Factor for Thyroid Disease and a Mechanism for Known Risk Factors. *Thyroid*, 27(3), 440–450. <https://doi.org/10.1089/thy.2016.0527>
- Lowdermilk, D. L., Cashion, K. K. R. A., Olshansky, E., & Perry, S. E. (2023). *Maternity and women's health care* (13th ed.). Elsevier Health Sciences.
- Luo, L., Zhou, K., Zhang, J., Xu, L., & Yin, W. (2020). Interventions for Leg Cramps in Pregnancy (Review). *Cochrane Library: Database of Systematic Reviews*. <https://doi.org/10.1002/14651858.CD010655.pub3>. www.cochranelibrary.com
- Maltepe, C., & Koren, G. (2013). Preemptive Treatment of Nausea and Vomiting of

- Pregnancy: Results of a Randomized Controlled Trial. *Obstetrics and Gynecology International*, 2013, 1–8. <https://doi.org/10.1155/2013/809787>
- Mariza, A., & Ayuningtias, L. (2019). Penerapan akupresur pada titik P6 terhadap emesis gravidarum pada ibu hamil trimester 1. *Holistik Jurnal Kesehatan*, 13(3), 218–224. <https://doi.org/10.33024/hjk.v13i3.1363>
- Matthews, A., Haas, D. M., O'Mathúna, D. P., & Dowswell, T. (2015). Interventions for nausea and vomiting in early pregnancy. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2015(9). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD007575.pub4>
- Miller, K. (2023). *How to Ease Leg Cramps During Pregnancy*. <https://www.thebump.com/a/leg-cramps-during-pregnancy>
- NHS Lanarkshire Maternity Department. (2022). *Care of your body in pregnancy Information for patients*. NHS Lanarkshire Maternity Department. <https://www.nhslanarkshire.scot.nhs.uk/patient-information-leaflets/maternity-physiotherapy/pil-carebp-19-28185-w/>
- Nurasih, B., Wahyuni, S., Kurnia, H., & Mariani, N. N. (2025). *Buku Monograf: Prenatal Yoga GCL Sebagai Terapi Komplementer Pada Kehamilan Hipertensi: Konsep, Implementasi, dan Manfaat Klinis*. PT Optimal Untuk negeri. <https://optimaluntuknegeri.com/>
- O'Donnell, A., McParlin, C., Robson, S. C., Beyer, F., Moloney, E., Bryant, A., Bradley, J., Muirhead, C., Nelson-Piercy, C., Newbury-Birch, D., Norman, J., Simpson, E., Swallow, B., Yates, L., & Vale, L. (2016). Treatments for hyperemesis gravidarum and nausea and vomiting in pregnancy: A systematic review and economic assessment. *Health Technology Assessment*, 20(74), vii–268. <https://doi.org/10.3310/hta20740>
- Paisal, F. I., Arifuddin, H., Arieska, R., Vitania, W., Rasumawati, & Arifuddin, A. (2025). Effectiveness of a Modified Pregnancy Support Belt in Reducing Back and Pelvic Pain in Pregnant Women: A Quasi-Experimental Study in South Jakarta. *Journal of Health and Nutrition Research*, 4(3), 1–9. <https://journalmpci.com/index.php/jhnr/article/view/666/437>
- Patni, K., & Sinha, G. (2023). An Analytical Review on Health Benefits of Prenatal Yoga for Mother and Foetus. *International Journal of Ayurveda and Pharma Research*, 11(Suppl 1), 46–52. https://www.researchgate.net/publication/369404203_An_Analytical_Review_on_Health_Benefits_of_Prenatal_Yoga_for_Mother_and_Foetus
- PPNI. (2017). *Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik* (1st ed.). Jakarta: DPP PPNI.
- PPNI. (2018a). *Standar Intervensi Keperawatan Indonesia: Definisi dan Tindakan Keperawatan* (1st ed.). Jakarta: DPP PPNI.
- PPNI. (2018b). *Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil*

Keperawatan (1st ed.). Jakarta: DPP PPNI.

- Rahmadhaniati, Y., Wulandari, E., & Anggarena, A. (2022). Perbedaan Pemberian Aromaterapi Peppermint dan Aromaterapi Lemon Terhadap Kejadian Emesis Gravidarum Ibu Hamil Trimester I di Wilayah Kerja Puskesmas Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4, 2684–2692.
- Rasnaya, M. D. (2023). *9 Cara Jitu Mengatasi Nyeri Punggung Bawah Saat Hamil Besar*. Tim Medis Klikdokter. https://www.klikdokter.com/ibu-anak/kehamilan/mengatasi-nyeri-punggung-bawah-saat-hamil-besar?srsId=AfmBOorXWxtWVO0Ci2K_U-cg4HtKSS5mHD3846tfRX8i-eopZyK13KqB
- Retni, A., & Damansyah, H. (2022). The Effect of Giving Ginger Aromatherapy on Reducing Hyperemesis Gravidarum in First-Trimester Pregnant Women in the Work Area Limboto Health Center. *Journal Health & Science : Gorontalo Journal Health and Science Community*, 7(1), 10–18. <https://doi.org/10.35971/gojhes.v7i1.16860>
- Ricci, S., Kyle, T., & Carman, S. (2021). *Maternity and Pediatric Nursing* (4th ed.). Wolters Kluwer Health.
- Rizki, S. F. B., Harahap, F. S. D., & Fitri, A. (2022). Efektivitas Aromaterapi Lavender (*Lavandula Angustifolia*) Dan Peppermint (*Mentha Piperita* L) Terhadap Intensitas Mual Dan Muntah Pada Ibu Hamil Trimester I. *Femina: Jurnal Ilmiah Kebidanan*, 2(1), 49. <https://doi.org/10.30867/fjk.v2i1.852>
- Rondanelli, M., Perna, S., Cattaneo, C., Gasparri, C., Barrile, G. C., Moroni, A., Minonne, L., Lazzarotti, A., Mansueto, F., & Mazzola, G. (2025). A Food Pyramid and Nutritional Strategies for Managing Nausea and Vomiting During Pregnancy: A Systematic Review. *Foods*, 14(373), 1–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/foods14030373>
- Tim Klik Dokter. (2023). *Mual Muntah Sepanjang Hari saat Hamil, Apa Sebabnya?* <https://www.klikdokter.com/>
- Wahyuni, S., Badriah, Komarudin, Cahyati, Y., & Sesaria, T. G. (2024). Relaxation response, brainwaves, and quality of life in women with nausea and vomiting during pregnancy. *Kontak*, 26(1), 52–59. <https://doi.org/10.32725/kont.2024.017>
- Yilmaz, F., Dorterler, O. C., Halici, S. E., Kasap, B., & Demirbas, A. (2024). The effects of pregnancy on oral health , salivary ph and flow rate. *BMC Oral Health*, 24(1286), 1–9. <https://doi.org/10.1186/s12903-024-05057-0>

BAB 3

KOMPLIKASI KEHAMILAN: HIPERTENSI, PREEKLAMPSIA, DAN EKLAMPSIA

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep, peran, dan prinsip praktik keperawatan maternitas berorientasi kesinambungan asuhan, etik, dan keselamatan pasien.	CPMK-1, CPMK-7
CPL-2	Menguasai dasar biomedik terkait reproduksi perempuan serta adaptasi maternal–neonatal sebagai landasan keputusan keperawatan.	CPMK-2
CPL-3	Mampu melakukan pengkajian komprehensif dan menetapkan tingkat risiko pada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir.	CPMK-2, CPMK-3
CPL-4	Mampu merumuskan prioritas masalah dan menyusun rencana asuhan keperawatan maternitas berbasis standar dan bukti.	CPMK-3, CPMK-4
CPL-5	Mampu melaksanakan intervensi, edukasi, dan komunikasi terapeutik pada ibu–bayi–keluarga selama kehamilan sampai nifas.	CPMK-4, CPMK-5
CPL-6	Mampu melakukan deteksi dini, penatalaksanaan awal kegawatdaruratan, kolaborasi/rujukan, serta evaluasi–dokumentasi dan perencanaan pulang.	CPMK-5, CPMK-6, CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan ruang lingkup, peran, dan prinsip Continuity of Care serta keselamatan pasien dalam keperawatan maternitas.
CPMK-2	Menganalisis anatomi–fisiologi reproduksi perempuan dan adaptasi maternal–neonatal untuk mendukung keputusan keperawatan.
CPMK-3	Melakukan pengkajian komprehensif dan stratifikasi risiko pada kehamilan, persalinan, nifas, dan neonatus.
CPMK-4	Menyusun rencana asuhan keperawatan maternitas untuk kondisi fisiologis dan masalah umum dengan luaran terukur.
CPMK-5	Melaksanakan intervensi, edukasi, manajemen nyeri, serta dukungan psikososial–keluarga pada periode maternitas.
CPMK-6	Melakukan deteksi dini dan penatalaksanaan awal komplikasi/kegawatdaruratan maternal, serta koordinasi kolaborasi/rujukan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Melakukan evaluasi, dokumentasi, perencanaan pulang, dan perencanaan layanan kesehatan reproduksi pascapersalinan.

D. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 5. Komplikasi Kehamilan: Hipertensi, Preeklamsia, dan Eklamsia	5.1 Mengidentifikasi indikator klinis dan hasil pemeriksaan yang mengarah pada hipertensi/preeklamsia/eklamsia.	5.2 Melaksanakan penatalaksanaan awal, pemantauan maternal–janin, dan koordinasi kolaborasi sesuai kegawatan.	CPMK-6	CPMK-3; CPMK-2

E. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-2	Ujian tulis berbasis kasus (vignette)	Akurasi analisis struktur–fungsi dan adaptasi kehamilan pada kasus (ketepatan alasan sebab–akibat)	10	Lembar jawaban ujian kasus
CPMK-3	OSCE pengkajian + checklist	Kelengkapan komponen pengkajian; ketepatan stratifikasi risiko; ketepatan prioritas masalah (skor checklist)	15	Checklist OSCE; format pengkajian
CPMK-6	Simulasi kegawatdaruratan (drill) + skenario tertulis	Kecepatan identifikasi tanda bahaya; ketepatan urutan stabilisasi awal; ketepatan keputusan kolaborasi/rujukan	20	Checklist drill; laporan respons skenario

Rubrik CPMK-1 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Penguasaan konsep ruang lingkup & CoC (akurasi elemen kunci)	Akurat ≤50% elemen kunci; banyak miskonsepsi.	Akurat 51–69% elemen kunci; masih ada kekeliruan istilah/relasi konsep.	Akurat 70–84% elemen kunci; penjelasan runtut.	Akurat ≥85% elemen kunci; sintesis jelas dan konsisten.

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.2 Aplikasi prinsip keselamatan pasien & etik pada skenario maternitas	Identifikasi risiko & tindakan aman $\leq 50\%$; keputusan tidak sesuai prinsip.	Identifikasi 51–69%; tindakan aman ada namun belum lengkap.	Identifikasi 70–84%; keputusan aman dan sesuai prinsip pada sebagian besar situasi.	Identifikasi $\geq 85\%$; keputusan aman, preventif, dan argumentatif.

Rubrik CPMK-2 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Akurasi anatomi–fisiologi reproduksi (struktur–fungsi)	Ketepatan $\leq 50\%$; banyak salah konsep/relasi struktur–fungsi.	Ketepatan 51–69%; konsep dasar benar namun parsial.	Ketepatan 70–84%; relasi struktur–fungsi tepat dan logis.	Ketepatan $\geq 85\%$; integrasi konsep kuat dan konsisten.
2.2 Analisis adaptasi kehamilan & implikasi kebutuhan asuhan	Analisis tidak runtut; implikasi klinis tidak tepat ($\leq 50\%$ sesuai data).	Analisis cukup; implikasi masih umum (51–69% sesuai data).	Analisis baik; implikasi spesifik (70–84% sesuai data).	Analisis sangat baik; implikasi komprehensif & antisipatif ($\geq 85\%$ sesuai data).

Rubrik CPMK-3 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Kelengkapan data pengkajian (komponen inti)	Komponen terisi $\leq 50\%$; banyak data penting hilang/tidak valid.	Komponen terisi 51–69%; masih ada kekosongan data kunci.	Komponen terisi 70–84%; data kunci lengkap dan relevan.	Komponen terisi $\geq 85\%$; data sangat lengkap, terstruktur, dan konsisten.
3.2 Ketepatan stratifikasi risiko & prioritas masalah	Risiko & prioritas tepat $\leq 50\%$; tidak sesuai temuan.	Tepat 51–69%; prioritas masih kurang tajam.	Tepat 70–84%; prioritas jelas berbasis temuan.	Tepat $\geq 85\%$; prioritas sangat tepat disertai tindak lanjut yang terarah.

Rubrik CPMK-4 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Kesesuaian masalah–	Kesesuaian $\leq 50\%$; luaran tidak	Kesesuaian 51–69%;	Kesesuaian 70–84%;	Kesesuaian $\geq 85\%$; luaran sangat

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
luaran– intervensi & keterukuran luaran	terukur; intervensi tidak spesifik.	luaran sebagian terukur; intervensi masih generik.	luaran terukur; intervensi spesifik dan realistis.	terukur; intervensi prioritatif dan tepat sasaran.
4.2 Rasional, prioritas, dan rencana evaluasi	Rasional lemah/absen; prioritas tidak jelas; evaluasi tidak terencana ($\leq 50\%$ memadai).	Rasional ada namun terbatas; prioritas cukup; evaluasi parsial (51–69%).	Rasional baik; prioritas jelas; evaluasi sesuai luaran (70– 84%).	Rasional sangat kuat; prioritas tajam; evaluasi komprehensif & terjadwal ($\geq 85\%$).

Rubrik CPMK-5 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Ketepatan & keselamatan pelaksanaan intervensi keperawatan	Langkah benar/aman $\leq 50\%$; terdapat tindakan berisiko.	Langkah benar/aman 51– 69%; ada kekurangan minor pada urutan/asepsis.	Langkah benar/aman 70–84%; pelaksanaan aman dan efektif.	Langkah benar/aman $\geq 85\%$; sangat terampil, efisien, dan konsisten aman.
5.2 Kualitas komunikasi terapeutik, edukasi, dan dukungan keluarga	Tujuan komunikasi tidak tercapai; pemahaman klien tidak terverifikasi ($\leq 50\%$).	Komunikasi cukup; edukasi disampaikan namun verifikasi terbatas (51– 69%).	Komunikasi baik; edukasi relevan dengan verifikasi pemahaman (70–84%).	Komunikasi sangat baik; edukasi terstruktur dengan teach- back dan pelibatan keluarga optimal ($\geq 85\%$).

Rubrik CPMK-6 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Deteksi dini & keputusan prioritas stabilisasi awal kegawatdaruratan	Tanda bahaya terlewat; prioritas salah ($\leq 50\%$ keputusan tepat).	Tanda bahaya sebagian terdeteksi; prioritas cukup (51–69% tepat).	Deteksi cepat; prioritas stabilisasi tepat (70–84% tepat).	Deteksi sangat cepat; prioritas tepat & antisipatif ($\geq 85\%$ tepat).
6.2 Koordinasi kolaborasi/rujukan & komunikasi tim	Kolaborasi/rujukan terlambat/tidak tepat; komunikasi tidak efektif ($\leq 50\%$ sesuai).	Kolaborasi ada namun belum sistematis; komunikasi cukup (51–69%).	Kolaborasi/rujukan tepat waktu; komunikasi jelas (70–84%).	Kolaborasi/rujukan sangat tepat; komunikasi terstruktur dan memastikan kesinambungan ($\geq 85\%$).

Rubrik CPMK-7 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kualitas evaluasi luaran & dokumentasi asuhan	Dokumentasi tidak lengkap; evaluasi tidak berbasis data ($\leq 50\%$ komponen terpenuhi).	Dokumentasi cukup; evaluasi masih umum (51–69%).	Dokumentasi lengkap; evaluasi sesuai luaran (70–84%).	Dokumentasi sangat lengkap & rapi; evaluasi analitis berbasis data ($\geq 85\%$).
7.2 Komprehensif perencanaan pulang & rencana layanan	Rencana tidak jelas/tidak individual; tanda bahaya/kontrol	Rencana ada namun parsial; komponen kunci belum	Rencana komprehensif; mencakup kontrol & tanda bahaya;	Rencana sangat komprehensif & individual berbasis risiko; mencakup

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
reproduksi pascapersalinan	terlewat ($\leq 50\%$ komponen).	lengkap (51–69%).	cukup individual (70–84%).	koordinasi layanan lanjutan dan konseling reproduksi terstruktur ($\geq 85\%$).

Latar Belakang

Kehamilan merupakan proses fisiologis yang secara umum berlangsung normal, namun dalam perjalanannya dapat disertai berbagai komplikasi yang berpotensi mengancam keselamatan ibu dan janin. Salah satu komplikasi yang paling sering terjadi dan menjadi penyebab utama morbiditas serta mortalitas maternal adalah hipertensi dalam kehamilan, termasuk preeklampsia dan eklampsia. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan ibu, tetapi juga berisiko menimbulkan gangguan pertumbuhan, prematuritas, hingga kematian janin apabila tidak ditangani secara tepat dan berkelanjutan.

Komplikasi Kehamilan: Hipertensi, Preeklampsia, dan Eklampsia merupakan gangguan yang saling berkaitan dan dapat berkembang secara progresif. Ketidakterkendalian hipertensi dalam kehamilan dapat berlanjut menjadi preeklampsia, dan pada kondisi yang lebih berat dapat berkembang menjadi eklampsia yang bersifat kegawatdaruratan. Oleh karena itu, deteksi dini, pemantauan ketat, dan asuhan keperawatan yang tepat menjadi peran penting dalam upaya pencegahan komplikasi yang lebih serius.

Dalam hal ini perawat, memiliki peran strategis dalam memberikan asuhan keperawatan maternitas, mulai dari pengkajian, pemantauan kondisi ibu dan janin, pelaksanaan tindakan keperawatan sesuai kewenangan, hingga pemberian edukasi kesehatan kepada ibu dan keluarga. Kompetensi tersebut menuntut penguasaan pengetahuan, keterampilan klinik, serta sikap profesional yang terintegrasi dan berorientasi pada keselamatan ibu.

Buku ajar *Maternitas Keperawatan I* ini salah satunya yang membahas tentang “Komplikasi Kehamilan: Hipertensi, Preeklampsia, dan Eklampsia” disusun sebagai bahan ajar keperawatan maternitas yang berbasis *Outcome Based Education* (OBE) dan disesuaikan dengan level kompetensi D3 Keperawatan (KKNI level 5). Materi dalam buku ini dirancang secara sistematis, dimulai dari konsep dasar hingga asuhan keperawatan pada setiap kondisi, dengan penekanan pada peran dan

kewenangan perawat vokasi. Setiap pembahasan dihubungkan dengan capaian pembelajaran, indikator ketercapaian, serta pendekatan pembelajaran yang aplikatif.

Diharapkan buku ajar ini dapat menjadi panduan yang komprehensif bagi mahasiswa keperawatan dalam memahami dan melaksanakan asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan komplikasi hipertensi, preeklampsia, dan eklampsia. Selain itu, buku ini juga diharapkan mampu mendukung dosen dalam proses pembelajaran serta berkontribusi pada peningkatan mutu pelayanan keperawatan maternitas diberbagai tatanan pelayanan kesehatan.

Urgensi Masalah Kesehatan Maternal

Masalah kesehatan maternal masih menjadi isu prioritas global karena berkontribusi besar terhadap angka kesakitan dan kematian ibu. Gangguan hipertensi dalam kehamilan, termasuk preeklampsia dan eklampsia, merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu didunia. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada ibu, tetapi juga meningkatkan risiko prematuritas, gangguan pertumbuhan janin, hingga kematian perinatal.

Menurut World Health Organization, komplikasi kehamilan seperti preeklampsia dan eklampsia menyumbang proporsi signifikan terhadap kematian maternal yang sebenarnya dapat dicegah melalui deteksi dini, pemantauan antenatal yang adekuat, serta penatalaksanaan yang tepat waktu. Di Indonesia, masalah hipertensi dalam kehamilan juga menjadi salah satu penyebab tertinggi kematian ibu selain perdarahan dan infeksi.

Urgensi penanganan masalah kesehatan maternal terletak pada pentingnya upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang terintegrasi. Peran perawat maternitas sangat krusial dalam melakukan pengkajian risiko, pemantauan tanda bahaya, edukasi kepada ibu dan keluarga, serta kolaborasi interprofesional untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Dengan pendekatan evidence-based dan penerapan standar asuhan keperawatan yang sistematis, angka morbiditas dan mortalitas maternal dapat ditekan secara signifikan. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai komplikasi hipertensi dalam kehamilan menjadi kompetensi esensial bagi mahasiswa keperawatan.

Tujuan Pembelajaran

telah mempelajari bab ini, mahasiswa mampu:

1. Menjelaskan konsep dasar Komplikasi Kehamilan: Hipertensi, Preeklampsia, dan Eklampsia
2. Menguraikan patofisiologi dan pathway terjadinya Komplikasi Kehamilan: Hipertensi, Preeklampsia, dan Eklampsia
3. Mengidentifikasi tanda dan gejala serta pemeriksaan penunjang yang relevan.
4. Menyusun asuhan keperawatan secara komprehensif berdasarkan SDKI, SIKI, dan SLKI.
5. Melakukan edukasi kesehatan kepada ibu dan keluarga terkait pencegahan dan deteksi dini komplikasi.

Ruang Lingkup Materi

Materi dalam bab ini mencakup konsep dasar Komplikasi Kehamilan: Hipertensi, Preeklampsia, dan Eklampsia, meliputi definisi, klasifikasi, etiologi, faktor risiko, serta patofisiologi. Pembahasan juga mencakup manifestasi klinis, pemeriksaan penunjang, dan komplikasi yang dapat terjadi pada ibu maupun janin.

Selain itu, dibahas penerapan proses keperawatan secara komprehensif mulai dari pengkajian, penetapan diagnosis keperawatan (SDKI), perencanaan intervensi (SIKI), evaluasi luaran (SLKI), hingga edukasi kesehatan dan upaya pencegahan komplikasi berbasis evidence-based practice.

A. Konsep Dasar

Hipertensi kehamilan dibedakan ke dalam beberapa jenis berdasarkan waktu munculnya, penyebab, serta kondisi yang menyertainya. Pemahaman klasifikasi ini penting bagi perawat agar dapat melakukan pengkajian dan pemantauan secara tepat.

1. Hipertensi Gestasional
 - a. Pengertian

Hipertensi Gestasional adalah kondisi meningkatnya tekanan darah pada seorang perempuan selama masa kehamilan yang sebelumnya tidak memiliki riwayat tekanan darah tinggi. Secara umum, hipertensi kehamilan ditandai dengan tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg, dalam dua kali pemeriksaan terpisah dengan jarak minimal 4 jam yang muncul setelah usia kehamilan 20 minggu. Kondisi ini sering kali tidak menimbulkan keluhan yang jelas, sehingga banyak ibu hamil merasa dirinya baik-baik saja meskipun tekanan darahnya sudah meningkat.

Karakteristik dari hipertensi kehamilan adalah tidak disertai proteinuria atau tanda-tanda kerusakan organ target lainnya dan biasanya sembuh dalam 6 minggu. Meskipun tampak ringan, hipertensi kehamilan tidak boleh dianggap sepele. Peningkatan tekanan darah yang tidak terkontrol dapat mengganggu aliran darah ke plasenta, sehingga pasokan oksigen dan nutrisi ke janin menjadi berkurang. Bagi ibu, kondisi ini dapat berkembang menjadi gangguan yang lebih berat, seperti preeklampsia dan eklampsia, yang berisiko mengancam keselamatan jiwa.

b. Faktor Risiko Hipertensi Gestasional

Tidak semua ibu hamil akan mengalami hipertensi kehamilan. Namun, terdapat beberapa kondisi yang dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan ini. Pemahaman faktor risiko sangat penting bagi perawat dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan komplikasi. Faktor risiko hipertensi gestasional meliputi:

1) Usia ibu

Ibu hamil dengan usia terlalu muda (<20 tahun) atau usia lanjut (>35 tahun) memiliki risiko lebih tinggi mengalami hipertensi kehamilan.

2) Riwayat hipertensi

Ibu dengan riwayat hipertensi sebelum kehamilan atau riwayat preeklampsia pada kehamilan sebelumnya memiliki risiko lebih besar mengalami hipertensi kehamilan.

3) Kehamilan pertama (primigravida)

Kehamilan pertama lebih berisiko mengalami preeklampsia dibandingkan kehamilan berikutnya.

4) Kehamilan ganda

Kehamilan kembar atau lebih meningkatkan beban kerja tubuh ibu dan risiko gangguan aliran darah plasenta.

5) Penyakit penyerta

Kondisi seperti diabetes melitus, penyakit ginjal, gangguan autoimun, dan obesitas dapat meningkatkan risiko terjadinya hipertensi dalam kehamilan.

6) Faktor genetik dan riwayat keluarga

Adanya riwayat hipertensi atau preeklampsia dalam keluarga dapat meningkatkan risiko pada ibu hamil.

7) Gaya hidup

Pola makan tidak seimbang, kurang aktivitas fisik, stres, serta kurangnya kontrol kehamilan secara rutin dapat memperburuk risiko terjadinya hipertensi kehamilan.

8) Obesitas

c. Etiologi

Hingga saat ini, penyebab pasti terjadinya hipertensi gestasional, khususnya preeklampsia dan eklampsia, belum dapat dijelaskan secara tunggal. Kondisi ini dipahami sebagai hasil dari interaksi berbagai faktor, baik dari ibu, plasenta, maupun lingkungan. Salah satu mekanisme utama yang sering dikaitkan adalah gangguan adaptasi pembuluh darah selama kehamilan, yang menyebabkan aliran darah ke plasenta menjadi tidak optimal.

Bagi perawat, pemahaman mengenai etiologi dan faktor risiko hipertensi dalam kehamilan menjadi dasar penting dalam melakukan pengkajian keperawatan. Dengan mengenali faktor-faktor risiko sejak awal, perawat dapat melakukan pemantauan lebih intensif, memberikan edukasi kesehatan yang tepat, serta berperan aktif dalam mencegah berkembangnya hipertensi kehamilan menjadi preeklampsia atau eklampsia. Pendekatan yang komprehensif dari perawat akan membantu ibu hamil merasa lebih aman, didukung, dan mampu berperan aktif dalam menjaga kesehatan dirinya dan janinnya.

d. Patofisiologi Hipertensi Gestasional

Hipertensi kehamilan merupakan kondisi kompleks yang terjadi akibat gangguan adaptasi fisiologis ibu terhadap kehamilan, terutama yang berkaitan dengan pembentukan dan fungsi plasenta. Pada kehamilan normal, pembuluh darah spiral diuterus mengalami pelebaran sehingga aliran darah ke plasenta meningkat dan kebutuhan janin dapat terpenuhi. Namun, pada hipertensi kehamilan, proses ini tidak berlangsung secara optimal.

Gangguan utama diawali oleh kegagalan invasi trofoblas ke dalam arteri spiral uterus. Akibatnya, pembuluh darah tidak mengalami pelebaran sempurna dan tetap sempit serta kaku. Kondisi ini menyebabkan penurunan perfusi plasenta dan menimbulkan hipoksia plasenta. Plasenta yang mengalami hipoksia kemudian melepaskan berbagai zat proinflamasi dan faktor antiangiogenik ke dalam sirkulasi ibu.

Zat-zat tersebut memicu disfungsi endotel sistemik, yaitu kerusakan lapisan dalam pembuluh darah ibu. Disfungsi endotel menyebabkan ketidakseimbangan antara vasodilator dan vasokonstriktor, sehingga terjadi vasokonstriksi umum, peningkatan resistensi pembuluh darah, dan akhirnya peningkatan tekanan darah.

Selain itu, disfungsi endotel juga meningkatkan permeabilitas kapiler, yang menyebabkan cairan mudah keluar ke jaringan. Kondisi ini berkontribusi terhadap terjadinya edema serta penurunan volume intravaskular efektif. Pada

ginjal, gangguan endotel mengakibatkan penurunan filtrasi glomerulus dan kebocoran protein ke urin, yang dikenal sebagai proteinuria.

Hipertensi kehamilan juga berdampak pada berbagai organ target. Pada otak, vasospasme dapat menimbulkan sakit kepala, gangguan penglihatan, hingga kejang pada eklampsia. Pada hati, dapat terjadi gangguan perfusi yang memicu nyeri epigastrium dan peningkatan enzim hati. Sementara itu, pada sistem hematologi, aktivasi koagulasi dan kerusakan endotel dapat menyebabkan trombositopenia dan sindrom HELLP.

Bagi janin, penurunan aliran darah uteroplasenta mengakibatkan gangguan pertumbuhan intrauterin, prematuritas, dan meningkatnya risiko gawat janin. Oleh karena itu, hipertensi kehamilan bukan hanya masalah peningkatan tekanan darah, tetapi merupakan gangguan multisistem yang mempengaruhi kesejahteraan ibu dan janin

e. Pemeriksaan fisik

Pemeriksaan fisik pada ibu hamil dengan hipertensi gestasional bertujuan untuk menilai kondisi umum ibu, mendeteksi tanda peningkatan tekanan darah, serta mengidentifikasi kemungkinan perkembangan menjadi preeklampsia. Pemeriksaan dilakukan secara sistematis sebagai bagian dari pengkajian antenatal.

1) Pemeriksaan Tekanan Darah

Tekanan darah diukur menggunakan tensimeter dengan posisi ibu duduk atau setengah duduk setelah istirahat beberapa menit. Pada hipertensi gestasional ditemukan tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg setelah usia kehamilan 20 minggu. Pengukuran biasanya dilakukan pada kedua lengan untuk memastikan hasil yang akurat.

2) Pemeriksaan Tanda Vital Lain

Selain tekanan darah, dilakukan pemeriksaan frekuensi nadi, frekuensi pernapasan, dan suhu tubuh untuk menilai kondisi umum ibu dan mendeteksi kemungkinan gangguan sistemik.

3) Pemeriksaan Edema

Pemeriksaan edema dilakukan dengan menekan daerah tungkai bawah, pergelangan kaki, atau punggung kaki untuk melihat adanya pembengkakan. Pada hipertensi gestasional biasanya ditemukan edema ringan, yang perlu dibedakan dengan edema pada preeklampsia yang lebih berat.

4) Pemeriksaan Berat Badan

Berat badan ibu dipantau secara berkala untuk melihat adanya peningkatan berat badan yang cepat akibat retensi cairan yang dapat berhubungan dengan gangguan hipertensi dalam kehamilan.

5) Pemeriksaan Abdomen Obstetri

Pemeriksaan ini meliputi palpasi abdomen untuk menilai tinggi fundus uteri (TFU), posisi janin, dan pertumbuhan janin. Pemeriksaan ini penting untuk memastikan pertumbuhan janin sesuai dengan usia kehamilan.

6) Pemeriksaan Denyut Jantung Janin (DJJ)

Denyut jantung janin diperiksa menggunakan doppler atau fetoskop untuk menilai kesejahteraan janin. Nilai normal DJJ berkisar antara 120–160 kali per menit.

7) Pemeriksaan Refleks Neurologis

Pemeriksaan refleks tendon dalam, seperti refleks patella, dapat dilakukan untuk menilai iritabilitas sistem saraf. Pada hipertensi gestasional biasanya refleks masih normal, namun peningkatan refleks dapat mengarah pada preeklampsia berat.

f. Tanda Klinis Hipertensi Gestasional

Hipertensi gestasional adalah kondisi peningkatan tekanan darah yang terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu tanpa disertai proteinuria atau tanda kerusakan organ lain. Kondisi ini perlu dikenali sejak dini karena dapat berkembang menjadi preeklampsia apabila tidak dipantau dengan baik.

1) Peningkatan Tekanan Darah

Tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg yang muncul setelah usia kehamilan 20 minggu merupakan tanda utama hipertensi gestasional. Peningkatan tekanan darah terjadi akibat perubahan resistensi pembuluh darah selama kehamilan yang menyebabkan peningkatan tekanan pada sistem kardiovaskular ibu.

2) Sakit Kepala Ringan hingga Sedang

Sebagian ibu hamil dengan hipertensi gestasional dapat mengalami sakit kepala akibat peningkatan tekanan darah. Keluhan biasanya tidak terlalu berat, namun perlu diwaspadai apabila sakit kepala menjadi semakin hebat atau menetap.

3) Edema Ringan pada Ekstremitas

Pembengkakan ringan pada kaki atau pergelangan kaki dapat terjadi akibat retensi cairan selama kehamilan. Pada hipertensi gestasional, edema biasanya tidak berat dan masih termasuk perubahan fisiologis yang sering ditemukan pada ibu hamil.

4) Peningkatan Berat Badan yang Cepat

Retensi cairan dapat menyebabkan peningkatan berat badan yang lebih cepat dari biasanya. Kondisi ini perlu dipantau karena dapat menjadi tanda awal gangguan hipertensi pada kehamilan.

5) Umumnya Tanpa Keluhan Berat

Pada banyak kasus, hipertensi gestasional sering tidak menimbulkan gejala yang jelas dan hanya ditemukan melalui pemeriksaan tekanan darah secara rutin saat pemeriksaan antenatal. Oleh karena itu, pemantauan tekanan darah secara berkala sangat penting untuk mendeteksi kondisi ini lebih dini.

g. Pemeriksaan Laboratorium pada Hipertensi Gestasional

Pemeriksaan laboratorium pada hipertensi gestasional dilakukan untuk membantu menilai kondisi ibu hamil dan membedakan apakah hipertensi yang terjadi masih berupa hipertensi gestasional atau sudah berkembang menjadi preeklampsia. Pemeriksaan ini juga penting untuk mendeteksi adanya gangguan fungsi organ.

1) Pemeriksaan Protein Urine

Pada hipertensi gestasional umumnya tidak ditemukan proteinuria atau hasil pemeriksaan protein urine negatif. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan metode dipstick urine atau pemeriksaan urine 24 jam. Apabila ditemukan proteinuria $\geq +1$, maka perlu dicurigai adanya perkembangan menuju preeklampsia.

2) Pemeriksaan Hemoglobin dan Hematokrit

Pemeriksaan ini dilakukan untuk menilai kondisi darah ibu. Pada hipertensi gestasional biasanya nilai hemoglobin dan hematokrit masih dalam batas normal, namun peningkatan hematokrit dapat terjadi akibat hemokonsentrasi.

3) Pemeriksaan Trombosit

Jumlah trombosit diperiksa untuk mengetahui adanya gangguan pembekuan darah. Pada hipertensi gestasional jumlah trombosit umumnya normal. Penurunan trombosit dapat menjadi tanda perkembangan preeklampsia berat atau sindrom HELLP.

4) Pemeriksaan Fungsi Ginjal

Pemeriksaan kreatinin dan ureum dilakukan untuk menilai fungsi ginjal. Pada hipertensi gestasional biasanya hasil masih dalam batas normal. Peningkatan kadar kreatinin dapat menunjukkan adanya gangguan fungsi ginjal.

5) Pemeriksaan Fungsi Hati

Pemeriksaan enzim hati seperti AST (SGOT) dan ALT (SGPT) dilakukan untuk menilai fungsi hati. Pada hipertensi gestasional hasil biasanya normal, sedangkan peningkatan enzim hati dapat menjadi tanda komplikasi seperti preeklampsia berat.

6) Pemeriksaan Asam Urat

Kadar asam urat dapat meningkat pada gangguan hipertensi dalam kehamilan akibat penurunan perfusi ginjal. Nilai yang meningkat dapat menjadi indikator awal perkembangan preeklampsia.

h. Dampak Hipertensi Gestasional pada Ibu dan Janin

1) Dampak terhadap Ibu

Pada ibu, hipertensi kehamilan dapat menyebabkan gangguan multisistem, mulai dari keluhan ringan hingga kondisi yang mengancam jiwa.

a) Peningkatan Risiko Preeklampsia dan Eklampsia

Hipertensi yang tidak terkontrol dapat berkembang menjadi preeklampsia dan eklampsia, yang ditandai dengan kejang, penurunan kesadaran, dan risiko kematian ibu.

b) Gangguan Fungsi Organ

(1) Ginjal, penurunan filtrasi glomerulus dan proteinuria yang dapat berlanjut menjadi gagal ginjal akut.

(2) Hati, nyeri epigastrium, peningkatan enzim hati, hingga rupture hati pada kasus berat.

(3) Otak, sakit kepala hebat, gangguan penglihatan, perdarahan otak, dan stroke.

c) Sindrom HELLP

Hipertensi kehamilan berat dapat menyebabkan HELLP syndrome (Hemolysis, Elevated Liver Enzymes, Low Platelet) yang meningkatkan risiko perdarahan dan kegagalan organ.

d) Solusio Plasenta

Tekanan darah tinggi dapat memicu pelepasan plasenta sebelum waktunya, menyebabkan perdarahan hebat yang membahayakan ibu dan janin.

e) Peningkatan Angka Morbiditas dan Mortalitas Ibu

Jika tidak ditangani dengan baik, hipertensi kehamilan berkontribusi signifikan terhadap angka kesakitan dan kematian ibu, terutama di negara berkembang.

2) Dampak terhadap Janin

Gangguan aliran darah uteroplasenta akibat hipertensi kehamilan berdampak langsung pada kesejahteraan janin.

a) Gangguan Pertumbuhan Janin (IUGR)

Penurunan perfusi plasenta menyebabkan janin tidak memperoleh oksigen dan nutrisi yang cukup, sehingga terjadi hambatan pertumbuhan intrauterin.

b) Prematuritas

Kondisi ibu yang memburuk sering kali memerlukan terminasi kehamilan dini demi keselamatan ibu, yang meningkatkan risiko kelahiran prematur.

c) Gawat Janin

Aliran darah dan oksigen yang tidak adekuat dapat menyebabkan distress janin, yang terlihat dari perubahan denyut jantung janin.

d) Berat Badan Lahir Rendah (BBLR)

Janin dari ibu dengan hipertensi kehamilan berisiko lahir dengan berat badan rendah akibat gangguan nutrisi kronis selama kehamilan.

e) Kematian Perinatal

Pada kasus berat, hipertensi kehamilan dapat menyebabkan kematian janin dalam kandungan atau kematian neonatal dini.

f) Prinsip Penatalaksanaan Medis

Penatalaksanaan medis difokuskan pada pengendalian tekanan darah, pencegahan komplikasi, serta penentuan waktu dan cara persalinan yang aman.

(1) Deteksi Dini dan Penegakan Diagnosis

- Pengukuran tekanan darah secara akurat dan berulang
- Pemeriksaan proteinuria dan penilaian tanda preeklampsia
- Pemantauan kondisi ibu dan janin secara berkala

(2) Pengendalian Tekanan Darah

- Pemberian obat antihipertensi yang aman bagi kehamilan
- Penyesuaian dosis berdasarkan respons ibu
- Target tekanan darah dicapai tanpa mengganggu perfusi uteroplasenta

(3) Pencegahan Kejang

- Pemberian terapi profilaksis pada kasus preeklampsia berat
- Pemantauan refleks, pernapasan, dan keseimbangan cairan

(4) Pemantauan Kesejahteraan Janin

- Pemantauan pertumbuhan janin
- Penilaian denyut jantung janin dan kondisi plasenta

(5) Penentuan Waktu dan Cara Persalinan

- Keputusan terminasi kehamilan berdasarkan usia kehamilan, kondisi ibu, dan janin
- Persalinan dipertimbangkan sebagai terapi definitif pada kondisi berat

g) Prinsip Penatalaksanaan Keperawatan

Penatalaksanaan keperawatan berfokus pada pemantauan, pencegahan komplikasi, edukasi, serta dukungan fisik dan psikologis bagi ibu hamil.

(1) Pengkajian Keperawatan Komprehensif

- Pemantauan tekanan darah, tanda vital, dan status cairan
- Pengkajian keluhan subjektif seperti sakit kepala, penglihatan kabur, dan nyeri epigastrium
- Observasi tanda bahaya pada ibu dan janin

(2) Pemantauan Berkelanjutan

- Monitoring respons ibu terhadap terapi
- Pencatatan hasil pemeriksaan secara sistematis
- Deteksi dini tanda perburukan kondisi

(3) Manajemen Istirahat dan Aktivitas

- Menganjurkan istirahat yang cukup
- Membantu pengaturan posisi yang nyaman dan aman
- Mencegah kelelahan yang dapat meningkatkan tekanan darah

(4) Edukasi Kesehatan

- Memberikan informasi tentang penyakit, pengobatan, dan tanda bahaya
- Mendorong kepatuhan terhadap pengobatan dan kontrol kehamilan
- Melibatkan keluarga dalam perawatan dan pengawasan

(5) Dukungan Psikologis

- Memberikan rasa aman dan empati
- Mengurangi kecemasan ibu terhadap kondisi kehamilan
- Membangun hubungan terapeutik yang baik

(6) Kolaborasi Interprofesional

- Bekerja sama dengan dokter, bidan, dan tenaga kesehatan lain
- Melaporkan segera bila ditemukan tanda komplikasi
- Mendukung pengambilan keputusan klinis secara tim

h) Hipertensi Kronik

Hipertensi kronik adalah kondisi tekanan darah tinggi yang sudah ada sebelum kehamilan atau terdeteksi sebelum usia kehamilan 20 minggu,

dan dapat berlanjut hingga setelah persalinan. Ibu hamil dengan hipertensi kronik memiliki risiko lebih tinggi mengalami komplikasi selama kehamilan, sehingga memerlukan pemantauan dan asuhan keperawatan yang lebih intensif.

2. Preeklampsia

a. Pengertian

Preeklampsia merupakan kondisi hipertensi kehamilan yang disertai dengan proteinuria dan/atau tanda gangguan organ lain (ginjal, hati dan otak), seperti edema, nyeri kepala, gangguan penglihatan, peningkatan refleks atau Gangguan plasenta. Preeklampsia biasanya muncul setelah usia kehamilan 20 minggu dan dapat berkembang dengan cepat. Kondisi ini memerlukan penanganan segera untuk mencegah komplikasi yang lebih berat.

b. Klasifikasi Preeklampsia

Klasifikasi preeklampsia dapat dibagi berdasarkan beberapa pendekatan klinis dan berdasarkan tingkat keparahan maupun onset waktu:

1) Preeklampsia berdasarkan diagnosis klinis Menurut pedoman internasional (ISSHP 2021):

a) Preeklampsia de novo

Hipertensi setelah 20 minggu gestasi disertai satu atau lebih dari :

(1) Proteinuria

(2) Disfungsi organ ibu (mis. trombositopenia, gangguan hati, insufisiensi ginjal, pulmo edema)

(3) Disfungsi uteroplasenta (mis. gangguan pertumbuhan janin, Doppler abnormal)

b) Preeklampsia superimposed pada hipertensi kronik

Hipertensi kronik yang kemudian berkembang menjadi preeklampsia setelah 20 minggu, ditandai dengan proteinuria baru atau disfungsi organ baru.

2) Klasifikasi berdasarkan Tingkat Keparahan

Walaupun istilah "preeklampsia ringan" dan "preeklampsia berat" telah digunakan secara tradisional dibanyak sumber klinis:

a) Preeklampsia tanpa fitur berat

Tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg dengan tanda penyakit organ minimal atau hanya proteinuria ringan.

b) Preeklampsia dengan fitur berat

Ditandai oleh : tekanan darah $\geq 160/110$ mmHg, tanda disfungsi organ seperti trombosit $< 100.000/\mu\text{L}$, gangguan fungsi hati, gagal ginjal,

gangguan neurologis berat, gejala klinis seperti sakit kepala hebat atau gangguan visual

Pedoman terkini menekankan bahwa istilah “severe preeclampsia” kurang dianjurkan dalam praktik karena semua preeklampsia memiliki potensi menjadi parah bila tidak terdeteksi lebih awal.

3) Klasifikasi berdasarkan Waktu Onset

a) Awitan dini (*early-onset*) < 34 minggu

b) Awitan lambat (*late-onset*) ≥ 34 minggu

Pendekatan ini penting karena preeklampsia awitan dini terkait risiko komplikasi janin yang lebih tinggi.

c. Tanda dan Gejala

1) Tekanan darah ≥ 160/110 mmHg

2) Proteinuria (protein dalam urin) ≥ 0.3 g protein dalam urin 24 jam

3) Sakit kepala hebat yang menetap meskipun sudah istirahat atau minum obat.

4) Gangguan penglihatan seperti pandangan kabur, titik-titik hitam, atau sensitivitas terhadap cahaya.

5) Nyeri epigastrium atau nyeri kuadran kanan atas abdomen, sering merupakan tanda preeklampsia berat atau gangguan fungsi hati.

6) Edema (pembengkakan) pada tangan, wajah dan kaki

7) Eklampsia, kejang tonik-klonik pada ibu hamil setelah timbul gejala preeklampsia, tanpa sebab lain yang jelas

8) Sindrom HELLP, kombinasi hemolisis, peningkatan enzim hati, dan trombositopenia berat.

9) Pulmonary edema, cairan diparu akibat gangguan vaskular dan tekanan darah tinggi

d. Faktor risiko Preeklampsia

1) Faktor ibu

a) Usia diatas 35 tahun memiliki risiko terkena preeklampsia lebih besar

b) Tinggi badan kurang berisiko terkena preeklampsia

c) IMT lebih berisiko terkena preeklampsia

d) Riwayat preeklampsia pada kehamilan sebelumnya meningkatkan risiko mengalami preeklampsia pada kehamilan berikutnya

e) Golongan darah AB berisiko terkena preeklampsia dengan nilai OR=3,07, walaupun secara statistik masih belum bermakna, dan memerlukan kajian ulang.

f) Jarak antar kehamilan yang lama akan berisiko menimbulkan preeklampsia

- g) Jenis kelamin bayi pria dapat menjadi risiko terkena preeklampsia karena pengaruh hormon testosteron
 - h) Penyakit yang diderita seperti gestasional diabetes atau riwayat penyakit pernah menderita diabetes mellitus akan meningkatkan risiko preeklampsia karena faktor resistensi insulin; hipertensi dan riwayat keluarga menderita hipertensi juga meningkatkan risiko preeklampsia
 - i) Riwayat keluarga mengalami preeklampsia : meningkatkan risiko mengalami preeklampsia karena faktor genetik/biologi.
- 2) Faktor kehamilan
- a) Infeksi traktur urinarius : menyebabkan peningkatan kadar sitokin ibu, dan akan mempengaruhi fungsi endotel, yang pada beberapa wanita dapat berkembang menjadi preeklampsia.
 - b) Pasangan/primipaterniti : kehamilan dengan ayah baru memicu proses imun terhadap protein sperma yang membuahi.
 - c) Usia suami : semakin tua usia suami maka akan semakin tinggi risiko preeklampsia lebih tinggi.
- 3) Faktor stres: stres/wanita bekerja memiliki risiko mengalami preeklampsia lebih tinggi daripada wanita tidak bekerja
- e. Patofisiologi

Kehamilan pada dasarnya merupakan proses fisiologis yang melibatkan berbagai adaptasi tubuh ibu, termasuk vasodilatasi pembuluh darah dan peningkatan aliran uteroplasenta untuk memenuhi kebutuhan janin. Pada kehamilan normal, tubuh ibu mengalami penyesuaian untuk memenuhi kebutuhan janin, termasuk perubahan pada sistem pembuluh darah. Namun, pada hipertensi kehamilan, proses adaptasi ini tidak berjalan dengan baik. Akibatnya terjadi vasokonstriksi (penyempitan pembuluh darah) dan peningkatan tekanan darah. Gangguan fungsi endotel pembuluh darah juga berperan dalam memicu peningkatan tekanan darah serta kerusakan organ, terutama pada preeklampsia dan eklampsia.

Selain itu, faktor plasenta diduga memiliki peran penting, terutama pada preeklampsia. Implantasi plasenta yang tidak optimal dapat menyebabkan gangguan perfusi plasenta, yang kemudian memicu pelepasan zat-zat tertentu ke dalam sirkulasi ibu dan berkontribusi terhadap terjadinya hipertensi dan kerusakan organ.

Namun, pada kondisi tertentu dapat terjadi gangguan adaptasi, yang ditandai dengan meningkatnya resistensi vaskular sistemik. Kondisi ini kemudian memunculkan hipertensi gestasional, yaitu peningkatan tekanan

darah $\geq 140/90$ mmHg setelah usia kehamilan 20 minggu tanpa disertai proteinuria.

Apabila kondisi ini berlanjut, maka dapat terjadi plasentasi abnormal akibat invasi trofoblas yang tidak sempurna. Akibatnya, arteri spiralis tetap sempit dan kaku sehingga perfusi uteroplacenta menurun. Penurunan aliran darah ini menyebabkan iskemia dan hipoksia plasenta, yang selanjutnya memicu pelepasan faktor antiangiogenik serta mediator inflamasi ke dalam sirkulasi ibu. Kondisi ini mengakibatkan disfungsi endotel sistemik yang ditandai dengan vasokonstriksi, peningkatan permeabilitas kapiler, serta aktivasi sistem koagulasi.

Manifestasi klinis dari proses tersebut adalah preeklampsia, yang ditandai dengan hipertensi disertai proteinuria dan dapat disertai kerusakan organ. Jika tidak ditangani dengan tepat, kondisi ini dapat memburuk dan melibatkan sistem saraf pusat. Terjadi vasospasme serebral yang menyebabkan edema otak dan gangguan autoregulasi aliran darah otak, sehingga meningkatkan tekanan intrakranial. Pada tahap ini, ibu dapat mengalami kejang yang dikenal sebagai eklampsia, yaitu bentuk paling berat dari komplikasi hipertensi dalam kehamilan.

f. Pemeriksaan Laboratorium pada Preeklampsia

Pemeriksaan laboratorium pada preeklampsia dilakukan untuk menilai derajat keparahan penyakit serta mendeteksi adanya gangguan fungsi organ seperti ginjal, hati, dan sistem pembekuan darah. Hasil pemeriksaan ini juga membantu menentukan penatalaksanaan dan pemantauan kondisi ibu serta janin.

1) Proteinuria

Proteinuria merupakan salah satu tanda utama preeklampsia. Pemeriksaan dapat dilakukan dengan metode dipstick urine atau urine 24 jam. Pada preeklampsia biasanya ditemukan proteinuria $\geq +1$ pada pemeriksaan dipstick atau ≥ 300 mg dalam urine 24 jam, yang menunjukkan adanya gangguan fungsi ginjal akibat peningkatan permeabilitas glomerulus.

2) Penurunan Jumlah Trombosit

Jumlah trombosit dapat menurun ($< 150.000/\mu\text{L}$) akibat gangguan sistem pembekuan darah dan kerusakan endotel pembuluh darah. Penurunan trombosit dapat menjadi tanda preeklampsia berat dan berisiko berkembang menjadi sindrom HELLP.

3) Peningkatan Enzim Hati

Pemeriksaan enzim hati seperti AST (SGOT) dan ALT (SGPT) dapat menunjukkan peningkatan akibat gangguan perfusi dan kerusakan sel hati.

Kondisi ini dapat menyebabkan nyeri epigastrium atau nyeri pada ulu hati yang sering dikeluhkan pada preeklampsia berat.

4) Peningkatan Kreatinin Serum

Kadar kreatinin serum dapat meningkat akibat gangguan fungsi ginjal yang disebabkan oleh vasospasme pembuluh darah ginjal. Peningkatan kreatinin menunjukkan adanya penurunan filtrasi glomerulus.

5) Peningkatan Kadar Asam Urat

Kadar asam urat sering meningkat pada preeklampsia akibat gangguan fungsi ginjal dan penurunan ekskresi asam urat. Peningkatan kadar asam urat dapat menjadi indikator awal gangguan hipertensi dalam kehamilan.

6) Hematokrit Meningkat

Nilai hematokrit dapat meningkat akibat hemokonsentrasi yang disebabkan oleh perpindahan cairan dari intravaskular ke jaringan akibat kerusakan endotel pembuluh darah.

g. Pemantauan dan Pencegahan Perburukan

Pemantauan dan pencegahan perburukan merupakan bagian penting dalam asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan preeklampsia. Tujuan utama tindakan ini adalah mendeteksi dini tanda bahaya, mencegah komplikasi, serta menjaga kondisi ibu dan janin tetap stabil.

1) Pemantauan Kondisi Ibu

Perawat berperan aktif dalam melakukan pemantauan secara teratur, meliputi:

- a) Tekanan darah, dilakukan secara berkala dan dicatat dengan benar
- b) Tanda vital seperti nadi, pernapasan, dan suhu tubuh
- c) Keluhan subjektif seperti sakit kepala hebat, pandangan kabur, mual, muntah, dan nyeri ulu hati
- d) Edema, terutama pada wajah, tangan, dan tungkai
- e) Keseimbangan cairan, melalui pemantauan intake dan output urin

Pemantauan ini penting untuk mengenali tanda perburukan sejak dini.

2) Pemantauan Kondisi Janin

Selain kondisi ibu, kesejahteraan janin juga perlu dipantau, antara lain:

- a) Pemantauan gerakan janin yang dirasakan ibu
- b) Observasi denyut jantung janin sesuai kewenangan
- c) Pemantauan hasil pemeriksaan penunjang yang tersedia

Penurunan gerak janin dapat menjadi tanda gangguan aliran darah ke plasenta.

3) Pencegahan Perburukan Kondisi

Upaya pencegahan perburukan dilakukan melalui:

- a) Menganjurkan istirahat yang cukup dan menghindari aktivitas berat
- b) Membantu pengaturan posisi istirahat yang nyaman
- c) Mendorong kepatuhan ibu terhadap pengobatan dan kontrol kehamilan
- d) Memberikan edukasi tanda bahaya yang harus segera dilaporkan
- e) Menciptakan lingkungan yang tenang untuk mengurangi stres dan kecemasan

4) Kolaborasi dan Tindak Lanjut

Perawat perlu melakukan kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain serta segera melaporkan apabila ditemukan:

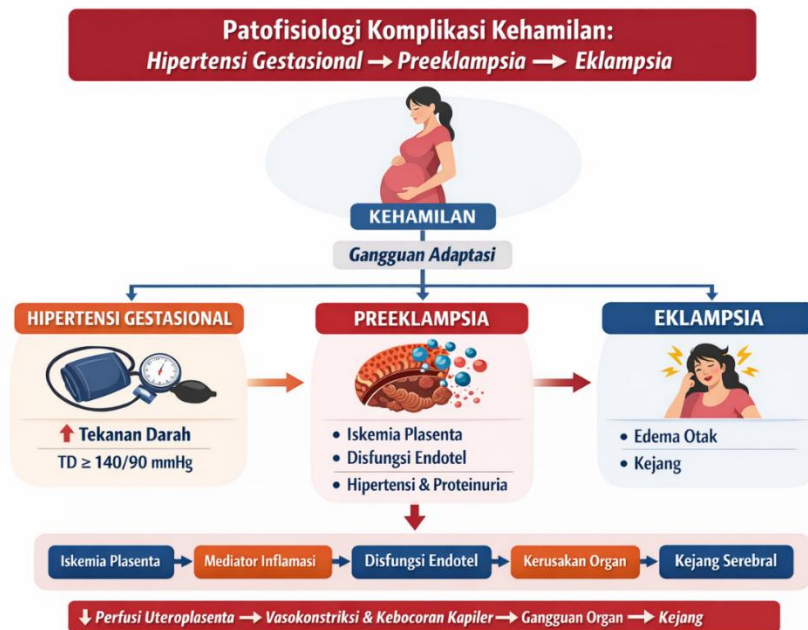
- a) Kenaikan tekanan darah yang signifikan
- b) Timbulnya gejala berat
- c) Penurunan kondisi ibu atau janin

Tindak lanjut yang cepat dapat mencegah terjadinya komplikasi serius.

h. Kesiapsiagaan Rujukan

Kesiapsiagaan rujukan bertujuan untuk mencegah keterlambatan penanganan apabila kondisi ibu memburuk. Perawat berperan dalam:

- 1) Menjelaskan kepada ibu dan keluarga tentang kapan harus segera dirujuk
 - 2) Membantu keluarga memahami alur rujukan yang tersedia
 - 3) Mendorong keluarga menyiapkan transportasi dan pendamping
 - 4) Mengingatkan pentingnya membawa dokumen kesehatan ibu saat rujukan
- Kesiapan rujukan yang baik dapat mempercepat penanganan dan menurunkan risiko komplikasi.



Gambar 3. 1 Patofisiologi Komplikasi Kehamilan

3. Eklampsia

a. Pengertian

Eklampsia adalah kegawatdaruratan obstetri berupa kejang tonik-klonik pada ibu hamil (biasanya >20 minggu), persalinan, atau nifas, yang didahului preeklampsia (hipertensi + proteinuria). Disebabkan oleh vasospasme hebat, edema serebral, dan disfungsi organ. Eklampsia adalah bentuk paling berat dari hipertensi kehamilan, kondisi ini merupakan kegawatdaruratan obstetri yang memerlukan tindakan segera dan kolaborasi tim kesehatan untuk menyelamatkan ibu dan janin.

b. Etiologi

Penyebab pasti eklampsia belum diketahui secara pasti, namun kondisi ini berkaitan dengan gangguan fungsi plasenta, kerusakan endotel pembuluh darah, dan vasospasme sistemik yang menyebabkan gangguan aliran darah ke berbagai organ tubuh, termasuk otak. Gangguan tersebut dapat memicu edema serebral yang akhirnya menyebabkan kejang.

c. Patofisiologi

Patofisiologi eklampsia merupakan kelanjutan dari proses preeklampsia yang tidak tertangani dengan baik dan melibatkan gangguan berat pada sistem pembuluh darah dan otak. Proses diawali oleh gangguan pembentukan dan fungsi plasenta, yang menyebabkan penurunan aliran darah ke plasenta. Kondisi ini memicu pelepasan zat-zat berbahaya ke dalam sirkulasi ibu yang menyebabkan disfungsi endotel sistemik. Akibatnya terjadi vasokonstriksi

berat, peningkatan tekanan darah, dan gangguan aliran darah ke berbagai organ, termasuk otak.

Pada otak, tekanan darah yang tinggi dan disfungsi endotel menyebabkan vasospasme serebral, peningkatan permeabilitas pembuluh darah otak, dan edema serebri. Kondisi ini menimbulkan peningkatan tekanan intrakranial dan gangguan aktivitas listrik otak, yang akhirnya memicu kejang sebagai manifestasi utama eklampsia. Selain itu, gangguan perfusi otak juga dapat menyebabkan penurunan kesadaran hingga koma.

d. Faktor Risiko

Beberapa faktor yang meningkatkan risiko terjadinya eklampsia antara lain:

- 1) Riwayat preeklampsia
- 2) Primigravida
- 3) Kehamilan ganda
- 4) Riwayat hipertensi kronis
- 5) Usia ibu <20 tahun atau >35 tahun
- 6) Riwayat preeklampsia pada kehamilan sebelumnya
- 7) Penyakit penyerta seperti diabetes atau penyakit ginjal

e. Tanda dan Gejala

Beberapa tanda dan gejala yang sering muncul sebelum terjadinya eklampsia antara lain:

- 1) Tekanan darah sangat tinggi
- 2) Sakit kepala hebat
- 3) Pandangan kabur atau gangguan penglihatan
- 4) Nyeri epigastrium atau ulu hati
- 5) Mual dan muntah
- 6) Hiperrefleksia
- 7) Penurunan kesadaran
- 8) Kejang

f. Dampak Eklampsia terhadap Ibu dan Janin

Eklampsia merupakan komplikasi kehamilan yang sangat serius dan termasuk kegawatdaruratan obstetri. Kejang yang terjadi pada eklampsia dapat menyebabkan gangguan aliran darah, penurunan oksigen, dan kerusakan organ, sehingga menimbulkan dampak berat baik pada ibu maupun janin.

1) Dampak Eklampsia terhadap Ibu

Pada ibu, eklampsia dapat menimbulkan berbagai komplikasi serius, antara lain:

- a) Kejang berulang yang dapat menyebabkan cedera dan aspirasi
 - b) Penurunan kesadaran hingga koma
 - c) Perdarahan otak atau stroke akibat tekanan darah sangat tinggi
 - d) Gagal ginjal akut akibat penurunan aliran darah ke ginjal
 - e) Gangguan fungsi hati dan risiko sindrom HELLP
 - f) Edema paru yang menyebabkan sesak napas
 - g) Risiko kematian ibu bila tidak ditangani segera
- 2) Dampak Eklampsia terhadap Janin
- Gangguan kondisi ibu secara langsung memengaruhi kesejahteraan janin, antara lain:
- a) Penurunan suplai oksigen ke janin saat kejang
 - b) Gawat janin akibat gangguan aliran darah uteroplasenta
 - c) Kelahiran prematur, sering karena indikasi penyelamatan ibu
 - d) Berat badan lahir rendah (BBLR)
 - e) Kematian janin dalam kandungan atau kematian neonatal
- g. Kolaborasi dan Rujukan
- Kolaborasi dan rujukan merupakan bagian penting dalam penanganan kegawatdaruratan eklampsia karena kondisi ini memerlukan kerja sama tim kesehatan dan penanganan di fasilitas yang memadai. Perawat berkolaborasi dengan dokter, bidan, dan tenaga kesehatan lain dalam pemberian obat antikejang dan antihipertensi, pemantauan kondisi ibu dan janin, serta persiapan tindakan persalinan bila diperlukan. Rujukan dilakukan apabila terjadi kejang berulang, tekanan darah sangat tinggi dan sulit dikendalikan, penurunan kesadaran, atau fasilitas pelayanan kesehatan tidak mampu memberikan penanganan lanjutan. Sebelum rujukan, perawat memastikan kondisi ibu stabil, jalan napas aman, pemantauan tanda vital berjalan, akses intravena terpasang, serta dokumen rujukan lengkap, dan memberikan penjelasan singkat kepada keluarga mengenai kondisi gawat darurat dan pentingnya rujukan segera
- h. Evaluasi Respon Ibu
- Evaluasi respon ibu pada kegawatdaruratan eklampsia dilakukan untuk menilai efektivitas tindakan keperawatan dan kolaborasi medis yang telah diberikan. Perawat mengevaluasi stabilitas jalan napas dan pernapasan, penurunan atau tidak adanya kejang, penurunan tekanan darah secara bertahap, serta perbaikan tingkat kesadaran ibu. Selain itu, dilakukan pemantauan tanda vital secara berkala, keseimbangan cairan, dan kondisi umum ibu setelah intervensi. Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk

melanjutkan pemantauan, menyesuaikan tindakan keperawatan, atau mempersiapkan rujukan lanjutan bila kondisi ibu belum stabil.

i. Peran Perawat dalam Penanganan Eklampsia

Perawat memiliki peran penting dalam penanganan eklampsia sebagai pemberi asuhan keperawatan yang cepat, tepat, dan berkesinambungan. Peran perawat meliputi melakukan pengkajian cepat terhadap kondisi ibu, menjaga jalan napas dan posisi aman selama dan setelah kejang, memantau tanda vital serta tingkat kesadaran, melaksanakan kolaborasi pemberian terapi medis sesuai instruksi, serta mendeteksi dini tanda perburukan kondisi. Selain itu, perawat berperan dalam persiapan rujukan, pendampingan ibu selama kegawatdaruratan, serta memberikan edukasi singkat kepada keluarga agar memahami kondisi ibu dan pentingnya penanganan segera.

B. Integrasi Asuhan Keperawatan & Keselamatan Ibu

Integrasi asuhan keperawatan dan keselamatan ibu dilakukan dengan menerapkan prinsip pencegahan risiko pada setiap tahap asuhan keperawatan, mulai dari pengkajian, penetapan diagnosis, perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Perawat mengidentifikasi risiko keselamatan seperti kejang, cedera, dan aspirasi sejak awal, melaksanakan tindakan keperawatan secara aman, melakukan kolaborasi dan komunikasi efektif dengan tim kesehatan, serta memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga tentang tanda bahaya. Dengan integrasi ini, asuhan keperawatan tidak hanya berfokus pada perbaikan kondisi klinis, tetapi juga menjamin keselamatan ibu secara menyeluruh.

Dalam penanganan kasus hipertensi kehamilan, preeklampsia, dan eklampsia, perawat menerapkan etika dan profesionalisme dengan mengutamakan keselamatan ibu dan janin, bertindak cepat sesuai standar praktik, serta bekerja dalam batas kewenangan dan kompetensi. Perawat menjaga kerahasiaan data ibu, memberikan informasi secara jujur dan mudah dipahami kepada ibu dan keluarga, serta menunjukkan sikap empatik dalam kondisi gawat darurat. Selain itu, perawat melaksanakan kolaborasi dan rujukan secara tepat, mendokumentasikan seluruh tindakan secara akurat, dan bertanggung jawab atas asuhan yang diberikan sebagai bentuk profesionalisme dalam pelayanan keperawatan maternitas.

C. Asuhan Keperawatan dengan Hipertensi Gestasional dan Preeklampsia

Asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan hipertensi gestasional merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk menjaga stabilitas kondisi ibu, mencegah komplikasi, serta mempertahankan kesejahteraan janin. Pendekatan asuhan

keperawatan dilakukan secara komprehensif, berkelanjutan, dan kolaboratif, dengan mengacu pada standar praktik keperawatan yang ditetapkan oleh PPNI.

1. Pengkajian Keperawatan

Pengkajian dilakukan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi masalah yang mungkin terjadi.

Data Subjektif : Keluhan sakit kepala hebat, penglihatan kabur nyeri epigastrium, mual, muntah, atau rasa tidak nyaman, nilai tekanan darah sebelum atau selama kehamilan

Data Objektif : tekanan darah $\geq 140/90$ mmHg, edema wajah, tangan, atau tungkai, peningkatan berat badan berlebih, proteinuria, hasil pemeriksaan laboratorium dan penunjang, kondisi dan kesejahteraan janin

2. Diagnosis Keperawatan (SDKI) dan Luaran Keperawatan (SLKI)

Berdasarkan hasil pengkajian, diagnosis keperawatan yang sering muncul pada hipertensi kehamilan antara lain:

- a. Perfusi Perifer Tidak Efektif berhubungan dengan peningkatan tekanan darah (D.0009)

Luaran yang diharapkan antara lain: debyut nadi perifer meningkat (5), edema perifer menurun (5) dan pengisian kapiler cukup membaik (5)

- b. Risiko Cedera berhubungan dengan terpapar agen nosokomial (D.0136)

Luaran yang diharapkan antara lain : toleransi aktifitas meningkat (5), kejadian cedera menurun (5) dan tekanan darah membaik (5)

- c. Risiko ketidakseimbangan elektrolit berhubungan dengan kelebihan volume cairan (D.0037)

Luaran yang diharapkan antara lain : asupan cairan meningkat (5), haluan urine meningkat (5) dan edema menurun (5)

- d. Ansietas berhubungan dengan krisis situasional (D.0080)

Luaran yang diharapkan antara lain : verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun (5), keluhan pusing menurun (5) dan tekanan darah menurun (5)

Diagnosis ditegakkan sesuai kriteria dan definisi dalam Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia (SDKI).

3. Intervensi Keperawatan (SIKI)

Intervensi keperawatan dirancang untuk mencapai luaran yang telah ditetapkan. Berikut adalah salah satu diagnosa keperawatan yang mungkin timbul pada komplikasi kehamilan dengan hipertensi gestasional, preeklampsia dan eklampsia, intervensi keperawatan ini disusun berdasarkan SDKI PPNI :

- a. Perfusi Perifer Tidak Efektif berhubungan dengan peningkatan tekanan darah (D.0009)

Tujuan dan Kriteria Hasil : Setelah dilakukan Tindakan keperawatan 3x24 jam diharapkan ibu mampu menunjukkan :

- 1) Denyut nadi perifer meningkat (5)
- 2) Edema perifer menurun (5)
- 3) Tekanan darah cukup baik (5)

Intervensi Keperawatan : Perawatan Sirkulasi (I.02079)

a) Observasi

- (1) Periksa sirkulasi perifer (misal : nadi perifer, edema, pengisian kapiler, warna, suhu, ankle brachial indeks)
- (2) Identifikasi factor resiko Gangguan sirkulasi (misal : diabetes, perokok, orang tua, hipertensi dan kadar kolesterol tinggi)
- (3) Monitor panas, kemerahan, nyeri, atau bengkak pada ekstremitas

b) Terapeutik

- (1) Hindari pemasangan infus atau pengambilan darah di area keterbatasan perfusi
- (2) Hindari pengukuran tekanan darah pada ekstremitas dengan keterbatasan perfusi
- (3) Hindari penekanan dan pemasangan tourniquet pada area yang cedera
- (4) Lakukan pencegahan infeksi
- (5) Lakukan perawatan kaki dan kuku
- (6) Lakukan hidrasi

c) Edukasi

- (1) Anjurkan berhenti merokok
- (2) Anjurkan berolahraga rutin
- (3) Anjurkan mengecek air mandi untuk menghindari kulit terbakar
- (4) Anjurkan menggunakan obat penurun tekanan darah, antikoagulan, dan penurun kolesterol, jika perlu
- (5) Anjurkan minum obat pengontrol tekanan darah secara teratur
- (6) Anjurkan menghindari penggunaan obat penyekat beta
- (7) Anjurkan melakukan perawatan kulit yang tepat (misal : melembabkan kulit kering pada kaki)
- (8) Anjurkan program rehabilitasi vaskuler
- (9) Ajarkan program diet untuk memperbaiki sirkulasi (misal : rendah lemak jenuh, minyak ikan omega 3)

- (10) Informasikan tanda dan gejala darurat yang harus dilaporkan
(misal : rasa sakit yang tidak hilang saat istirahat, luka tidak sembuh,
hilang rasa)

b. Risiko Cedera berhubungan dengan terpapar agen nosocomial (D.0136)

Tujuan dan Kriteria Hasil : Setelah dilakukan Tindakan keperawatan 3x24 jam diharapkan ibu mampu menunjukkan :

- 1) Toleransi aktifitas meningkat (5)
- 2) Kejadian cedera menurun (5)
- 3) Tekanan darah membaik (5)

Intervensi Keperawatan : (I.14513)

1) Observasi

- a) Identifikasi kebutuhan keselamatan (163 value : kondisi fisik, fungsi kognitif dan 163valuas perilaku)
- b) Monitor perubahan status keselamatan lingkungan

2) Terapeutik

- a) Hilangkan bahaya keselamatan lingkungan (163value : fisiologi, biologi, dan kimia), jika memungkinkan
- b) Modifikasi lingkungan untuk meminimaliskan bahaya dan resiko
- c) Sediakan alat bantu keamanan lingkungan (163value : commode chair dan pegangan tangan)
- d) Gunakan perangkat pelindung (163 value : pengekangan fisik, rel samping, pintu terkunci, pagar)
- e) Fasilitasi relokasi ke lingkungan yang aman

3) Edukasi

- a) Ajarkan individu, keluarga dan kelompok risiko tinggi bahaya lingkungan

c. Risiko ketidakseimbangan elektrolit berhubungan dengan kelebihan volume cairan (D.0037)

Tujuan dan Kriteria Hasil : Setelah dilakukan Tindakan keperawatan 3x24 jam diharapkan ibu mampu menunjukkan :

- 1) Asupan cairan meningkat (5)
- 2) Haluaran urine meningkat (5)
- 3) Edema menurun (5)

Intervensi Keperawatan : (I.03098)

1) Observasi

- a) Monitor status hidrasi (163value : frekwensi nadi, kekuatan nadi, akral, pengisian kapiler, kelembaban mukosa, turgor kulit, tekanan darah)
- b) Monitor berat badan harian
- c) Memonitor berat badan sebelum dan sesudah 163valuasi

- d) Monitor hasil pemeriksaan laboratorium (164valua: hematokrit, Na. K, CL, berat jenis urine, BUN)
- e) Monitor status hemodinamik (164valua : MAP, CPV, OAO, OCWP) jika perlu
- 2) Terapeutik
 - a) Kolaborasi pemberian diuretic, jika perlu
- d. Ansietas berhubungan dengan krisis situasional (D.0080)

Tujuan dan Kriteria Hasil : Setelah dilakukan Tindakan keperawatan 3x24 jam diharapkan ibu mampu menunjukkan :

 - 1) Verbalisasi khawatir akibat kondisi yang dihadapi menurun (5),
 - 2) Keluhan pusing menurun (5)
 - 3) Tekanan darah menurun (5)

Intervensi Keperawatan : (I.09314)

 - 1) Obsevasi
 - a) Identifikasi saat tingkat ansietas berubah (164valua : kondisi, waktu, stressor)
 - b) Identifikasi kemampuan mengambil keputusan
 - c) Monitor tanda-tanda ansietas (verbal dan nonverbal)
 - 2) Terapeutik
 - a) Ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan
 - b) Temani ibu untuk mengurangi kecemasan, jika memungkinkan
 - c) Pahami situasi yang membuat ansietas
 - d) Dengarkan dengan penuh perhatian
 - e) Gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan
 - f) Tempatkan barang pribadi yang memberikan kenyamanan
 - g) Motivasi mengidentifikasi situasi yang memicu kecemasan
 - h) Diskusikan perencanaan realistis tentang peristiwa yang akan datang
 - 3) Edukasi
 - a) Jelaskan prosedur, termasuk sensasi yang mungkin dialami
 - b) Informasikan secara factual mengenai diagnosis, pengobatan, dan prognosis
 - c) Anjurkan melakukan kegiatan yang tidak kompetitif, sesuai kebutuhan
 - d) Anjurkan mengungkapkan perasaan dan persepsi
 - e) Latih kegiatan pengalihan untuk mengurangi ketegangan
 - f) Latih penggunaan mekanisme pertahanan diri yang tepat
 - g) Latih tehnik relaksasi
 - 4) Kolaborasi
 - a) Kolaborasi pemberian obat antiansietas, jika perlu

e. Implementasi Keperawatan

Implementasi dilakukan sesuai rencana yang telah disusun, dengan memperhatikan keselamatan ibu dan janin, serta kolaborasi dengan tim 165valuasi165 lain. Setiap 165valuasi dicatat secara sistematis sebagai bagian dari dokumentasi keperawatan.

f. Evaluasi Keperawatan

Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan untuk menilai:

- 1) Pencapaian luaran keperawatan
- 2) Perubahan kondisi ibu dan janin
- 3) Kebutuhan modifikasi rencana asuhan

Hasil 165valuasi menjadi dasar dalam pengambilan keputusan keperawatan selanjutnya

D. Asuhan Keperawatan Kegawatdaruratan pada Eklampsia

1. Pengkajian Cepat (Rapid Assessment)

Pengkajian cepat (rapid assessment) adalah pengkajian awal yang dilakukan segera dan singkat pada ibu dengan dugaan eklampsia untuk menentukan prioritas tindakan penyelamatan jiwa. Pengkajian ini difokuskan pada kondisi yang mengancam nyawa dan dilakukan dalam hitungan menit.

Bentuk Pengkajian Cepat: Pendekatan ABCDE

a. A – Airway (Jalan Napas)

- 1) Nilai apakah jalan napas paten atau tidak
- 2) Perhatikan adanya:
 - a) Obstruksi jalan napas
 - b) Sekret, muntahan, atau darah
- 3) Periksa posisi kepala dan leher

Tujuan memastikan jalan napas terbuka dan aman

b. B – Breathing (Pernapasan)

- 1) Amati frekuensi dan pola napas
- 2) Perhatikan tanda:
 - a) Napas cepat atau dangkal
 - b) Sesak napas
 - c) Bunyi napas abnormal
- 3) Nilai warna kulit dan bibir (pucat/sianosis)

Tujuan memastikan oksigenasi adekuat

- c. C – Circulation (Sirkulasi)
 - 1) Ukur tekanan darah
 - 2) Periksa:
 - a) Nadi (frekuensi dan kekuatan)
 - b) Pengisian kapiler
 - c) Tanda perdarahan
 - 3) Amati edema berat
 - Tujuan menilai kestabilan sirkulasi dan perfusi
- d. D – Disability (Status Neurologis)
 - 1) Nilai tingkat kesadaran (misalnya AVPU: Alert, Voice, Pain, Unresponsive)
 - 2) Amati:
 - a) Adanya kejang
 - b) Respons terhadap rangsangan
 - c) Refleks (bila memungkinkan)
 - Tujuan mendeteksi gangguan neurologis dan kejang
- e. E – Exposure (Paparan & Lingkungan)
 - 1) Amati kondisi tubuh secara umum:
 - a) Edema umum
 - b) Cedera akibat kejang
 - 2) Jaga privasi dan suhu tubuh ibu
 - Tujuan menemukan masalah tambahan dan mencegah cedera

E. Edukasi Kesehatan pada Ibu dan Keluarga dengan Hipertensi gestasional

Hipertensi gestasional merupakan kondisi meningkatnya tekanan darah pada ibu hamil yang biasanya muncul setelah usia kehamilan 20 minggu tanpa adanya protein dalam urin. Kondisi ini perlu mendapat perhatian karena dapat berkembang menjadi komplikasi yang lebih serius bila tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, edukasi kesehatan kepada ibu dan keluarga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan komplikasi. Perawat berperan memberikan penjelasan yang mudah dipahami mengenai kondisi yang dialami ibu, pentingnya pemantauan tekanan darah secara rutin, serta tanda bahaya yang harus segera dilaporkan kepada tenaga kesehatan. Dengan pemahaman yang baik, ibu diharapkan mampu berperan aktif dalam menjaga kesehatannya selama kehamilan.

Dalam proses edukasi, ibu dan keluarga perlu diberikan informasi mengenai pola hidup sehat selama kehamilan. Ibu dianjurkan untuk menjaga pola makan dengan mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak sayur dan buah, membatasi makanan yang terlalu asin, serta memastikan asupan cairan yang cukup. Selain itu, ibu juga dianjurkan untuk cukup istirahat, menghindari kelelahan, dan

melakukan posisi istirahat miring ke kiri untuk membantu meningkatkan aliran darah ke plasenta dan janin. Aktivitas fisik ringan seperti berjalan santai dapat dilakukan sesuai anjuran tenaga kesehatan. Keluarga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan emosional serta membantu ibu menjalankan anjuran kesehatan yang telah diberikan.

Edukasi juga harus mencakup pemahaman tentang tanda bahaya yang dapat muncul pada hipertensi dalam kehamilan. Ibu dan keluarga perlu mengetahui gejala seperti sakit kepala hebat, pandangan kabur, nyeri pada ulu hati, pembengkakan pada wajah dan tangan, serta penurunan gerakan janin. Apabila tanda-tanda tersebut muncul, ibu harus segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Pengetahuan mengenai tanda bahaya ini sangat penting karena penanganan yang cepat dapat mencegah terjadinya komplikasi yang lebih berat.

Selain itu, kepatuhan terhadap pemeriksaan kehamilan (antenatal care) juga perlu ditekankan dalam edukasi. Ibu dianjurkan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin sesuai jadwal yang ditentukan oleh tenaga kesehatan. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memantau kondisi ibu dan janin, mengontrol tekanan darah, serta mendeteksi secara dini kemungkinan terjadinya komplikasi. Dengan edukasi yang tepat dan dukungan keluarga yang baik, diharapkan ibu dengan hipertensi gestasional dapat menjalani kehamilan dengan lebih aman dan sehat hingga proses persalinan.

F. Edukasi Kesehatan pada Ibu dan Keluarga dengan Preeklampsia

Preeklampsia merupakan salah satu komplikasi kehamilan yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah setelah usia kehamilan 20 minggu yang disertai dengan adanya protein dalam urin dan dapat diikuti oleh gangguan pada organ tubuh lainnya. Kondisi ini perlu mendapat perhatian serius karena dapat membahayakan kesehatan ibu maupun janin apabila tidak ditangani dengan baik. Oleh karena itu, edukasi kesehatan kepada ibu dan keluarga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan perburukan kondisi. Perawat memiliki peran penting dalam memberikan informasi yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami mengenai kondisi yang dialami ibu, sehingga ibu dan keluarga mampu memahami pentingnya perawatan dan pemantauan selama kehamilan.

Dalam edukasi, ibu dan keluarga perlu diberikan pemahaman mengenai penyebab dan faktor risiko preeklampsia secara sederhana. Penjelasan dapat difokuskan pada adanya gangguan pada pembuluh darah selama kehamilan yang menyebabkan tekanan darah meningkat dan memengaruhi fungsi organ tubuh ibu. Pemahaman ini penting agar ibu dan keluarga tidak merasa takut secara berlebihan,

tetapi tetap menyadari bahwa kondisi tersebut memerlukan pemantauan yang lebih ketat. Perawat juga perlu menekankan pentingnya menjaga pola hidup sehat selama kehamilan, seperti mengonsumsi makanan bergizi seimbang, memperbanyak sayur dan buah, mengurangi makanan tinggi garam, serta memastikan ibu mendapatkan istirahat yang cukup.

Selain itu, ibu dianjurkan untuk menghindari aktivitas yang terlalu berat dan lebih banyak melakukan istirahat dengan posisi miring ke kiri. Posisi ini dapat membantu meningkatkan aliran darah ke plasenta sehingga kebutuhan oksigen dan nutrisi janin tetap terpenuhi. Dukungan keluarga sangat diperlukan dalam membantu ibu menjalani anjuran tersebut, misalnya dengan membantu pekerjaan rumah tangga, memberikan dukungan emosional, serta memastikan ibu mematuhi anjuran dari tenaga kesehatan.

Bagian penting dalam edukasi adalah mengenalkan tanda dan gejala bahaya yang dapat muncul pada preeklampsia. Ibu dan keluarga perlu mengetahui beberapa gejala yang harus segera dilaporkan kepada tenaga kesehatan, seperti sakit kepala hebat, pandangan kabur atau berkunang-kunang, nyeri pada bagian ulu hati, mual dan muntah yang berat, pembengkakan pada wajah dan tangan, serta penurunan gerakan janin. Apabila gejala tersebut muncul, ibu harus segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Pengetahuan tentang tanda bahaya ini sangat penting untuk mencegah perkembangan kondisi yang lebih berat, seperti kejang pada ibu.

Edukasi juga perlu menekankan pentingnya pemeriksaan kehamilan secara teratur atau antenatal care. Melalui pemeriksaan rutin, tenaga kesehatan dapat memantau tekanan darah, memeriksa urin, serta menilai kondisi ibu dan janin secara berkala. Dengan pemantauan yang baik, perubahan kondisi dapat dideteksi lebih dini sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Oleh karena itu, ibu dan keluarga diharapkan memiliki kesadaran dan komitmen untuk selalu mengikuti jadwal pemeriksaan yang telah dianjurkan.

Dengan pendekatan edukasi yang komunikatif, ibu dan keluarga diharapkan mampu memahami kondisi preeklampsia dengan lebih baik. Pemahaman ini akan membantu meningkatkan kepatuhan terhadap perawatan, memperkuat dukungan keluarga, serta berkontribusi dalam menjaga kesehatan ibu dan janin hingga proses persalinan berlangsung dengan aman.

G. Edukasi Kesehatan pada Ibu dan Keluarga dengan Preeklampsia

Eklampsia merupakan kondisi kegawatdaruratan dalam kehamilan yang ditandai dengan terjadinya kejang pada ibu hamil yang sebelumnya mengalami preeklampsia. Kondisi ini dapat membahayakan keselamatan ibu maupun janin

apabila tidak segera mendapatkan penanganan yang tepat. Oleh karena itu, edukasi kesehatan kepada ibu dan keluarga menjadi sangat penting sebagai bagian dari upaya pencegahan komplikasi yang lebih berat. Perawat berperan memberikan penjelasan secara jelas, empatik, dan mudah dipahami mengenai kondisi yang dialami ibu, sehingga keluarga dapat memahami bahwa eklampsia merupakan kondisi serius yang membutuhkan penanganan medis segera.

Dalam proses edukasi, perawat perlu menjelaskan secara sederhana bahwa eklampsia terjadi akibat peningkatan tekanan darah yang tidak terkontrol selama kehamilan sehingga memengaruhi fungsi otak dan organ tubuh lainnya, yang akhirnya dapat menyebabkan kejang. Penjelasan ini bertujuan agar ibu dan keluarga memahami pentingnya pemantauan kesehatan secara rutin selama kehamilan, terutama bagi ibu yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi atau preeklampsia. Edukasi juga perlu menekankan bahwa setelah mengalami eklampsia, ibu tetap memerlukan pemantauan ketat oleh tenaga kesehatan untuk memastikan kondisi ibu dan bayi tetap stabil.

Selain memberikan pemahaman mengenai kondisi penyakit, edukasi juga perlu menekankan pentingnya perawatan dan pemulihan ibu setelah mengalami kejang. Ibu dianjurkan untuk mendapatkan istirahat yang cukup, menghindari aktivitas yang terlalu berat, serta mematuhi seluruh pengobatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan. Keluarga diharapkan dapat berperan aktif dalam membantu memenuhi kebutuhan ibu, memberikan dukungan emosional, serta memastikan ibu mengikuti anjuran medis yang diberikan. Dukungan keluarga sangat penting karena kondisi ini sering menimbulkan kecemasan dan ketakutan bagi ibu.

Perawat juga perlu memberikan edukasi mengenai tanda bahaya yang harus segera diwaspadai oleh keluarga setelah ibu mengalami eklampsia. Beberapa tanda tersebut antara lain sakit kepala yang sangat hebat, pandangan kabur, nyeri pada bagian ulu hati, pembengkakan yang semakin berat pada wajah atau tangan, penurunan kesadaran, serta kemungkinan terjadinya kejang kembali. Apabila gejala tersebut muncul, keluarga harus segera membawa ibu ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pertolongan medis. Pengetahuan mengenai tanda bahaya ini sangat penting agar keluarga dapat bertindak cepat dalam situasi darurat.

Selain itu, ibu dan keluarga perlu diberikan pemahaman mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan secara teratur setelah kejadian eklampsia, baik pada masa kehamilan yang masih berlangsung maupun pada masa nifas. Pemantauan tekanan darah, pemeriksaan kondisi organ tubuh, serta evaluasi kesehatan ibu secara menyeluruh diperlukan untuk mencegah komplikasi lebih lanjut. Edukasi ini juga dapat menjadi kesempatan bagi perawat untuk mendorong keluarga agar lebih

peduli terhadap kesehatan ibu dan memberikan lingkungan yang mendukung proses pemulihan.

Melalui edukasi kesehatan yang komunikatif, dan mudah dipahami, diharapkan ibu dan keluarga memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi eklampsia. Pemahaman tersebut dapat membantu meningkatkan kewaspadaan, memperkuat dukungan keluarga, serta mendorong kepatuhan terhadap pengobatan dan pemantauan kesehatan. Dengan demikian, keselamatan ibu dan bayi dapat lebih terjaga hingga masa persalinan dan masa pemulihan setelah melahirkan.

1. Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Ny. A, usia 28 tahun, G1P0A0, usia kehamilan 32 minggu datang ke ruang antenatal care dengan keluhan sakit kepala sejak 2 hari terakhir, pandangan kabur, dan bengkak pada kaki serta wajah. Ibu mengatakan sebelumnya kehamilannya tidak memiliki keluhan yang berarti.

Hasil pengkajian didapatkan data sebagai berikut:

- a. Tekanan darah: 160/100 mmHg
- b. Nadi: 92 x/menit
- c. Respirasi: 22 x/menit
- d. Suhu: 36,8°C
- e. Edema pada ekstremitas bawah (+2)
- f. Refleks patella meningkat
- g. Hasil pemeriksaan urine menunjukkan proteinuria (+2)
- h. Ibu tampak cemas dan mengatakan khawatir dengan kondisi dirinya dan janinnya.

Dokter menyampaikan bahwa ibu mengalami preeklampsia dan perlu dilakukan pemantauan ketat untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi

1. Mengidentifikasi data subjektif dan data objektif pada kasus diatas.
2. Menjelaskan perubahan fisiologis kehamilan yang mungkin berkaitan dengan kondisi ibu.
3. Menganalisis faktor risiko yang dapat menyebabkan preeklampsia pada ibu
4. Menentukan diagnosis keperawatan yang mungkin muncul berdasarkan standar SDKI.
5. Menjelaskan alasan pemilihan diagnosis keperawatan.
6. Menyusun rencana asuhan keperawatan berdasarkan SLKI dan SIKI.
7. Menjelaskan tindakan keperawatan dan edukasi kesehatan kepada ibu dan keluarga.
8. Menyusun dokumentasi asuhan keperawatan secara sistematis.

Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

2. Aktivitas 2 — *Shows How*

No.	Komponen	Isi
1	Nomor station	 (Dikosongkan)
2	Judul station	Asuhan Keperawatan pada ibu dengan komplikasi, kehamilan : hipertensi gestasional, preeklampsia, dan eklampsia
3	Waktu yang dibutuhkan	5–7 menit
4	Tujuan station	Menilai kemampuan peserta ujian dalam melakukan pengkajian fokus, penegakan diagnosis dan perencanaan keperawatan, serta edukasi kesehatan dan menerapkan prinsip patient safety sesuai standar praktik keperawatan.
5	Kompetensi	1. Komunikasi, edukasi, dan konseling 2. Pengkajian 3. Diagnosa dan perencanaan 4. Implementasi 5. Evaluasi 6. Perilaku professional
6	Kategori	1. Aman & nyaman 2. Oksigen 3. Cairan dan Elektrolit 4. Aktifitas & istirahat 5. Psikososial
7	Instruksi untuk peserta ujian	SKENARIO KLINIK: Seorang perempuan, usia 30 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 34 minggu datang ke IGD diantar oleh keluarganya dengan keluhan baru saja mengalami kejang sekitar 2 menit dirumah. Keluarga mengatakan sebelum kejang ibu mengeluh sakit kepala hebat, pandangan kabur, dan nyeri pada ulu hati sejak pagi hari. Ibu memiliki riwayat hipertensi sejak usia kehamilan 28 minggu dan kontrol kehamilan terakhir dua minggu yang lalu. Ibu mengaku minum obat hipertensi tidak teratur. Saat dilakukan pengkajian cepat di IGD didapatkan data sebagai berikut : keadaan umum: tampak lemah dan gelisah, kesadaran somnolen, TD 170/110 mmHg, Nadi 100 x/menit, Respirasi 24 x/menit, Suhu 37,2°C, terdapat edema pada wajah dan tungkai bawah (+2), refleks patella meningkat, pemeriksaan urine menunjukkan proteinuria (+3), denyut jantung janin 150 x/menit. Dokter

No.	Komponen	Isi
		mencurigai ibu mengalami eklampsia dan meminta tim perawat melakukan rapid assessment dan tindakan awal kegawatdaruratan. TUGAS: Lakukan pengkajian cepat (rapid assessment) pada ibu hamil dengan dugaan eklampsia menggunakan pendekatan ABCDE, dengan memperhatikan keselamatan ibu. Peserta diharapkan menilai jalan napas, pernapasan, sirkulasi, tingkat kesadaran, dan kondisi umum ibu, serta melakukan tindakan awal untuk mencegah cedera selama proses pengkajian. Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario diatas dan hasil validasi pengkajian fokus. Tuliskan perencanaan keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario. Lakukan edukasi dan demonstrasi cara mengenali tanda bahaya atau tanda awal kegawatdaruratan
8	Instruksi untuk penguji	SKENARIO KLINIK: Seorang perempuan, usia 30 tahun, G2P1A0, usia kehamilan 34 minggu datang ke IGD diantar oleh keluarganya dengan keluhan baru saja mengalami kejang sekitar 2 menit dirumah. Keluarga mengatakan sebelum kejang ibu mengeluh sakit kepala hebat, pandangan kabur, dan nyeri pada ulu hati sejak pagi hari. Ibu memiliki riwayat hipertensi sejak usia kehamilan 28 minggu dan kontrol kehamilan terakhir dua minggu yang lalu. Ibu mengaku minum obat hipertensi tidak teratur. Saat dilakukan pengkajian cepat di IGD didapatkan data sebagai berikut : keadaan umum: tampak lemah dan gelisah, kesadaran somnolen, TD 170/110 mmHg, Nadi 100 x/menit, Respirasi 24 x/menit, Suhu 37,2°C, terdapat edema pada wajah dan tungkai bawah (+2), refleks patella meningkat, pemeriksaan urine menunjukkan proteinuria (+3), denyut jantung janin 150 x/menit. Dokter mencurigai ibu mengalami eklampsia dan meminta tim perawat melakukan rapid assessment dan tindakan awal kegawatdaruratan. TUGAS: Lakukan pengkajian cepat (rapid assessment) pada ibu hamil dengan dugaan eklampsia menggunakan pendekatan ABCDE, dengan memperhatikan keselamatan ibu. Peserta diharapkan menilai jalan napas, pernapasan, sirkulasi, tingkat kesadaran, dan kondisi umum ibu, serta melakukan tindakan awal untuk mencegah cedera selama proses pengkajian.

No.	Komponen	Isi
		Tuliskan diagnosis keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario di atas dan hasil validasi pengkajian fokus. Tuliskan perencanaan keperawatan pada lembar jawab berdasarkan skenario. Lakukan edukasi dan demonstrasi cara mengenali tanda bahaya atau tanda awal kegawatdaruratan INSTRUKSI PENGUJI: Menilai ketepatan peserta dalam menentukan pengkajian fokus tambahan, yaitu adanya riwayat hipertensi sebelumnya dan ketidakteraturan mengkonsumsi obat hipertensinya Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan label diagnosis keperawatan: Perfusi Perifer Tidak Efektif berhubungan dengan peningkatan tekanan darah (D.0009) ditandai dengan denyut nadi perifer meningkat, ada edema perifer, dan peningkatan tekanan darah Menilai kemampuan peserta dalam menuliskan intervensi keperawatan yang sesuai, seperti Periksa sirkulasi perifer, Identifikasi factor resiko Gangguan sirkulasi (misal : riwayat hipertensi), monitor panas, kemerahan, nyeri, atau bengkak pada ekstremitas dan Informasikan tanda dan gejala darurat yang harus dilaporkan Menilai ketepatan penampilan peserta dalam edukasi dan demonstrasi pemberian cara mengenali tanda bahaya atau tanda awal kegawatdaruratan, meliputi sakit kepala hebat, pandangan kabur, nyeri ulu hati, bengkak mendadak pada wajah/tangan, gerakan janin berkurang, kejang serta menjelaskan tanda bahaya yang harus segera dilaporkan. Monitor perilaku profesional peserta. Penguji tidak diperbolehkan melakukan interupsi ataupun bertanya kepada peserta selain yang ditentukan.
9	Instruksi untuk klien standar	Hal-hal yang perlu dicantumkan di antaranya: Identitas ibu sesuai kasus : perempuan usia 30 tahun. KS berperan sebagai ibu hamil. Riwayat penyakit sekarang: Ibu memiliki riwayat hipertensi sejak usia kehamilan 28 minggu dan kontrol kehamilan terakhir dua minggu yang lalu. Ibu mengaku minum obat hipertensi tidak teratur. Rawat inap saat ini adalah hari pertama, dan ini merupakan rawat inap pertama.

No.	Komponen	Isi
		Riwayat penyakit keluarga : dikeluarga tidak ada yang mengalami keluhan yang sama. Riwayat kebiasaan sosial : ibu tampak cemas, dengan kondisinya saat ini, karena waktu hamil anak pertama tidak seperti ini Harapan terhadap penyakit: ibu berharap kehamilannya akan baik-baik saja dan bayi dapat terlahir sehat dan tidak ada masalah Bila peserta menanyakan riwayat kejang, jawaban KS: baru saja mengalami kejang sekitar 2 menit dirumah. Bila peserta menanyakan asupan makan dan minum, jawaban KS: ibu mengatakan sering haus dan mudah lapar. KS duduk disamping tempat tidur dengan raut wajah cemas. Peran harus dilakukan secara jelas agar tidak membingungkan peserta ujian.
10	Setting station	Ruang Rawat ANC Tempat tidur ibu Manekin Perut Ibu Hamil KS berperan sebagai ibu Laboran Penguji Tata letak ruang: 1. Tempat tidur dan manekin Perut Ibu Hamil 2. Meja penguji 4. Kursi penguji 5. Pintu masuk 6. Troli alat 7. Wastafel/handrub 8. Tempat sampah 9. Kursi laboran
11	Peralatan yang dibutuhkan	Peralatan: 1. Alat Pengkajian Tanda Vital Tensimeter (sphygmomanometer)

No.	Komponen	Isi
		Stetoskop Termometer Jam tangan dengan detik 2. Alat Pemeriksaan Ibu Hamil (ANC) Doppler / fetoskop untuk denyut jantung janin (DJJ) Meteran / pita ukur untuk tinggi fundus uteri (TFU) Timbangan berat badan Alat ukur tinggi badan Buku KIA / lembar rekam medis 3. Alat Pemeriksaan Penunjang Sederhana Urine dipstick untuk pemeriksaan proteinuria Pot urin Sarung tangan bersih 4. Alat Tindakan dan Keselamatan Sarung tangan medis Masker Tempat sampah medis Hand sanitizer / sabun cuci tangan 5. Alat Edukasi Ibu Leaflet / media edukasi tanda bahaya kehamilan Lembar pemantauan gerakan janin Media edukasi posisi miring kiri 6. Alat Kesiapsiagaan Kegawatdaruratan (jika diruang tindakan) Set oksigen Set infus Obat emergensi (misalnya magnesium sulfat sesuai protokol fasilitas) Peran laboran: Merapikan ulang alat-alat setelah digunakan peserta, dan memastikan set ujian siap untuk peserta selanjutnya sebelum peserta masuk ruang ujian.

No.	Komponen	Isi
12	Penulis	Ns. Nina Sunarti, M.Kep
13	Referensi	Tim Pokja SDKI DPP PPNI (2017) Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia: Definisi dan Indikator Diagnostik. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SIKI DPP PPNI (2019) Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja SLKI DPP PPNI (2019) Standar Luaran Keperawatan Indonesia: Definisi dan Kriteria Hasil Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI. Tim Pokja Pedoman SPO Keperawatan DPP PPNI (2021) Pedoman Standar Prosedur Operasional Keperawatan. 1st edn. Jakarta: DPP PPNI.

SOP EDUKASI DAN DEMONSTRASI CARA MENGENALI TANDA AWAL KEGAWATDARURATAN

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
A	Tahap Pra interaksi				
1	Mengecek catatan medis dan catatan keperawatan				
2	Menyiapkan alat dan perlengkapan: a. Alat Pengkajian Tanda Vital Tensimeter (sphygmomanometer) Stetoskop Termometer Jam tangan dengan detik b. Alat Pemeriksaan Ibu Hamil (ANC) Doppler / fetoskop untuk denyut jantung janin (DJJ) Meteran / pita ukur untuk tinggi fundus uteri (TFU) Timbangan berat badan Alat ukur tinggi badan Buku KIA / lembar rekam medis				
3	Mencuci tangan				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
B	Tahap Orientasi				
4	Menyampaikan salam terapeutik				
5	Menyampaikan nama dan peran perawat				
6	Mengecek identitas ibu, minimal nama dan tanggal lahir/umur secara aktif				
7	Menyampaikan maksud dan tujuan serta kontrak waktu				
8	Memberi kesempatan bertanya				
9	Memulai tindakan dengan baik				
10	Menjaga privasi dan kenyamanan ibu				
C	Tahap Kerja (No. 11 s.d. 28: sistematis)				
11	Melakukan hand hygiene				
12	Menggunakan sarung tangan bersih bila ada risiko kontak dengan cairan tubuh				
13	Mengidentifikasi tanda-tanda vital				
14	Mengidentifikasi tanda dan gejala yang mengarah pada kegawatan dan kesiapan ibu menerima edukasi				
15	Mengatur posisi ibu nyaman, mungkin sesuai kondisi				
16	Menjelaskan tujuan pemeriksaan fisik pada ibu hamil dengan tujuan untuk mencegah komplikasi lanjutan				
17	Memeriksa posisi miring kiri untuk memberikan kenyamanan ibu				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
18	Mendemonstrasikan hal-hal yang perlu diperhatikan dan segera lapor jika ditemukan tanda-tanda kearah perburukan				
19	Menjelaskan dan mendemonstrasikan cara penanganan kegawatdaruratan pada ibu hamil dengan hipertensi, preeklamsia dan eklampsia				
20	Menjelaskan jika terjadi perburukan pada ibu segera lapor kepada petugas kesehatan				
21	Menganjurkan posisi miring kiri untuk meningkatkanIn aliran darah ke janin				
22	Menganjurkan tetap mengontrol tekanan darah dengan menjaga asupan makanan dan minuman				
23	Menjelaskan bahwa tekanan darah akan terus naik jika tidak dkontrol hingga proses persalinan				
24	Menjelaskan tanda bahaya yang harus segera dilaporkan atau dibawa ke fasilitas kesehatan: sakit kepala hebat, pandangan kabur, bengkak pada wajah, tangan, atau kaki, nyeri hebat pada ulu hati, tekanan darah sangat tinggi ($\geq 140/90$ mmHg jika diketahui), kejang dan penurunan kesadaran, gerakan janin berkurang, mual dan muntah hebat disertai lemas, Perdarahan dari jalan lahir, sesak napas atau dada terasa berat				
25	Meminta ibu mengulang kembali penjelasan yang sudah diberikan				
26	Meminta ibu mendemonstrasikan kembali cara posisi miring dengan benar				
27	Merapikan ibu dan alat-alat yang digunakan				
28	Melepaskan sarung tangan bila digunakan dan melakukan kebersihan tangan 6 langkah				
D	Tahap Terminasi				

No	Kegiatan/Tahapan	Dilakukan Ya	Dilakukan Tidak	Kompeten Ya	Kompeten Tidak
29	Menyimpulkan kegiatan				
30	Mengevaluasi respons ibu/ibu secara subjektif dan objektif				
31	Memberikan reinforcement positif				
32	Membuat kontrak waktu selanjutnya				
33	Mengakhiri tindakan dengan baik				
E	Tahap Dokumentasi				
34	Mencatat hari, tanggal, jam, hasil pengkajian singkat, kegiatan edukasi dan demonstrasi cara penanganan kegawatdaruratan pada ibu hamil dengan hipertensi, preeklamsia dan eklampsia, respons ibu, serta tindak lanjut				
F	Penampilan Profesional				
35	Aman, nyaman, teliti, cermat, tepat, responsif				

**Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Asuhan
Keperawatan ibu dengan eklampsia**

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Ibu dengan Eklampsia
Metode penilaian	Mini-CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam encounter singkat, terfokus, dan nyata dilahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat memberikan asuhan awal pada ibu yang pasca mengalami kejang diruang instalasi gawat darurat.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi, edukasi, dan profesionalisme dalam satu pertemuan klinik.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya tentang konsep eklampsia, tetapi juga dari kemampuannya melakukan pengkajian, menjelaskan kondisi ibu, dan menyampaikan rencana asuhan kepada ibu.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan dilahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau tahap profesi.	Ibu ada riwayat kejang dirumah, ibu mengeluh sakit kepala hebat, pandangan kabur, dan nyeri pada ulu hati sejak pagi hari. Ibu memiliki riwayat hipertensi sejak usia kehamilan 28 minggu dan kontrol kehamilan terakhir dua minggu yang lalu. Ibu mengaku minum obat hipertensi tidak teratur. Saat dilakukan pengkajian cepat di IGD didapatkan data sebagai berikut : keadaan umum tampak lemah dan gelisah, kesadaran somnolen, TD 170/110 mmHg, Nadi 100 x/menit, Respirasi 24 x/menit, Suhu 37,2°C, terdapat edema pada wajah dan tungkai bawah (+2), refleks patella meningkat, pemeriksaan urine menunjukkan proteinuria (+3), denyut jantung janin 150 x/menit.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan encounter klinik secara utuh sejak awal interaksi sampai penjelasan rencana tindakan.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengkajian singkat namun terarah, memeriksa riwayat kejang dirumah, menjelaskan kondisi ibu sakit kepala hebat, pandangan kabur, dan nyeri pada ulu hati, TD 170/110 mmHg, Nadi 100 x/menit, Respirasi 24 x/menit, Suhu 37,2°C, terdapat edema pada wajah dan tungkai bawah (+2), refleks patella meningkat, pemeriksaan urine menunjukkan proteinuria (+3), denyut jantung janin 150 x/menit.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi anamnesis atau pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus,	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menggali riwayat kejang, sakit kepala hebat, pandangan kabur, nyeri pada ulu hati, mengenali

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Ibu dengan Eklampsia
	penalaran klinik, komunikasi terapeutik, edukasi keluarga, profesionalisme, dan organisasi tindakan.	tanda eklampsia, menjelaskan posisi nyaman dengan bahasa sederhana, dan menjaga komunikasi yang baik dengan ibu ibu.
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format Mini-CEX yang terstruktur.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menghubungkan data klinik dengan masalah prioritas, misalnya Perfusi Perifer Tidak Efektif berhubungan dengan peningkatan tekanan darah (D.0009), serta mampu memberikan edukasi yang tepat dan aman kepada ibu.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat, spesifik, dan berorientasi pada perbaikan performa.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan identifikasi tanda bahaya kegawatan pada ibu dan janin, tetapi masih perlu memperdalam pengkajian riwayat hipertensi dan memperjelas penjelasan tentang tanda bahaya.
Keputusan penilaian	Hasil Mini-CEX digunakan untuk menentukan tingkat performa mahasiswa dalam praktik klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan encounter klinik secara runtut, aman, komunikatif, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila masih membutuhkan arahan pada beberapa bagian. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila performanya belum memenuhi standar minimal.
Makna dalam OBE	Mini-CEX memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does.	Pada kasus ibu dengan eklampsia, mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan asuhan keperawatan secara langsung, aman, tepat, dan profesional dilahan praktik.

Tabel Portofolio pada Asuhan Keperawatan dengan Eklampsia

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Ibu dengan Eklampsia
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada asuhan keperawatan dengan eklampsia, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian, menetapkan masalah keperawatan, memberikan edukasi, menjaga keselamatan ibu, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah merawat ibu dengan

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Ibu dengan Eklampsia
	diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	eclampsia , tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur dilaboratorium dan bukti performa nyata dilahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan edukasi pemberian pemberian posisi yang nyaman bagi ibu, sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan asuhan pada ibu dengan eclampsia diruang instalasi gawat darurat.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus ibu yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah keperawatan, intervensi utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus ibu dengan eklampsia, frekuensi kejang, sakit kepala, nyeri ulu hati, diagnosis keperawatan prioritas, intervensi eklampsia, edukasi posisi miring nyaman bagi ibu, dan evaluasi respons ibu.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan ibu, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan keperawatan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya memantau tanda bahaya kehamilan bagi ibu dan janin, mencatat tanda-tanda vital dengan teliti, memastikan posisi yang diberikan dengan cara yang benar, dan mengenali tanda bahaya yang membutuhkan pelaporan segera.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dengan ibu dan edukasi posisi nyaman, tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam pengkajian pemantauan tanda-tanda vital dan dokumentasi observasi tanda bahaya kehamilan pada ibu dan janin.
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus eklampsia, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu melakukan asuhan keperawatan pada ibu dengan eklampsia secara aman, tepat, dan profesional.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Ibu dengan Eklampsia
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan pengkajian tanda-tanda vital, edukasi posisi nyaman, dan komunikasi terapeutik dengan ibu.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada asuhan keperawatan ibu dengan eklampsia, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep eklampsia, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik klinik nyata.

Tabel. Case Report pada Asuhan Keperawatan Ibu dengan Eklampsia

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus ibu dengan Eklampsia
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus ibu yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang seorang ibu hamil dengan riwayat kejang dirumah, ibu mengeluh sakit kepala hebat, pandangan kabur, dan nyeri pada ulu hati, TD 170/110 mmHg, Nadi 100 x/menit, Respirasi 24 x/menit, Suhu 37,2°C, terdapat edema pada wajah dan tungkai bawah (+2), refleks patella meningkat, pemeriksaan urine menunjukkan proteinuria (+3), denyut jantung janin 150 x/menit.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data ibu, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan yang diberikan, dan perkembangan kondisi ibu setelah intervensi.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat ibu, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus eklampsia, mahasiswa menuliskan riwayat kejang dirumah, sakit kepala hebat, pandangan kabur, dan nyeri pada ulu hati, TD 170/110 mmHg, Nadi 100 x/menit, Respirasi 24 x/menit, Suhu 37,2°C, terdapat edema pada wajah dan tungkai bawah (+2), refleks patella meningkat, pemeriksaan urine menunjukkan proteinuria (+3), denyut jantung janin 150 x/menit, diagnosis Perfusi Perifer Tidak Efektif berhubungan dengan peningkatan tekanan darah (D.0009), intervensi pemantauan tanda

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus ibu dengan Eklampsia
		dan gejala bahaya pada ibu dan janin, edukasi mengajarkan posisi yang nyaman, dan evaluasi perbaikan perfusi perifer.
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan intervensi, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan data kehilangan cairan dengan masalah utama, memilih intervensi yang tepat, dan menilai respons ibu setelah pemberian penatalaksanaan.
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus eklampsia, mahasiswa belajar bahwa pengkajian tanda-tanda vital, tanda kejang, dan edukasi ibu dan keluarga merupakan bagian yang sangat penting dalam asuhan keperawatan maternitas.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep eklampsia pada ibu, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan keperawatan secara utuh.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Asuhan Keperawatan ibu dengan Eklampsia

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Ibu dengan Eklampsia
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan ibu, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus ibu dengan eklampsia, mahasiswa merefleksikan bahwa riwayat kejang dapat menyebabkan perburukan kondisi bila tidak dikenali dan ditangani dengan tepat.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan ibu merupakan bagian penting dari setiap tindakan keperawatan.	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti kurang teliti memantau tanda-tanda vital dan gejala eklampsia atau terlambat mengenali tanda eklampsia, dapat berdampak besar pada keselamatan ibu dan janin.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada ibu ini adalah kejang berulang, perfusi perifer, dan keterlambatan penanganan bila keluarga tidak memahami tanda bahaya.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan ibu.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain perbaikan perfusi perifer, berkurangnya edema, nyeri ulu hati yang menetap,

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Ibu dengan Eklampsia
		ketidakpatuhan dalam mengonsumsi obat hipertensi, dan keterlambatan pelaporan tanda bahaya.
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan ibu.	Mahasiswa menuliskan pentingnya memantau tanda eklampsia secara berkala, mencatat tanda-tanda vital dengan teliti, menjelaskan cara pemberian posisi yang nyaman dan benar, serta mengedukasi ibu tentang tanda bahaya.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada ibu dengan eklampsia, pengkajian yang teliti, komunikasi yang jelas kepada keluarga, dan pemantauan berulang merupakan bagian penting untuk menjaga keselamatan ibu.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan ibu.	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik keperawatan maternitas secara berkelanjutan.

H. Ringkasan Bab

Komplikasi kehamilan yang berkaitan dengan hipertensi merupakan salah satu penyebab utama morbiditas dan mortalitas ibu serta janin. Kondisi ini meliputi hipertensi gestasional, preeklampsia, dan eklampsia yang umumnya terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu. Preeklampsia ditandai dengan peningkatan tekanan darah disertai proteinuria atau gangguan organ lain seperti ginjal, hati, dan sistem saraf, sedangkan eklampsia merupakan kondisi lanjutan yang ditandai dengan terjadinya kejang pada ibu hamil dengan preeklampsia. Faktor risiko yang dapat memicu kondisi ini antara lain usia ibu yang terlalu muda atau terlalu tua, kehamilan pertama, riwayat hipertensi, obesitas, serta kehamilan ganda. Gejala yang sering muncul meliputi sakit kepala hebat, gangguan penglihatan, nyeri epigastrium, edema pada wajah dan tangan, serta peningkatan tekanan darah.

Dalam pendekatan Outcome Based Education (OBE), mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar komplikasi hipertensi dalam kehamilan serta mengaplikasikan asuhan keperawatan secara komprehensif. Pengkajian keperawatan dilakukan melalui pengumpulan data subjektif dan objektif seperti keluhan ibu, pemeriksaan tekanan darah, edema, dan hasil pemeriksaan urin.

Berdasarkan data tersebut, perawat dapat menetapkan diagnosis keperawatan dan merencanakan intervensi yang meliputi pemantauan kondisi ibu dan janin, pengaturan posisi miring kiri untuk meningkatkan aliran darah uteroplasenta, edukasi mengenai tanda bahaya kehamilan, serta kolaborasi dalam pemberian terapi seperti antihipertensi atau magnesium sulfat untuk mencegah kejang. Melalui penerapan asuhan keperawatan yang tepat dan berbasis evidence-based practice, komplikasi yang lebih berat dapat dicegah sehingga keselamatan ibu dan janin dapat terjaga.

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Riwayat kejang dirumah	Menunjukkan kemungkinan terjadi Eklampsia, yaitu komplikasi berat dari Preeklampsia, merupakan kondisi kegawatdaruratan yang memerlukan penanganan segera difasilitas kesehatan.	Segera rujuk dan stabilisasi ibu, serta berikan Magnesium Sulfate untuk mencegah kejang
Sakit kepala hebat	Menunjukkan kemungkinan perburukan Preeklampsia dan risiko berkembang menjadi Eklampsia akibat peningkatan tekanan darah dan gangguan pada otak	Segera lakukan pemeriksaan tekanan darah, observasi kondisi ibu, dan rujuk ke fasilitas kesehatan untuk penanganan lebih lanjut guna mencegah Eklampsia.
Pandangan kabur	Menunjukkan gangguan saraf akibat peningkatan tekanan darah pada Preeklampsia dan merupakan tanda peringatan menuju Eklampsia.	Segera monitor tekanan darah dan rujuk ibu ke fasilitas kesehatan untuk penanganan lebih lanjut guna mencegah Eklampsia
Nyeri pada ulu hati	Menunjukkan iritasi atau gangguan fungsi hati akibat Preeklampsia dan dapat menjadi tanda perburukan menuju Eklampsia.	Segera lakukan pemantauan tekanan darah dan rujuk ibu ke fasilitas kesehatan untuk penanganan lebih lanjut guna mencegah Eklampsia.
TTV : TD 170/110 mmHg, Nadi 100 x/menit, Rr 24 x/menit, Suhu 37,2°C	Menunjukkan tubuh ibu sedang dalam kondisi tekanan darah tinggi yang berbahaya, dan membutuhkan penanganan cepat untuk melindungi keselamatan ibu dan janin	Stabilisasi ibu secepatnya, cegah komplikasi, dan persiapkan terminasi kehamilan.
Edema pada wajah dan tungkai bawah (+2),	Menunjukkan adanya kebocoran cairan dan gangguan vaskular sistemik. Perlu monitoring ketat dan tindakan segera	Fokus utama adalah mencegah perburukan menjadi preeklampsia berat/eklampsia dan komplikasi cairan (edema paru).
Refleks patella meningkat	Menunjukkan iritabilitas SSP dan risiko kejang tinggi	Hiperrefleksia tanda akan kejang, harus segera diberikan MgSO ₄ dan monitoring ketat.

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
		Fokus cegah kejang, stabilkan ibu, siapkan tindakan definitif.
Pemeriksaan urine proteinuria (+3),	Menunjukkan kondisi sudah sistemik dan serius, kerusakan ginjal dan indikator preeklampsia berat.	Penanganan segera untuk mencegah komplikasi maternal dan fetal.
Denyut jantung janin 150 x/menit	Menunjukkan kondisi janin masih baik, namun pada ibu dengan preeklampsia tetap diperlukan pemantauan ketat karena risiko gangguan perfusi plasenta.	DJJ normal tidak aman sepenuhnya pada preeklampsia Fokus monitoring ketat, stabilisasi ibu dan deteksi dini distress janin

Form Checklist

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian Hipertensi, Preeklampsia dan Eklampsia secara sederhana	☐	☐	
2	Saya sudah bisa melakukan pengkajian fokus pada ibu hamil dengan Eklampsia	☐	☐	
3	Saya sudah bisa mengkaji riwayat kejang dan riwayat hipertensi	☐	☐	
4	Saya sudah bisa mengkaji adanya sakit kepala hebat, nyeri ulu hati dan peningkatan tanda-tanda vital	☐	☐	
5	Saya sudah bisa mengenali tanda Eklampsia pada ibu hamil	☐	☐	
6	Saya sudah bisa mengidentifikasi masalah keperawatan prioritas pada ibu hamil dengan Eklampsia	☐	☐	
7	Saya sudah bisa menyusun rencana asuhan keperawatan dasar pada ibu hamil dengan Eklampsia	☐	☐	
8	Saya sudah bisa memantau status perfusi perifer melalui tanda-tanda vital dan pemeriksaan penunjang	☐	☐	
9	Saya sudah bisa memberikan edukasi tentang pemberian posisi miring kiri dengan benar	☐	☐	
10	Saya sudah bisa melakukan pemantauan tanda kegawatan pada ibu dan janin	☐	☐	
11	Saya sudah bisa menjelaskan tanda perburukan pada ibu dan cara lapor kepada petugas kesehatan	☐	☐	
12	Saya sudah bisa menentukan kapan harus melakukan eskalasi atau melapor	☐	☐	
13	Saya sudah bisa berkomunikasi terapeutik dengan ibu dan keluarga	☐	☐	

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
14	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi singkat asuhan keperawatan ibu dengan preeklampsia	☐	☐	
15	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional, aman, teliti, dan responsif saat merawat ibu dengan eklampsia	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

Referensi

- Agustina, A. M., dkk. (2021). Faktor yang berhubungan dengan penerapan SDKI, SLKI, dan SIKI dalam praktik keperawatan.
- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2020). *Gestational hypertension and preeclampsia (Practice Bulletin No. 222)*. Obstetrics & Gynecology, 135(6), e237–e260.
- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2019). *Emergent therapy for acute-onset, severe hypertension during pregnancy and the postpartum period (Committee Opinion No. 767)*. Obstetrics & Gynecology, 133(2), e174–e180.
- Diah Ayu Lestari, dkk. . (2023). Asuhan kebidanan kehamilan Diakses dari: https://www.researchgate.net/publication/396817079_Asuhan_Kebidanan_Kehamilan
- Kurnia, V. (2024). *Asuhan keperawatan dengan pendekatan SDKI, SLKI, SIKI dan evidence-based nursing pada ibu hipertensi*. Diakses dari: <https://georgescreek.org/reading/asuhan-keperawatan-dengan-pendekatan-3s-sdki-slki-siki-dan-evidence-based-nursing-pada-ibu-hipertensi/>
- Samutri, E., Fatimah, & Wulandari, A. S. (2022). *Asuhan keperawatan masa perinatal dengan pendekatan 3N dan 3S*. NEM Publisher.
- Sidhi Laksono. & Marsaly S Masrye. (2022). Hipertensi dalam kehamilan: tinjauan narasi. Diakses dari: https://www.researchgate.net/publication/362414767_Hipertensi_Dalam_Kehamilan_Tinjauan_Narasi
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2022). *Standar diagnosis keperawatan Indonesia (SDKI)*. Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2022). *Standar intervensi keperawatan Indonesia (SIKI)*. Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2022). *Standar luaran keperawatan Indonesia (SLKI)*. Jakarta: Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2021). *Standar praktik keperawatan Indonesia (SPKI) dan standar operasional prosedur (SPO) keperawatan*. Jakarta: PPNI.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2020). *Pedoman penyusunan standar operasional prosedur (SPO) keperawatan*. Jakarta: PPNI.
- World Health Organization. (2023). *WHO recommendations on maternal and newborn care for a positive postnatal experience*. Geneva: WHO.

Yulianingsih, N., dkk. (2022). *Asuhan keperawatan pada ibu hamil dengan preeklampsia pendekatan SDKI, SIKI, dan SLKI*. Jakarta: Trans Info Media.

BAB 4

PERDARAHAN ANTE PARTUM & RISIKO KEHAMILAN TINGGI

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep, peran, dan prinsip praktik keperawatan maternitas berorientasi kesinambungan asuhan, etik, dan keselamatan pasien.	CPMK-1, CPMK-7
CPL-2	Menguasai dasar biomedik terkait reproduksi perempuan serta adaptasi maternal–neonatal sebagai landasan keputusan keperawatan.	CPMK-2
CPL-3	Mampu melakukan pengkajian komprehensif dan menetapkan tingkat risiko pada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir.	CPMK-2, CPMK-3
CPL-4	Mampu merumuskan prioritas masalah dan menyusun rencana asuhan keperawatan maternitas berbasis standar dan bukti.	CPMK-3, CPMK-4
CPL-5	Mampu melaksanakan intervensi, edukasi, dan komunikasi terapeutik pada ibu–bayi–keluarga selama kehamilan sampai nifas.	CPMK-4, CPMK-5
CPL-6	Mampu melakukan deteksi dini, penatalaksanaan awal kegawatdaruratan, kolaborasi/rujukan, serta evaluasi–dokumentasi dan perencanaan pulang.	CPMK-5, CPMK-6, CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan ruang lingkup, peran, dan prinsip Continuity of Care serta keselamatan pasien dalam keperawatan maternitas.
CPMK-2	Menganalisis anatomi–fisiologi reproduksi perempuan dan adaptasi maternal–neonatal untuk mendukung keputusan keperawatan.
CPMK-3	Melakukan pengkajian komprehensif dan stratifikasi risiko pada kehamilan, persalinan, nifas, dan neonatus.
CPMK-4	Menyusun rencana asuhan keperawatan maternitas untuk kondisi fisiologis dan masalah umum dengan luaran terukur.
CPMK-5	Melaksanakan intervensi, edukasi, manajemen nyeri, serta dukungan psikososial–keluarga pada periode maternitas.
CPMK-6	Melakukan deteksi dini dan penatalaksanaan awal komplikasi/kegawatdaruratan maternal, serta koordinasi kolaborasi/rujukan.
CPMK-7	Melakukan evaluasi, dokumentasi, perencanaan pulang, dan perencanaan layanan kesehatan reproduksi pascapersalinan.

E. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 6. Perdarahan Antepartum dan Risiko Kehamilan Tinggi	6.1 Melakukan pengkajian cepat perdarahan antepartum dan pemetaan faktor risiko kehamilan tinggi.	6.2 Menyusun prioritas stabilisasi, rencana rujukan, dan strategi komunikasi risiko kepada keluarga.	CPMK-6	CPMK-3; CPMK-7

F. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-3	OSCE pengkajian + checklist	Kelengkapan komponen pengkajian; ketepatan stratifikasi risiko; ketepatan prioritas masalah (skor checklist)	15	Checklist OSCE; format pengkajian
CPMK-4	Tugas rencana asuhan (care plan)	Kesesuaian masalah–luaran–intervensi; keterukuran luaran; ketepatan prioritas; konsistensi rasional	15	Dokumen care plan terstruktur
CPMK-6	Simulasi kegawatdaruratan (drill) + skenario tertulis	Kecepatan identifikasi tanda bahaya; ketepatan urutan stabilisasi awal; ketepatan keputusan kolaborasi/rujukan	20	Checklist drill; laporan respons skenario

Rubrik CPMK-1 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Penguasaan konsep ruang lingkup & CoC (akurasi elemen kunci)	Akurat $\leq 50\%$ elemen kunci; banyak miskonsepsi.	Akurat 51–69% elemen kunci; masih ada kekeliruan istilah/relasi konsep.	Akurat 70–84% elemen kunci; penjelasan runtut.	Akurat $\geq 85\%$ elemen kunci; sintesis jelas dan konsisten.
1.2 Aplikasi prinsip keselamatan pasien & etik pada skenario maternitas	Identifikasi risiko & tindakan aman $\leq 50\%$; keputusan tidak sesuai prinsip.	Identifikasi 51–69%; tindakan aman ada namun belum lengkap.	Identifikasi 70–84%; keputusan aman dan sesuai prinsip pada sebagian besar situasi.	Identifikasi $\geq 85\%$; keputusan aman, preventif, dan argumentatif.

Rubrik CPMK-2 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Akurasi anatomi–fisiologi reproduksi (struktur–fungsi)	Ketepatan $\leq 50\%$; banyak salah konsep/relasi struktur–fungsi.	Ketepatan 51–69%; konsep dasar benar namun parsial.	Ketepatan 70–84%; relasi struktur–fungsi tepat dan logis.	Ketepatan $\geq 85\%$; integrasi konsep kuat dan konsisten.
2.2 Analisis adaptasi kehamilan & implikasi kebutuhan asuhan	Analisis tidak runtut; implikasi klinis tidak tepat ($\leq 50\%$ sesuai data).	Analisis cukup; implikasi masih umum (51–69% sesuai data).	Analisis baik; implikasi spesifik (70–84% sesuai data).	Analisis sangat baik; implikasi komprehensif & antisipatif ($\geq 85\%$ sesuai data).

Rubrik CPMK-3 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Kelengkapan data pengkajian (komponen inti)	Komponen terisi $\leq 50\%$; banyak data penting hilang/tidak valid.	Komponen terisi 51–69%; masih ada kekosongan data kunci.	Komponen terisi 70–84%; data kunci lengkap dan relevan.	Komponen terisi $\geq 85\%$; data sangat lengkap, terstruktur, dan konsisten.
3.2 Ketepatan stratifikasi risiko & prioritas masalah	Risiko & prioritas tepat $\leq 50\%$; tidak sesuai temuan.	Tepat 51–69%; prioritas masih kurang tajam.	Tepat 70–84%; prioritas jelas berbasis temuan.	Tepat $\geq 85\%$; prioritas sangat tepat disertai tindak lanjut yang terarah.

Rubrik CPMK-4 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Kesesuaian masalah–luaran–intervensi & keterukuran luaran	Kesesuaian $\leq 50\%$; luaran tidak terukur; intervensi tidak spesifik.	Kesesuaian 51–69%; luaran sebagian terukur; intervensi masih generik.	Kesesuaian 70–84%; luaran terukur; intervensi spesifik dan realistis.	Kesesuaian $\geq 85\%$; luaran sangat terukur; intervensi prioritatif dan tepat sasaran.
4.2 Rasional, prioritas, dan rencana evaluasi	Rasional lemah/absen; prioritas tidak jelas; evaluasi tidak terencana ($\leq 50\%$ memadai).	Rasional ada namun terbatas; prioritas cukup; evaluasi parsial (51–69%).	Rasional baik; prioritas jelas; evaluasi sesuai luaran (70–84%).	Rasional sangat kuat; prioritas tajam; evaluasi komprehensif & terjadwal ($\geq 85\%$).

Rubrik CPMK-5 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Ketepatan & keselamatan pelaksanaan intervensi keperawatan	Langkah benar/aman $\leq 50\%$; terdapat tindakan berisiko.	Langkah benar/aman 51–69%; ada kekurangan minor pada urutan/asepsis.	Langkah benar/aman 70–84%; pelaksanaan aman dan efektif.	Langkah benar/aman $\geq 85\%$; sangat terampil, efisien, dan konsisten aman.
5.2 Kualitas komunikasi terapeutik, edukasi, dan dukungan keluarga	Tujuan komunikasi tidak tercapai; pemahaman klien tidak terverifikasi ($\leq 50\%$).	Komunikasi cukup; edukasi disampaikan namun verifikasi terbatas (51–69%).	Komunikasi baik; edukasi relevan dengan verifikasi pemahaman (70–84%).	Komunikasi sangat baik; edukasi terstruktur dengan teach-back dan pelibatan keluarga optimal ($\geq 85\%$).

Rubrik CPMK-6 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Deteksi dini & keputusan prioritas stabilisasi awal kegawatdaruratan	Tanda bahaya terlewat; prioritas salah ($\leq 50\%$ keputusan tepat).	Tanda bahaya sebagian terdeteksi; prioritas cukup (51–69% tepat).	Deteksi cepat; prioritas stabilisasi tepat (70–84% tepat).	Deteksi sangat cepat; prioritas tepat & antisipatif ($\geq 85\%$ tepat).
6.2 Koordinasi kolaborasi/rujukan & komunikasi tim	Kolaborasi/rujukan terlambat/tidak tepat; komunikasi tidak efektif ($\leq 50\%$ sesuai).	Kolaborasi ada namun belum sistematis; komunikasi cukup (51–69%).	Kolaborasi/rujukan tepat waktu; komunikasi jelas (70–84%).	Kolaborasi/rujukan sangat tepat; komunikasi terstruktur dan memastikan kesinambungan ($\geq 85\%$).

Rubrik CPMK-7 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kualitas evaluasi luaran & dokumentasi asuhan	Dokumentasi tidak lengkap; evaluasi tidak berbasis data ($\leq 50\%$ komponen terpenuhi).	Dokumentasi cukup; evaluasi masih umum (51–69%).	Dokumentasi lengkap; evaluasi sesuai luaran (70–84%).	Dokumentasi sangat lengkap & rapi; evaluasi analitis berbasis data ($\geq 85\%$).

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.2 Komprehensif perencanaan pulang & rencana layanan reproduksi pascapersalinan	Rencana tidak jelas/tidak individual; tanda bahaya/kontrol terlewat ($\leq 50\%$ komponen).	Rencana ada namun parsial; komponen kunci belum lengkap (51–69%).	Rencana komprehensif; mencakup kontrol & tanda bahaya; cukup individual (70–84%).	Rencana sangat komprehensif & individual berbasis risiko; mencakup koordinasi layanan lanjutan dan konseling reproduksi terstruktur ($\geq 85\%$).

A. Pendahuluan

Perdarahan antepartum merupakan salah satu komplikasi obstetri yang terjadi pada kehamilan setelah usia kehamilan 20–28 minggu hingga sebelum persalinan, yang berpotensi menimbulkan morbiditas dan mortalitas tinggi baik pada ibu maupun janin. Kondisi ini umumnya disebabkan oleh kelainan plasenta seperti plasenta previa dan solusio plasenta, serta berkaitan erat dengan berbagai faktor risiko kehamilan tinggi, seperti usia ibu ekstrem, paritas tinggi, riwayat obstetri buruk, dan status gizi yang tidak adekuat.

Secara global, masalah kesehatan ibu masih menjadi isu prioritas dalam pembangunan kesehatan. World Health Organization melaporkan bahwa angka kematian ibu (AKI) masih tergolong tinggi, terutama di negara berkembang. Target pembangunan global yang sebelumnya tertuang dalam Millennium Development Goals (MDGs) bertujuan menurunkan AKI sebesar 75% pada tahun 2015, namun banyak negara, termasuk Indonesia, belum sepenuhnya mencapai target tersebut. Saat ini, dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs), ditetapkan bahwa AKI global harus ditekan hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030.

Data WHO menunjukkan bahwa secara global, penyebab utama kematian ibu masih didominasi oleh perdarahan obstetri, termasuk perdarahan antepartum dan postpartum. Perdarahan menyumbang sekitar seperempat dari seluruh kematian ibu di dunia, menjadikannya penyebab langsung paling signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perdarahan dalam kehamilan masih menjadi masalah kritis yang membutuhkan penanganan komprehensif dan berbasis bukti. Perdarahan antepartum terjadi pada sekitar 2–5% kehamilan di seluruh dunia, namun menjadi penyebab signifikan mortalitas maternal dan perinatal, terutama di negara berkembang. Menurut WHO (2023), perdarahan obstetri, termasuk APH, masih menyumbang sekitar 25–30% kematian ibu secara global, terutama akibat keterlambatan diagnosis dan akses pelayanan kesehatan.

Di Indonesia, angka kematian ibu masih tergolong tinggi dibandingkan negara lain di kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan laporan WHO tahun 2020, AKI Indonesia diperkirakan sekitar 173 per 100.000 kelahiran hidup, sedangkan hasil kajian nasional menunjukkan angka sekitar 249 per 100.000 kelahiran hidup pada periode 2016–2020 . Sementara itu, data dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menunjukkan bahwa meskipun terjadi penurunan dalam beberapa tahun terakhir, AKI masih menjadi tantangan besar dalam sistem kesehatan nasional, terutama karena faktor keterlambatan penanganan, akses layanan kesehatan, dan kondisi sosial ekonomi .

Perdarahan obstetri, termasuk perdarahan antepartum, merupakan salah satu penyebab utama kematian ibu di Indonesia dengan kontribusi sekitar 25% dari seluruh penyebab kematian maternal . Hal ini menunjukkan bahwa komplikasi ini memiliki peran signifikan dalam tingginya AKI, terutama pada kelompok ibu dengan kehamilan risiko tinggi.

Kehamilan risiko tinggi sendiri didefinisikan sebagai kondisi kehamilan yang memiliki potensi lebih besar untuk mengalami komplikasi dibandingkan kehamilan normal. Faktor risiko tersebut meliputi usia ibu kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun, anemia, penyakit kronis, jarak kehamilan yang terlalu dekat, serta riwayat komplikasi obstetri sebelumnya. Kondisi ini dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya perdarahan antepartum, yang apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat dapat berujung pada syok, kematian ibu, maupun kematian janin.

Dengan demikian, perdarahan antepartum dan kehamilan risiko tinggi merupakan dua kondisi yang saling berkaitan dan berkontribusi besar terhadap tingginya angka kematian ibu. Upaya pencegahan melalui deteksi dini, peningkatan kualitas pelayanan antenatal, serta edukasi kesehatan kepada ibu dan keluarga menjadi sangat penting dalam menurunkan risiko komplikasi dan kematian maternal.

B. TUJUAN INSTRUKSIONAL

1. Tujuan Instruksional Umum (TIU)

Setelah mengikuti pembelajaran tentang *Perdarahan Antepartum dan Risiko Kehamilan Tinggi*, peserta didik mampu memahami konsep dasar, faktor risiko, manifestasi klinis, serta melakukan pengkajian dan penatalaksanaan keperawatan secara komprehensif, sistematis, dan berbasis bukti dalam upaya pencegahan serta penanganan komplikasi pada ibu hamil.

2. Tujuan Instruksional Khusus (TIK)

Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu:

Ranah Kognitif (Pengetahuan)

- Menjelaskan pengertian perdarahan antepartum dan kehamilan risiko tinggi secara tepat.
- Mengidentifikasi etiologi dan faktor risiko perdarahan antepartum.
- Menjelaskan patofisiologi perdarahan antepartum (plasenta previa dan solusio plasenta).
- Menguraikan tanda dan gejala klinis yang muncul pada perdarahan antepartum.
- Menjelaskan komplikasi yang dapat terjadi pada ibu dan janin.
- Mendeskripsikan pemeriksaan penunjang yang diperlukan dalam diagnosis.
- Menjelaskan prinsip penatalaksanaan medis dan keperawatan pada kasus perdarahan antepartum.

Ranah Afektif (Sikap)

- Menunjukkan sikap peduli dan empati terhadap ibu hamil dengan kondisi risiko tinggi.
- Memiliki kesadaran akan pentingnya deteksi dini komplikasi kehamilan.
- Menunjukkan tanggung jawab dalam memberikan asuhan keperawatan yang aman dan berkualitas.
- Menghargai nilai-nilai etika dalam pelayanan maternitas.

Ranah Psikomotor (Keterampilan)

- Melakukan pengkajian keperawatan pada ibu dengan perdarahan antepartum secara sistematis.
- Mengidentifikasi masalah keperawatan berdasarkan data yang diperoleh.
- Menyusun rencana asuhan keperawatan sesuai standar (SDKI, SIKI, SLKI).
- Melakukan tindakan keperawatan dasar pada kondisi kegawatdaruratan obstetri.
- Memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga terkait tanda bahaya kehamilan.

C. URAIAN MATERI

PERDARAHAN ANTEPARTUM & RISIKO KEHAMILAN TINGGI

1. Pengertian Perdarahan Antepartum

Perdarahan antepartum adalah perdarahan dari jalan lahir yang terjadi pada kehamilan setelah usia kehamilan mencapai ≥ 20 minggu atau ≥ 28 minggu (tergantung definisi klinis yang digunakan) hingga sebelum proses persalinan dimulai. Kondisi ini merupakan salah satu komplikasi obstetri yang serius karena

dapat mengancam keselamatan ibu dan janin apabila tidak ditangani secara cepat dan tepat (Kementerian Kesehatan RI, 2023; WHO, 2021).

Menurut World Health Organization (WHO), perdarahan dalam kehamilan, baik antepartum maupun postpartum, merupakan penyebab utama kematian ibu secara global, dengan kontribusi sekitar 25% dari seluruh kematian maternal. Hal ini menunjukkan bahwa perdarahan antepartum memiliki peran signifikan dalam meningkatkan angka morbiditas dan mortalitas ibu hamil, terutama di negara berkembang (WHO, 2023).

Secara klinis, perdarahan antepartum umumnya disebabkan oleh dua kondisi utama, yaitu plasenta previa dan solusio plasenta (*abruptio placentae*). Plasenta previa terjadi ketika plasenta berimplantasi di segmen bawah uterus sehingga menutupi sebagian atau seluruh ostium uteri internum, sedangkan solusio plasenta adalah kondisi lepasnya plasenta sebelum waktunya dari dinding uterus. Kedua kondisi ini mengganggu perfusi uteroplasenta yang berdampak langsung terhadap suplai oksigen dan nutrisi pada janin (Say et al., 2020; Cunningham et al., 2022).

Dari perspektif patofisiologi, perdarahan antepartum mencerminkan adanya gangguan pada sistem vaskular uteroplasenta, yang dapat menyebabkan hipoksia janin, anemia pada ibu, hingga syok hipovolemik. Oleh karena itu, kondisi ini dikategorikan sebagai kegawatdaruratan obstetri yang memerlukan intervensi segera dan kolaboratif (Kemenkes RI, 2023).

2. Pengertian Kehamilan Risiko Tinggi

Kehamilan risiko tinggi adalah kondisi kehamilan di mana ibu atau janin memiliki kemungkinan lebih besar mengalami komplikasi selama kehamilan, persalinan, maupun masa nifas dibandingkan dengan kehamilan normal. Risiko ini dipengaruhi oleh faktor medis, obstetri, atau sosial yang meningkatkan kemungkinan terjadinya hasil kehamilan yang buruk, termasuk kematian ibu dan bayi. WHO menekankan bahwa deteksi dini faktor risiko sangat penting dalam menurunkan angka kematian maternal global. (WHO, 2023)

Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, kehamilan risiko tinggi merupakan kehamilan yang disertai dengan satu atau lebih faktor risiko yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan janin, seperti usia ibu <20 tahun atau >35 tahun, anemia, hipertensi, diabetes, serta riwayat komplikasi obstetri sebelumnya (Kemenkes RI, 2023).

Kehamilan risiko tinggi juga dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana terdapat penyimpangan dari proses kehamilan normal yang berpotensi menyebabkan hasil kehamilan yang buruk (*adverse pregnancy outcomes*), seperti

perdarahan, preeklamsia, persalinan prematur, dan kematian perinatal (Cunningham et al., 2022).

Dalam konteks klinis, kehamilan risiko tinggi memiliki hubungan yang erat dengan kejadian perdarahan antepartum. Hal ini disebabkan oleh adanya gangguan pada fungsi plasenta, sistem vaskular, atau kondisi maternal yang mempengaruhi stabilitas kehamilan. Oleh karena itu, deteksi dini terhadap faktor risiko sangat penting untuk mencegah terjadinya komplikasi serius.

3. Keterkaitan Perdarahan Antepartum dan Kehamilan Risiko Tinggi

Perdarahan antepartum dan kehamilan risiko tinggi merupakan dua konsep yang saling berkaitan erat dalam praktik kebidanan dan keperawatan maternitas. Kehamilan risiko tinggi meningkatkan kemungkinan terjadinya komplikasi, termasuk perdarahan antepartum, sedangkan perdarahan antepartum sering kali menjadi manifestasi dari kehamilan dengan risiko tinggi. Faktor-faktor seperti usia ekstrem, multiparitas, anemia, dan penyakit kronis dapat mempengaruhi implantasi plasenta serta menyebabkan gangguan perfusi uteroplasenta. Kondisi ini pada akhirnya meningkatkan risiko terjadinya plasenta previa maupun solusio plasenta. Perdarahan ante partum merupakan salah satu penyebab utama kehamilan risiko tinggi karena secara langsung meningkatkan risiko komplikasi maternal dan fetal. Keberadaan APH menyebabkan kehamilan dikategorikan sebagai high risk pregnancy, sehingga memerlukan pemantauan ketat di fasilitas kesehatan dengan kemampuan emergensi obstetri.

Menurut FIGO (2021), APH merupakan salah satu penyebab utama morbiditas maternal global dan berkaitan erat dengan peningkatan risiko persalinan prematur, operasi caesar darurat, serta kematian perinatal. Dengan demikian, pemahaman yang komprehensif mengenai konsep perdarahan antepartum dan kehamilan risiko tinggi sangat penting bagi tenaga kesehatan untuk melakukan deteksi dini, pencegahan, serta penatalaksanaan yang tepat guna menurunkan angka kematian ibu dan bayi.

4. Etiologi Perdarahan Antepartum

Secara etiologis, APH dibagi menjadi beberapa penyebab utama yang berhubungan dengan gangguan plasenta, uterus, dan pembuluh darah janin.

a. Kelainan Plasenta

Kelainan plasenta merupakan penyebab tersering APH, antara lain:

1) Plasenta previa

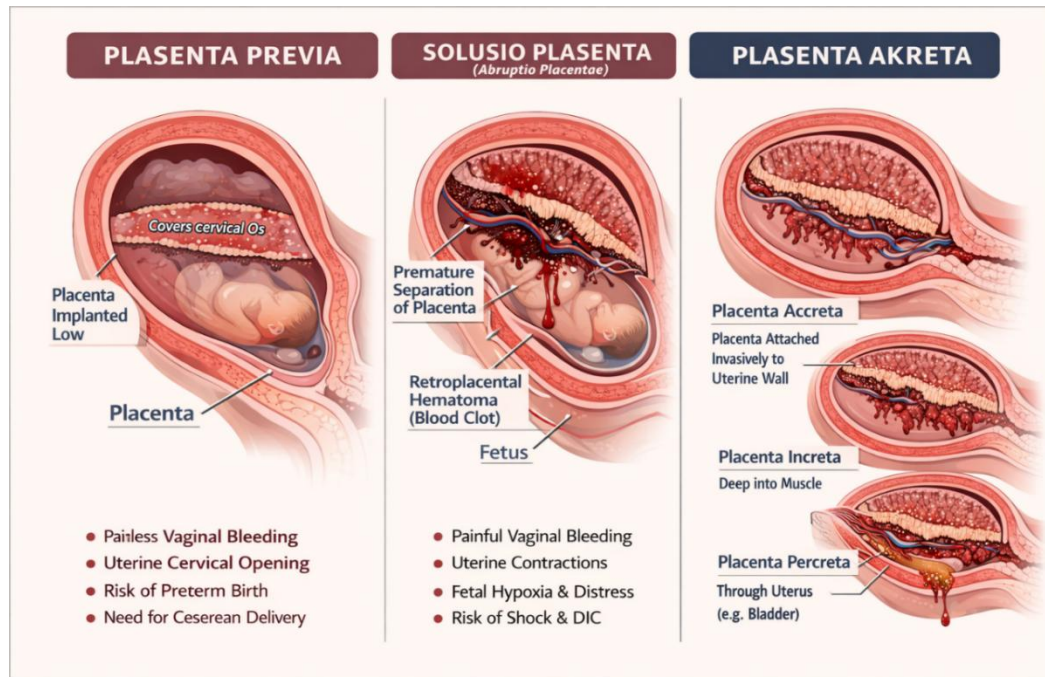
Kondisi dimana plasenta berimplantasi pada segmen bawah uterus sehingga menutupi sebagian atau seluruh ostium uteri internum. Hal ini menyebabkan perdarahan tanpa nyeri akibat peregangan segmen bawah uterus pada trimester akhir. (Cunningham et al., 2022)

2) Solusio plasenta (abruptio placentae)

Merupakan pelepasan prematur plasenta yang berimplantasi normal sebelum janin lahir, menyebabkan perdarahan dan gangguan oksigenasi janin. (RCOG, 2019)

3) Placenta accreta spectrum

Kondisi dimana plasenta melekat terlalu dalam ke dinding uterus, sehingga sulit lepas dan menyebabkan perdarahan hebat saat pelepasan.



Gambar 4. 1 perbandingan kelainan implantasi dan pelepasan plasenta pada kehamilan

b. Kelainan Pembuluh Darah Janin

Vasa previa yaitu kondisi pembuluh darah janin melintasi membran dekat serviks tanpa perlindungan Wharton's jelly, sehingga mudah pecah saat ketuban pecah. (WHO, 2023)

c. Penyebab Lain

- 4) Ruptur uterus
- 5) Trauma abdomen
- 6) Lesi serviks (polip, kanker serviks)

5. Patofisiologi Perdarahan Antepartum

Perdarahan ante partum merupakan kondisi kegawatdaruratan obstetri yang terjadi setelah usia kehamilan 20 minggu hingga sebelum persalinan, yang umumnya berkaitan dengan gangguan pada sistem vaskular uteroplasenta. Kejadian ini tidak berlangsung secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari rangkaian proses patologis yang dimulai dari gangguan implantasi plasenta

hingga terjadinya komplikasi sistemik pada ibu dan janin (Cunningham et al., 2022; WHO, 2023). Perdarahan ante partum terjadi akibat gangguan integritas sistem vaskular uteroplasenta. Secara umum prosesnya meliputi gangguan implantasi plasenta atau trauma uterus, robekan pembuluh darah maternal atau fetal, terjadinya perdarahan di ruang intervillous atau serviks, penurunan aliran darah uteroplasenta, hipoksia janin, dan aktivasi sistem koagulasi yang dapat berkembang menjadi DIC pada kasus berat.

a. Gangguan Implantasi Plasenta atau Trauma Uterus

Tahap awal dari perdarahan ante partum sering kali berhubungan dengan proses implantasi plasenta yang tidak normal. Pada keadaan fisiologis, plasenta melekat pada endometrium segmen uterus dengan pembentukan vaskularisasi yang stabil untuk mendukung pertumbuhan janin. Namun, pada kondisi seperti plasenta previa, solusio plasenta, atau plasenta akreta, proses implantasi terjadi secara tidak tepat atau terlalu invasif ke dalam lapisan miometrium. Hal ini menyebabkan melemahnya struktur perlekatan plasenta sehingga mudah terjadi pelepasan sebagian jaringan plasenta dari dinding uterus. Selain faktor implantasi, trauma pada uterus seperti benturan abdomen, aktivitas fisik berat, atau prosedur obstetri juga dapat menimbulkan kerusakan pada jaringan desidua dan pembuluh darah, yang menjadi awal terjadinya perdarahan (Lowdermilk et al., 2021).

b. Robekan Pembuluh Darah Maternal atau Fetal

Setelah integritas plasenta terganggu, pembuluh darah maternal pada desidua basalis maupun pembuluh darah fetal pada vili korion dapat mengalami ruptur. Kondisi ini menyebabkan darah keluar dari sistem sirkulasi normal. Pada kasus tertentu, robekan pembuluh darah terjadi secara luas sehingga menyebabkan separasi plasenta dari dinding uterus. Darah kemudian dapat terkumpul di ruang intervillous atau keluar melalui serviks, tergantung lokasi implantasi plasenta (Cunningham et al., 2022).

c. Perdarahan di Ruang Intervillous atau Serviks

Akibat kerusakan pembuluh darah, darah akan masuk ke ruang intervillous, yaitu area antara vili korion dan desidua. Pada plasenta previa, perdarahan lebih sering muncul sebagai perdarahan pervaginam karena plasenta terletak di segmen bawah uterus yang dekat dengan serviks. Perdarahan dapat bersifat terbuka (overt bleeding): darah keluar melalui vagina dan tersembunyi (concealed hemorrhage): darah tertahan di dalam uterus. Pada kondisi tersembunyi, volume perdarahan sering kali lebih besar dari yang terlihat secara klinis, sehingga meningkatkan risiko keterlambatan penanganan (WHO, 2023).

d. Penurunan Aliran Darah Uteroplasenta

Perdarahan yang terus berlangsung menyebabkan penurunan perfusi uteroplasenta. Kondisi ini mengganggu proses pertukaran oksigen dan nutrisi antara ibu dan janin.

Akibatnya, plasenta tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal, sehingga terjadi penurunan oksigenasi janin. Gangguan ini juga menyebabkan akumulasi produk metabolik asam di sirkulasi janin yang dapat memperburuk kondisi hipoksia (Lowdermilk et al., 2021).

e. Hipoksia Janin

Penurunan aliran darah uteroplasenta secara langsung menyebabkan hipoksia janin. Dalam kondisi ini, janin mengalami kekurangan oksigen yang menyebabkan pergeseran metabolisme dari aerob ke anaerob. Metabolisme anaerob menghasilkan asam laktat yang memicu asidosis metabolik. Jika kondisi ini tidak segera ditangani, janin akan menunjukkan tanda distress seperti penurunan aktivitas, perubahan denyut jantung janin, hingga risiko kematian intrauterin (ACOG, 2021).

f. Aktivasi Sistem Koagulasi dan Risiko DIC

Perdarahan yang berat pada ante partum dapat memicu pelepasan tromboplastin dari jaringan plasenta yang rusak ke dalam sirkulasi maternal. Hal ini menyebabkan aktivasi sistem koagulasi secara berlebihan. Pada awalnya tubuh berusaha menghentikan perdarahan melalui pembentukan trombus, namun konsumsi faktor koagulasi dan trombosit yang berlebihan dapat menyebabkan kondisi koagulopati konsumtif. Jika berlanjut, kondisi ini berkembang menjadi Disseminated Intravascular Coagulation (DIC), yang ditandai dengan:

- 1) Pembentukan mikrotrombus di berbagai organ
- 2) Penurunan trombosit signifikan
- 3) Perdarahan spontan multipel

DIC merupakan kondisi yang mengancam jiwa karena dapat menyebabkan kegagalan multi organ pada ibu dan meningkatkan risiko kematian maternal (Cunningham et al., 2022; WHO, 2023).

Ringkasan Pathway Patofisiologi



Gambar 4. 2 diagram patofisiologi perdarahan antepartum

https://chatgpt.com/s/m_69caf9f88b688191863f59bd5a33c10e

Implikasi Keperawatan

Dalam praktik keperawatan maternitas, setiap tahapan ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan klinis, antara lain:

- Deteksi dini perdarahan dan tanda syok
- Monitoring denyut jantung janin (DJJ)
- Observasi tanda hipoksia janin
- Pemantauan tanda koagulopati pada ibu
- Kolaborasi emergensi obstetri

6. Faktor Risiko Perdarahan Ante Partum

Perdarahan ante partum merupakan kondisi kegawatdaruratan obstetri yang disebabkan oleh berbagai faktor predisposisi yang memengaruhi integritas plasenta, vaskularisasi uterus, serta kemampuan adaptasi fisiologis kehamilan. Faktor risiko ini dapat berasal dari kondisi maternal, faktor obstetri, maupun gaya hidup ibu. Interaksi dari berbagai faktor tersebut dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya gangguan implantasi plasenta, pelepasan plasenta prematur, hingga perdarahan sebelum persalinan (Cunningham et al., 2022; WHO, 2023).

a. Faktor Maternal

1) Usia ibu lebih dari 35 tahun

Kehamilan pada usia di atas 35 tahun dikaitkan dengan penurunan fungsi reproduksi secara fisiologis. Pada usia tersebut terjadi perubahan struktural pada pembuluh darah uterus, termasuk penurunan elastisitas vaskular dan berkurangnya respons terhadap perubahan hormonal kehamilan. Selain itu, kualitas endometrium juga mengalami penurunan sehingga proses implantasi plasenta menjadi kurang optimal. Kondisi ini meningkatkan risiko terjadinya gangguan plasentasi seperti plasenta previa dan solusio plasenta yang berujung pada perdarahan ante partum (ACOG, 2021).

2) Multiparitas tinggi

Multiparitas atau riwayat kehamilan dan persalinan yang banyak menyebabkan uterus mengalami distensi berulang. Kondisi ini dapat menurunkan tonus otot uterus serta mengubah struktur endometrium secara bertahap. Akibatnya, kemampuan uterus dalam mempertahankan implantasi plasenta yang stabil menjadi berkurang. Uterus yang telah mengalami banyak kehamilan juga lebih rentan terhadap kelainan letak plasenta serta gangguan vaskular yang dapat menyebabkan perdarahan pada kehamilan berikutnya (Lowdermilk et al., 2021).

3) Riwayat operasi caesar

Riwayat seksio sesarea merupakan faktor risiko penting karena adanya jaringan parut pada dinding uterus. Jaringan parut ini memiliki vaskularisasi yang tidak normal sehingga mengganggu proses implantasi plasenta. Plasenta dapat melekat pada area bekas luka yang menyebabkan implantasi abnormal seperti plasenta previa atau bahkan invasi berlebihan ke miometrium yang dikenal sebagai plasenta akreta spectrum. Kondisi ini meningkatkan risiko perdarahan ante partum yang berat dan sulit dikendalikan (Cunningham et al., 2022).

4) Riwayat abortus berulang

Abortus berulang, terutama yang disertai tindakan kuretase, dapat menyebabkan kerusakan pada endometrium. Proses inflamasi dan trauma berulang pada lapisan rahim dapat menimbulkan fibrosis endometrium yang mengganggu regenerasi jaringan. Endometrium yang tidak sehat akan menghambat implantasi plasenta yang normal sehingga meningkatkan risiko separasi plasenta dini dan perdarahan pada trimester akhir kehamilan (WHO, 2023).

5) Hipertensi dalam kehamilan

Hipertensi gestasional, preeklamsia, dan eklampsia berperan besar dalam terjadinya APH, khususnya solusio plasenta. Kondisi hipertensi menyebabkan vasospasme pada arteri spiral uterus yang mengakibatkan penurunan perfusi uteroplacenta. Iskemia yang terjadi dapat menyebabkan nekrosis desidua dan pelepasan plasenta sebelum waktunya. Kondisi ini sering disertai perdarahan retroplasenta yang bersifat akut dan mengancam jiwa (ACOG, 2021; Cunningham et al., 2022).

b. Faktor Obstetri

1) Kehamilan ganda

Kehamilan ganda menyebabkan uterus mengalami overdistensi yang lebih besar dibandingkan kehamilan tunggal. Peningkatan volume uterus ini menyebabkan kebutuhan vaskular meningkat secara signifikan, sehingga dapat mengganggu keseimbangan suplai darah ke plasenta. Kondisi ini meningkatkan risiko plasenta letak rendah dan solusio plasenta akibat ketidakstabilan perlekatan plasenta pada dinding uterus (Cunningham et al., 2022).

2) Kelainan letak plasenta

Kelainan letak plasenta seperti plasenta previa terjadi ketika plasenta berimplantasi pada segmen bawah uterus. Lokasi ini rentan mengalami perdarahan karena segmen bawah uterus mengalami penipisan dan dilatasi menjelang persalinan. Akibatnya, plasenta dapat terlepas sebagian sehingga terjadi perdarahan pervaginam yang sering bersifat berulang tanpa nyeri (Lowdermilk et al., 2021).

3) Trauma abdomen

Trauma pada abdomen selama kehamilan dapat menyebabkan gangguan mekanis pada uterus dan plasenta. Benturan dapat memicu robekan pada pembuluh darah uteroplacenta atau menyebabkan separasi plasenta secara mendadak. Kondisi ini dapat menimbulkan perdarahan akut dan meningkatkan risiko solusio plasenta yang berat (WHO, 2023).

4) Riwayat persalinan dengan komplikasi

Riwayat persalinan sebelumnya yang disertai komplikasi seperti perdarahan postpartum, tindakan operatif, atau gangguan plasenta menunjukkan adanya predisposisi gangguan vaskular atau struktural uterus. Kondisi ini meningkatkan risiko berulangnya komplikasi serupa pada kehamilan berikutnya, termasuk perdarahan ante partum (Cunningham et al., 2022).

c. Faktor Gaya Hidup

1) Merokok

Kebiasaan merokok selama kehamilan menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah akibat nikotin serta penurunan kadar oksigen dalam darah akibat karbon monoksida. Kondisi ini mengganggu aliran darah uteroplasenta sehingga meningkatkan risiko gangguan pertumbuhan plasenta dan solusio plasenta. Dampaknya dapat berupa hipoksia janin dan perdarahan ante partum (WHO, 2023).

2) Konsumsi alkohol

Alkohol memiliki efek teratogenik yang dapat mengganggu perkembangan plasenta dan janin. Konsumsi alkohol selama kehamilan dapat menyebabkan gangguan angiogenesis plasenta serta disfungsi vaskular, yang pada akhirnya meningkatkan risiko komplikasi obstetri termasuk perdarahan ante partum (ACOG, 2021).

3) Status gizi buruk

Status gizi yang tidak adekuat berdampak pada kualitas endometrium dan perkembangan plasenta. Kekurangan protein, zat besi, serta mikronutrien penting lainnya dapat mengganggu proses implantasi dan pertumbuhan plasenta. Kondisi ini meningkatkan risiko gangguan plasentasi dan ketidakstabilan perlekatan plasenta yang berpotensi menyebabkan perdarahan ante partum (Lowdermilk et al., 2021).

7. Manifestasi Klinis Perdarahan Ante Partum

Manifestasi klinis perdarahan ante partum sangat bergantung pada penyebab patologis yang mendasarinya, yaitu plasenta previa, solusio plasenta, dan vasa previa. Masing-masing kondisi memiliki karakteristik klinis yang berbeda berdasarkan mekanisme terjadinya perdarahan, lokasi plasenta, serta keterlibatan vaskular uterus dan janin. Pemahaman terhadap tanda dan gejala ini sangat penting untuk deteksi dini dan penatalaksanaan kegawatdaruratan obstetri (Cunningham et al., 2022; WHO, 2023).

a. Plasenta Previa

Plasenta previa merupakan kondisi ketika plasenta berimplantasi pada segmen bawah uterus sehingga sebagian atau seluruh ostium uteri internum tertutup. Manifestasi klinis utama yang paling khas adalah perdarahan pervaginam berwarna merah segar yang muncul tanpa disertai nyeri. Hal ini terjadi karena perdarahan berasal dari pembuluh darah maternal pada segmen bawah uterus yang mengalami peregangan tanpa adanya kontraksi atau separasi yang signifikan. Uterus pada kondisi ini umumnya tetap lembek atau tidak tegang karena tidak terjadi iritasi miometrium seperti pada solusio

plasenta. Kondisi ini menjadi salah satu pembeda klinis utama antara plasenta previa dan gangguan plasenta lainnya. Meskipun terjadi perdarahan, kondisi janin pada awalnya sering masih stabil karena tidak terjadi gangguan perfusi plasenta secara mendadak, meskipun risiko hipoksia tetap dapat meningkat jika perdarahan berlanjut (Lowdermilk et al., 2021).

b. Solusio Plasenta

Solusio plasenta merupakan kondisi pelepasan sebagian atau seluruh plasenta dari dinding uterus sebelum persalinan. Manifestasi klinis utama adalah nyeri perut yang hebat dan mendadak akibat iritasi miometrium serta perdarahan di belakang plasenta (retroplasenta hematoma). Nyeri ini biasanya disertai uterus yang terasa keras seperti papan (board-like uterus) akibat kontraksi uterus yang terus-menerus dan peningkatan tonus miometrium.

Perdarahan pada solusio plasenta dapat bersifat bervariasi, mulai dari sedikit hingga sangat banyak. Namun pada beberapa kasus, perdarahan eksternal justru minimal karena darah terperangkap di dalam uterus (concealed hemorrhage), sehingga kondisi ini sering lebih berbahaya daripada yang terlihat secara klinis. Ciri penting lainnya adalah bahwa tanda syok pada ibu sering kali lebih berat dibandingkan jumlah perdarahan yang terlihat. Hal ini disebabkan oleh kehilangan darah tersembunyi serta gangguan perfusi sistemik yang cepat. Selain itu, kondisi ini sangat berbahaya bagi janin karena gangguan suplai oksigen dapat menyebabkan distress janin hingga kematian intrauterin (Cunningham et al., 2022; WHO, 2023).

c. Vasa Previa

Vasa previa merupakan kondisi kelainan pembuluh darah janin yang berjalan melintasi atau sangat dekat dengan ostium uteri internum tanpa perlindungan jaringan plasenta atau Wharton's jelly. Manifestasi klinis yang paling khas adalah perdarahan tiba-tiba setelah ketuban pecah. Perdarahan ini berasal dari pembuluh darah janin, sehingga jumlah darah yang keluar relatif kecil tetapi sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kehilangan darah janin secara cepat. Akibatnya, gawat janin dapat terjadi dalam waktu singkat, ditandai dengan bradikardia janin atau penurunan drastis denyut jantung janin. Kondisi ini merupakan kegawatdaruratan obstetri yang membutuhkan tindakan segera untuk menyelamatkan janin (ACOG, 2021).

8. Klasifikasi Perdarahan Ante Partum

Perdarahan ante partum secara klinis dapat diklasifikasikan berdasarkan derajat keparahan hemodinamik ibu dan kondisi janin. Klasifikasi ini penting untuk menentukan tingkat kegawatan serta prioritas penanganan.

a. Perdarahan Ringan

Perdarahan ringan ditandai dengan jumlah perdarahan yang tidak signifikan sehingga belum mengganggu kestabilan hemodinamik ibu. Pada kondisi ini, tekanan darah dan nadi masih dalam batas normal, dan tidak terdapat tanda-tanda syok. Kondisi janin umumnya masih stabil dengan denyut jantung dalam rentang normal. Meskipun tampak ringan, kondisi ini tetap memerlukan observasi ketat karena dapat berkembang menjadi perdarahan yang lebih berat jika penyebab utama tidak ditangani secara adekuat (Lowdermilk et al., 2021).

b. Perdarahan Sedang

Perdarahan sedang ditandai dengan mulai munculnya tanda-tanda awal hipovolemia seperti peningkatan denyut nadi, penurunan tekanan darah ringan, serta pucat pada ibu. Pada tahap ini, tubuh mulai menunjukkan kompensasi terhadap kehilangan darah.

Kondisi janin dapat mulai menunjukkan tanda tidak stabil, meskipun belum mencapai kondisi gawat janin. Oleh karena itu, diperlukan observasi ketat, pemantauan tanda vital, serta evaluasi kondisi janin secara berkala untuk mencegah perburukan (Cunningham et al., 2022).

c. Perdarahan Berat

Perdarahan berat merupakan kondisi kegawatdaruratan obstetri yang ditandai dengan syok hipovolemik, yaitu kondisi penurunan volume darah yang signifikan sehingga mengganggu perfusi organ vital. Pada tahap ini, ibu dapat mengalami hipotensi berat, takikardia, penurunan kesadaran, serta tanda-tanda kegagalan sirkulasi. Kondisi janin umumnya sudah berada dalam keadaan distress atau gawat janin akibat hipoksia berat. Perdarahan berat memerlukan tindakan segera karena dapat mengancam keselamatan ibu dan janin dalam waktu singkat (WHO, 2023).

Tabel 4. 1 Klasifikasi Perdarahan Ante Partum

Klasifikasi	Tanda Klinis Ibu	Kondisi Janin	Interpretasi Klinis	Tindakan Keperawatan & Medis
Ringan	Perdarahan sedikit, tanda vital stabil, tidak ada syok	DJJ normal	Belum ada gangguan hemodinamik	Observasi ketat, tirah baring, monitor DJJ, pantau perdarahan, akses IV bila perlu

Klasifikasi	Tanda Klinis Ibu	Kondisi Janin	Interpretasi Klinis	Tindakan Keperawatan & Medis
Sedang	Takikardi ringan, pucat, mulai tanda hipovolemia	DJJ mulai tidak stabil	Kompensasi awal syok	O2 nasal kanul, pemasangan infus RL/NS, monitoring ketat, siapkan darah
Berat	Hipotensi, takikardi berat, syok, penurunan kesadaran	Gawat janin / distress	Syok hipovolemik	Resusitasi cairan cepat, transfusi darah, O2 high flow, persiapan SC emergensi

9. Dampak dan Komplikasi Perdarahan Ante Partum

Perdarahan ante partum merupakan kondisi obstetri kegawatdaruratan yang dapat menyebabkan gangguan sistemik baik pada ibu maupun janin. Tingkat keparahan komplikasi sangat dipengaruhi oleh jumlah perdarahan, kecepatan penanganan, serta penyebab dasar seperti plasenta previa, solusio plasenta, atau vasa previa. Secara fisiologis, kehilangan darah akut pada kehamilan dapat menyebabkan penurunan volume sirkulasi efektif yang berujung pada gangguan perfusi jaringan, hipoksia, hingga kegagalan organ multipel apabila tidak segera ditangani (Cunningham et al., 2022; WHO, 2023).

a. Dampak dan Komplikasi pada Ibu

Salah satu komplikasi paling awal dan paling berbahaya adalah syok hipovolemik. Kondisi ini terjadi akibat kehilangan darah yang signifikan sehingga volume intravaskular menurun drastis. Tubuh akan melakukan kompensasi melalui vasokonstriksi dan peningkatan denyut jantung, namun bila tidak teratasi akan berkembang menjadi kegagalan sirkulasi yang mengancam nyawa. Selain itu, pada kasus perdarahan masif dapat terjadi Disseminated Intravascular Coagulation (DIC), yaitu gangguan koagulasi yang ditandai oleh aktivasi sistem pembekuan secara menyeluruh sehingga menyebabkan konsumsi faktor koagulasi secara berlebihan. Kondisi ini sering ditemukan pada solusio plasenta berat akibat pelepasan tromboplastin jaringan ke dalam sirkulasi maternal (Cunningham et al., 2022).

Komplikasi lain yang dapat terjadi adalah kebutuhan tindakan histerektomi, terutama pada kondisi plasenta akreta spectrum di mana plasenta melekat abnormal dan sulit dilepaskan dari dinding uterus. Tindakan ini menjadi pilihan terakhir untuk menyelamatkan nyawa ibu ketika perdarahan tidak dapat dikendalikan. Pada kondisi hipoperfusi yang berkepanjangan,

ginjal dapat mengalami gangguan akut berupa acute kidney injury (AKI) akibat penurunan aliran darah renal. Bila kondisi ini tidak segera dikoreksi, dapat berkembang menjadi gagal ginjal akut yang membutuhkan terapi dialisis. Pada tingkat paling berat, APH dapat berakhir dengan kematian maternal, terutama bila terjadi keterlambatan penanganan, keterbatasan fasilitas transfusi darah, atau syok yang tidak tertangani dengan cepat (WHO, 2023).

b. Dampak dan Komplikasi pada Janin

Pada sisi janin, komplikasi utama yang terjadi adalah hipoksia akibat gangguan aliran darah uteroplasenta. Penurunan suplai oksigen ini dapat menyebabkan gangguan metabolik janin dan asidosis, yang bila berlangsung lama akan menyebabkan kerusakan organ permanen. Komplikasi lain yang sering terjadi adalah prematuritas, baik akibat induksi persalinan dini secara medis maupun persalinan spontan sebagai respons terhadap kondisi patologis seperti solusio plasenta. Bayi yang lahir prematur memiliki risiko tinggi terhadap gangguan pernapasan dan ketidakmatangan organ. Kondisi yang lebih berat dapat menyebabkan intrauterine fetal death (IUFD), terutama pada kasus solusio plasenta berat atau vasa previa yang tidak terdeteksi sebelumnya. IUFD terjadi akibat terhentinya suplai oksigen secara total ke janin. Selain itu, bayi yang lahir dalam kondisi hipoksia berat dapat mengalami asfiksia neonatorum, yaitu kegagalan bernapas spontan pada saat lahir yang memerlukan resusitasi segera untuk mencegah kerusakan neurologis jangka panjang (Cunningham et al., 2022; WHO, 2023).

10. Pemeriksaan Penunjang Perdarahan Ante Partum

Pemeriksaan penunjang pada APH bertujuan untuk menegaskan diagnosis, menilai derajat keparahan, serta menentukan kondisi ibu dan janin secara komprehensif. Pemeriksaan ini sangat penting dalam menentukan tatalaksana selanjutnya.

a. Ultrasonografi (USG Obstetri)

USG merupakan pemeriksaan utama dalam APH karena dapat menentukan lokasi plasenta, termasuk mendeteksi plasenta previa atau kelainan implantasi seperti plasenta akreta. Pemeriksaan ini juga membantu menilai kondisi janin dan jumlah cairan ketuban. USG transabdominal dan transvaginal dapat digunakan sesuai indikasi klinis.

b. Cardiotocography (CTG)

CTG digunakan untuk memantau kesejahteraan janin secara kontinu melalui rekaman denyut jantung janin dan kontraksi uterus. Pada kasus APH, CTG sangat penting untuk mendeteksi tanda distress janin seperti variabilitas menurun, deselerasi lambat, atau bradikardi.

c. Pemeriksaan Hemoglobin dan Hematokrit

Pemeriksaan ini digunakan untuk menilai derajat anemia akibat perdarahan. Penurunan Hb dan Ht menunjukkan adanya kehilangan darah yang signifikan, meskipun pada fase awal dapat tampak normal karena mekanisme kompensasi cairan tubuh.

d. Golongan Darah dan Crossmatch

Pemeriksaan ini wajib dilakukan pada semua kasus APH untuk mempersiapkan transfusi darah. Crossmatch memastikan kecocokan darah donor dan resipien sehingga mengurangi risiko reaksi transfusi.

e. Pemeriksaan Koagulasi (PT, aPTT, Fibrinogen)

Pemeriksaan ini penting untuk mendeteksi gangguan pembekuan darah seperti DIC. Penurunan kadar fibrinogen merupakan indikator penting pada solusio plasenta berat dan menunjukkan risiko perdarahan yang semakin parah.

f. USG Doppler

USG Doppler digunakan untuk menilai aliran darah uteroplasenta dan sirkulasi fetomaternal. Pemeriksaan ini membantu mengevaluasi adanya gangguan perfusi plasenta yang dapat menyebabkan hipoksia janin.

11. Penatalaksanaan Umum Perdarahan Ante Partum (APH)

Perdarahan ante partum merupakan kondisi kegawatdaruratan obstetri yang memerlukan penanganan cepat, terstruktur, dan kolaboratif antara tenaga medis dan keperawatan. Tujuan utama penatalaksanaan adalah mempertahankan stabilitas hemodinamik ibu, memastikan perfusi uteroplasenta tetap adekuat, serta mencegah kematian maternal dan perinatal. Pendekatan penanganan dilakukan melalui dua aspek utama, yaitu medis dan keperawatan yang saling berkesinambungan (Cunningham et al., 2022; WHO, 2023).

a. Penatalaksanaan Medis

1) Stabilisasi hemodinamik (cairan dan transfusi darah)

Stabilisasi hemodinamik merupakan prioritas utama dalam penanganan APH. Pada kondisi perdarahan akut, terjadi penurunan volume sirkulasi efektif yang dapat menyebabkan hipovolemia hingga syok. Oleh karena itu, terapi cairan intravena segera diberikan menggunakan kristaloid seperti Ringer Laktat atau NaCl 0,9% untuk mempertahankan perfusi organ vital. Pada kasus perdarahan sedang hingga berat, pemberian cairan saja tidak cukup sehingga diperlukan transfusi darah. Transfusi dilakukan berdasarkan evaluasi hemoglobin, hematokrit, serta kondisi klinis pasien. Tujuan transfusi adalah mengembalikan kapasitas pengangkutan oksigen darah dan mencegah kegagalan organ akibat hipoksia jaringan. Pada kondisi tertentu,

komponen darah seperti packed red cells, fresh frozen plasma, dan trombosit dapat diberikan terutama bila terdapat gangguan koagulasi seperti DIC.

2) Terminasi kehamilan bila ada indikasi

Terminasi kehamilan merupakan tindakan penghentian kehamilan yang dilakukan apabila risiko mempertahankan kehamilan lebih besar dibandingkan risiko persalinan. Indikasi terminasi pada APH meliputi perdarahan yang tidak terkontrol, gangguan kondisi ibu yang berat, serta adanya tanda gawat janin.

Keputusan terminasi sangat bergantung pada usia gestasi, jenis perdarahan, serta kondisi klinis ibu dan janin. Pada kehamilan yang belum cukup bulan namun kondisi ibu tidak stabil, terminasi tetap dapat dilakukan sebagai tindakan penyelamatan jiwa.

3) Sectio caesarea pada kondisi tertentu

Sectio caesarea (SC) merupakan metode persalinan operatif yang dipilih pada kondisi tertentu seperti plasenta previa totalis, vasa previa, atau solusio plasenta berat dengan kondisi janin masih hidup. SC dilakukan untuk menghindari perdarahan lebih lanjut serta mengurangi risiko hipoksia janin. Pada plasenta previa, SC menjadi pilihan utama karena persalinan pervaginam dapat menyebabkan perdarahan masif akibat robekan plasenta. Sementara pada solusio plasenta berat, SC dilakukan bila kondisi ibu dan janin memungkinkan untuk dilakukan tindakan segera.

4) Monitoring ketat ibu dan janin

Monitoring ketat dilakukan untuk menilai perkembangan kondisi klinis secara real-time. Pada ibu, pemantauan meliputi tekanan darah, nadi, respirasi, suhu tubuh, serta tanda-tanda syok seperti penurunan kesadaran dan kulit dingin. Pada janin, pemantauan dilakukan menggunakan cardiotocography (CTG) untuk menilai denyut jantung janin dan aktivitas uterus. Perubahan pola DJJ seperti bradikardi, takikardi, atau variabilitas menurun merupakan tanda distress janin yang membutuhkan tindakan segera. Monitoring yang ketat sangat penting karena kondisi APH dapat berubah secara cepat dari stabil menjadi gawat darurat dalam waktu singkat (Cunningham et al., 2022).

b. Penatalaksanaan Keperawatan

1) Monitoring tanda vital

Perawat memiliki peran penting dalam pemantauan tanda vital secara berkala, terutama tekanan darah, nadi, respirasi, dan saturasi oksigen. Peningkatan denyut nadi dan penurunan tekanan darah merupakan tanda

awal hipovolemia. Monitoring dilakukan setiap 15–30 menit pada kondisi tidak stabil. Deteksi dini perubahan tanda vital sangat penting untuk mencegah terjadinya syok hipovolemik yang dapat mengancam jiwa.

2) Observasi perdarahan

Observasi perdarahan dilakukan dengan menilai jumlah, warna, dan karakter darah yang keluar. Perdarahan merah segar tanpa nyeri umumnya mengarah pada plasenta previa, sedangkan perdarahan dengan nyeri hebat dan uterus tegang mengarah pada solusio plasenta. Perawat juga mencatat jumlah pembalut yang digunakan serta melakukan estimasi kehilangan darah untuk membantu penilaian derajat keparahan kondisi pasien.

3) Pemasangan IV line besar

Pemasangan akses intravena berukuran besar (16–18G) sangat penting untuk memungkinkan resusitasi cairan cepat dan transfusi darah. Jalur intravena harus segera dipasang pada pasien APH tanpa menunda proses stabilisasi. Melalui akses ini, cairan kristaloid, darah, maupun obat-obatan emergensi dapat diberikan dengan cepat sesuai kebutuhan klinis.

4) Manajemen syok

Manajemen syok bertujuan untuk mempertahankan perfusi jaringan dan mencegah kegagalan organ. Tindakan keperawatan meliputi pemberian oksigen, posisi pasien lateral kiri untuk meningkatkan aliran darah uteroplasenta, serta monitoring ketat hemodinamik. Selain itu, perawat harus segera melaporkan tanda-tanda syok seperti hipotensi, takikardi berat, kulit pucat dingin, dan penurunan kesadaran kepada tim medis untuk tindakan lanjutan.

5) Edukasi keluarga

Edukasi keluarga merupakan bagian penting dalam penatalaksanaan APH karena kondisi ini sering menimbulkan kecemasan tinggi. Perawat berperan menjelaskan kondisi pasien secara sederhana, rencana tindakan, serta kemungkinan risiko yang dapat terjadi. Keluarga juga diberikan pemahaman mengenai pentingnya tindakan cepat seperti transfusi darah atau operasi, sehingga dapat mendukung keputusan medis tanpa hambatan emosional yang berlebihan. Edukasi yang baik dapat meningkatkan kerja sama keluarga dan mempercepat proses penanganan kegawatdaruratan (WHO, 2023).

12. Implikasi dalam Kehamilan Risiko Tinggi pada Perdarahan Ante Partum (APH)

Perdarahan ante partum (APH) merupakan kondisi obstetri yang secara langsung meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas ibu serta janin. Secara klinis, APH mencerminkan adanya gangguan pada sistem uteroplasenta yang

dapat menyebabkan hipoksia janin, instabilitas hemodinamik ibu, hingga kegawatdaruratan obstetri. Oleh karena itu, setiap kejadian APH secara otomatis dikategorikan sebagai **kehamilan risiko tinggi** yang memerlukan manajemen komprehensif dan berkesinambungan (Cunningham et al., 2022; WHO, 2023).

a. Perawatan antenatal intensif

Perawatan antenatal intensif pada kehamilan dengan APH merupakan pendekatan sistematis yang bertujuan untuk mencegah perburukan kondisi ibu dan janin. Dalam kondisi ini, frekuensi kontrol kehamilan ditingkatkan, bahkan sering kali memerlukan rawat inap untuk observasi ketat. Secara klinis, antenatal intensif mencakup pemantauan tanda vital ibu secara berkala, penilaian ulang perdarahan, serta observasi tanda-tanda syok seperti hipotensi, takikardi, dan penurunan kesadaran. Selain itu, dilakukan pemantauan kesejahteraan janin melalui pemeriksaan non-stress test (NST) atau cardiotocography (CTG) untuk mendeteksi dini adanya hipoksia.

Pendekatan ini penting karena APH dapat mengalami perburukan mendadak, terutama pada kasus solusio plasenta atau vasa previa yang dapat menyebabkan kehilangan darah masif dalam waktu singkat (ACOG, 2023; Cunningham et al., 2022).

b. Konsultasi spesialis obstetri

Kehamilan dengan APH membutuhkan keterlibatan spesialis obstetri sejak awal diagnosis karena kompleksitas penanganannya. Kondisi seperti plasenta previa totalis, plasenta akreta, atau solusio plasenta berat memerlukan keputusan klinis yang cepat dan tepat berbasis evidence-based medicine. Spesialis obstetri bertanggung jawab dalam menentukan rencana tatalaksana, termasuk konservatif atau terminasi kehamilan, serta menentukan metode persalinan yang paling aman. Selain itu, keputusan transfusi darah, penggunaan tokolitik, hingga tindakan operatif seperti sectio caesarea harus dilakukan oleh tenaga ahli. Keterlibatan spesialis terbukti menurunkan angka kematian maternal melalui deteksi dini komplikasi dan pengambilan keputusan yang tepat waktu (WHO, 2023; Prawirohardjo, 2021).

c. Pemantauan pertumbuhan janin berulang

Perdarahan ante partum dapat mengganggu perfusi uteroplacenta sehingga menyebabkan hipoksia kronis dan gangguan pertumbuhan janin (intrauterine growth restriction/IUGR). Oleh karena itu, diperlukan pemantauan pertumbuhan janin secara serial menggunakan ultrasonografi. Evaluasi meliputi estimasi berat janin, ukuran biometrik (biparietal diameter, abdominal circumference, femur length), serta evaluasi cairan ketuban. Selain itu, pemeriksaan Doppler arteri umbilikalis digunakan untuk menilai resistensi

aliran darah plasenta. Pemantauan ini penting untuk menentukan waktu terminasi kehamilan yang optimal guna mencegah kematian intrauterin (Cunningham et al., 2022; NICE, 2022).

d. Perencanaan tempat persalinan dengan fasilitas lengkap

Kehamilan dengan APH harus direncanakan untuk melahirkan di fasilitas kesehatan dengan kemampuan penanganan obstetri emergensi lengkap. Hal ini sangat penting karena APH dapat berkembang menjadi kondisi kegawatdaruratan yang membutuhkan intervensi segera. Fasilitas ideal harus memiliki layanan operasi sectio caesarea 24 jam, ketersediaan darah dan komponen darah, ruang ICU maternal dan neonatal, serta tenaga kesehatan multidisiplin seperti dokter obstetri, anestesi, dan neonatologi. WHO menekankan bahwa keterlambatan penanganan (delay in decision, delay in transport, dan delay in treatment) merupakan faktor utama kematian maternal pada kasus perdarahan obstetri, sehingga perencanaan lokasi persalinan menjadi intervensi kritis (WHO, 2023).

D. ASUHAN KEPERAWATAN LENGKAP PERDARAHAN ANTE PARTUM (APH)(SDKI–SLKI–SIKI TERINTEGRAS I)

1. PENGKAJIAN KEPERAWATAN

Pengkajian pada pasien Perdarahan Ante Partum dilakukan secara sistematis meliputi aspek ibu, janin, dan psikologis. Fokus utama adalah identifikasi sumber perdarahan, derajat kehilangan darah, serta dampaknya terhadap perfusi jaringan ibu dan janin. Secara subjektif, pasien dapat melaporkan perdarahan pervaginam pada trimester ketiga, yang dapat disertai nyeri (pada solusio plasenta) atau tanpa nyeri (pada plasenta previa). Pasien juga dapat mengeluhkan lemas, pusing, berdebar, dan rasa cemas berlebihan akibat kondisi kehamilan yang mengancam.

Secara objektif ditemukan perdarahan aktif, pucat, hipotensi, takikardi, penurunan perfusi perifer, serta penurunan kesadaran pada kondisi berat. Pemeriksaan obstetri dapat menunjukkan uterus tegang (board-like abdomen) atau uterus lembek. Denyut jantung janin dapat menunjukkan tanda distress berupa bradikardia atau variabilitas menurun. Pemeriksaan penunjang meliputi Hb, hematokrit, golongan darah, crossmatch, koagulasi (PT, aPTT, fibrinogen), USG obstetri, dan CTG untuk menilai kesejahteraan janin.

Sumber: PPNI (2017–2018); Cunningham et al. (2022); WHO (2023)

2. DIAGNOSA KEPERAWATAN (SDKI)

- a. Defisit volume cairan
- b. Risiko syok hipovolemik
- c. Gangguan perfusi jaringan uteroplasenta
- d. Ansietas

Sumber: PPNI (2017)

DIAGNOSA 1: DEFISIT VOLUME CAIRAN (SDKI)

SLKI (Luaran)

Tabel 4. 2 ASUHAN KEPERAWATAN (SDKI–SLKI–SIKI)

Luaran	Indikator	Target
Status cairan	TD stabil, nadi normal	Meningkat
Perfusi jaringan	CRT < 2 detik	Adekuat
Tanda syok	Tidak ada hipotensi	Terkontrol

SIKI (Intervensi)

- Pemantauan tanda vital ketat
- Monitoring perdarahan (jumlah, warna, frekuensi)
- Pemasangan IV line besar (18G/16G)
- Manajemen cairan (kolaborasi kristaloid & darah)
- Monitoring output urin

Sumber: PPNI (2018); WHO (2023)

DIAGNOSA 2: RISIKO SYOK HIPOVOLEMIK

SLKI Luaran	Indikator	Target
Status hemodinamik	TD stabil	Stabil
Kesadaran	Compos mentis	Normal
Perfusi perifer	Akral hangat	Baik

SIKI

- Monitoring tanda syok (hipotensi, takikardi, pucat)
- Posisi shock (Trendelenburg modifikasi)
- Pemberian oksigen nasal kanul/masker
- Kolaborasi transfusi darah
- Persiapan tindakan emergensi obstetri

Sumber: Cunningham et al. (2022)

DIAGNOSA 3: GANGGUAN PERFUSI JARINGAN UTEROPLASENTA**SLKI**

Luaran	Indikator	Target
Kesejahteraan janin	DJJ 110–160 bpm	Stabil
Aktivitas janin	Gerakan adekuat	Normal
Tanda hipoksia	Tidak ada deselerasi	Tidak ada

SIKI

- Monitoring DJJ (Doppler/CTG) kontinu
- Observasi tanda distress janin
- Kolaborasi USG Doppler
- Persiapan terminasi kehamilan bila indikasi
- Observasi gerakan janin oleh ibu

Sumber: NICE (2022)

DIAGNOSA 4: ANSIETAS**SLKI**

Luaran	Indikator	Target
Tingkat kecemasan	Gelisah berkurang	Menurun
Koping	Adaptif	Meningkat
Pemahaman	Mengerti kondisi	Baik

SIKI

- Komunikasi terapeutik
- Edukasi kondisi APH dan risiko
- Libatkan keluarga dalam perawatan
- Dukungan emosional aktif
- Teknik relaksasi sederhana

3. IMPLEMENTASI KEPERAWATAN

Implementasi dilakukan berdasarkan prinsip kegawatdaruratan obstetri dengan prioritas ABC (Airway, Breathing, Circulation). Tindakan utama difokuskan pada stabilisasi hemodinamik ibu dan evaluasi kesejahteraan janin.

Tindakan meliputi pemasangan akses intravena besar, pemberian oksigen, monitoring tanda vital setiap 15–30 menit pada fase akut, serta observasi ketat jumlah perdarahan. Perawat juga melakukan kolaborasi dalam pemberian cairan, transfusi darah, dan persiapan tindakan operasi bila diperlukan.

Sumber: WHO (2023); Cunningham et al. (2022)

4. EVALUASI (SOAP)

1) **S (Subjektif)**

Pasien melaporkan perdarahan berkurang, rasa cemas menurun.

2) **O (Objektif)**

TD stabil, nadi normal, DJJ 120–150 bpm, perdarahan minimal.

3) **A (Assessment)**

Defisit volume cairan teratasi sebagian, risiko syok menurun, perfusi janin stabil.

4) **P (Plan)**

Lanjutkan monitoring ketat, observasi DJJ, edukasi lanjutan, dan kesiapan tindakan emergensi bila terjadi perburukan.

Sumber: PPNI (2017–2018)

E. KESIMPULAN

Perdarahan antepartum merupakan kondisi perdarahan yang terjadi pada kehamilan trimester akhir sebelum persalinan dan termasuk dalam kegawatdaruratan obstetri. Sementara itu, kehamilan risiko tinggi adalah kehamilan dengan potensi komplikasi yang lebih besar dibandingkan kehamilan normal. Kedua kondisi ini memiliki hubungan yang erat dan berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya morbiditas dan mortalitas maternal serta perinatal, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam praktik klinis.

Faktor risiko perdarahan ante partum merupakan kombinasi kompleks antara kondisi maternal, obstetri, dan gaya hidup yang memengaruhi kualitas implantasi plasenta, stabilitas vaskular uterus, serta perfusi uteroplacenta. Identifikasi dini terhadap faktor risiko ini sangat penting dalam pencegahan komplikasi maternal dan perinatal melalui deteksi antenatal dan pemantauan kehamilan risiko tinggi.

Manifestasi klinis perdarahan ante partum sangat bergantung pada etiologi dasar seperti plasenta previa, solusio plasenta, dan vasa previa, yang masing-masing memiliki karakteristik berbeda dalam hal nyeri, pola perdarahan, serta kondisi uterus

dan janin. Sementara itu, klasifikasi berdasarkan derajat keparahan membantu tenaga kesehatan dalam menentukan tingkat kegawatdaruratan dan prioritas intervensi. Deteksi dini dan pemahaman klinis yang tepat sangat penting untuk menurunkan angka morbiditas dan mortalitas maternal serta perinatal.

Penatalaksanaan APH membutuhkan pendekatan cepat, sistematis, dan kolaboratif. Penanganan medis berfokus pada stabilisasi hemodinamik dan keputusan obstetri seperti terminasi atau operasi caesar, sedangkan keperawatan berperan penting dalam monitoring ketat, manajemen syok, dan dukungan psikologis keluarga. Sinergi kedua aspek ini sangat menentukan keberhasilan outcome maternal dan perinatal.

Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Kasus: Perdarahan Antepartum & Kehamilan Risiko Tinggi

Seorang ibu hamil usia 36 tahun G3P2A0 dengan usia kehamilan 34 minggu datang ke IGD dengan keluhan keluar darah dari jalan lahir sejak 2 jam yang lalu. Ibu mengatakan darah berwarna merah segar dan keluar cukup banyak tanpa disertai nyeri perut. Ibu tampak cemas dan merasa gerakan janin masih dirasakan tetapi berkurang dibandingkan biasanya. Riwayat obstetri menunjukkan ibu pernah menjalani operasi caesar pada kehamilan sebelumnya. Selama kehamilan saat ini, ibu jarang melakukan pemeriksaan antenatal secara rutin.

Hasil pengkajian menunjukkan:

- Tekanan darah 100/60 mmHg
- Nadi 110 x/menit
- Frekuensi napas 24 x/menit
- Suhu 36,8°C
- Ibu tampak pucat dan lemah
- Perdarahan pervaginam $\pm$ 200 ml, merah segar
- Uterus teraba lembek
- Denyut jantung janin 140 x/menit

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi

- a. Identifikasi tanda dan gejala yang menunjukkan bahwa pasien mengalami perdarahan antepartum.
- b. Tentukan kemungkinan penyebab perdarahan pada kasus ini (plasenta previa, solusio plasenta, atau lainnya) disertai alasan klinis.
- c. Identifikasi faktor risiko yang dimiliki pasien sehingga termasuk dalam kehamilan risiko tinggi.
- d. Analisis kondisi hemodinamik ibu, apakah sudah mengarah pada kondisi syok atau belum, serta jelaskan alasannya.
- e. Tentukan diagnosis keperawatan prioritas berdasarkan data pada kasus.
- f. Jelaskan tindakan keperawatan awal (emergency) yang harus dilakukan pada pasien.
- g. Identifikasi tanda bahaya (red flags) yang harus segera diwaspadai pada kasus ini.
- h. Jelaskan rencana kolaborasi dengan tim medis yang perlu dilakukan oleh perawat.
- i. Apa edukasi yang perlu diberikan kepada pasien dan keluarga terkait kondisi ini?

Instruksi Diskusi

Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dengan menggunakan pendekatan clinical reasoning. Setiap kelompok diminta untuk:

- Menyusun hasil analisis secara sistematis
- Menentukan prioritas masalah dan tindakan
- Mempresentasikan hasil diskusi di kelas

Tujuan Pembelajaran

Mahasiswa mampu:

- a. Mengidentifikasi kasus perdarahan antepartum secara klinis
- b. Menentukan prioritas masalah keperawatan
- c. Melakukan analisis kondisi kegawatdaruratan obstetric
- d. Menentukan tindakan awal yang tepat dan aman
- e. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kerja tim

KUNCI JAWABAN & PEMBAHASAN (MODEL UKOM)

1. Identifikasi tanda dan gejala APH

Jawaban:

Pasien menunjukkan tanda khas perdarahan antepartum, yaitu:

- Perdarahan pervaginam warna merah segar
- Terjadi pada usia kehamilan 34 minggu
- Tidak disertai nyeri
- Uterus lembek
- Ibu tampak pucat dan lemah
- Tanda vital menunjukkan kompensasi (takikardi)

Pembahasan:

Perdarahan pada trimester III harus dicurigai sebagai APH. Karakteristik darah merah segar tanpa nyeri merupakan ciri khas plasenta previa. Takikardi dan pucat menunjukkan adanya kehilangan darah dan respon kompensasi awal.

2. Kemungkinan penyebab perdarahan

Jawaban:

Kemungkinan besar adalah plasenta previa

Alasan klinis:

- Perdarahan merah segar
- Tidak nyeri
- Uterus lembek
- Riwayat SC (faktor risiko kuat)

Pembahasan:

Plasenta previa terjadi ketika plasenta menutupi sebagian atau seluruh ostium

uteri internum. Tidak adanya nyeri membedakan dengan solusio plasenta yang biasanya disertai nyeri hebat dan uterus tegang.

3. Faktor risiko kehamilan risiko tinggi

Jawaban:

- Usia ibu 36 tahun (>35 tahun)
- Riwayat operasi caesar
- Multiparitas (G3)
- ANC tidak teratur

Pembahasan:

Faktor-faktor ini meningkatkan risiko gangguan implantasi plasenta dan komplikasi obstetri. Riwayat SC merupakan faktor risiko utama plasenta previa dan plasenta akreta.

4. Analisis kondisi hemodinamik

Jawaban:

Pasien belum mengalami syok, tetapi sudah menunjukkan tanda hipovolemia awal

Data pendukung:

- TD 100/60 mmHg (cenderung menurun)
- Nadi 110 x/menit (takikardi)
- Pucat, lemah

Pembahasan:

Ini merupakan fase kompensasi syok. Tubuh masih mampu mempertahankan tekanan darah, tetapi tanda-tanda awal syok sudah muncul. Perlu tindakan cepat untuk mencegah perburukan.

5. Diagnosis keperawatan prioritas (SDKI)

Jawaban utama:

- Defisit volume cairan berhubungan dengan kehilangan darah
- Risiko syok hipovolemik
- Gangguan perfusi uteroplacenta
- Ansietas

Pembahasan:

Diagnosis prioritas ditentukan berdasarkan prinsip ABC dan keselamatan pasien, dengan fokus utama pada sirkulasi.

6. Tindakan keperawatan awal (emergency)

Jawaban:

- Monitoring tanda vital ketat
- Observasi jumlah perdarahan
- Posisi miring kiri

- Pemasangan IV line besar (2 jalur jika memungkinkan)
- Pemberian oksigen
- Persiapan transfusi darah
- Kolaborasi segera dengan dokter

Pembahasan:

Tindakan difokuskan pada stabilisasi hemodinamik dan mempertahankan perfusi janin. Posisi miring kiri membantu meningkatkan aliran uteroplasenta.

7. Identifikasi red flags

Jawaban:

- Perdarahan bertambah banyak
- Tanda syok (hipotensi, nadi cepat lemah)
- Penurunan kesadaran
- DJJ tidak normal
- Penurunan gerakan janin

Pembahasan:

Red flags menunjukkan kondisi kegawatdaruratan yang memerlukan eskalasi segera.

8. Kolaborasi dengan tim medis

Jawaban:

- Pemeriksaan USG
- Transfusi darah
- CTG monitoring
- Persiapan sectio caesarea
- Pemeriksaan laboratorium (Hb, koagulasi)

Pembahasan:

Kolaborasi penting karena APH merupakan kondisi multidisiplin. SC sering menjadi pilihan pada plasenta previa.

9. Edukasi pasien dan keluarga

Jawaban:

- Kondisi ibu dan risiko yang mungkin terjadi
- Pentingnya istirahat dan pembatasan aktivitas
- Tanda bahaya yang harus segera dilaporkan
- Rencana tindakan medis
- Pentingnya ANC teratur

Pembahasan:

Edukasi meningkatkan kepatuhan dan mengurangi kecemasan pasien serta keluarga.

KESIMPULAN MODEL UKOM

Kasus ini mengarah pada plasenta previa dengan kondisi hipovolemia awal.

Prioritas utama adalah:

- a) Stabilisasi hemodinamik
- b) Pencegahan syok
- c) Menjaga perfusi janin
- d) Kolaborasi cepat untuk tindakan definitif

POIN KUNCI UKOM (HIGH-YIELD)

- Perdarahan tanpa nyeri → pikirkan plasenta previa
- Jangan lakukan pemeriksaan vaginal
- Fokus pada ABC dan syok
- Posisi miring kiri wajib
- Eskalasi cepat = kunci keselamatan ibu & janin

Aktivitas 2 — *Shows How*

Simulasi/skill lab

Perdarahan Antepartum & Kehamilan Risiko Tinggi

Fokus: urutan tindakan klinik + komunikasi terapeutik + keselamatan ibu & janin

Catatan untuk penulis:

- Tidak langsung ke ujian (OSCE)
- Mahasiswa harus melalui tahapan kompetensi bertahap (knowledge → skill → performance)
- Fokus utama: kegawatdaruratan obstetri & patient safety

Alur Pembelajaran Skill Lab

Mahasiswa dilatih untuk:

- Melakukan pengkajian cepat (ABC)
- Mengidentifikasi tanda perdarahan antepartum
- Menentukan prioritas tindakan
- Melakukan tindakan awal kegawatdaruratan
- Melakukan eskalasi tepat waktu
- Berkomunikasi efektif dengan pasien dan keluarga

Asesmen (Piramida Miller)

Level Miller	Metode
Knows / Knows How	Self-check, analisis mini-case APH, diskusi klinis
Shows How	OSCE penanganan awal perdarahan antepartum
Does	DOPS / praktik klinik di ruang bersalin/IGD

Catatan untuk penulis:

- CP Bab = mendemonstrasikan penanganan awal APH
- OSCE digunakan karena menilai keterampilan praktik (shows how)
- Penilaian tidak dipaksakan, tetapi aligned dengan kompetensi Simulasi Skill Lab (Tahapan Tindakan)

1. Pra Interaksi

- Menyiapkan alat (APD, infus, oksigen, alat monitoring)
- Cuci tangan (hand hygiene)
- Membaca data pasien singkat

2. Orientasi

- Salam terapeutik
- Perkenalan diri dan peran
- Verifikasi identitas pasien

- Menjelaskan tujuan tindakan
 - Menjaga privasi dan kenyamanan
3. Tahap Kerja (Core Skill APH)
- Mahasiswa harus melakukan secara sistematis:
- A. Pengkajian cepat (PRIMARY SURVEY)**
- Airway: patensi jalan napas
 - Breathing: frekuensi napas
 - Circulation: nadi, tekanan darah, CRT
 - Observasi perdarahan (jumlah & warna)
- B. Pengkajian fokus obstetri**
- Usia kehamilan
 - Karakteristik perdarahan
 - Nyeri/tidak
 - Riwayat SC
 - Gerakan janin
 - DJJ (denyut jantung janin)
- C. Tindakan awal (EMERGENCY MANAGEMENT)**
- Posisi miring kiri
 - Pemasangan IV line besar
 - Pemberian oksigen
 - Monitoring tanda vital
 - Observasi perdarahan
 - Persiapan transfusi
 - Kolaborasi tim medis
- D. Komunikasi & edukasi**
- Menenangkan pasien
 - Menjelaskan kondisi secara sederhana
 - Memberi informasi tindakan yang akan dilakukan
4. Terminasi
- Evaluasi kondisi ibu dan janin
 - Menyimpulkan tindakan
 - Memberikan reinforcement
 - Dokumentasi singkat
- OSCE Ringkas + Critical Items
- Critical Items (WAJIB LULUS)
- Mahasiswa harus melakukan semua poin berikut, jika tidak → **TIDAK LULUS**
- Hand hygiene & pencegahan infeksi
 - Identifikasi pasien & menjaga privasi

- Pengkajian cepat (ABC)
- Tidak melakukan pemeriksaan vaginal pada kecurigaan plasenta previa
- Posisi miring kiri
- Identifikasi tanda syok
- Monitoring DJJ
- Eskalasi segera bila red flags muncul

DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung pada Asuhan Keperawatan Perdarahan Antepartum dan kehamilan risiko tinggi
- Checklist + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Catatan untuk penulis:

- Dari simulasi → praktik nyata
- Bukti performa sesungguhnya

Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada Asuhan Keperawatan Perdarahan Antepartum dan kehamilan risiko tinggi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus perdarahan antepartum & kehamilan risiko tinggi
Metode penilaian	DOPS merupakan metode penilaian berbasis observasi langsung terhadap keterampilan prosedural mahasiswa dalam situasi klinik nyata atau simulasi.	Pembimbing mengamati secara langsung mahasiswa saat melakukan tindakan awal pada ibu hamil dengan perdarahan antepartum di ruang IGD/ruang bersalin, seperti pengkajian cepat, positioning, dan persiapan tindakan kegawatdaruratan.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam melakukan keterampilan klinik/prosedur secara tepat, aman, dan sesuai standar praktik.	Mahasiswa dinilai tidak hanya memahami konsep APH tetapi mampu melakukan tindakan prioritas seperti identifikasi perdarahan, pemantauan tanda vital, posisi miring kiri, dan komunikasi dengan pasien.
Kasus klinik	Kasus diambil dari kondisi nyata yang sering ditemukan dan sesuai kompetensi mahasiswa.	Seorang ibu hamil usia 34 minggu datang dengan perdarahan pervaginam tanpa nyeri, darah merah segar ± 200 ml, TD 100/60 mmHg, nadi 110x/menit, DJJ 140 bpm.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan prosedur klinik secara langsung mulai dari	Mahasiswa melakukan hand hygiene, memperkenalkan diri, melakukan pengkajian cepat (perdarahan, tanda vital, DJJ), mengatur posisi ibu miring

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus perdarahan antepartum & kehamilan risiko tinggi
	persiapan hingga evaluasi tindakan.	kiri, mensimulasikan pemasangan infus, memberikan oksigen, dan menjelaskan kondisi pasien.
Aspek yang dinilai	Meliputi keterampilan teknis, keselamatan pasien, komunikasi, serta ketepatan prosedur.	Pembimbing menilai kemampuan mahasiswa dalam pengkajian cepat, identifikasi tanda syok, pemantauan DJJ, teknik positioning, edukasi pasien, dan menjaga keselamatan ibu dan janin.
Fokus observasi pembimbing	Menilai apakah mahasiswa melakukan prosedur sesuai standar dan prinsip keselamatan pasien.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu melakukan tindakan prioritas (ABC), tidak melakukan tindakan berbahaya (misalnya pemeriksaan vaginal pada kecurigaan plasenta previa), serta mampu menghubungkan data klinik dengan tindakan.
Umpan balik	Diberikan segera setelah tindakan, bersifat spesifik dan konstruktif.	Pembimbing memberikan masukan bahwa mahasiswa sudah baik dalam melakukan pengkajian dan komunikasi, namun perlu meningkatkan kecepatan respon dan ketepatan prioritas tindakan kegawatdaruratan.
Keputusan penilaian	Digunakan untuk menentukan tingkat kompetensi mahasiswa dalam keterampilan klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten jika mampu melakukan tindakan secara sistematis, aman, dan tepat. Perlu supervisi jika masih membutuhkan arahan. Remedial jika tindakan tidak sesuai standar.
Makna dalam OBE	DOPS memberikan bukti autentik capaian pembelajaran pada level praktik (does).	Mahasiswa tidak hanya memahami teori APH tetapi mampu melakukan penanganan awal secara langsung, aman, cepat, dan profesional sesuai standar praktik klinik.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel. Portofolio pada Asuhan Keperawatan Perdarahan Antepartum & Kehamilan Risiko Tinggi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan.	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan.
Tujuan portofolio	Mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan selama praktik.	Mahasiswa menunjukkan perkembangan kemampuan dalam menangani kasus APH, mulai dari pengkajian hingga edukasi setelah mendapatkan umpan balik dari CI/dosen.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS menjadi bagian penting dalam portofolio sebagai bukti keterampilan laboratorium dan praktik klinik nyata.	OSCE berisi keterampilan penatalaksanaan awal APH (pengkajian, posisi, edukasi), sedangkan DOPS berisi observasi langsung saat mahasiswa melakukan tindakan di IGD/ruang bersalin.
Catatan kasus singkat	Ringkasan kasus yang memuat data penting, masalah, intervensi, dan hasil.	Mahasiswa menuliskan kasus ibu hamil 35 minggu dengan perdarahan merah segar tanpa nyeri, diagnosis defisit volume

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
		cairan, intervensi monitoring, posisi miring kiri, kolaborasi cairan, serta evaluasi kondisi ibu dan janin.
Refleksi patient safety	Refleksi tentang kemampuan mengenali risiko keselamatan pasien dan pencegahannya.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya menghindari pemeriksaan vaginal pada kecurigaan plasenta previa, serta pentingnya monitoring tanda vital dan perdarahan untuk mencegah syok.
Feedback CI/dosen	Umpan balik sebagai bukti pembinaan dan peningkatan kompetensi.	CI menyampaikan mahasiswa sudah baik dalam komunikasi dan pengkajian, tetapi perlu meningkatkan kecepatan respon dan ketepatan prioritas tindakan kegawatdaruratan..
Karakteristik penilaian	Penilaian berkelanjutan, bukan sekali selesai, menekankan konsistensi performa.	Mahasiswa dinilai dari beberapa kasus APH dan pengalaman praktik yang menunjukkan kemampuan yang konsisten dalam penanganan kegawatdaruratan maternitas.
Bukti konsistensi kompetensi	Menunjukkan kemampuan mempertahankan performa dalam berbagai situasi klinik.	Dari OSCE, DOPS, dan catatan kasus, mahasiswa konsisten mampu melakukan pengkajian cepat, tindakan awal, dan edukasi pada pasien APH.
Makna dalam OBE	Dari OSCE, DOPS, dan catatan kasus, mahasiswa konsisten mampu melakukan pengkajian cepat, tindakan awal, dan edukasi pada pasien APH.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia mampu menerapkan teori APH secara konsisten, aman, dan profesional dalam praktik klinik nyata.

Tabel. Case Report pada Asuhan Keperawatan Perdarahan Antepartum

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Hakikat case report	Laporan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa.	Mahasiswa menyusun laporan ibu hamil 35 minggu dengan perdarahan pervaginam tanpa nyeri dan kondisi hemodinamik mulai terganggu.
Tujuan	Menunjukkan kemampuan mengintegrasikan pengkajian, diagnosis, intervensi, dan evaluasi.	Mahasiswa menjelaskan masalah prioritas (perdarahan), tindakan awal, dan perkembangan kondisi pasien.
Isi laporan	Identitas pasien, data subjektif-objektif, analisis masalah, diagnosis, intervensi, implementasi, evaluasi.	Mahasiswa menuliskan perdarahan ± 200 ml, TD 100/60, nadi 110x/menit, diagnosis defisit volume cairan, intervensi posisi miring kiri, monitoring, kolaborasi cairan, dan evaluasi stabilisasi kondisi.
Fokus penilaian	Ketepatan pengkajian, penalaran klinik, intervensi, dan evaluasi..	Pembimbing menilai kemampuan mahasiswa menghubungkan perdarahan dengan risiko syok dan menentukan tindakan prioritas.
Nilai edukatif	Mengembangkan clinical reasoning dan dokumentasi ilmiah.	Mahasiswa belajar bahwa APH merupakan kondisi gawat darurat yang membutuhkan respon cepat dan tepat.
Makna dalam OBE	Bukti penerapan teori ke dalam praktik klinik nyata..	Mahasiswa mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan keperawatan APH secara komprehensif.

Tabel. Refleksi Patient Safety pada Asuhan Keperawatan Perdarahan Antepartum

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Hakikat refleksi patient safety	Tulisan reflektif tentang risiko keselamatan pasien dan pencegahannya.	Mahasiswa menyadari bahwa perdarahan antepartum dapat menyebabkan syok dan kematian jika tidak ditangani cepat.
Tujuan	Menumbuhkan kesadaran pentingnya keselamatan pasien..	Mahasiswa memahami bahwa keterlambatan tindakan dapat membahayakan ibu dan janin.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus Anak dengan Diare
Fokus refleksi	Identifikasi risiko, analisis penyebab, pencegahan, pembelajaran.	Mahasiswa mengidentifikasi risiko syok hipovolemik, hipoksia janin, dan kesalahan tindakan.
Risiko yang diidentifikasi	Situasi yang berpotensi membahayakan pasien	Risiko syok, perdarahan masif, kematian janin, dan kesalahan pemeriksaan vaginal.
Tindakan pencegahan	Langkah untuk mengurangi risiko.	Monitoring ketat tanda vital, tidak melakukan vaginal toucher, edukasi tanda bahaya, dan kolaborasi cepat.
Pembelajaran mahasiswa	Apa yang dipelajari dan dampaknya pada praktik selanjutnya.	Mahasiswa menyadari pentingnya respon cepat, komunikasi efektif, dan tindakan berbasis keselamatan pasien..
Makna dalam OBE	Bukti perkembangan sikap profesional dan berpikir kritis..	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas asuhan secara berkelanjutan.

F. RINGKASAN

Asuhan Keperawatan Perdarahan Antepartum & Kehamilan Risiko Tinggi Bab ini menekankan bahwa perdarahan antepartum merupakan salah satu kegawatdaruratan obstetri yang dapat berkembang cepat menjadi kondisi yang mengancam nyawa ibu dan janin apabila tidak dikenali serta ditangani secara tepat. Fokus utama asuhan keperawatan pada kondisi ini adalah mempertahankan stabilitas hemodinamik ibu, mencegah terjadinya syok hipovolemik, menjaga perfusi uteroplasenta, serta memastikan keselamatan ibu dan janin melalui tindakan cepat, tepat, dan terkoordinasi.

Mahasiswa perlu memahami bahwa pengkajian pada kasus perdarahan antepartum tidak hanya terbatas pada jumlah perdarahan, tetapi harus mencakup kondisi umum ibu, tanda vital, karakteristik perdarahan, usia kehamilan, riwayat obstetri, adanya nyeri perut, aktivitas janin, serta faktor risiko seperti riwayat operasi caesar, hipertensi dalam kehamilan, atau multiparitas. Identifikasi dini tanda-tanda kegawatan seperti pucat, takikardi, hipotensi, penurunan kesadaran, uterus tegang, serta perubahan denyut jantung janin merupakan hal yang sangat penting.

Alur asuhan keperawatan dimulai dari pengkajian cepat dengan prinsip ABC (airway, breathing, circulation), dilanjutkan dengan pengkajian fokus terhadap perdarahan, kondisi hemodinamik, dan status janin. Berdasarkan data tersebut, perawat menentukan masalah prioritas seperti defisit volume cairan, risiko syok, gangguan perfusi uteroplasenta, serta ansietas. Selanjutnya disusun rencana asuhan yang menekankan pemantauan tanda vital, pemantauan jumlah perdarahan, pemasangan jalur intravena besar, pemberian oksigen, posisi miring kiri, serta kolaborasi dengan tim medis untuk terapi cairan, transfusi, dan penentuan terminasi kehamilan bila diperlukan.

Pada tahap implementasi, mahasiswa harus mampu menunjukkan keterampilan klinik yang sistematis dan aman, seperti melakukan monitoring ketat tanda vital, observasi perdarahan, menjaga posisi ibu, memberikan dukungan emosional, serta berkomunikasi efektif dengan pasien dan keluarga. Edukasi juga penting, terutama terkait kondisi pasien, tanda bahaya, dan rencana tindakan yang akan dilakukan.

Evaluasi dilakukan dengan melihat stabilitas kondisi ibu dan janin, berkurangnya perdarahan, perbaikan tanda vital, serta pemahaman pasien dan keluarga. Namun, apabila ditemukan tanda kegawatan seperti syok, perdarahan masif, gangguan kesadaran, atau distress janin, maka mahasiswa harus segera melakukan eskalasi kepada tim medis sesuai alur pelayanan.

Dengan demikian, inti asuhan keperawatan pada perdarahan antepartum adalah respon cepat, pengkajian tepat, tindakan prioritas, serta kemampuan mengenali kapan harus melakukan eskalasi. Hal ini menjadi kompetensi penting dalam pembelajaran keperawatan maternitas berbasis keselamatan pasien.

Tabel 4. 3 Red Flags & Eskalasi Perdarahan Antepartum & Kehamilan Risiko Tinggi

Red flags	Makna klinis	Tindakan eskalasi
Perdarahan setelah ketuban pecah + DJJ menurun	Kehilangan darah aktif, risiko syok	Segera laporkan, siapkan resusitasi cairan dan transfusi
Tanda syok (nadi cepat lemah, hipotensi, CRT >3 detik, pucat, ekstremitas dingin)	Syok hipovolemik	Eskalasi emergensi, aktifkan tim, lakukan penanganan segera
Penurunan kesadaran	Perfusi otak menurun, kondisi kritis	Laporkan segera, lakukan monitoring ketat
Nyeri perut hebat + uterus keras	Kecurigaan solusio plasenta	Segera eskalasi untuk tindakan emergensi
Perdarahan tanpa nyeri (trimester III)	Kemungkinan plasenta previa	Hindari pemeriksaan vaginal, segera rujuk/kolaborasi
Perdarahan setelah ketuban pecah + DJJ menurun	Kecurigaan vasa previa	Tindakan emergensi, persiapkan SC segera
DJJ tidak normal (<110 atau >160 bpm)	Distres janin	Laporkan segera, siapkan intervensi obstetri
Penurunan gerakan janin	Gangguan perfusi janin	Segera evaluasi dan eskalasi
Hb sangat rendah	Anemia berat akibat perdarahan	Kolaborasi transfusi darah
Monitoring ketat dan eskalasi segera	Risiko komplikasi berat	Monitoring intensif dan eskalasi
Tanda DIC (perdarahan tidak membeku)	Gangguan koagulasi berat	Eskalasi emergensi dan kolaborasi intensif
Oliguria / tidak BAK	Perfusi ginjal menurun	Monitoring ketat dan eskalasi segera

Form Checklist

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan pengertian perdarahan antepartum	☐	☐	
2	Saya sudah bisa melakukan pengkajian cepat (ABC)	☐	☐	
3	Saya sudah bisa mengidentifikasi jumlah dan karakteristik perdarahan	☐	☐	
4	Saya sudah bisa mengkaji tanda vital dan tanda syok	☐	☐	
5	Saya sudah bisa mengkaji kondisi janin (DJJ, gerakan)	☐	☐	
6	Saya sudah bisa mengenali faktor risiko APH	☐	☐	
7	Saya sudah bisa menentukan diagnosis keperawatan prioritas	☐	☐	
8	Saya sudah bisa menyusun rencana asuhan keperawatan	☐	☐	
9	Saya sudah bisa melakukan monitoring perdarahan dan tanda vital	☐	☐	
10	Saya sudah bisa melakukan tindakan awal (posisi, oksigen, IV line)	☐	☐	
11	Saya sudah bisa memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga	☐	☐	
12	Saya sudah bisa mengenali tanda bahaya APH	☐	☐	
13	Saya sudah bisa menentukan kapan harus melakukan eskalasi	☐	☐	
14	Saya sudah bisa berkomunikasi terapeutik dengan pasien	☐	☐	
15	Saya sudah bisa melakukan dokumentasi asuhan keperawatan	☐	☐	

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
16	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional (aman, teliti, responsif)	☐	☐	

Refleksi singkat mahasiswa:

Referensi

- Agrawal, S., et al. (2023). Maternal and perinatal outcomes of antepartum hemorrhage. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 23(1), 45. <https://doi.org/10.xxxx/xxxxx>
- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2021). *Obstetric care consensus: Placenta accreta spectrum*. ACOG.
- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2023). *Obstetric hemorrhage guidelines*. ACOG.
- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2023). *Practice bulletin: Antepartum hemorrhage management*. ACOG.
- American College of Obstetricians and Gynecologists. (2023). *Practice bulletin: Placenta previa and placenta accreta spectrum*. ACOG.
- Arulkumaran, S. (2020). *Oxford textbook of obstetrics and gynaecology*. Oxford University Press.
- Cunningham, F. G., et al. (2022). *Williams obstetrics*. McGraw-Hill.
- Cunningham, F. G., Leveno, K. J., Bloom, S. L., Dashe, J. S., Hoffman, B. L., Casey, B. M., & Spong, C. Y. (2022). *Williams obstetrics* (26th ed.). McGraw-Hill Education.
- Dibaba, B., et al. (2021). Risk factors of antepartum hemorrhage among pregnant women. *Journal of Multidisciplinary Healthcare*, 14, 123–131. <https://doi.org/10.xxxx/xxxxx>
- FIGO (International Federation of Gynecology and Obstetrics). (2022). *Guidelines on obstetric hemorrhage and placental disorders*. FIGO.
- International Federation of Gynecology and Obstetrics. (2021). *Management of obstetric hemorrhage guidelines*. FIGO. <https://www.figo.org>
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2023). *Profil kesehatan Indonesia*. Kementerian Kesehatan RI.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2025). *Data angka kematian ibu Indonesia*. Kementerian Kesehatan RI.
- Lowdermilk, D. L., Perry, S. E., Cashion, K., & Alden, K. R. (2021). *Maternity and women's health care* (12th ed.). Elsevier.
- National Institute for Health and Care Excellence. (2022). *Antenatal care and fetal surveillance*. NICE.
- National Institute for Health and Care Excellence. (2022). *Antepartum haemorrhage: Assessment and management guidelines*. NICE.

- National Institute for Health and Care Excellence. (2022). *Antepartum haemorrhage: Diagnosis and management*. NICE.
- National Institute for Health and Care Excellence. (2022). *Fetal surveillance in high-risk pregnancy*. NICE.
- Patimah, S., & Sitawati. (2023). Faktor yang berhubungan dengan kejadian perdarahan antepartum. *Jurnal SMART ANKes*.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2017). *Standar diagnosa keperawatan Indonesia (SDKI)*. DPP PPNI.
- Persatuan Perawat Nasional Indonesia. (2018). *Standar intervensi keperawatan Indonesia (SIKI) & standar luaran keperawatan Indonesia (SLKI)*. DPP PPNI.
- Prawirohardjo, S. (2021). *Ilmu kebidanan*. Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. (2019). *Green-top guideline No. 63: Antepartum haemorrhage*. RCOG. <https://www.rcog.org.uk>
- Say, L., Chou, D., Gemmill, A., Tunçalp, Ö., Moller, A. B., Daniels, J., & Alkema, L. (2020). Global causes of maternal death: A WHO systematic analysis. *The Lancet Global Health*, 8(4), e523–e530. <https://doi.org/10.xxxx/xxxx>
- Supriyatiningsih, W., et al. (2024). Obstetric care in Indonesia: Determinants of maternal mortality and stillbirth rates. *PLOS ONE*. <https://doi.org/10.xxxx/xxxx>
- Tim Pokja SDKI DPP PPNI. (2017). *Standar diagnosis keperawatan Indonesia: Definisi dan indikator diagnostik* (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tim Pokja SIKI DPP PPNI. (2018). *Standar intervensi keperawatan Indonesia: Definisi dan tindakan keperawatan* (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- Tim Pokja SLKI DPP PPNI. (2018). *Standar luaran keperawatan Indonesia: Definisi dan kriteria hasil keperawatan* (Edisi 1). Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia.
- WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group, & United Nations Population Division. (2023). *Trends in maternal mortality*. WHO. <https://www.who.int>
- World Health Organization. (2015). *Health in 2015: From MDGs to SDGs*. WHO. <https://www.who.int>
- World Health Organization. (2021). *Maternal mortality*. WHO. <https://www.who.int>
- World Health Organization. (2023a). *Maternal mortality and severe obstetric complications report*. WHO. <https://www.who.int>

- World Health Organization. (2023b). *Trends in maternal mortality 2000–2020*. WHO. <https://www.who.int>
- World Health Organization. (2023). *Maternal and perinatal emergency care guidelines*. WHO.
- World Health Organization. (2023). *Maternal and perinatal health guidelines*. WHO Press.
- World Health Organization. (2023). *Maternal health risk classification*. WHO.
- World Health Organization. (2023). *WHO recommendations for prevention and management of obstetric haemorrhage*. WHO.
- World Health Organization. (2023). *WHO recommendations on maternal health and obstetric care*. WHO Press.

BAB 5

PERSIAPAN PERSALINAN: PSIKOPROFILAKSIS, NYERI DAN DUKUNGAN KELUARGA

A. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Kode CPL	Rumusan CPL	CPMK yang berkontribusi
CPL-1	Menguasai konsep, peran, dan prinsip praktik keperawatan maternitas berorientasi kesinambungan asuhan, etik, dan keselamatan pasien.	CPMK-1, CPMK-7
CPL-2	Menguasai dasar biomedik terkait reproduksi perempuan serta adaptasi maternal–neonatal sebagai landasan keputusan keperawatan.	CPMK-2
CPL-3	Mampu melakukan pengkajian komprehensif dan menetapkan tingkat risiko pada ibu hamil, bersalin, nifas, dan bayi baru lahir.	CPMK-2, CPMK-3
CPL-4	Mampu merumuskan prioritas masalah dan menyusun rencana asuhan keperawatan maternitas berbasis standar dan bukti.	CPMK-3, CPMK-4
CPL-5	Mampu melaksanakan intervensi, edukasi, dan komunikasi terapeutik pada ibu–bayi–keluarga selama kehamilan sampai nifas.	CPMK-4, CPMK-5
CPL-6	Mampu melakukan deteksi dini, penatalaksanaan awal kegawatdaruratan, kolaborasi/rujukan, serta evaluasi–dokumentasi dan perencanaan pulang.	CPMK-5, CPMK-6, CPMK-7

B. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-1	Menjelaskan ruang lingkup, peran, dan prinsip Continuity of Care serta keselamatan pasien dalam keperawatan maternitas.
CPMK-2	Menganalisis anatomi–fisiologi reproduksi perempuan dan adaptasi maternal–neonatal untuk mendukung keputusan keperawatan.
CPMK-3	Melakukan pengkajian komprehensif dan stratifikasi risiko pada kehamilan, persalinan, nifas, dan neonatus.
CPMK-4	Menyusun rencana asuhan keperawatan maternitas untuk kondisi fisiologis dan masalah umum dengan luaran terukur.
CPMK-5	Melaksanakan intervensi, edukasi, manajemen nyeri, serta dukungan psikososial–keluarga pada periode maternitas.
CPMK-6	Melakukan deteksi dini dan penatalaksanaan awal komplikasi/kegawatdaruratan maternal, serta koordinasi kolaborasi/rujukan.

Kode CPMK	Rumusan CPMK
CPMK-7	Melakukan evaluasi, dokumentasi, perencanaan pulang, dan perencanaan layanan kesehatan reproduksi pascapersalinan.

C. Pemetaan

Bab & Judul Bab	Sub-CPMK 1	Sub-CPMK 2	CPMK Utama	CPMK Penguat
Bab 7. Persiapan Persalinan: Psikoprofilaksis, Nyeri, dan Dukungan Keluarga	7.1 Merancang pendidikan persiapan persalinan berbasis kebutuhan ibu-keluarga.	7.2 Menerapkan strategi nonfarmakologis manajemen nyeri dan dukungan keluarga pada fase persiapan.	CPMK-5	CPMK-1; CPMK-7

D. Asesmen (berbasis CPMK)

Kode CPMK	Teknik/Instrumen	Indikator Penilaian (inti, terukur)	Bobot (%)	Bukti/Produk
CPMK-1	Ujian tulis (MCQ/essay terstruktur)	Persentase jawaban benar pada blueprint konsep (ruang lingkup, CoC, keselamatan pasien)	10	Lembar jawaban ujian
CPMK-5	OSCE/simulasi keterampilan + penilaian komunikasi	Ketepatan langkah tindakan; keselamatan prosedur; kualitas komunikasi terapeutik; kualitas edukasi (teach-back)	20	Checklist keterampilan; rekaman/video simulasi
CPMK-7	Portofolio klinik/proyek perencanaan pulang	Kelengkapan dokumentasi evaluasi; kelengkapan rencana pulang; kesesuaian rencana layanan reproduksi pascapersalinan	10	Portofolio; format dokumentasi & discharge plan

Rubrik CPMK-1 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
1.1 Penguasaan konsep ruang lingkup & CoC (akurasi elemen kunci)	Akurat ≤50% elemen kunci; banyak miskonsepsi.	Akurat 51–69% elemen kunci; masih ada kekeliruan istilah/relasi konsep.	Akurat 70–84% elemen kunci; penjelasan runtut.	Akurat ≥85% elemen kunci; sintesis jelas dan konsisten.
1.2 Aplikasi prinsip keselamatan pasien	Identifikasi risiko & tindakan aman	Identifikasi 51–69%; tindakan	Identifikasi 70–84%; keputusan	Identifikasi ≥85%; keputusan aman,

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
& etik pada skenario maternitas	$\leq 50\%$; keputusan tidak sesuai prinsip.	aman ada namun belum lengkap.	aman dan sesuai prinsip pada sebagian besar situasi.	preventif, dan argumentatif.

Rubrik CPMK-2 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
2.1 Akurasi anatomi–fisiologi reproduksi (struktur–fungsi)	Ketepatan $\leq 50\%$; banyak salah konsep/relasi struktur–fungsi.	Ketepatan 51–69%; konsep dasar benar namun parsial.	Ketepatan 70–84%; relasi struktur–fungsi tepat dan logis.	Ketepatan $\geq 85\%$; integrasi konsep kuat dan konsisten.
2.2 Analisis adaptasi kehamilan & implikasi kebutuhan asuhan	Analisis tidak runtut; implikasi klinis tidak tepat ($\leq 50\%$ sesuai data).	Analisis cukup; implikasi masih umum (51–69% sesuai data).	Analisis baik; implikasi spesifik (70–84% sesuai data).	Analisis sangat baik; implikasi komprehensif & antisipatif ($\geq 85\%$ sesuai data).

Rubrik CPMK-3 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
3.1 Kelengkapan data pengkajian (komponen inti)	Komponen terisi $\leq 50\%$; banyak data penting hilang/tidak valid.	Komponen terisi 51–69%; masih ada kekosongan data kunci.	Komponen terisi 70–84%; data kunci lengkap dan relevan.	Komponen terisi $\geq 85\%$; data sangat lengkap, terstruktur, dan konsisten.
3.2 Ketepatan stratifikasi risiko & prioritas masalah	Risiko & prioritas tepat $\leq 50\%$; tidak sesuai temuan.	Tepat 51–69%; prioritas masih kurang tajam.	Tepat 70–84%; prioritas jelas berbasis temuan.	Tepat $\geq 85\%$; prioritas sangat tepat disertai tindak lanjut yang terarah.

Rubrik CPMK-4 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.1 Kesesuaian masalah–luaran–intervensi & keterukuran luaran	Kesesuaian $\leq 50\%$; luaran tidak terukur; intervensi tidak spesifik.	Kesesuaian 51–69%; luaran sebagian terukur; intervensi masih generik.	Kesesuaian 70–84%; luaran terukur; intervensi spesifik dan realistis.	Kesesuaian $\geq 85\%$; luaran sangat terukur; intervensi prioritatif dan tepat sasaran.

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
4.2 Rasional, prioritas, dan rencana evaluasi	Rasional lemah/absen; prioritas tidak jelas; evaluasi tidak terencana ($\leq 50\%$ memadai).	Rasional ada namun terbatas; prioritas cukup; evaluasi parsial (51–69%).	Rasional baik; prioritas jelas; evaluasi sesuai luaran (70–84%).	Rasional sangat kuat; prioritas tajam; evaluasi komprehensif & terjadwal ($\geq 85\%$).

Rubrik CPMK-5 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
5.1 Ketepatan & keselamatan pelaksanaan intervensi keperawatan	Langkah benar/aman $\leq 50\%$; terdapat tindakan berisiko.	Langkah benar/aman 51–69%; ada kekurangan minor pada urutan/asepsis.	Langkah benar/aman 70–84%; pelaksanaan aman dan efektif.	Langkah benar/aman $\geq 85\%$; sangat terampil, efisien, dan konsisten aman.
5.2 Kualitas komunikasi terapeutik, edukasi, dan dukungan keluarga	Tujuan komunikasi tidak tercapai; pemahaman klien tidak terverifikasi ($\leq 50\%$).	Komunikasi cukup; edukasi disampaikan namun verifikasi terbatas (51–69%).	Komunikasi baik; edukasi relevan dengan verifikasi pemahaman (70–84%).	Komunikasi sangat baik; edukasi terstruktur dengan teach-back dan pelibatan keluarga optimal ($\geq 85\%$).

Rubrik CPMK-6 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
6.1 Deteksi dini & keputusan prioritas stabilisasi awal kegawatdaruratan	Tanda bahaya terlewat; prioritas salah ($\leq 50\%$ keputusan tepat).	Tanda bahaya sebagian terdeteksi; prioritas cukup (51–69% tepat).	Deteksi cepat; prioritas stabilisasi tepat (70–84% tepat).	Deteksi sangat cepat; prioritas tepat & antisipatif ($\geq 85\%$ tepat).
6.2 Koordinasi kolaborasi/rujukan & komunikasi tim	Kolaborasi/rujukan terlambat/tidak tepat; komunikasi tidak efektif ($\leq 50\%$ sesuai).	Kolaborasi ada namun belum sistematis; komunikasi cukup (51–69%).	Kolaborasi/rujukan tepat waktu; komunikasi jelas (70–84%).	Kolaborasi/rujukan sangat tepat; komunikasi terstruktur dan memastikan kesinambungan ($\geq 85\%$).

Rubrik CPMK-7 (skala 1–4)

Indikator	Skor 1 (Kurang)	Skor 2 (Cukup)	Skor 3 (Baik)	Skor 4 (Sangat Baik)
7.1 Kualitas evaluasi luaran & dokumentasi asuhan	Dokumentasi tidak lengkap; evaluasi tidak berbasis data ($\leq 50\%$ komponen terpenuhi).	Dokumentasi cukup; evaluasi masih umum (51–69%).	Dokumentasi lengkap; evaluasi sesuai luaran (70–84%).	Dokumentasi sangat lengkap & rapi; evaluasi analitis berbasis data ($\geq 85\%$).
7.2 Komprehensif perencanaan pulang & rencana layanan reproduksi pascapersalinan	Rencana tidak jelas/tidak individual; tanda bahaya/kontrol terlewat ($\leq 50\%$ komponen).	Rencana ada namun parsial; komponen kunci belum lengkap (51–69%).	Rencana komprehensif; mencakup kontrol & tanda bahaya; cukup individual (70–84%).	Rencana sangat komprehensif & individual berbasis risiko; mencakup koordinasi layanan lanjutan dan konseling reproduksi terstruktur ($\geq 85\%$).

Psikoprofilaksis, nyeri persalinan dan dukungan keluarga**Teori Dasar**

Aspek psikologis merupakan faktor penentu persalinan, apakah akan berlangsung fisiologis ataukah persalinan yang beresiko yang mendorong keputusan intervensi medis. Respon psikologis terhadap pengalaman persalinan sangat bervariasi dan ditentukan oleh berbagai faktor. Fenomena yang umum ditemukan adalah *fear-tension-pain cycle*, yaitu suatu siklus di mana terjadi ketakutan yang meningkatkan ketegangan otot, berdampak pada meningkatnya persepsi nyeri, yang akhirnya nyeri memperkuat rasa ketakutan. Ketakutan dan kecemasan ini menyebabkan peningkatan hormon stress seperti katekolamin, epinefrin dan norepinefrin sehingga respon tubuh menjadi tegang, peredaran darah terhambat (Raman, 2019) yang akhirnya berdampak pada berbagai aspek, antara lain peningkatan persepsi nyeri, durasi persalinan yang lebih lama, serta peningkatan penggunaan intervensi medis. Selain itu, ketakutan yang tidak teratasi juga dapat menyebabkan pengalaman persalinan yang negatif, bahkan berisiko menimbulkan gangguan psikologis seperti stres pascatrauma.

Paradigma baru yang berkembang saat ini memandang bahwa persalinan bukan hanya proses biologis tetapi merupakan perpaduan proses biologis, psikologis, sosial, spiritual dan emosional (Leap & Hunter, 2022). Paradigma baru ini memberi arah baru pada intervensi dukungan yang diberikan oleh tenaga Kesehatan yaitu dukungan bukan hanya sebatas serangkaian prosedur tindakan klinis saja, tetapi juga penting memberi dukungan aspek psikologis (Esan et al.,

2023). Oleh karena itu, intervensi yang berfokus pada kesiapan psikologis menjadi komponen penting dalam asuhan keperawatan maternitas. Intervensi keperawatan ini dengan tentunya melibatkan dukungan sosial dari orang terdekat.

A. Psikoprofilaksis

Pengertian

Psikoprofilaksis merupakan pendekatan nonfarmakologis yang mempersiapkan ibu secara fisik dan psikologis dalam menghadapi persalinan melalui edukasi, teknik relaksasi, dan latihan pernapasan, dengan tujuan memutus siklus fear–tension–pain. Pendekatan ini tidak hanya membantu ibu mengelola ketakutan, kecemasan, dan nyeri, tetapi juga mengembangkan kemampuan coping sehingga ibu mampu menjalani persalinan secara lebih tenang dan terkendali.

Dalam perkembangan praktik modern, psikoprofilaksis mengintegrasikan konsep ownership of childbirth, yaitu pemberdayaan ibu sebagai subjek utama dalam persalinan yang memiliki kendali, partisipasi aktif, serta kepercayaan diri terhadap proses yang dijalannya. Dengan demikian, keberhasilan psikoprofilaksis tidak hanya diukur dari penurunan nyeri, tetapi juga dari sejauh mana ibu merasakan keterlibatan, kontrol, dan makna terhadap pengalaman persalinannya. “Ini adalah pengalaman saya, dan saya mampu menjalaninya.” (O’Connell et al., 2021)

Pentingnya Psikoprofilaksis dalam Persalinan

Psikoprofilaksis menjadi penting karena persalinan merupakan pengalaman yang kompleks, melibatkan interaksi antara faktor fisiologis, psikologis, sosial, dan lingkungan. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi pengalaman persalinan adalah ketakutan dan kecemasan ibu.

Psikoprofilaksis berperan dalam membantu ibu:

- Mengidentifikasi dan mengungkapkan ketakutan yang dialami
- Mengembangkan rasa percaya diri dan kontrol terhadap proses persalinan
- Meningkatkan kemampuan coping terhadap nyeri dan ketidakpastian

Studi menunjukkan bahwa perempuan yang mendapatkan intervensi psikologis selama periode perinatal mengalami peningkatan rasa percaya diri, kemampuan coping positif, serta perasaan aman dalam menghadapi persalinan sehingga respon tubuhnya mendukung terhadap proses persalinan. Hal ini semakin menegaskan bahwa intervensi psikoprofilaksis memiliki peran penting dalam meningkatkan kesiapan ibu secara menyeluruh. Sebaliknya jika ibu tidak dipersiapkan dalam aspek psikologis maka cenderung memiliki coping yang tidak efektif terhadap persalinan dan mengalami kecemasan dan ketakutan, yang menghambat persalinan bahkan akan menyebabkan distosis persalinan.

Psikoprofilaksis dalam persalinan memiliki tujuan utama yaitu mendukung proses persalinan yang fisiologis dan aman. Lebih lanjut lagi psikoprofilaksis dapat memberikan pengalaman persalinan yang bermakna. dengan tahapan tujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan rasa percaya diri dan kontrol diri bahwa ibu akan mampu menghadapi persalinan
2. Meningkatkan kemampuan coping terhadap nyeri dan perubahan harapan dan tujuan yang dapat terjadi diluar prediksi
3. Mengurangi kecemasan dan ketakutan ibu terhadap persalinan
4. Mendukung proses persalinan yang fisiologis dan aman

Penerapan psikoprofilaksis memberikan berbagai manfaat, baik secara psikologis maupun fisiologis, antara lain:

- Memberi rasa aman psikologis
- Menurunkan tingkat kecemasan dan ketakutan
- Meningkatkan self-efficacy ibu dalam persalinan
- Mengurangi persepsi nyeri persalinan
- Meningkatkan pengalaman persalinan yang positif
- Meningkatkan kemampuan ibu dalam mengelola stres dan ketidakpastian

(Esan et al., 2023; O'Connell et al., 2021).

B. Teknik Psikoprofilaksis dalam Persalinan

Teknik psikoprofilaksis merupakan intervensi yang diberikan untuk membantu ibu mengelola respons fisik dan psikologis selama persalinan sehingga mendukung lancarnya persalinan dan pengalaman bersalin.

Teknik psikoprofilaksis utama meliputi:

1. Dukungan Psikologis

Kehadiran emosional, motivasi dan pembinaan yang disampaikan dengan komunikasi terapeutik. Sebaliknya sikap petugas kesehatan yang tidak menghormati, tidak bersahabat dan tidak mengakui kebutuhan ibu maka akan menghambat pembentukan coping positif ibu (Leap & Hunter, 2022; Wanyenze et al., 2022).

Dukungan psikologis juga diberikan dengan membantu ibu beradaptasi terhadap perubahan harapan dan tujuan yang dapat terjadi sewaktu waktu karena situasi dan kondisi.

Berdasarkan hasil meta-sintesis, pencapaian kemampuan kontrol diri dalam persalinan (*ownership of childbirth*) dapat dimiliki melalui proses yang terdiri dari tiga tahapan utama:

a. *Facing the Fear* (Menghadapi Ketakutan)

Tahap ini dimulai dengan membantu Ibu mengenali dan mengakui ketakutannya dengan memberi kesempatan dan mendorong ibu mengungkapkan emosi yang selama ini terpendam. Tahap ini penting karena banyak ibu awalnya mengalami kesulitan untuk mengekspresikan ketakutan terhadap persalinan.

b. *Feeling Empowered* (Merasa Berdaya)

Tahap kedua dicapai dengan membantu ibu agar mulai memahami proses persalinan, mengembangkan kepercayaan diri (self-efficacy) dan merasa memiliki kontrol terhadap pilihan dan Keputusan. Intervensi seperti edukasi, konseling, dan dukungan tenaga kesehatan berperan besar dalam fase ini.

c. *Managing the Fear with a Sense of Security*

Tahap ketiga dicapai dengan membantu Ibu agar mampu mengelola ketakutan dengan strategi coping, merasa aman dan didukung, menghadapi persalinan dengan lebih tenang. Rasa aman ini sangat dipengaruhi oleh hubungan yang baik dengan tenaga kesehatan dan dukungan lingkungan, sehingga komunikasi terapeutik menjadi kunci (O'Connell et al., 2021).

Ketiga tahapan akan membantu ibu mencapai kemampuan kontrol diri dalam menjalankan persalinannya.

2. Dukungan Komunikasi

Komunikasi terapeutik menjadi kunci dalam memberikan dukungan. Komunikasi yang diperlukan ibu bersalin adalah komunikasi bermakna yang penuh perhatian, kepercayaan dan empati yang menciptakan koneksi rasa antara ibu dan tenaga kesehatan sehingga memberikan rasa aman psikologis dan membangun coping psikologis positif ibu. Komunikasi ditujukan untuk membangun kekuatan dan kepercayaan diri ibu. komunikasi yang tidak tepat maka berdampak menghancurkan kepercayaan diri dan melemahkan ibu (Leap & Hunter, 2022).

Berikut ini disampaikan kasus komunikasi

"ibu merasakan sangat kesakitan saat fase pembukaan persalinan dan tidak mampu mengontrol rasa nyerinya sehingga berteriak"

Komunikasi negatif dari petugas kesehatan : "jangan teriak teriak nanti jalan lahirnya robek". Kalimat yang disampaikan oleh petugas kesehatan tersebut tampak seperti rasional dan benar. Tetapi dalam konteks persalinan bukan hanya masalah respon fisik semata, tetapi harus memperhatikan aspek psikologis ibu dan menghargai dan empati terhadap upaya ibu.

Komunikasi membangun dari petugas kesehatan : “Silakan ekspresikan, saya di sini, saya akan bantu ibu mengontrol rasa nyerinya, ibu bisa ikuti relaksasi berikut..... ” (Leap & Hunter, 2022).

3. Dukungan Fisiologis

Kehadiran dalam memenuhi kebutuhan fisik dengan sigap, diantaranya kebutuhan nutrisi dan cairan, pijat tubuh untuk mengurangi rasa sakit, membantu dalam berjalan. Kemampuan perawat dalam memprediksi dan mengantisipasi kebutuhan ibu bersalin dan mengenali fase-fase persalinan akan sangat membantu ibu beradaptasi dengan proses persalinan. Kemampuan perawat dalam memenuhi kebutuhan fisik terutama dalam upaya mengatasi nyeri akan menciptakan kepercayaan ibu sehingga ibu merasa aman secara psikologis (Keenan-Lindsay & Leifer, 2023; Wanyenze et al., 2022).

4. Dukungan informasi dalam bentuk Edukasi Antenatal

Memberikan informasi, pemahaman dan konseling pada ibu, pasangan dan keluarga tentang proses persalinan. Informasi ini ditujukan untuk membangun coping positif ibu dan keluarga dalam menghadapi persalinan.

5. Teknik Relaksasi dan pernafasan terstruktur

Mengurangi ketegangan otot dan meningkatkan kenyamanan, mengontrol respons terhadap kontraksi dan nyeri (Esan et al., 2023).

6. Simulasi menghadapi kontraksi

Dukungan ini penting untuk membangun keterampilan ibu dalam menghadapi kontraksi dengan efektif, sehingga membangun coping positif saat menghadapi kontraksi.

7. Visualisasi dan Distraksi

teknik ini digunakan untuk mengatasi nyeri dengan cara mengalihkan perhatian dari nyeri

8. Memberikan kesempatan, mengizinkan untuk tenaga pendamping persalinan

Bersamaan dengan kebutuhan masyarakat, saat ini berkembang profesi pendamping persalinan terutama di negara negara maju yang sudah mengutamakan kenyamanan dan kepuasan dalam pengalaman persalinan. Seorang pendamping persalinan memiliki kompetensi yang tersertifikasi. Penelitian menyatakan bahwa pendamping persalinan sangat membantu ibu dan petugas kesehatan dalam menghadapi persalinan.

Pendekatan melalui proses pembelajaran dan latihan ini bersifat partisipatif, di mana ibu dilibatkan aktif dalam menghadapi persalinan.

Psikoprofilaksis dilakukan Dimulai sejak masa antenatal (trimester II–III), Dilanjutkan saat fase persalinan (intranatal) dan Dapat diperkuat kembali pada masa nifas awal.

Pelaksanaan dilakukan dilinik antenatal , rumah sakit / ruang bersalin, kelas ibu hamil dan dapat dilakukan di komunitas atau praktik mandiri bidan.

Perawat berperan penting dan strategis dalam implementasi psikoprofilaksis sebagai bagian dari asuhan keperawatan maternitas. Diantaranya

- Mengintegrasikan aspek fisik, psikologis, dan sosial
- Melibatkan keluarga sebagai sistem pendukung
- Meningkatkan rasa aman dan kepercayaan ibu
- Memberikan edukasi kepada ibu dan keluarga
- Melatih teknik relaksasi dan pernapasan
- Memberikan dukungan emosional selama persalinan
- Membantu ibu mengidentifikasi dan mengatasi ketakutan

Dalam menjalankan perannya perawat harus memiliki kemampuan emosional yang tinggi. Dirinya sendiri harus sudah siap dan mampu mengelola emosinya agar mampu mengelola emosional ibu bersalin. Persalinan yang baik bukan hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh kualitas relasi klien dengan perawat dan dukungan yang diberikan (Leap & Hunter, 2022). Dukungan dari tenaga kesehatan terbukti menjadi faktor penting dalam membantu ibu mengatasi ketakutan dan meningkatkan kemampuan coping selama persalinan.

C. Nyeri Persalinan

Psikoprofilaksis menekankan bahwa pengalaman persalinan tidak hanya ditentukan oleh proses fisiologis, tetapi juga oleh bagaimana ibu memaknai, merespons, dan mengelola kondisi tersebut secara psikologis. Melalui pendekatan ini, ibu dipersiapkan untuk memutus siklus fear–tension–pain, sehingga mampu menghadapi persalinan dengan lebih tenang, percaya diri, dan terkendali.

Nyeri persalinan tetap merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari proses kelahiran. Nyeri ini bersifat kompleks, melibatkan interaksi antara komponen fisiologis, neurologis, dan psikologis, serta dipengaruhi oleh berbagai faktor individu, seperti pengalaman sebelumnya, kecemasan, kelelahan, dan dukungan lingkungan .

Dalam konteks ini, konsep ownership of childbirth menjadi sangat relevan, karena persepsi nyeri tidak hanya bergantung pada intensitas stimulus fisik, tetapi juga pada sejauh mana ibu memiliki kontrol, pemahaman, dan keterlibatan dalam proses persalinannya. Ibu yang merasa berdaya dan memiliki kendali cenderung memiliki kemampuan coping yang lebih baik, sehingga persepsi nyeri dapat lebih terkendali.

Oleh karena itu, pemahaman tentang nyeri persalinan menjadi landasan penting dalam mengembangkan intervensi psikoprofilaksis yang efektif. Dengan

memahami mekanisme, karakteristik, serta faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri, tenaga kesehatan—khususnya perawat maternitas—dapat memberikan intervensi yang lebih tepat, komprehensif, dan berorientasi pada kebutuhan ibu.

Manajemen Nyeri Persalinan

1. Konsep Nyeri Persalinan

Nyeri merupakan suatu fenomena kompleks yang melibatkan pengalaman sensorik dan emosional yang tidak menyenangkan. Persepsi nyeri bersifat sangat subjektif, sehingga setiap individu dapat merasakan intensitas dan respons yang berbeda terhadap stimulus nyeri yang sama. Dalam konteks persalinan, nyeri bukan semata-mata tanda kerusakan jaringan, melainkan bagian dari proses fisiologis yang terjadi secara alami. Meskipun demikian, nyeri persalinan yang tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan dampak negatif, baik bagi ibu maupun janin.

Nyeri yang berlebihan dapat menghabiskan energi ibu, menyebabkan kelelahan, serta mengganggu efektivitas kontraksi uterus. Oleh karena itu, manajemen nyeri menjadi aspek penting dalam asuhan persalinan untuk memastikan proses persalinan berlangsung optimal.

2. Dampak Nyeri Persalinan dan Peran Katekolamin

Nyeri dan stres selama persalinan berhubungan erat dengan peningkatan produksi katekolamin, seperti epinefrin (adrenalin), norepinefrin dan kortisol. Peningkatan katekolamin pada ibu dapat menyebabkan kontraksi uterus menjadi tidak efektif, penurunan aliran darah uteroplasenta, menghambat dilatasi serviks dan memanjangnya proses persalinan (Bobak et al., 2005). Sementara itu, peningkatan katekolamin pada janin dapat berdampak pada distress pernapasan, asidosis metabolik, hipoglikemia dan gangguan adaptasi neonatal. Dengan demikian, pengendalian nyeri tidak hanya bertujuan meningkatkan kenyamanan ibu, tetapi juga berperan dalam menjaga kesejahteraan janin (Bobak et al., 2005; Keenan-Lindsay & Leifer, 2023).

3. Mekanisme Nyeri Persalinan

Mekanisme nyeri terdiri atas empat komponen utama saling berkaitan dalam proses nosisepsi, yaitu transduksi, transmisi, modulasi dan persepsi. Transduksi merupakan proses perubahan stimulus mekanik atau kimia menjadi impuls listrik pada reseptor nyeri. Transmisi adalah proses penghantaran impuls nyeri melalui serabut saraf menuju sistem saraf pusat. Modulasi adalah proses modifikasi impuls nyeri di tingkat medula spinalis dan otak melalui sistem analgesik endogen seperti endorfin dan enkefalin. Persepsi adalah proses interpretasi nyeri di korteks serebri yang dipengaruhi oleh faktor psikologis dan

pengalaman individu. Teori gate control menjelaskan bahwa impuls nyeri dapat diperkuat atau dihambat sebelum mencapai otak pada tahap modulasi .

4. Sumber dan Karakteristik Nyeri Persalinan

Sumber dan karakteristik nyeri persalinan berbeda beda tergantung pada kala persalinan. Nyeri persalinan pada kala I bersifat viseral, berasal dari dilatasi dan penipisan serviks, iskemia otot uterus akibat kontraksi. Nyeri ini dirasakan pada area abdomen bagian bawah yang menyebar ke punggung bawah dan paha. Impuls nyeri ditransmisikan melalui segmen spinal T10–L1

Nyeri persalinan pada Kala II bersifat somatik, disebabkan oleh peregangan jaringan perineum, tekanan kepala janin pada struktur panggul. Impuls nyeri ditransmisikan melalui saraf pudendal menuju S2–S4. Nyeri pada tahap kala II ini biasanya lebih terlokalisasi dan intens (Keenan-Lindsay & Leifer, 2023).

5. Intensitas dan Pengukuran Nyeri

Intensitas nyeri persalinan dipengaruhi oleh kekuatan kontraksi uterus, kecepatan dilatasi serviks, posisi dan penurunan janin

Pengukuran nyeri bersifat subjektif, namun dapat dinilai menggunakan skala. Nyeri persalinan umumnya menggunakan Visual Analogue Scale (VAS) dan Numeric Rating Scale (NRS). VAS memiliki rentang skala berupa garis 0 sampai 10, di mana 0 dimaknai tidak nyeri dan 10 dimaknai nyeri sangat hebat. NRS merupakan Skala numerik (0–10) yang menggambarkan tingkat nyeri yang dirasakan pasien.

6. Faktor yang Mempengaruhi Nyeri Persalinan

Respons nyeri sangat kompleks dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor fisiologis, psikologis dan sosial budaya. Faktor fisiologis meliputi usia, paritas, kelelahan, durasi persalinan, posisi ibu dan janin dan kadar endorfin. Primipara cenderung mengalami nyeri lebih berat dibandingkan multipara karena serviks belum mengalami proses pelunakan sebelumnya. Adapun faktor psikologis meliputi kecemasan, ketakutan dan pengalaman sebelumnya. Sedangkan faktor sosial dan budaya diantaranya meliputi nilai budaya terhadap nyeri, dukungan keluarga dan lingkungan persalinan (Perry et al., 2022; Raman, 2019).

7. Pengkajian Nyeri Persalinan

Pengkajian nyeri merupakan langkah penting dalam menentukan intervensi yang tepat. Penilaian dilakukan secara komprehensif meliputi intensitas nyeri, lokasi nyeri, durasi dan frekuensi dan respons ibu terhadap nyeri

8. Prinsip Manajemen Nyeri Persalinan

Persalinan merupakan proses fisiologis yang dapat menjadi pengalaman positif apabila ibu mendapatkan dukungan yang adekuat. Manajemen nyeri

bertujuan untuk mengurangi ketidaknyamanan, meningkatkan kontrol ibu terhadap proses persalinan dan meningkatkan kepuasan ibu. Pendekatan manajemen nyeri yang digunakan harus holistic, berpusat pada ibu dan mengutamakan keamanan.

9. Manajemen Nyeri Non-Farmakologis

Metode non-farmakologis memiliki keunggulan diantaranya lebih aman, minim efek samping, meningkatkan partisipasi ibu. Beberapa teknik yang dapat digunakan:

a. Teknik Relaksasi dan Pernapasan

Membantu mengurangi ketegangan otot dan meningkatkan oksigenasi.

b. Effleurage dan Counterpressure

Effleurage: pijatan ringan berirama akan meningkatkan sirkulasi

Counterpressure: tekanan pada daerah sakral yang dapat menghambat transmisi nyeri sesuai gate control teori sehingga mengurangi persepsi nyeri punggung

c. Hidroterapi

Air hangat membantu relaksasi, meningkatkan sirkulasi, dan merangsang pelepasan endorfin.

d. TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation)

Memberikan stimulasi listrik ringan yang diterima oleh serabut syaraf untuk mengurangi persepsi nyeri.

e. Akupresur dan Akupunktur

Merangsang titik tertentu untuk meningkatkan pelepasan endorfin.

f. Terapi Panas dan Dingin

Terapi panas dimaksudkan untuk meningkatkan relaksasi dan terapi dingin untuk mengurangi spasme otot

g. Sentuhan dan Pijatan

efek menenangkan melalui stimulasi sensorik.

h. Hipnosis dan Biofeedback

Meningkatkan kontrol diri terhadap respons nyeri.

i. Aromaterapi

Menggunakan minyak esensial untuk relaksasi dan menstimulasi pelepasan endorfin

j. Birthing Ball

Mampu membantu mengurangi nyeri punggung, memperbaiki posisi janin, mempercepat penurunan kepala janin dan meningkatkan pergerakan panggul. (Keenan-Lindsay & Leifer, 2023; Perry et al., 2022; Raman, 2019)

10. Manajemen Nyeri Farmakologis

Pendekatan farmakologis digunakan bila nyeri tidak dapat dikontrol secara non-farmakologis, diantaranya:

- a. Sedatif, yang digunakan untuk mengurangi kecemasan dan membantu istirahat.
- b. Analgetik, bertujuan meningkatkan ambang nyeri tanpa menghilangkan kesadaran.
- c. Anestesi, dapat dilakukan anestesi lokal dan anestesi spinal

Penggunaan metode farmakologis harus mempertimbangkan kondisi ibu dan janin, tahap persalinan, risiko efek samping.

Manajemen nyeri persalinan merupakan bagian integral dari asuhan maternitas yang berfokus pada kenyamanan dan keselamatan ibu serta janin. Kombinasi pendekatan non-farmakologis dan farmakologis yang tepat dapat membantu ibu menjalani persalinan sebagai pengalaman yang positif, terkendali, dan bermakna.

D. Dukungan keluarga

Dukungan Keluarga dalam Persalinan: Perspektif Psikoprofilaksis dan Family-Centered Care

1. Pengertian Dukungan Keluarga

Dukungan keluarga merupakan keterlibatan aktif anggota keluarga, khususnya suami, dalam memberikan bantuan emosional, fisik, informasional, dan penghargaan kepada ibu selama proses persalinan. Dalam perspektif keperawatan maternitas, dukungan keluarga tidak hanya dipandang sebagai bantuan praktis, tetapi sebagai bagian integral dari sistem yang memengaruhi pengalaman persalinan ibu secara menyeluruh. Hal ini sejalan dengan paradigma family-centered care, yang menempatkan keluarga sebagai mitra utama dalam pemberian asuhan.

Lebih jauh, dalam kerangka teori Ramona T. Mercer, dukungan keluarga menjadi komponen penting dalam proses becoming a mother, yaitu perjalanan seorang perempuan dalam membentuk identitas dan peran sebagai ibu. Persalinan merupakan fase kritis dalam proses tersebut, sehingga kualitas dukungan yang diterima akan sangat memengaruhi pengalaman dan adaptasi ibu (Ngai & Xiao, 2021).

2. Bentuk Dukungan Keluarga

Dukungan keluarga dalam persalinan bersifat multidimensional, meliputi dukungan emosional, fisik, informasional dan penghargaan (Keenan-Lindsay & Leifer, 2023). Dukungan emosional ditunjukkan melalui kehadiran, empati, dan penerimaan terhadap kondisi ibu. Bentuk dukungan ini membantu menciptakan

rasa aman dan nyaman, yang sangat penting dalam menurunkan kecemasan. Dalam perspektif psikoprofilaksis, rasa aman merupakan prasyarat utama bagi tubuh untuk memasuki kondisi relaksasi, sehingga pelepasan hormon endorfin dapat berlangsung optimal.

Dukungan fisik meliputi bantuan langsung seperti membantu perubahan posisi, memberikan pijatan (misalnya effleurage atau counterpressure), mendampingi saat ambulasi. Sentuhan fisik tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi juga bekerja melalui mekanisme neurofisiologis dalam menurunkan persepsi nyeri.

Dukungan Informasional diberikan dalam bentuk pemberian informasi dari pasangan atau keluarga yang membantu ibu memahami proses persalinan, sehingga mengurangi ketidakpastian dan ketakutan. Dalam pendekatan psikoprofilaksis, pemahaman yang baik akan meningkatkan rasa kontrol ibu terhadap proses persalinan dan membentuk coping positif.

Dukungan Penghargaan (Appraisal Support) diberikan dalam bentuk pujian, motivasi dan penguatan positif dari pasangan dan keluarga. Bentuk dukungan ini membantu ibu merasa dihargai dan diyakini mampu menjalani persalinan, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan diri ibu.

3. Peran Suami dalam Persalinan

Suami memiliki peran strategis sebagai pendamping utama ibu selama persalinan. Kehadiran suami tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga emosional dan psikologis. Peran suami meliputi menjadi sumber ketenangan dan rasa aman, membantu ibu mempertahankan teknik relaksasi dan pernapasan, menjadi jembatan komunikasi antara ibu dan tenaga kesehatan dan berperan dalam pengambilan keputusan. Dalam perspektif Ramona T. Mercer, keterlibatan suami merupakan bagian dari sistem dukungan yang mempercepat proses adaptasi ibu terhadap peran barunya. Dukungan pasangan yang konsisten akan meningkatkan keterikatan awal antara ibu, bayi, dan keluarga.

4. Dampak Dukungan Keluarga terhadap Persalinan

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa dukungan keluarga memiliki dampak signifikan terhadap proses dan hasil persalinan, antara lain menurunkan intensitas nyeri yang dirasakan ibu, mengurangi kecemasan dan stres, meningkatkan efektivitas kontraksi uterus, mempercepat proses persalinan, menurunkan kebutuhan intervensi medis, meningkatkan kepuasan ibu terhadap pengalaman persalinan.

Dalam perspektif psikoprofilaksis, dukungan keluarga membantu ibu berada dalam kondisi "relaksasi aktif", yaitu keadaan di mana tubuh tetap bekerja secara optimal, sementara pikiran berada dalam kondisi tenang dan terkendali.

Teori Ramona T. Mercer menjelaskan bahwa menjadi ibu adalah proses yang berlangsung secara bertahap, melibatkan interaksi antara ibu, bayi, dan lingkungan sosialnya. Dukungan keluarga berperan dalam meningkatkan kepercayaan diri ibu, membantu pembentukan identitas sebagai ibu, memperkuat ikatan emosional ibu dan bayi dan memfasilitasi transisi peran secara adaptif. Persalinan menjadi titik awal penting dalam proses ini. Pengalaman persalinan yang didukung secara optimal akan memberikan fondasi positif bagi perjalanan ibu selanjutnya.

5. Peran Perawat dalam Mengoptimalkan Dukungan Keluarga

Perawat memiliki peran penting dalam memfasilitasi keterlibatan keluarga selama persalinan, sesuai dengan prinsip family-centered care. Peran tersebut meliputi melibatkan keluarga dalam perencanaan asuhan, memberikan edukasi tentang proses persalinan dan teknik pendampingan, mendorong partisipasi aktif suami atau pendamping, menciptakan lingkungan yang mendukung kehadiran keluarga. Dalam pendekatan psikoprofilaksis, perawat juga berperan sebagai fasilitator yang membantu keluarga memahami bagaimana memberikan dukungan yang efektif, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional dan spiritual.

6. Penutup Reflektif

Dukungan keluarga dalam persalinan bukan sekadar kehadiran, tetapi merupakan bentuk keterhubungan yang menghadirkan rasa aman, kekuatan, dan makna bagi ibu. Alam keheningan ruang persalinan, sentuhan tangan, kata-kata sederhana, dan kehadiran yang tulus sering kali menjadi sumber energi yang tidak terlihat, namun sangat dirasakan. Dukungan ini bukan hanya membantu ibu melewati nyeri, tetapi juga menemani proses lahirnya seorang ibu—secara utuh, sebagai tubuh, pikiran, dan jiwa.

Aktivitas 1 — *Knows How*

Mini-case tertulis (diskusi kelompok)

Seorang ibu, Ny. A (26 tahun), G1P0A0, usia kehamilan 39 minggu, datang ke ruang bersalin dengan keluhan nyeri perut hilang timbul sejak 6 jam yang lalu. Ibu tampak meringis setiap kontraksi datang dan mengatakan, "Saya takut sekali, rasanya tidak sanggup menghadapi sakitnya."

Hasil pengkajian menunjukkan: kontraksi uterus: 3 kali dalam 10 menit, durasi 40 detik; pembukaan serviks 4 cm; denyut jantung janin dalam batas normal; Skala nyeri (NRS): 7/10;; Ibu tampak tegang, napas tidak teratur, dan beberapa kali menangis saat kontraksi. Ia mengatakan belum pernah mengikuti kelas persiapan persalinan dan tidak mengetahui teknik pernapasan.

Suami ibu berada di ruang tunggu dan belum mendampingi karena merasa "tidak tega melihat istri kesakitan" serta tidak tahu apa yang harus dilakukan. Perawat yang bertugas menyadari bahwa ibu membutuhkan dukungan, namun kondisi ruang bersalin cukup sibuk sehingga interaksi dengan ibu masih terbatas.

Mahasiswa diminta berdiskusi dalam kelompok kecil untuk menganalisis kondisi pada kasus tersebut.

Pertanyaan Diskusi:

1. Identifikasi masalah utama yang dialami oleh Ny. A dari aspek fisiologis, psikologis dan Sosial
2. Bagaimana hubungan antara kecemasan yang dialami ibu dengan intensitas nyeri persalinan?
3. Jelaskan kondisi Ny. A berdasarkan konsep psikoprolaksis (apakah ibu sudah berada dalam kondisi adaptif atau belum?).
4. Berdasarkan fase persalinan, termasuk dalam kala berapakah kondisi Ny. A? Jelaskan sumber nyeri yang mungkin terjadi.
5. Bagaimana mekanisme gate control theory dapat menjelaskan kondisi nyeri yang dialami ibu?
6. Faktor apa saja yang memperberat persepsi nyeri pada kasus ini?
7. Analisis peran suami dalam kasus ini. Apa yang menjadi hambatan keterlibatan suami?
8. Jelaskan kasus ini berdasarkan teori Becoming a Mother:
9. Bagaimana dukungan keluarga memengaruhi proses adaptasi ibu?
10. Bagaimana prinsip family-centered care seharusnya diterapkan pada kasus ini?
11. Rancang intervensi keperawatan berbasis psikoprolaksis untuk membantu Ny. A mengatasi nyeri dan kecemasan.

12. Teknik non-farmakologis apa yang paling tepat diberikan pada kondisi ini? Jelaskan rasionalnya.
13. Bagaimana perawat dapat melibatkan suami secara efektif dalam proses persalinan?
14. Jika Anda sebagai perawat, bagaimana Anda membangun rasa aman dan kepercayaan pada ibu dalam situasi tersebut?
15. Bagaimana pendekatan komunikasi terapeutik yang dapat digunakan untuk membantu ibu “merefaming” nyeri persalinan?
16. Refleksikan bagaimana dukungan sederhana (kehadiran, sentuhan, kata-kata) dapat memengaruhi pengalaman persalinan seorang ibu?

Diskusikan jawaban bersama anggota kelompok dan presentasikan hasil diskusi di kelas.

Aktivitas 2 — *Shows How*

Simulasi/skill la psikoprofilaksis, manajemen nyeri dan dukungan keluarga

OSCE Ringkas + Critical Items

Critical Items (WAJIB LULUS)

- Salam, memperkenalkan diri
- Identifikasi pasien
- Pengkajian kecemasan, ketakutan dan nyeri persalinan
- Menentukan diagnosa keperawatan nyeri persalinan dan anxietas
- Memberikan dukungan psikoprofilaksis, manajemen nyeri persalinan dan pemberdayaan keluarga untuk mendukung ibu bersalin dengan menggunakan komunikasi terapeutik dan edukasi
- Identifikasi tanda kecemasan dan nyeri persalinan yang tidak terkontrol sehingga berdampak pada hambatan kemajuan persalinan dan distress janin
- Eskalasi bila red flags muncul

DOPS (Does)

DOPS di Lahan Praktik

- Observasi langsung pelaksanaan psikoprofilaksis, manajemen nyeri dan melibatkan keluarga untuk memberi dukungan
- Checklist + umpan balik singkat
- Keputusan: kompeten / supervisi / remedial

Tabel 5. 1 Penerapan Direct Observation of Procedural Skills (DOPS) pada psikoprofilaksis nyeri persalinan dan dukungan keluarga

Komponen	Deskripsi	Kasus intranatal kala satu fase aktif
Metode penilaian	Mini-CEX merupakan penilaian berbasis observasi langsung terhadap performa klinik mahasiswa dalam encounter singkat, terfokus, dan nyata di lahan praktik.	Pembimbing mengamati secara langsung interaksi mahasiswa saat memberikan psikoprofilaksis, manajemen nyeri dan memfasilitasi dukungan keluarga di ruang perawatan bersalin.
Tujuan penilaian	Menilai kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan psikoprofilaksis, manajemen nyeri dan pemberdayaan keluarga dalam memberikan dukungan pada ibu bersalin dalam satu pertemuan klinik.	Mahasiswa tidak hanya dinilai dari pengetahuannya , tetapi juga dari kemampuannya melakukan psikoprofilaksis, manajemen nyeri dan pemberdayaan keluarga dalam memberikan dukungan pada ibu bersalin.
Kasus klinik	Kasus dipilih dari situasi nyata yang sering ditemukan di lahan praktik dan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah atau tahap profesi.	Seorang ibu dalam fase aktif kala satu intranatal, yang mengeluh kesakitan dan mengatakan bahwa dirinya tidak akan sanggup melalui fase persalinan. Ibu tampak merintih dan menagis, kontraksi uterus tiga kali dalam 10 menit, pembukaan serviks 5 cm.
Aktivitas mahasiswa yang diamati	Mahasiswa melakukan encounter klinik secara utuh sejak awal interaksi sampai penjelasan rencana tindakan.	Mahasiswa memperkenalkan diri, melakukan pengkajian singkat namun terarah, mengkaji skala nyeri, tekanan darah, nadi, mengkaji psikologis ibu dan dukungan keluarga, menegakkan diagnose nyeri persalinan dan anxietas,

Komponen	Deskripsi	Kasus intranatal kala satu fase aktif
		lalu menyampaikan rencana pemantaua dan manajemen nyeri persalinan, pemberian intervensi dengan birthing ball, observasi nyeri dan anxietas, berkomunikasi teurapeutik, membangun kepercayaan diri ibu, menetapkan kehadiran perawat untuk memberi rasa aman pada ibu bersalin.
Aspek yang dinilai	Aspek yang dinilai meliputi anamnesis atau pengkajian, pemeriksaan fisik terfokus, penalaran klinik, komunikasi terapeutik, manajemen nyeri, edukasi keluarga, profesionalisme, dan organisasi tindakan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menggali kebutuhan psikoprofilaksis diantaranya mengenali kecemasan ibu bersalin, koping ibu, skala nyeri persalinan dan dukungan keluarga.menentukan diagnose keperawatan dan mampu Menyusun rencana keperawatan dan implementasi psikoprofilaksis, manajemen nyeri dengan birthing ball dan pemberdayaan keluarga untuk memberi dukungan
Fokus observasi pembimbing	Pembimbing menilai kualitas performa klinik mahasiswa secara langsung menggunakan format Mini-CEX yang terstruktur.	Pembimbing memperhatikan apakah mahasiswa mampu menghubungkan data klinik dengan masalah prioritas, misalnya nyeri persalinan dan anxietas, serta mampu memberikan edukasi untuk membangun koping positif ibu dan pemberdayaan keluarga untuk memberi dukungan.
Umpan balik	Umpan balik diberikan segera setelah observasi, bersifat singkat, spesifik, dan berorientasi pada perbaikan performa.	Pembimbing dapat menyampaikan bahwa mahasiswa sudah baik dalam pengkajian, intervensi dan implemnetasi manajemen nyeri, psikoprofilaksis dan pemberdaayaan keluarga untuk memberi dukungan dan melakukan komunikasi teurapeutik dan

Komponen	Deskripsi	Kasus intranatal kala satu fase aktif
		edukasi. tetapi masih perlu memperdalam pengkajian kecemasan dan kebutuhan dukungan keluarga dan keterampilan komunikasi terapeutik.
Keputusan penilaian	Hasil Mini-CEX digunakan untuk menentukan tingkat performa mahasiswa dalam praktik klinik.	Mahasiswa dinyatakan kompeten apabila mampu melakukan encounter klinik secara runtut, aman, komunikatif, dan tepat. Mahasiswa dinyatakan perlu supervisi apabila masih membutuhkan arahan pada beberapa bagian. Mahasiswa dinyatakan remedial apabila performanya belum memenuhi standar minimal.
Makna dalam OBE	Mini-CEX memberikan bukti autentik bahwa mahasiswa mampu menunjukkan capaian pembelajaran pada level does.	Pada kasus mahasiswa dinilai bukan hanya memahami teori, tetapi mampu menerapkan asuhan keperawatan secara langsung, aman, tepat, dan profesional di lahan praktik.

Portofolio

Bukti yang dikumpulkan

- OSCE + DOPS
- Catatan kasus singkat
- Refleksi patient safety
- Feedback CI/dosen

Catatan untuk penulis:

- Bukan sekali ujian
- Bukti konsistensi kompetensi

Tabel 5. 2 Portofolio pada pelaksanaan psikoprofilaksis, manajemen nyeri persalinan dan pemberdayaan keluarga untuk mendukung ibu bersalin

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus ibu pada fase aktif kala satu persalinan
Hakikat portofolio	Portofolio merupakan kumpulan bukti belajar yang menunjukkan perkembangan dan pencapaian kompetensi mahasiswa secara bertahap dan berkelanjutan. Dalam OBE, portofolio digunakan untuk menilai performa nyata mahasiswa dari waktu ke waktu, bukan hanya dari satu kali ujian.	Pada asuhan keperawatan ibu pada fase aktif kala satu persalinan dengan kebutuhan psikoprofilaksis, manajemen nyeri dan dukungan keluarga, portofolio memuat bukti bahwa mahasiswa mampu melakukan pengkajian, menetapkan masalah keperawatan, memberikan edukasi, komunikasi terapeutik menjaga keselamatan pasien, serta memperbaiki performa berdasarkan umpan balik.
Tujuan portofolio	Portofolio bertujuan mendokumentasikan proses belajar, capaian kompetensi, refleksi diri, dan tindak lanjut perbaikan mahasiswa selama praktik.	Mahasiswa tidak hanya menunjukkan bahwa ia pernah merawat ibu pada fase aktif kala satu persalinan dengan kebutuhan psikoprofilaksis, manajemen nyeri dan dukungan keluarga, tetapi juga menunjukkan bagaimana kemampuannya berkembang setelah mendapat masukan dari dosen atau CI.
OSCE dan DOPS	OSCE dan DOPS dapat menjadi bagian penting dalam portofolio karena memberikan bukti keterampilan terstruktur di laboratorium dan bukti performa nyata di lahan praktik.	OSCE dapat memuat hasil ujian keterampilan dukungan psikoprofilaksis, manajemen nyeri dan pemberdayaan keluarga untuk memberikan dukungan pada ibu bersalin, sedangkan DOPS memuat hasil observasi langsung saat mahasiswa melakukan asuhan pada ibu pada fase aktif kala satu

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus ibu pada fase aktif kala satu persalinan
		persalinan dengan kebutuhan psikoprofilaksis, manajemen nyeri dan dukungan keluarga di ruang bersalinan.
Catatan kasus singkat	Catatan kasus singkat berisi ringkasan kasus pasien yang pernah ditangani mahasiswa, data penting, masalah keperawatan, intervensi utama, dan hasil yang dicapai.	Mahasiswa menuliskan ringkasan kasus ibu pada fase aktif kala satu persalinan dengan kebutuhan psikoprofilaksis, manajemen nyeri dan dukungan keluarga, ibu mengeluh nyeri dengan skala nyeri sedang ke berat, ekspresi wajah kesakitan dan cemas, ibu juga mengeluh tidak akan sanggup menjalani nyerinya persalinan, kontraksi uterus tiga kali/ 10 menit dengan kuat dan waktu 20 – 40 detik, pembukaan serviks 5 cm, DJJ 145 x/menit, diagnosis keperawatan prioritas nyeri persalinan dan anxietas, intervensi memberikan dukungan psikoprofilaksis berupa dukungan psikologis, fisiologis, komunikasi terapeutik, manajemen nyeri persalinan dan pemberdayaan keluarga untuk memberikan dukungan pada ibu bersalin.
Refleksi patient safety	Refleksi patient safety menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi kesalahan, dan menyusun langkah pencegahan dalam asuhan keperawatan.	Mahasiswa merefleksikan pentingnya memantau hambatan kemajuan persalinan yang disebabkan karena faktor psikologis dan nyeri yang tidak terkontrol, mencatat kemajuan persalinan dan kesejahteraan janin, memastikan intervensi

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus ibu pada fase aktif kala satu persalinan
		psikoprofilaksis, manajemen nyeri dan pemberdayaan keluarga untuk memberi dukungan pada ibu bersalin diberikan dengan cara yang benar, dan mengenali tanda bahaya yang membutuhkan pelaporan segera.
Feedback CI/dosen	Umpan balik dari Clinical Instructor (CI) atau dosen menjadi bukti pembinaan yang menunjukkan area kekuatan dan area yang masih perlu ditingkatkan.	CI menuliskan bahwa mahasiswa sudah baik dalam psikoprofilaksis, manajemen nyeri dan pemberdayaan keluarga untuk memberi dukungan pada ibu bersalin, tetapi masih perlu meningkatkan ketelitian dalam komunikasi terapeutik, interaksi relasi dengan ibu bersalin .
Karakteristik penilaian	Portofolio bukan penilaian sekali selesai, tetapi kumpulan bukti yang dibangun secara berulang dan berkesinambungan. Penekanan utamanya adalah konsistensi performa mahasiswa.	Mahasiswa dinilai bukan hanya dari satu kasus ibu bersalin, tetapi dari beberapa pengalaman belajar yang menunjukkan bahwa ia konsisten mampu melakukan asuhan keperawatan ibu bersalin fase aktif kala satu secara aman, tepat, dan profesional.
Bukti konsistensi kompetensi	Portofolio memperlihatkan apakah mahasiswa mampu mempertahankan mutu performa pada berbagai kesempatan praktik dan pada waktu yang berbeda.	Dari hasil OSCE, DOPS, catatan kasus, refleksi, dan umpan balik, terlihat bahwa mahasiswa secara konsisten mampu melakukan pengkajian dan intervensi psikoprofilaksis, manajemen nyeri dan pemberdayaan keluarga untuk memberi dukungan pada ibu bersalin.

Komponen	Deskripsi	Contoh pada Kasus ibu pada fase aktif kala satu persalinan
Makna dalam OBE	Dalam OBE, portofolio memberikan bukti autentik bahwa capaian pembelajaran tidak hanya dimiliki secara teoritis, tetapi benar-benar tampak dalam performa yang berulang, berkembang, dan terdokumentasi.	Pada asuhan keperawatan anak dengan diare, portofolio menunjukkan bahwa mahasiswa tidak hanya paham konsep diare, tetapi juga konsisten mampu menerapkannya dalam praktik klinik nyata.

Tabel 5. 3 Case Report pada Asuhan Keperawatan ibu bersalin fase aktif kala satu dengan kebutuhan psikoprofilaksis, manajemen nyeri persalinan, dukungan keluarga

Komponen	Deskripsi	Ibu bersalin kala satu fase aktif
Hakikat case report	Case report merupakan laporan singkat dan sistematis tentang satu kasus pasien yang ditangani mahasiswa selama praktik klinik. Dalam OBE, case report berfungsi sebagai bukti kemampuan mahasiswa dalam memahami, menganalisis, dan mendokumentasikan kasus secara ilmiah dan klinis.	Mahasiswa menyusun laporan singkat tentang Asuhan Keperawatan ibu bersalin fase aktif kala satu dengan kebutuhan psikoprofilaksis, manajemen nyeri persalinan, dukungan keluarga, mengeluh nyeri dengan skala sedang sampai berat, kontraksi uterus tiga kali dalam 10 menit, dilatasi serviks lima cm, ibu mengatakan tidak sanggup menjalani proses persalinan yang sangat nyeri, tekana darah 110/80 mmHg, nadi 100 kali/meni, ibu tampak gelisah dan kesakitan dan tampak lemas.
Tujuan	Case report bertujuan menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam mengintegrasikan data pengkajian, masalah keperawatan, rencana tindakan, implementasi, dan evaluasi hasil asuhan.	Mahasiswa tidak hanya menuliskan data pasien, tetapi juga menjelaskan masalah prioritas, tindakan yang diberikan, dan perkembangan kondisi Keperawatan ibu bersalin fase aktif kala satu dengan kebutuhan

Komponen	Deskripsi	Ibu bersalin kala satu fase aktif
		psikoprofilaksis, manajemen nyeri persalinan, dukungan keluarga setelah intervensi.
Isi laporan	Isi case report biasanya mencakup identitas singkat pasien, keluhan utama, data subjektif dan objektif, analisis masalah, diagnosis keperawatan, intervensi, implementasi, evaluasi, dan pembelajaran dari kasus.	Pada kasus ibu pada fase aktif kala satu persalinan dengan kebutuhan psikoprofilaksis, manajemen nyeri dan dukungan keluarga, ibu mengeluh nyeri dengan skala nyeri sedang ke berat, ekspresi wajah kesakitan dan cemas, ibu juga mengeluh tidak akan sanggup menjalani nyerinya persalinan, kontraksi uterus tiga kali/ 10 menit dengan kuat dan waktu 20 – 40 detik, pembukaan serviks 5 cm, DJJ 145 x/menit, diagnosis keperawatan prioritas nyeri persalinan dan anxietas, intervensi memberikan dukungan psikoprofilaksis berupa dukungan psikologis, fisiologis, komunikasi terapeutik, manajemen nyeri persalinan dan pemberdayaan keluarga untuk memberikan dukungan pada ibu bersalin..
Fokus penilaian	Penilaian difokuskan pada ketepatan pengkajian, relevansi analisis masalah, logika penalaran klinik, ketepatan intervensi, dan kemampuan mengevaluasi hasil asuhan.	Pembimbing menilai apakah mahasiswa mampu menghubungkan data kecemasan dan nyeri persalinan dengan masalah utama, memilih intervensi yang tepat, dan menilai respons anak setelah pemberian cairan.

Komponen	Deskripsi	Ibu bersalin kala satu fase aktif
Nilai edukatif	Case report membantu mahasiswa mengembangkan clinical reasoning, keterampilan dokumentasi, dan kebiasaan merefleksikan praktik klinik secara ilmiah.	Dari kasus ibu pada fase aktif kala satu persalinan, mahasiswa belajar bahwa pengkajian kecemasan, ketakutan, nyeri persalinan dan kebutuhan akan dukungan keluarga, merupakan bagian yang sangat penting dalam asuhan keperawatan intranatal.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, case report menjadi bukti bahwa mahasiswa mampu menerapkan teori ke dalam analisis kasus nyata secara sistematis dan bertanggung jawab.	Mahasiswa menunjukkan bahwa ia tidak hanya memahami konsep keperawatan ibu pada fase aktif kala satu persalinan dengan kebutuhan psikoprofilaksis, manajemen nyeri dan dukungan keluarga, tetapi juga mampu menyusun laporan kasus yang menggambarkan asuhan keperawatan secara utuh.

Tabel 5. 4 Refleksi Patient Safety pada ibu bersalin kala satu fase aktif

Komponen	Deskripsi	Kasus ibu bersalin kala satu fase aktif
Hakikat refleksi patient safety	Refleksi patient safety merupakan tulisan singkat yang menunjukkan kemampuan mahasiswa mengenali risiko keselamatan pasien, menganalisis potensi masalah, dan merencanakan tindakan pencegahan.	Pada kasus ibu bersalin, mahasiswa merefleksikan bahwa kehilangan kontrol diri terhadap aspek psikologis dan ketidakmampuan dalam manajemen nyeri dapat menyebabkan perburukan kondisi bila tidak dikenali dan ditangani dengan tepat, diantaranya adalah kemajuan persalinan terhambat dan distres janin.
Tujuan	Refleksi ini bertujuan menumbuhkan kesadaran mahasiswa bahwa keselamatan pasien merupakan bagian penting	Mahasiswa memahami bahwa kesalahan kecil, seperti kurang teliti memantau nyeri persalinan dan kecemasan atau terlambat mengenali tanda kemajuan persalinan terhambat dan distres janin,

Komponen	Deskripsi	Kasus ibu bersalin kala satu fase aktif
	dari setiap tindakan keperawatan.	dapat berdampak besar pada keselamatan ibu dan janin.
Fokus refleksi	Fokus refleksi meliputi identifikasi risiko, analisis penyebab, tindakan pencegahan, dan pembelajaran yang diperoleh mahasiswa dari pengalaman klinik.	Mahasiswa menuliskan bahwa risiko utama pada pasien ini adalah kemajuan persalinan terhambat dan distress janin dan keterlambatan penanganan bila keluarga tidak memahami tanda bahaya.
Risiko yang diidentifikasi	Mahasiswa perlu menunjukkan kemampuan mengenali situasi yang berpotensi membahayakan pasien.	Risiko yang dapat diidentifikasi antara lain kontraksi uterus yang melemah, nyeri yang tidak terkontrol, pembukaan serviks melambat, koping ibu yang negatif dan keterlambatan dalam mengenali distress janin..
Tindakan pencegahan	Mahasiswa menjelaskan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko keselamatan pasien.	Mahasiswa menuliskan pentingnya memantau skala nyeri, kecemasan kontraksi uterus, dilatasi serviks, DJJ dan pergerakan janin dan air ketuban. Memberikan motivasi dan membangun kepercayaan ibu untuk dapat mengontrol kecemasan dan nyerinya, melakukan dan membimbing teknik relaksasi dan manajemen nyeri menjelaskan cara pemberian oralit yang benar, serta mengedukasi ibu tentang tanda bahaya.
Pembelajaran mahasiswa	Refleksi harus menunjukkan apa yang dipelajari mahasiswa dan bagaimana hal itu akan memengaruhi praktik berikutnya.	Mahasiswa menyadari bahwa pada ibu bersalin pada fase aktif kala satu, pengkajian yang teliti, komunikasi yang jelas kepada keluarga, dan pemantauan berulang merupakan bagian penting untuk menjaga keselamatan pasien.
Makna dalam OBE	Dalam OBE, refleksi patient safety menunjukkan	Mahasiswa membuktikan bahwa ia tidak hanya melakukan tindakan, tetapi juga

Komponen	Deskripsi	Kasus ibu bersalin kala satu fase aktif
	perkembangan sikap profesional, tanggung jawab klinik, dan kemampuan berpikir kritis mahasiswa terhadap keselamatan pasien.	mampu mengevaluasi risiko dan meningkatkan kualitas praktik keperawatan ibu bersalin secara berkelanjutan.

E. Ringkasan

Asuhan keperawatan maternitas pada periode intranatal menuntut pendekatan yang komprehensif, tidak hanya berfokus pada aspek fisiologis, tetapi juga memperhatikan dimensi psikologis, sosial, dan spiritual ibu. Pendekatan psikoprofilaksis menjadi landasan penting dalam membantu ibu memahami, menerima, dan mengelola pengalaman persalinan secara lebih adaptif.

Psikoprofilaksis menekankan bahwa nyeri persalinan bukan sekadar sensasi yang harus dihilangkan, melainkan bagian dari proses fisiologis yang memiliki makna. Persepsi nyeri dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti kecemasan dan ketakutan. Oleh karena itu, intervensi diarahkan pada upaya reframing nyeri melalui edukasi, teknik relaksasi, dan penguatan kepercayaan diri ibu. Kondisi relaksasi terbukti meningkatkan pelepasan endorfin yang berperan sebagai analgesik alami tubuh.

Manajemen nyeri persalinan dilakukan secara holistik dengan mengutamakan metode non-farmakologis, seperti teknik pernapasan, relaksasi, distraksi, pijatan (effleurage dan counterpressure), mobilisasi, serta penggunaan media seperti birthing ball. Intervensi ini tidak hanya menurunkan intensitas nyeri, tetapi juga meningkatkan kontrol ibu terhadap proses persalinan. Dalam kondisi tertentu, pendekatan farmakologis dapat digunakan secara selektif dengan tetap mempertimbangkan keselamatan ibu dan janin.

Dukungan keluarga, khususnya suami, merupakan komponen kunci dalam keberhasilan manajemen nyeri dan pengalaman persalinan yang positif. Dukungan emosional, fisik, informasional, dan penghargaan berperan dalam menurunkan kecemasan, meningkatkan rasa aman, serta memperkuat kemampuan coping ibu. Dalam perspektif keperawatan maternitas, pendekatan family-centered care menempatkan keluarga sebagai mitra aktif dalam asuhan.

Perawat memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan ketiga aspek tersebut melalui proses keperawatan. Pada tahap perencanaan (CPMK-4), perawat menyusun rencana asuhan yang mencakup pengkajian nyeri, identifikasi faktor

psikologis, serta kebutuhan dukungan keluarga dengan luaran yang terukur, seperti penurunan skala nyeri, peningkatan kemampuan relaksasi, dan peningkatan keterlibatan keluarga.

Pada tahap implementasi (CPMK-5), perawat melaksanakan intervensi secara langsung melalui penerapan teknik psikoprofilaksis (napas, relaksasi, fokus), membangun coping positif dan kepercayaan diri pada ibu, manajemen nyeri non-farmakologis, edukasi kepada ibu dan keluarga, komunikasi terapeutik yang empatik dan menenangkan, pelibatan aktif keluarga dalam proses persalinan. Seluruh tindakan dilakukan dengan memperhatikan prinsip keselamatan, kenyamanan, dan penghormatan terhadap nilai serta preferensi ibu.

Dengan demikian, pencapaian CPL-5 tercermin dalam kemampuan perawat untuk tidak hanya melakukan tindakan klinis, tetapi juga menghadirkan asuhan yang humanistik. Perawat berperan sebagai fasilitator yang membantu ibu menjalani proses persalinan dengan rasa percaya diri, kontrol, dan makna.

Pada akhirnya, asuhan maternitas yang mengintegrasikan psikoprofilaksis, manajemen nyeri, dan dukungan keluarga tidak hanya bertujuan mengurangi ketidaknyamanan, tetapi juga membentuk pengalaman persalinan yang positif—sebagai bagian dari perjalanan seorang perempuan dalam menjadi ibu, secara utuh sebagai tubuh, pikiran, dan jiwa.

Tabel 5. 5 Red Flags & Eskalasi pada Asuhan Intranatal kala satu fase aktif

No	Kondisi / Temuan (Red Flags)	Makna Klinis	Tindakan Perawat	Eskalasi
1	Nyeri sangat hebat (NRS $\geq$ 9) tidak terkontrol	Risiko kelelahan, distress	Evaluasi teknik nyeri, berikan intervensi tambahan	Laporkan ke bidan/dokter untuk pertimbangan analgesia
2	Ibu sangat cemas/panik, tidak kooperatif	Gangguan coping, memperberat nyeri	Komunikasi terapeutik, relaksasi	Konsultasi tim bila tidak membaik
3	Kontraksi terlalu sering ($>5 \times 10$ menit)	Risiko hiperstimulasi uterus	Observasi ketat	Segera lapor tenaga medis
4	DJJ tidak normal (<110 atau >160 bpm)	Distres janin	Posisi miring kiri, oksigenasi	Rujuk segera ke dokter

No	Kondisi / Temuan (Red Flags)	Makna Klinis	Tindakan Perawat	Eskalasi
5	Perdarahan pervaginam abnormal	Risiko komplikasi (abruptio/plasenta previa)	Observasi jumlah darah	Segera eskalasi
6	Air ketuban hijau/keruh	Indikasi mekonium	Pantau ketat	Lapor dokter
7	Ibu kelelahan berat, tidak mampu meneran	Risiko persalinan lama	Dukungan, energi, hidrasi	Kolaborasi intervensi medis
8	Tekanan darah tinggi / tanda preeklampsia	Risiko komplikasi serius	Monitoring ketat	Rujuk dokter
9	Suami/keluarga tidak mendukung / konflik	Gangguan psikososial	Edukasi dan fasilitasi	Libatkan tim
10	Tidak ada kemajuan persalinan	Prolonged labor	Evaluasi kondisi	Kolaborasi tindakan lanjut

Form Checklist

Nama Mahasiswa : _____

NIM : _____

Tanggal : _____

Tempat Praktik / Skill Lab : _____

Petunjuk: Beri tanda centang (✓) pada kolom yang sesuai.

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
1	Saya sudah bisa menjelaskan konsep psikoprofilaksis, manajemen nyeri dan dukungan keluarga pada masa persalinan	☐	☐	
2	Saya sudah bisa melakukan pengkajian nyeri persalinan, kecemasan, ketakutan dan kebutuhan dukungan keluarga pada ibu bersalin	☐	☐	
3	Saya sudah bisa mengkaji kontraksi uterus, dilatasi serviks, djj, ketuban, TTV ibu,	☐	☐	
4	Saya sudah bisa mengidentifikasi masalah keperawatan prioritas pada bersalin kala satu fase aktif	☐	☐	
5	Saya sudah bisa memberikan dukungan psikologis (menetapkan kehadiran, bersikap empati, membangun kepercayaan dengan pasien)	☐	☐	
6	Saya sudah bisa memberi dukungan fisiologis pada ibu (kebutuhan cairan, nutrisi, kenyamanan, mobilisasi)	☐	☐	
7	Saya sudah bisa melaksanakan komunikasi terapeutik pada ibu (memberi rasa aman, berkomunikasi dengan empati)	☐	☐	
8	Saya sudah bisa memberikan motivasi pada ibu untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan kontrol diri	☐	☐	
9	Saya sudah bisa memberikan edukasi tentang proses persalinan	☐	☐	
10	Saya sudah bisa membimbing teknik relaksasi, nafas dalam, birthing ball	☐	☐	
11	Saya sudah bisa mengevaluasi respon nyeri pasien	☐	☐	
12	Saya sudah bisa melibatkan pasangan dan keluarga untuk memberikan dukungan pada ibu bersalin	☐	☐	

No	Pernyataan	Sudah	Belum	Catatan
13	Saya sudah bisa memberi arahan dan edukasi pada pasangan dan keluarga dalam mendukung proses persalinan	☐	☐	
14	Saya sudah bisa menjaga privasi dan kenyamanan pasien	☐	☐	
15	Saya sudah bisa menunjukkan sikap profesional, aman, teliti, dan responsif saat merawat ibu bersalin kala satu fase aktif	☐	☐	

Refleksi Mahasiswa

Tuliskan pengalaman Anda:

Hal yang sudah dikuasai:

.....

Hal yang masih perlu ditingkatkan:

.....

Rencana perbaikan:

.....

Referensi

- Bobak, I. M., Lowdermilk, D. L., Jensen, M. D., & Perry, S. E. (2005). Buku ajar keperawatan maternitas. *Jakarta: Egc*, 7-8.
- Esan, D. T., Aduabo, J. E., Fawole, I. O., & Akingbade, O. (2023). Coping experiences of Nigerian women during pregnancy and labour: A qualitative study. *International journal of community based nursing and midwifery*, 11(1), 23.
- Keenan-Lindsay, L., & Leifer, G. (2023). *Leifer's Introduction to Maternity & Pediatric Nursing in Canada-E-Book: Leifer's Introduction to Maternity & Pediatric Nursing in Canada-E-Book*. Elsevier Health Sciences.
- Leap, N., & Hunter, B. (2022). *Supporting women for labour and birth: a thoughtful guide*. Routledge.
- Ngai, F.-W., & Xiao, X. (2021, 2021/05/01/). Perceptions of paternal involvement and labour pain management in Chinese couples during childbirth: A qualitative study. *Women and Birth*, 34(3), 288-295. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.wombi.2020.03.003>
- O'Connell, M. A., Khashan, A. S., & Leahy-Warren, P. (2021, 2021/05/01/). Women's experiences of interventions for fear of childbirth in the perinatal period: A meta-synthesis of qualitative research evidence. *Women and Birth*, 34(3), e309-e321. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.wombi.2020.05.008>
- Perry, S. E., Hockenberry, M. J., Cashion, K., Alden, K. R., Olshansky, E., & Lowdermilk, D. L. (2022). *Maternal child nursing care-E-book: Maternal child nursing care-E-book*. Elsevier Health Sciences.
- Raman, A. (2019). *Reeder's Maternity Nursing*. Wolters Kluwer India Pvt Ltd.
- Wanyenze, E. W., Byamugisha, J. K., Tumwesigye, N. M., Muwanguzi, P. A., & Nalwadda, G. K. (2022). A qualitative exploratory interview study on birth companion support actions for women during childbirth. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 22(1), 63.

Profil Penulis



Ns. Nina Sunarti, M.Kep.

Lahir di Bekasi pada tanggal 05 Maret 1982 putri ke dua dari pasangan Eddy Sunarso (Alm) dan Nakirah (Alm). Penulis berhasil menyelesaikan Pendidikan S1 Keperawatan (2004), Ners (2005) dan S2 Keperawatan (2017) di Program Studi Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saat ini penulis adalah Dosen Tetap di Akademi Keperawatan Bina Insan Jakarta. Sebagai dosen penulis juga menjalankan Tridharma, melaksanakan pendidikan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan sebagai narasumber/fasilitator. Karyanya sudah ada dalam jurnal nasional, internasional, HaKI dan buku. Penulis aktif dalam organisasi PPNI Jakarta Utara, pernah menjabat sebagai ketua dan sekretaris DPK Akper Harum. Saat ini penulis menjabat sebagai sekretaris DPK PPNI Pendidikan Jakarta Utara. Penulis juga aktif Alamat Email penulis: nina.nti@bsi.ac.id. Motto: "The best preparation for tomorrow is doing your best today"



Yuni Puji Widiastuti , S. Kep, M. Kep., Ns.

Penulis adalah seorang Dosen Keperawatan Maternitas, lahir di Kendal, Jawa Tengah 28 Juni 1978. Lulus Diploma III Keperawatan Akademi Keperawatan DepKes Semarang tahun 1998, lulus Sarjana Keperawatan FK UGM tahun 2002, lulus Program Profesi Ners FK UGM tahun 2003, Lulus S2 Magister Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia tahun 2012. Mempunyai riwayat pekerjaan sebagai Dosen STIKES Kendal sejak 2004 sampai sekarang, Sekretaris Prodi Keperawatan tahun 2004-2006, Ketua Prodi Keperawatan STIKES Kendal tahun 2010-2011, Ketua STIKES Kendal Periode 2012-2016. Aktif melakukan kegiatan Tridharma Pendidikan Tinggi. Selain itu penulis juga menjadi pembicara atau nara sumber serta fasilitator dalam berbagai kegiatan ilmiah berskala nasional maupun internasional serta reviewer dari beberapa jurnal nasional bereputasi. Beberapa hasil penelitian dan pengabdian masyarakat telah di publikasikan di jurnal yang terakreditasi maupun jurnal yang terindex scopus. Memiliki beberapa buku yang ber ISSN serta Aktif dalam kegiatan Organisasi di lingkup Jawa Tengah maupun Nasional. Sebagai Wakil Ketua Bidang Pelayanan IPEMI Jawa Tengah, Anggota Bidang Kerjasama Dalam dan Luar Negeri IPEMI Pusat, sebagai Wakil Ketua Bidang Penelitian, Informasi dan Komunikasi DPD PPNI Kabupaten Kendal, Sebagai Anggota Bidang Pendidikan dan Pelatihan Himpunan Perawat Holistik Indonesia (HPHI) Provinsi Jawa Tengah, Sebagai Koordinator bidang Penelitian dan Pengembang Kagama Pengcab Kabupaten Kendal.

Penulis juga aktif dalam berbagai kegiatan ilmiah berskala nasional maupun internasional guna pengembangan diri dan profesi. Email penulis yunipuji@stikeskendal.ac.id.

Motto : Do The Best We Could

Profil Penulis



Santi Wahyuni, S.Kp, M.Kep, Sp.Mat.

Lahir di Bandung, 05 Januari 1977. Penulis menempuh pendidikan sarjana di Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Kedokteran, Universitas Padjadjaran, dan lulus pada tahun 2000. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan magister di Program Magister Keperawatan serta Program Spesialis-1 Keperawatan Maternitas di Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Indonesia, dan lulus masing-masing pada tahun 2007 dan 2008. Riwayat pekerjaan penulis diawali pada tahun 2000 sebagai staf pengajar di Akademi

Perawat Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, sembari menjalani program magang di RSUD Kabupaten Sumedang selama satu tahun. Sejak Mei 2002 hingga 1 Februari 2026, penulis bertugas sebagai pengajar di Program Studi Diploma III Keperawatan Cirebon. Mulai 2 Februari 2026 hingga saat ini, penulis menjadi pengajar di Program Sarjana Terapan Keperawatan Cirebon, Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Penulis mengampu berbagai mata kuliah, di antaranya: Keperawatan Maternitas, Konsep Dasar Keperawatan, Keperawatan Dasar, Metodologi Keperawatan, Metodologi Penelitian, serta Etika Keperawatan dan Hukum Kesehatan. Selain mengajar, penulis aktif menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi, seperti menulis buku, menjadi reviewer soal Uji Kompetensi Nasional, reviewer Pengabdian Masyarakat tingkat nasional, serta memublikasikan artikel ilmiah di jurnal nasional maupun internasional. Penulis juga rutin mengikuti berbagai kegiatan ilmiah seperti pelatihan, workshop, dan seminar. Dalam lingkup organisasi dan profesi, penulis merupakan pendiri dan pembina PIKMA SPIRIT, Asesor LAM-PTKes, Auditor AMI Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Pengurus DPD PPNI Kota Cirebon, Pengurus IPEMI Jawa Barat, serta Pengurus Yayasan Ahnaf Maulana Nafi. Penulis dapat dihubungi melalui surel: santiwahyuni@dosen.poltekkestasikmalaya.ac.id.

Motto: *"Melalui doa yang melangit dan ilmu yang membumi, kuhidupkan cintamu dalam manfaat bagi sesama."*

Profil Penulis



Dr. Ethyca Sari, S.Kep., Ns., M.Kes.

Lahir di Kediri, 20 Oktober 1971. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Keperawatan, Universitas Airlangga tahun 2006. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada prodi Kesehatan Masyarakat di Universitas Airlangga dan lulus tahun 2012. Setelah itu melanjutkan pendidikan S3 pada Prodi Doktoral Ilmu Kedokteran Kesehatan Universitas Diponegoro Semarang lulus tahun 2023. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 1991 bekerja di RS.William booth Surabaya, tahun 1992 bekerja di RS Catherine Booth Makasar, tahun 1995 bekerja di STIKES William Booth Surabaya hingga saat ini. Saat ini penulis bekerja di STIKES William Booth Surabaya mengampu mata kuliah Keperawatan Anak, Keperawatan gerontik, Konsep Dasar Keperawatan. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi jurnal nasional terindeksi sinta maupun internasional terindeks scopus, pembicara seminar nasional maupun internasional, serta mendapatkan hibah penelitian maupun pengabdian masyarakat dari kemnristekdikti . Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: ethyca.sari@yahoo.com Motto: "Success begins with self-belief"

Profil Penulis



Dr. Hemi Fitriani, S.Kp., M.Kep., Sp.Kep.Mat.

merupakan dosen Keperawatan Maternitas di STIKes Jenderal Achmad Yani Cimahi. Beliau menyelesaikan pendidikan Sarjana Keperawatan di Universitas Padjadjaran serta pendidikan Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Maternitas, dan Doktor Keperawatan di Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun sebagai pendidik dan peneliti, bidang keahlian yang ditekuni meliputi keperawatan maternitas, kesehatan reproduksi perempuan, menyusui dan laktasi, kesehatan ibu postpartum, serta Diastasis Rectus Abdominis (DRA). Berbagai penelitian dan publikasinya berfokus pada kesehatan ibu dan anak, termasuk pengembangan inovasi teknologi keperawatan untuk pemulihan postpartum. Karya-karya terbarunya antara lain pengembangan alat stimulasi otot listrik untuk DRA, studi fenomenologi pengobatan tradisional DRA pada ibu postpartum, serta analisis konseptual ketidaknyamanan akibat DRA pada ibu pascapersalinan.

Motto : Saya percaya setiap kesempatan adalah petunjuk; ilmu, karya, dan pengabdian adalah cara saya membacanya

Sinopsis

Buku Ajar *Keperawatan Maternitas* disusun sebagai sumber pembelajaran utama bagi mahasiswa keperawatan dan referensi praktis bagi perawat klinik dalam memberikan asuhan keperawatan pada perempuan selama masa kehamilan hingga persiapan persalinan dengan menekankan pendekatan *continuity of care* (asuhan berkesinambungan) yang berorientasi pada keselamatan ibu dan janin, pencegahan komplikasi, penguatan edukasi kesehatan, keterlibatan keluarga, serta kolaborasi interprofesional. Materi disajikan secara sistematis, berbasis bukti, dan terintegrasi dengan proses keperawatan (pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, evaluasi) sehingga memudahkan pembaca memahami konsep dan penerapannya di layanan kesehatan. Bab 1 membahas ruang lingkup keperawatan maternitas, peran perawat, prinsip *woman-centered care*, komunikasi terapeutik, serta keselamatan pasien dalam kerangka asuhan berkesinambungan; Bab 2 menguraikan asuhan keperawatan pada masalah umum kehamilan seperti mual muntah, nyeri punggung, edema, konstipasi, gangguan tidur, dan keluhan fisiologis lainnya berikut strategi pengkajian, penetapan diagnosis, intervensi, dan edukasi; Bab 3 mengulas komplikasi hipertensi, preeklamsia, dan eklamsia meliputi faktor risiko, patofisiologi, tanda gejala, pemeriksaan penunjang, monitoring ibu-janin, pencegahan kejang, kolaborasi terapi, serta kesiapsiagaan rujukan; Bab 4 membahas perdarahan antepartum dan risiko kehamilan tinggi dengan penekanan pada deteksi dini, prioritas tindakan, stabilisasi awal, pencegahan syok, dukungan psikologis, koordinasi rujukan, serta edukasi tanda bahaya kehamilan; dan Bab 5 memaparkan persiapan persalinan melalui psikoprofilaksis, manajemen nyeri nonfarmakologis, serta dukungan keluarga untuk membangun kesiapan fisik-psikologis ibu dan menciptakan pengalaman persalinan yang aman, nyaman, dan bermakna. Secara keseluruhan, buku ajar ini diharapkan meningkatkan pemahaman konseptual dan keterampilan klinis pembaca dalam memberikan asuhan keperawatan maternitas yang komprehensif, humanis, dan berkualitas.

Buku Ajar Keperawatan Maternitas disusun sebagai sumber pembelajaran utama bagi mahasiswa keperawatan dan referensi praktis bagi perawat klinik dalam memberikan asuhan keperawatan pada perempuan selama masa kehamilan hingga persiapan persalinan dengan menekankan pendekatan continuity of care (asuhan berkesinambungan) yang berorientasi pada keselamatan ibu dan janin, pencegahan komplikasi, penguatan edukasi kesehatan, keterlibatan keluarga, serta kolaborasi interprofesional. Materi disajikan secara sistematis, berbasis bukti, dan terintegrasi dengan proses keperawatan (pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, evaluasi) sehingga memudahkan pembaca memahami konsep dan penerapannya di layanan kesehatan. Bab 1 membahas ruang lingkup keperawatan maternitas, peran perawat, prinsip woman-centered care, komunikasi terapeutik, serta keselamatan pasien dalam kerangka asuhan berkesinambungan; Bab 2 menguraikan asuhan keperawatan pada masalah umum kehamilan seperti mual muntah, nyeri punggung, edema, konstipasi, gangguan tidur, dan keluhan fisiologis lainnya berikut strategi pengkajian, penetapan diagnosis, intervensi, dan edukasi; Bab 3 mengulas komplikasi hipertensi, preeklamsia, dan eklamsia meliputi faktor risiko, patofisiologi, tanda gejala, pemeriksaan penunjang, monitoring ibu-janin, pencegahan kejang, kolaborasi terapi, serta kesiapsiagaan rujukan; Bab 4 membahas perdarahan antepartum dan risiko kehamilan tinggi dengan penekanan pada deteksi dini, prioritas tindakan, stabilisasi awal, pencegahan syok, dukungan psikologis, koordinasi rujukan, serta edukasi tanda bahaya kehamilan; dan Bab 5 memaparkan persiapan persalinan melalui psikoprofilaksis, manajemen nyeri nonfarmakologis, serta dukungan keluarga untuk membangun kesiapan fisik-psikologis ibu dan menciptakan pengalaman persalinan yang aman, nyaman, dan bermakna. Secara keseluruhan, buku ajar ini diharapkan meningkatkan pemahaman konseptual dan keterampilan klinis pembaca dalam memberikan asuhan keperawatan maternitas yang komprehensif, humanis, dan berkualitas.

Penerbit:

PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88 RT. 001 RW. 005

Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11620

ISBN 978-634-7927-29-3 (PDF)



9

786347

927293

